

伤寒恒论

郑钦安

文硕阁

wenshuoge.com

目录

关于我们	3
郑钦安原序	5
张仲景原序（校补）	6
伤寒恒论卷一	7
伤寒恒论卷二	38
伤寒恒论卷三	72
伤寒恒论卷四	87
伤寒恒论卷五	103
伤寒恒论卷六	115
伤寒恒论卷七	119
伤寒恒论卷八	137
伤寒恒论卷九	141
伤寒恒论卷十	161

版权声明

本书版权保护已经过期，属于公版书！并由"文硕阁"网站的用户制作并发布于文硕阁 网站内,请大家在“合理使用”范围内使用

这本电子书可供中华人民共和国（the People's Republic of China）和世界上大多数其他地区的任何人免费使用，几乎没有任何限制。您可以根据本文件中包含的"传硕公版书许可条款"中的授权许可进行复制、赠送或改编它。

如果您不在中华人民共和国，您必须在使用本电子书之前查看您所在国家/地区的法律。

什么是公版书？

根据我国现行「著作权法」第 20、21 条的规定，除署名权、修改权、保护作品完整权外，中国公民对其著作的法定权利均于作者死亡后第五十年的 12 月 31 日截止。超过著作权法保护日期后，其作品就进入了公有领域（公共版权）

这种因作者死亡超过 50 年而丧失发行权、改编权等著作权利的书籍，就称为“公共版权书籍”，简称“公版书”。

传硕公版书保护计划

中华文明5000多年绵延不断、经久不衰，在长期演进过程中，形成了中国人看待世界、看待社会、看待人生的独特价值体系、文化内涵和精神品质，这是我们区别于其他国家和民族的根本特征，也铸就了中华民族博采众长的文化自信。

文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴，文化强民族强。

所以我们发起了公版书保护计划。来帮助把中国五千年的文明硕果进行电子化并服务于大众，我们网站所有内容都是免费、自由、无版权的。对所有的读者免费！

使用 **文硕阁** 中的公版书 不需要获得许可（在中国，这属于“合理使用”）。这适用于所有用途，包括商业用途。换句话说，即使是商业盈利用途，也无需支付版税。

我们希望能有更多的用户加入到文硕阁网站中来，让我们一起来保护传承文明的硕果。

源浚者流长，根深者叶茂。文化自信是一个国家、一个民族发展中最基本、最深沉、最持久的力量。

如何联系我们？

网站：www.wenshuoge.com

邮箱：7sbook@duck.com



(扫码访问网站)



(扫码加客服微信)

郑钦安原序

《伤寒》一书，相传千余年，俱云仲景原文，名贤迭出，注家亦多，不胜枚举。余阅原文，颇有领悟。兹将原文逐条一一剖析，不敢与前贤并驾，但就鄙见所及，逐条发明，虽不敢云高出手眼，此亦救世之本心，聊以补名贤之不逮，亦大快事也，高明谅之，是为序。

一、此书即遵舒驰远先生分列上、中、下篇，挨次发明，而他书则前后原文不一。总之论其原文，发明圣意，即前后错乱，而原文终在也。学者亦不必论短、论长则得矣。

二、太阳篇条内有称中风字句，当是太阳受风，而中字不当，何也？中者如矢之中靶，人何能当？况书有称中经中风中脏之别，而条内所称中风，全不似中风面目，学者察之。

大清光绪二十年孟冬月上浣临邛郑寿全钦安序

张仲景原序（校补）

论曰：余每览越人入虢之诊，望齐侯之色，未尝不慨然叹其才秀也。怪当今居世之士，曾不留神医药，精究方术，上以疗君亲之疾，下以救贫贱之厄，中以保身长全，以养其生，但竞逐荣势，企踵权豪，孜孜汲汲，惟名利是务，崇饰其末，忽弃其本，华其外而悴其内，皮之不存，毛将安附焉！卒然遭邪风之气，婴非常之疾，患及祸至，而方震栗，降志屈节，钦望巫祝，告穷归天，束手受败，赍百年之寿命，持至贵之重器，委付凡医，恣其所措。咄嗟呜呼！厥身已毙，神明消灭，变为异物；幽潜重泉，徒为啼泣。痛夫举世昏迷，莫能觉悟；不惜其命，若是轻生，彼何荣势之云哉！而进不能爱人知人，退不能爱身知己，遇灾值祸，身居厄地；蒙蒙昧昧，蠢若游魂。哀乎！趋世之士，驰竞浮华，不固根本，忘躯徇物，危若冰谷，至于

是也。

余宗族素多，向余二百；建安纪年以来，犹未十稔，其死亡者，三分有二，伤寒十居其七。感往昔之沦丧，伤横夭之莫救。乃勤求古训，博采众方，撰用素问九卷，八十一难，阴阳大论，胎胪药录，并平脉辨证，为伤寒杂病论合十六卷，虽未能尽愈诸病，庶可以见病知源，若能寻余所集，思过半矣。

夫天布五行，以运万类；人禀五常，以有五脏，经络府俞，阴阳会通；玄冥幽微，变化难极。自非才高识妙，岂能探其理致哉！上古有神农、黄帝、歧伯、伯高、雷公、少俞、少师、仲文，中世有长桑，扁鹊，汉有公乘阳庆及仓公，下此以往，未之闻也。观今之医，不念思求经旨，以演其所知，各承家技，始终顺旧；省疾问病，务在口给；相对斯须，便处汤药；按寸不及尺，握手不及足，人迎趺阳，三部不参；动数发息，不满五十，短期未知决诊，九候曾无仿佛；明堂阙庭，尽不见察，所谓窥管而已，夫欲视死别生，实为难矣。孔子云：“生而知之者上，学则亚之，多闻博识，知之次也”。余宿尚方术，请事斯语。

伤寒恒论卷一

太阳上篇

凡风伤卫之证，列于此篇，计五十三法（据舒本校增）

一、太阳为之病，脉浮①，头项强痛而恶寒②原文。

①脉浮：浮象浅表，轻按即得，指邪初入也。

②头项强（jiàng）痛：即头痛项强之意，谓颈部有牵强不适之感。项指颈之后部。恶（wù）寒：畏寒怕冷。

郑论：按太阳本气主寒水，太阳统周身皮肤，毛窍、营卫、百脉，经络，为一身纲领。毛窍乃太阳寒水气化出路（一），一切外邪之来，必由毛窍而始入内，出入两字，乃邪正机关，万病绳墨。脉浮者，指邪初入也；头项强痛者，指邪犯太阳地面经络也；恶寒者，指太阳本气受病也。恶寒二字，乃太阳提纲，认证眼目，知得恶寒二字，无论一年四季为病，只要见得病人现有头、项、腰、背强痛，恶寒、发热，即按太阳法治之，毋得拘于时令，而有失经旨也。

（一）气化二字有两说：从毛窍而出者，轻清之露也；从下而出者，重浊之汁也。故太阳有传经、传腑，皆在这气化上探求（顶批）。

【阐释】本节乃太阳病的脉证提纲。以后凡提“太阳病”三字，就有这些脉证的出现。太阳病是外感病的初期阶段，其病在表。郑氏提出“气化”二字，乃伤寒书一部的真机，以及知得恶寒二字，无论一年四季为病，……毋得拘于时令，而有失经旨也，确有精卓之见。太阳经脉循行的部位，上额、交巅、入络脑，还出别下项，连风府，故邪客其经，必令头项强痛也。而头痛之部位在后，与阳明头痛之在前，少阳头痛之在两侧，有明显区别。本条所说恶寒，包括恶风在内，又往往与发热并见。然恶寒与发热虽都是表证的主要征象，而恶寒尤为太阳表证的辨证要点。

二、病有发热恶寒者③，发于阳也④；无热恶寒者，发于阴也⑤。发于阳者七日愈，发于阴者六日愈，以阳数七，阴数六故也。

③病：此处指太阳病。

④阳：指太阳。

⑤阴：指少阴。

郑论：按太阳风伤卫证，发热、恶风、自汗。（伤寒）〔寒伤〕营证，发热、恶寒、无汗。此言病发于阳，指太阳也；太阳底面，即是少阴，病发于阴，指少阴也。若专指太阳营卫之阴阳，则与太阳风、寒两伤病情不符。余每临症，常见独恶寒身痛而不发热者，每以桂枝汤重加附子，屡屡获效，以此推之，则病发于阴，确有实据。至所言六日、七日者，是论阴阳之度数说法也。

【阐释】此节郑按与历代注家专指太阳营卫之阴阳有所不同。病发于阳，指太阳也。太阳底面，即是少阴，病发于阴，指少阴也。若专指太阳营卫之阴阳，则与太阳风寒两伤病情不符。随即举出其临症常见独恶寒身痛而不发热者，以桂枝汤重加附子而获效。笔者治恶寒身痛而出冷汗不止者，常用桂枝汤加附子、黄芪治之，数剂即愈。

三、太阳病，头痛至七日以上自愈者①，以行其经尽故也。若欲作再经者，针足阳明，使经不传则愈。

①头痛：下应有恶寒、发热、项强等症状，单举头痛是一种省文。七日以上自愈：这是指太阳经已经行完之故。

郑论：按此条言邪传七日自愈，各经皆能分消其势也。设若未尽，又复递传，针足阳明，预泄其气机，邪自无复传也。

【阐释】旧说伤寒日传一经，由太阳、阳明、少阳、太阴、少阴、厥阴，但此说前人已举出其谬误。郑氏在《医理真传》、《医法圆通》两书中亦指斥其非，并非一日二日挨次相传，日行则与传不同，是指本经，而非他经矣。至于针足阳明，使经不传，周禹载谓应针趺阳穴，陈修圆认为应针三里穴，可供临证选用。但承澹龢言趺阳穴不可用，足三里比较切于实际，以太阳病头痛发热等证，其血液大多奔放于表层与上部，“三里”一针能引血压下降，头部充血即趋下行，而头痛可愈，脑系之压迫遽减，生理机转可为之一变而汗出热解。承氏经验，当取“头维”、“足三里”、“内庭”诸穴，可确实收效于俄顷。

四、太阳病欲解时，从巳至未上。

郑论：此言风寒之轻者也，逢太阳旺时，亦可自解也。

【阐释】太阳为阳中之阳，而一昼夜之中，从巳时至未时，即上午十时至

下午二时，是阳气最旺之时，所以太阳病不论自愈或服药而解，都可以借助于阳气旺盛之时，这是古人从临症经验积累而获得的结论。

五、欲自解者，必当先烦，〔烦〕乃有汗而解，何以知之？脉浮，故知汗出（必）解（也）。后段

郑论：凡病欲解，胸中自有一段气机鼓动，先烦二字，即是鼓动机关，此间有自汗而解，战汗而解，狂汗而解，鼻血而解，从何得知，得知于脉浮耳。设脉不以浮应，又不得汗，其烦即为内伏之候，又不得以欲自解言也。

【阐释】郑氏在序中即说：“总之论其原文，发明圣意，即前后错乱，而原文终在也，学者亦不必论长论短则得也。”（以后此种错乱甚多，不再引郑氏原文）本条原列在条最末一段，郑氏移在此处，是承接前条之意。烦是正气抗邪气，欲作汗的先兆，邪正相争故烦，脉浮是邪在表的确据，故知汗出必解也。

六、太阳病，发热、汗出、恶风、脉缓者①，名为中风②。

①脉缓：王冰说：“缓者，缓纵之状，非动而迟缓也”。即应指柔和。

②中风，即现在的伤风，与后世方书所载猝然晕倒。口眼喎（wāi歪）斜的中风不同。

郑论：按太阳既为风邪所伤，风为阳邪，卫为阳道，两阳相搏，拂郁而热生，故见发热，风邪扰动，血液不藏，随气机而发泄于外，故见自汗，脉缓二字，指此刻正未大伤，尚得有此和缓之状，是亦病之轻浅说法也。

【阐释】本条指出太阳病中风的主证主脉。中风、伤风、感冒，名称虽异，但都是外感风邪，却是一致的，不过有轻重之不同。《证治要诀》说：“轻则为感，重则为伤，又重则为中，故《伤寒论》中的中风证，是伤风的重证，后世的感冒乃伤风中的轻证”。从而可以明确此条之中风，与《金匱》中风历节篇之中风不同，与后世杂病中的猝然仆倒，口眼 斜的中风，其涵义则迥异，绝对不可以混为一谈。

七、太阳中风，阳浮而阴弱③，阳浮者，热自发，阴弱者，汗自出。啬啬恶寒④，淅淅恶风⑤翕翕发热⑥，鼻鸣干呕者①，桂枝汤主之②。

③阳浮而阴弱：浮脉主风，阳也、表也，表邪实而里必虚，则阴自弱。简言之，即脉象浮弱。

④啬（sè瑟）音：形容怕冷畏缩之状。

⑤淅（xī希）淅，风声，如冷雨寒风侵入肌肤的感觉。

⑥翕（xī 吸）翕，病人自觉发热的情况，好像羽毛披复在身上一样。

①鼻鸣：鼻中窒塞，气息不利而发出的鸣响。呕而无物谓之干呕。

②主之：《伤寒论》文中凡言某汤主之，表示为最适当的首选方剂。宜某汤，表示类方中较适当的方剂，与某汤，表示无十分适当方剂，可试与之（以后上述诸种情况仿此，不另作注释）。

郑论：按阳浮阴弱四字，诸家俱以寸浮尺弱为定论。余细绎斯言，浮脉主风、阳也、表也，表邪实而里必虚，则阴自弱。风邪已据阳分，蹂躏于中，阴不敢与之抗，俯首听令，血淮随气机而外泄，故曰阳浮者热自发，阴弱者汗自出，啬啬、淅淅、翕翕，是形容病有难开、难阖、难解之状，至鼻鸣干呕四字，系属阳明，当于桂枝汤内加（甘）〔干〕葛、半夏，方为合法。

【阐释】本条是桂枝汤证的脉象和证状。郑氏释本条谓：“浮脉主风，阳也、表也，表邪实而里必虚，则阴自弱。至鼻鸣干呕，系属阳明”。此不同于过去诸家之注，是有见地的。至啬啬、淅淅、翕翕，是说明恶风、恶寒、发热同时并见的形容词。

桂枝汤方（校补）

桂枝三两（去皮）芍药三两甘草二两（炙）生姜三两（切）大枣十二枚（擘）上五味，口父咀三味③，以水七升，微火煮取三升④，去滓，适寒温⑤，服一升。服已须臾，歠热稀粥一升余⑥，以助药力。温复令一时许⑦，遍身皦皦微似有汗者益佳⑧，不可令如水流离，病必不除。若一服汗出病差，停后服，不必尽剂；若不汗，更服依前法；又不汗，后服小促其间⑨，半日许令三服尽。若病重者，一日一夜服，周时观之⑩。服一剂尽，病证犹在者，更作服。若汗不出，乃服至二、三剂。禁生冷、粘滑、肉面、五辛、酒酪、臭恶等物。

【方解及其应用范围】桂枝汤乃《伤寒论》之首方，为仲景群方之冠，乃滋阴和阳，调和营卫，解肌发汗之总方也。桂枝配芍药，是于发汗中寓敛汗之旨，和营中有调胃之功。生

③口父（fǔ 甫）咀：古代煎药，先将药料切碎为末，好像经过咀嚼似的，称之为口父咀。

④微火：取和缓不猛之火力，使不沸溢。

⑤适寒温：使冷热适当。

⑥歠：同啜，大饮也，就是大口喝之意。

⑦温复：复盖衣被，使周身温暖，以助出汗。

⑧𦵏（zhí 直）𦵏：形容微汗潮润之状。

⑨小促其间：缩短服药间隔时间。

⑩周时：一日一夜二十四小时之意。

五辛：《本草纲目》载：大蒜、小蒜、胡荽、韭、芸苔为五辛。

酪：指动物乳类。

姜味辛，能助桂解肌泄邪。大枣味甘，能佐芍和营益阴。甘草甘平，调和诸药，安内攘外，配伍最佳，故取效大。柯韵伯谓：“凡头痛发热，恶风恶寒，其脉浮而弱，汗自出者，不拘何经，不论中风、伤寒、杂病，咸得用此”。近代有医家诋毁本方者，咸谓古方不能治今病。本方之能治今病，已为临床所证实。兹举近代伤寒学家恽铁樵对用本方之标准，以供参考。其谓：“太阳病发热，形寒、头痛、项强、口中和，汗自出，始可用桂枝汤。口中和就是舌面润，舌质不绛，唇不干绛，不渴。如其口渴，舌干、唇绛，即是温病，桂枝是禁药。”故桂枝汤之可用不可用，在辨证之确切与否，诚所谓差之毫厘，失之千里矣。郑氏在《医法圆通》中说：“桂枝汤一方，乃调和阴阳，澈上澈下，能内能外之方，非仅治仲景原文所论病条而已”。随即指出“今人不明圣意，死守陈法，不改变通，由其不识阴阳之妙，变化之机也”。接着提出“桂枝汤方，原不仅治一伤风证，凡是太阳经地面之病，皆可用得。”并将经验病形，列出十条：（）治胸腹痛，背亦彻痛者，（）治通身寒冷；（）治小儿角弓反张，手足抽掣；（）脑后生疮；（）治周身皮肤作痒，时而恶风；（）治足跟痛，痛彻腰股；（）治小儿两腮肿，发热恶风；（）治小儿发热痘出；（）治妇人妊娠恶阻；（）治发热、恶风、下痢，日数十次。笔者师法郑氏，除用本方加减治疗上述诸病外，用以治伤风咳嗽，以及长期低热症，均获满意疗效；合玉屏散以治流行性感冒，有立竿见影之效。

近人用本方加减治鼻炎、多种皮肤病，疗效不错，主要是协调营卫的作用；又治风寒之邪内闭而足肿痛，痛彻腰股，或关节肌肉风寒痹而有汗者，均可用本方治疗。

八、桂枝本为解肌①，若其人脉浮紧，发热汗不出者，不可与〔之〕也，（须当）〔常须〕识此，勿令误〔也〕②。后段

①解肌：就是解散肌表之邪，也属发汗的范畴，但与开表发汗不同。

②“识”：此同“志”，记也。

郑论：此条明言桂枝汤，乃解太阳风伤卫之证，非治脉紧寒伤营者所宜。故曰：（须当）〔常须〕识此，勿令误。是教人辨明营卫风寒用药界限也。不知何故，称桂枝本为解肌，肌肉属阳明，非桂枝所宜，必是后人之误，应当削去解肌二字，而曰桂枝汤非脉浮紧者所宜，何等直切也。

【阐释】本条是《伤寒论》条后半段，郑氏作为单独一条处理，并云应当削去“解肌”二字，似有未当。桂枝汤的作用是和营解肌，适用于汗出恶风的表虚证。如果脉浮紧，发热而汗不出的表实证，就不能用此方，而麻黄汤则为对证之方也。

九、凡服桂枝汤吐者，其后必吐脓血也。

郑论：按桂枝汤本调和阴阳之祖方，何得云服桂枝汤吐者，其后必吐脓血也。当其时，胸中或有火逆，或有痰逆，或有郁热，得桂枝辛温助之，上涌而吐，理或有之。然亦有吐仍属佳兆者，理应细辨。设无火、痰、郁热诸逆，以后服之，未定吐脓血，学者切勿执此，当以认证为要。

【阐释】桂枝汤辛温助阳，是太阳中风的主方。设病非风寒，或阴虚而内热素盛，皆不能服。如误服桂枝汤，势将引起火热益甚，热盛则涌吐，甚则以后有吐脓血的可能。柯韵伯说：“桂枝汤不特酒客当禁，凡热淫于内者，用甘温辛热以助其阳，不能解肌，反能涌越，热势所过，致伤阳络，则吐脓血必也”。至于条文中的“吐”字和“必吐脓血”句，均当活看，主要应看误治的程度轻重来决定。若既吐脓血，则可按《金匱呕吐篇》所说：“不可治呕，脓尽自愈”。

亦可用桔梗甘草汤排脓解毒，《千金》苇茎汤去瘀生新，并可随证加入银花、连翘、败酱、鱼腥草等清热解毒之品。

十、〔若〕酒客病①，不可（以）〔与〕桂枝汤，得之则（吐）〔呕〕，以酒客不喜（甜）〔甘〕故也。

①酒客：指平素喜欢饮酒之人。

郑论：按酒客有喜甜食者，有不喜甜食者，不得执一而论。若酒客病桂枝汤证，而此方遂不可用乎？此是专为得汤则呕者说法也。

【阐释】嗜酒之人，平素湿热必重，虽患了脉缓汗出的中风证，不可用桂枝汤治疗。因桂枝辛温，能助其热，甘草、大枣味甘，能助其湿，湿盛则中满而呕。如郑氏所言：“酒客有喜甜食者，有不喜甜食者，不得执一而论”。事实上酒客亦有湿热

不甚，服用桂枝汤而不呕吐。如湿热素盛之人，虽不是酒客，亦要慎用。若酒客病桂枝汤证，可于桂枝汤方中加厚朴、杏仁治之。盖厚朴苦温以祛湿，杏仁之苦泄以清热，湿热去则不呕也。

十一、发汗后，水药不得入口为逆，若更发汗，必吐下不止。前段

郑论：病至水药不得入口，必有寒逆、火逆、水逆之别。此则因发汗后，明系发汗过多，以致亡阳，不能镇纳浊阴，以致阴邪僭居高位，隔拒胸中，宣布失职，气机不得下降，故有此候，若更汗之，则中气愈虚，而吐下更甚也，法宜扶阳、宣中、降逆为主。

【阐释】此条原文系《伤寒论》条之一段。此证胃阳素虚，夙有寒饮，发汗则伤其上焦之阳气，故水药不得入口，此为逆也。若更发汗，又伤其中、下焦之阳气，中焦伤而吐不止，下焦伤而利不止。如郑氏所言：“明系发汗过多，以致亡阳……若更汗之，则中气愈虚，而吐下更甚也。法宜扶阳、宣中、降逆为主。”笔者在临证中，常用附子理中汤加半夏、吴茱萸治之。

十二、太阳病，头痛、发热、汗出、恶风，桂枝汤主之。

郑论：此即太阳风伤卫证之候，桂枝〔汤〕的方，兹不赘。

【阐释】太阳经脉之循行，起于目内眦，上额、交巅，从巅入络脑，循项背而下。此节首提出头痛二字，知外邪客太阳最高之处，故太阳头痛，每在正中与头后部，与阳明、少阳头痛之部位不同。次言发热、汗出、恶风等证，乃太阳中风的候，此经病由上而下，故先言头痛，而次及项背也。其脉当为浮弱，舌苔当为薄白，桂枝汤乃适当之方也，

十三、太阳病，外证未解①，脉浮弱者，当以汗解，宜桂枝汤。

①外证：指表证而言，表证所指者狭，外证所指者广，实际并没有大的区别。

郑论：此条既外证未解，可以再汗，但脉浮弱，其正必虚，故不能助药力以祛邪外出，余意当于桂枝汤内，或加饴糖，或加附子，方为妥当。

【阐释】此条乃脉象浮弱，外证未解之治法也。若脉浮紧是为伤寒外证未解，又当用麻黄汤也。郑氏指出其正必虚，于桂枝汤内，或加饴糖，或加附子，以助药力祛邪外出，为其经验之总结。笔者对于体虚之人，或产妇漏汗不止，外感风寒之邪，皆用桂枝汤加附子以助药力，祛邪外出而愈。

十四、太阳病，发热汗出者，此为营弱卫强，故使汗出，欲救邪风者②，宜桂枝汤（主之）。

②救：驱散的意思。邪风：内经所谓：虚邪贼风。这里指作风邪解。

郑论：此条明是太阳为风邪所伤，卫分邪实，营分正虚耳。

【阐释】营卫在正常时，是相互协调的。太阳为风邪所伤，卫分邪实，故有汗；营分正虚，故无汗。弱言正气虚，强谓邪气实，即肌理不开，皮毛独疏之谓。惟其营弱，故里汗闭而不出，惟其卫强，故表汗独出也。故宜用桂枝汤救邪风之所伤，邪风去则卫气和，汗出止则营自复。

十五、病人脏无他病①，时发热自汗出②，而不愈者，此（为）卫气不和也。先其时发汗则愈，宜桂枝汤。

①脏无他病：指病不在里之义。

郑论：此条定是失于解表，不然，何得云先其时发汗则愈，宜桂枝汤耶？

【阐释】时发热，自汗出，颇似阳明，故曰脏无他病，以明其为表证也。《外台》云：“里和表病，汗之则愈”。本条先其时发汗则愈，系迎其气机而导之之意也。

十六、病常自汗出者，此为荣气和③，荣气和者，外不谐④，以卫气不共荣气谐和故（所）〔尔〕⑤；以荣行脉中，卫行脉外，复发其汗，荣卫和则愈，宜桂枝汤（则愈）。

②时发热自汗出：指间歇性发热，自汗出。

③荣气和：荣不病也。

④外不谐：外是“卫”的代称，即卫失调。

⑤谐和故尔：指卫气与荣气不协调。

郑论：按病常自汗，似不专主太阳荣卫不和，如果属太阳荣卫不和，亦必有恶风、畏寒足征。兹云自汗出，其中有素禀阳虚，或多言，或过用心，或稍劳动，而即自汗出者，皆在不足之例，尚敢轻用桂枝汤乎？此条大抵专主荣卫不和说法也，学者宜细求之。

【阐释】本条荣卫不和，不是由于外受风寒所致，而是由于荣卫本身不能互相协调的自汗出，不论是卫强荣弱或卫弱荣强，仍宜桂枝汤治疗。但郑氏深一层指出有素禀阳虚，或多言，或过用心，或稍劳动，而即自汗出者，皆在不足之例，不能用桂枝汤治疗，值得我们临证时审慎。然则如何治之，笔者认为郑氏所订之补坎益离丹为合拍之方。

十七、太阳病，初服桂枝汤，反烦不解者，先刺风池风府⑥，却与桂枝汤〔则〕愈。

⑥风池：穴名，在脑后（脑空穴外）发际中，在枕骨斜方凹陷中，足少阳胆经穴。风府：穴名，在项后入发际一寸，在枕骨与第一颈椎之间，是督脉经的穴位。

郑论：此条明言解表未透，邪未遽出，故见烦，刺风池风府穴者，泄其邪热，仍以桂枝汤，俾邪尽出无遗，故自愈也。

【阐释】太阳中风证，治以桂枝汤，病不解而反烦者，此药力未达，烦者，为正邪相争之现象。经云：大风颈项痛，刺风池。又曰：风从外入，令人振寒，汗出头痛，身重恶寒，刺在风府。此刺法之所本也。刺法所以泄其邪势，然后再服桂枝汤，俾邪尽出无遗而愈也。

十八、风家表解①，而不了了者②，十二日愈，原文

①风家：凡“家”字俱皆指宿病而言，此处应作太阳中风伤寒看。

②不了了：就是不清楚、不爽快之意。

郑论：既称表解，邪已去矣，应当清爽如常，此则不了了者，是邪去而正未复也。延至十二日者，俟正气渐渐复还也。

【阐释】表解还有不爽快的感觉，一是余邪还未全清，一是正气尚未全复，而预计十二日愈者，经尽之时，余邪尽，自然愈矣。亦有教人不必服药，当心静养就可渐渐痊愈的意思。本论中的日数，多是约略之词，必须灵活的领会其精神实质。

十九、中风发热，六七日不解而烦，有表里证③，渴欲饮水，水入则吐者，名曰水逆④，五苓散主之（多服暖水，汗出愈）。

③有表里证：表证指发热、恶风、汗出、脉浮等；里证指烦渴欲饮水，小便不利、水入即吐等。

④水逆：胃有停水，水气不化，渴欲饮水，水入即吐的意思。

郑论：此条既称六七日不解而烦，有表里证，应有表里证形足征，方为确论。况病形所见，全是太阳腑证，观于用五苓散方，是独重在太阳腑分一面，并未道及表证一面，原文何得称有表里证也。里证即太阳腑证也，即言外邪入腑，何等直切。况此刻病现饮水入口即吐，是因太阳之气化不宣，中宫之转输失职，气机升多降少，以致上逆而吐，用五苓散多服(一)，俾太阳之气化行，水道通，气机下降，自然逆者不逆，而吐者不吐也。学者宜细绎之。

(一)多服二字，定教人不可见其吐而遂不与之服也。

【阐释】本条中风发热，六七日经尽不解，此即表证；渴欲饮水，邪传里也，此即里证。郑注何得谓病形所见，全是太阳腑证？至郑氏所言太阳之气化不宣，中宫之转输失职，气机升多降少，以致上逆而吐，五苓散和表里，散停饮，故治之而愈，这是正确的。又原文五苓散主之后有“多服暖水，汗出愈。”舒本亦有此七字。但《伤寒论》原文无此七字，此系五苓散方后所载，舒、郑二氏竟移于原文之后，不识何故？

二十、太阳病，发汗后，大汗出，胃中干，烦（燥）〔躁〕不得眠，欲得饮水者，（少与之）〔少少与饮之〕，〔令〕胃气和则愈。若脉浮，小便不利，微热消渴者①，五苓散主之。

①消渴：形容渴饮不止的意思。《金匱》上的消渴是饮多少，小便多少，属于一种病名。本条之消渴是形容口渴甚，是一种症状，二者不可混同。

郑论：按太阳既发汗后，复见大汗出，汗为血液，血液过伤，胃中失养，故胃干，津液不能上下交通，故烦（燥）〔躁〕不得眠，欲得水饮者，少与之，令胃和则愈。盖水亦阴也，土燥得水以润之，自然燥者不燥，而病自见其愈也。若见小便不利，微渴者，是血液亡于外，而气化失于内也，主以五苓化太阳之气，气化一宣，则水道通，里气畅，升降不乖，病焉有不愈者乎？

【阐释】此节乃发汗伤津，胃与膀胱之救治不同也。郑氏谓：“汗为血液，血液过伤，胃中失养，故胃干。”此处称汗为血液，不能是一般所指之血液，而作为一种不能养荣之津液。胃中津液受损不足者，以致烦燥作渴，只须饮水以和胃气则愈，非五苓散证也。若脉浮，小便不利，微热消渴者，此膀胱气化不行也。

膀胱为太阳之腑，脉浮微热，太阳之表邪未尽，故用五苓散两解表里，小便利则水去渴止。用散而不用汤者，取药性直达于下也。

五苓散方（校补）

猪苓十八铢（去皮）泽泻一两六铢白朮十八铢茯苓十八铢桂枝半两（去皮）上五味，捣为散②以白饮和服方寸匕③，日三服，多饮暖水，汗出愈，如法将息。

②散：将药制成粉末，叫做散。

③白饮：即米汤。方寸匕：是古代餐具之一，曲柄浅斗，状如今之羹匙。《名医别录》云：“方寸匕者，作匕正方一寸，抄散不落为度。”

【方解及其应用范围】本方功专利水，乃化气行水之剂。《伤寒论》太阳腑分之主方也。茯苓甘温，助阳益脾，淡渗利窍，除湿，色白入肺，泻热而下通膀胱。猪苓甘淡，入肺而通膀胱，利便行水与茯苓同。泽泻甘淡微咸，入膀胱，利小便，功专祛湿行水。三者皆有导水下行，通行小便之功。益土所以制水，故以白朮健脾去湿。最妙在桂枝一味，化膀胱气机，使膀胱津液得以通调，外则输津于皮毛，内则通行于上下，自然小便利，口渴除。观方后云：“多饮暖水，汗出愈”，则本方不但有利水之功，且有发汗作用；要知如五苓散者，也可为太阳经腑两解之方也。本方现多改作汤剂。至于本方之应用，《伤寒论》列为太阳腑证之主方，治疗口渴、小便不利、膀胱蓄水、表里上下同病。郑氏在《医法圆通》中更用以：（1）治大便泻水，而小便全无者；（2）治头晕、咳嗽、呕吐、腹胀、小便短；（3）治霍乱吐泻，思饮冷水者。以上三症，本非此方所治之病，因其有无小便及小便短的证状，故能治之而愈，可谓善于运用成方。笔者曾用此方治腹水胀满。患者腹部胀满，食欲不振，食后胀满更甚，虽口干而不思饮水，小便短少，人困无神，舌苔白腻，脉沉数而滑。此脾失健运，气化不行，水湿阻滞，用五苓倍桂、朮，再加上桂以化膀胱之气，气行水即行，加椒目专行水道以消水胀，而腹胀之症即愈。又伤湿咳嗽之症，肌肉隐黄，头眩，痰涎及泡沫痰特多，腕中不畅，有时呕吐清水，身体倦怠，小便不利，口中津液多，虽渴不欲饮水，舌苔白腻，脉沉细而滑。系因膀胱气机不利，湿邪反上干清道而咳，则须以渗利为主，五苓散加味治之。痰饮咳嗽其根本由于水饮所致，祛其水饮则咳嗽自愈，如中腹胀满，上气喘逆，二便不利，或四肢俱肿者，此为痰水壅滞，五苓散能上下分消其痰水，治之而愈。近人加减推广应用本方，凡属津液运行失调的病症，均可以用此加减施治而获效。

二十一、太阳病发汗，汗出不解，〔其〕人仍发热，心下悸①，头眩身瞤〔动〕②，振振欲擗地者③，真武汤主之。

①心下悸：即心下筑筑跳动。

②身瞤（shùn顺）动：即全身筋肉跳动之意。

③振振欲擗（pǐ 匹）地：就是站立不稳，摇摇欲坠的样子。

郑论：按发汗原是解表，表解自然热退，乃不易之理，今汗出而热仍然，所现种种病形，非表邪未透之征，却是亡阳之候，必是因发汗过度，伤及肾阳。太阳底面，即是少阴，此际发热者，阳越于外也，心下悸，头眩身瞤者，阳气外亡而群阴僭上也。振振欲擗地者，阳欲藏而不得也。夫先天之真阳，喜藏而不喜露，藏则命根永固，露则危亡立生，主以真武汤，是重藏阳之意也。

【阐释】郑氏所按，大有卓见，与成无己、张隐庵、陈修圆等之注“仍发热”为邪气未解也，太阳之病不解也等不同。郑氏说：“所现种种病形，非表邪未透之征，却是亡阳之候，必是因发汗过度，伤及肾阳。太阳底面，即是少阴，此际发热者，阳越于外也，心下悸、头眩、身瞤者，阳气外亡，而群阴僭上也；振振欲擗地者，阳欲藏而不得也。”实即发汗过度，损及肾阳，主以真武汤，是温经复阳之意，使阴气不上逆为病也。（真武汤方，载少阴篇）

二十二、太阳病，〔发汗〕，遂漏不止①，其人恶风，小便难②，四肢微急③，难以屈伸者，桂枝加附子汤〔主〕之。

①漏：渗泄不止的意思，在这里形容汗多。

②难：不通畅的意思。

③急：拘急，即屈伸运动不自如。

郑论：按发汗而至漏不止，其伤及肾阳也明甚。太阳底面，即是少阴，其人恶风者，外体疏也，小便难者，汗为水液，气化行于外，而不行于内也。四肢微急，难以屈伸者，血液外亡，而筋脉失养也。

此际理应以扶阳为是，原文取桂枝加附子汤，意在用附子，取内以固其根蒂，得桂枝，外以祛其未尽之邪，内外兼备，斯无大害，庶不失立方之妙也。

【阐释】太阳病的治法，虽然以发汗为主，但以粳粳汁出为佳。今发汗太过，遂漏不止，乃伤及肾阳，肾与膀胱为表里，肾阳衰则膀胱寒结，故小便难。四肢为诸阳之本，不得阳气以养之，故微急，且至难以屈伸者。郑氏谓：“用附子内以固其根蒂，得桂枝外以祛其未尽之邪，内外兼备。”此乃发汗太过，导致阳虚液脱救逆之法也。

桂枝加附子汤方（校补）

桂枝三两（去皮）芍药三两甘草三两（炙）生姜三两（切）大枣十二枚（擘）附子一枚（炮、去皮、破八片）上六味，以水七升，煮取三升，去滓，温服一升。本云桂枝汤，今加附子，将息如前法。

【方解及其应用范围】桂枝汤乃仲景群方之冠，乃滋阴和阳，调和营卫之方也，加附子复阳固表，适用于汗出过多，阳气受耗，津液暂亏的证候。盖表阳密，则漏汗自止，恶风自罢矣；汗止津回，则小便自调，四肢自柔矣。笔者常用此方治产妇体虚，其脉浮细，舌质淡，苔薄白，漏汗不止，获得良好效果。又治阳虚体弱之人患伤风感冒，大都面容苍白，头痛，倦怠乏力，恶风寒，舌质淡白，白腻苔，脉浮而细，亦取得满意疗效。近人推广应用以治阳虚之鼻衄（nǚ女去声）、便血、尿血或妇人带下经漏者；阳虚而筋脉失养之证，如腰背拘急酸痛、中风半身强直、手足痿弱者。

二十三、太阳〔病〕中风，以火劫发汗，邪风被火热，血（液）〔气〕〔流溢〕，失其常度，两阳相熏灼①，其身发黄。阳盛则欲衄②，阴虚小便难③，阴阳俱虚竭④，身体则枯燥，但头汗〔出〕，剂颈而还，腹满（而）〔微〕喘，口干咽烂，或不大便，（人）〔久〕则谵语，甚者至哕，手足（燥）〔躁〕扰，捻衣摸床⑤，小便利者，其人可（至）〔治〕。

①两阳：风为阳邪，火亦属阳，中风用火劫，故称两阳。

②阳盛：指邪热炽盛。

③阴虚：指阴津不足。

④阴阳俱虚竭：指气血亏乏而言。

⑤捻衣摸床：神志昏迷时，手不自觉的摸弄衣床。

郑论：据此条所见种种病形，都缘误用火劫发汗，遂至亢阳为灾，邪火燎原，竟有不可扑灭之势，但视其人小便尚利，一线之元阴犹存，故曰可治。若小便全无，则元阴已尽，危亡即在转瞬之间。

【阐释】本条乃太阳病中风，被火误治后的各种变证，风火相煽，真阴有欲亡之候。揭出小便利一语，从而可知津液尚未尽竭，为此证之生机。如郑氏所说：“但视其人小便尚利，一线之元阴犹存，故曰可治。”邪盛正虚之候，以小便的有无来决定预后良否，是可靠的经验总结。笔者认为其治法应清里热、滋阴液、利小便，可用白虎加人参汤或猪苓汤治疗。

二十四、太阳病二日，反（烦）〔躁〕，（反）〔凡〕熨其背⑥，而大汗出，（火）〔大〕热入胃，胃中水竭，（烦燥）〔躁烦〕，必发谵语，十余日振栗自下利者，此为欲解也。故其汗，从腰以下不得汗，欲小便不得，反呕欲失溲，足下恶风，大便鞭，小便当数，而反不数及〔不〕多，大便已，头卓然而痛⑦，其人足心必热，谷气下流故也⑧。

⑥熨：火热疗法之一。千金方有熨背散，民间有以砖烧热，外以布包放置体外以取暖发汗的。

⑦卓然而痛：即突然头痛得很厉害的意思。

⑧谷气：指人饮食以后所产生的热气。

郑论：按太阳二日，系阳明主气之候，邪已入胃，应当察其邪从阳化为病，从阴化为病，随其所化而治之，方为合法。粗工不知，反熨其背而大汗出，火热入胃，势必夺其胃中津液，津液被夺，则邪热炽，热乘于心，神无所主而谵语生，邪延十余日，忽振栗自下者，是里热下行，病有从下解之意，其汗从腰以下不得，欲小便不得者，太阳气化不宣，津液被热夺也。反呕者，气机上逆也。欲失溲，而足下恶风，下元之气不足也。迨至大便多，则里气畅，头卓然而痛，是邪仍欲从三阳表分而出，足下必发热者，阳气复回之征，皆佳兆也。

【阐释】本节论述误用火治（即熨背）后的变证，阳气上盛，阴液受损，及自愈的机转。郑氏注文甚详，说理亦明透，当今用熨法治病者甚少，故从略。

二十五、太阳病，以火熏之，不得汗，其人必（燥）〔躁〕，（过）〔到〕经不解，（为）〔必〕圜血①，名为火邪。

①圜（q ī ng青）血：即便血也。

郑论：太阳为病，本应外解，今以火熏不汗而反（燥）〔躁〕，是邪不从外出，而从内趋也。火动于中，逼血下行，而成圜血之候，亦时势之使然也。

【阐释】此邪不从外出，而从内趋也。火动于中，逼血下行，而成圜血之候。此证由火误引起，便血时但治其火，不必止血，火清邪去，其病自愈。仲景未出方治，至于救误的方法，自不外清解血热，大黄黄连泻心汤加黄芩，可以采用。

二十六、微数之脉，慎不可（灸）〔灸〕，因火为邪，则为烦逆，追虚逐实②，血散脉中③，火气虽微，内攻有力，焦骨伤筋④，血难复也。上段

②追虚逐实：血本虚而更加火法，劫伤阴分，是为追虚；热本实，而更用火法，增加里热，是为逐实。

③血散脉中：火毒内攻，血液流溢，失其常度。

④焦骨伤筋，形容火毒危害之烈，由于血为火灼，筋骨失去濡养，故曰焦骨伤筋。

郑论：据脉微数，数主有热，故不可（灸）〔灸〕，若妄（灸）〔灸〕之，则为害不浅，故见种种病形，此是为有余之候言之，而非为不足者言之。病人苟现面白唇青，舌润不渴，小便清利，脉现洪大、洪数、弦劲，此系元阳外越之候，回阳又虑不及，尚得以不可（灸）〔灸〕言之乎？余思原文加一慎字，此中隐已包括虚实两法在于中也。

【阐释】灸有隔姜而灸，隔蒜而灸之别。必其人寒湿内阻，阳气不达，关节酸疼者，乃可灸之。微数之脉，阴虚多热也。若用灸法，则火热亢灼，造成诸多变证。但郑氏举出：“病人苟现面白唇青，舌润不渴，小便清利，脉现洪大、洪数、弦劲，此系元阳外越之候，回阳又虑不及，尚得以不可灸言之乎？”故应脉证合参，不能单凭脉以辨证。加一“慎”字，不可轻易读过。

二十七、烧针令其汗①，针处被寒，核起而赤者，必发奔豚②。气从少腹上冲〔心〕者，灸其核上各一壮③，与桂枝加桂汤，更加桂〔二两〕也。

①烧针：就是用粗针外裹棉花，蘸油烧之，俟针红即去棉油而刺入，是古人取汗的一种治法。

②奔豚（tún如屯）：在此处是形容悸气自小腹上冲心胸之势，与肾积为奔豚之义不同。

③灸其核上各一壮：在针刺部位的肿块上，各用艾火灼烧一次（一壮就是灸一个艾丸至烬）。

郑论：烧针者，温经御寒法也。针处被寒，核起而赤者，寒邪聚于皮肤，有欲从外出之势也，何得云必发奔豚？奔豚乃少阴之证，此刻邪在太阳，未犯少阴，即以桂枝加桂汤更加桂，其邪在太阳也明甚，果属奔豚上冲，又非桂枝加桂倍桂所长也，学者宜细绎之。

【阐释】按烧针取汗，亦是汗法之一，但针处宜当避寒，若不慎而被寒袭，则针处核起而赤者，必发奔豚。郑氏注谓：“此寒邪聚于皮肤，有欲从外出之势，何得云必发奔豚？”此刻邪在太阳，未入少阴，即不得为奔豚之证。灸其核上各一壮，以

散外寒，与桂枝加桂汤更加桂，是即先刺风池、风府，却与桂枝汤之成例，盖必疏泄高表之气，然后可以一汗而奏功。

桂枝加桂汤方（校补）

桂枝五两（去皮）芍药三两生姜三两（切）甘草二两（炙）大枣十二枚（擘）上五味，以水七升，煮取三升，去滓，温服一升。本云桂枝汤，今加桂满五两，所以加桂者，以能泄奔豚之气也。

【方解及其应用范围】本方由桂枝汤加重桂枝用量而成，为散寒降冲，和荣止痛之剂。桂枝汤调和荣卫，加重桂枝用量增加通阳降冲之力（但亦有用肉桂者）。盖本证为心阳虚，感寒，不能制水，水寒之气上逆，故自觉气上冲心胸。此处奔豚气病与《金匱》奔豚病之义不同。故凡自觉寒气自小腹上冲之症，皆可用之。

二十八、太阳病，当恶寒发热，今自汗出，〔反〕不恶寒发热，关上脉细数者，以医吐之过也。一〔二〕日吐之者，腹中饥，口不能食；三四日吐之者，不喜糜粥，饮食冷〔食〕，朝食暮吐，〔以医吐之〕所致〔也〕，此为小逆④。

④小逆：是属误治而引起的病变，但尚不十分严重的意思。

郑论：此条既无发热恶寒，则无外邪可知，咎在医家误吐之过，屡吐不止，渐至朝食暮吐，其胃阳之衰败已极，原文称为小逆，学者不得遽谓之小逆也。

【阐释】此条为太阳病误用吐法而引起胃中虚寒，关于一二日、三四日者，说明发病时间的长短，对胃的影响有轻重不同，严重的朝食暮吐，原文称此为小逆。郑注谓：“学者不得遽谓之小逆也。”有深意焉。笔者对治此证，轻者用理中汤，重者用附子理中汤，皆加半夏、吴茱萸治之，获得满意效果。

二十九、太阳病吐之，但太阳病当恶寒，今反不恶寒，不欲近衣，此为吐〔之〕内烦也①。

①内烦：即心中烦闷之意。

郑论：按吐治法，亦寓发散之意，但无恶寒，则不得为太阳证，不欲近衣，内定有热，而曰吐内烦，是此病形，全是吐之过，何也？吐则气机发外，有不可禁止之势，故现此内烦，俟气定神安，而能近衣，则病自愈。若气定而仍不欲近衣，则又不得以吐内烦称之也，学者宜细辨之。

【阐释】本条与上条同为太阳病误吐所致的病变，可是出现的证状，却不完全一样

。本条的内烦不欲近衣是胃液受伤，胃热化燥，误吐虽同而病变各异，其治疗方法也就随之不同。据《医宗金鉴》：“惟宜用竹叶石膏汤，于益气生津中清热宁神”，于理于法皆合，可以采用。

三十、太阳病，外证未解（者）②，不可下也，下之为逆。欲解外者，宜桂枝汤。

②外证：此处指表证。

郑论：按病当外解者，原不可下，下之则引邪深入，为害不小。

病机果有向表之势，随机而导之，则得矣。

【阐释】表证当解外，里证当攻下，此一定不易之法。郑氏云：“病当外解者，原不可下，下之则引邪深入，为害不小。”非但外邪未解可用桂枝汤，即虽经误下，而邪欲还表者，仍可用桂枝汤随机而导之则愈。

三十一、太阳病，先发汗不解，而复下之，脉浮〔者〕不愈。浮为在（表）〔外〕，而反下之，故令不愈。今脉浮，故（知）在外，当须（发汗）〔解外〕则愈，宜桂枝汤。

郑论：按随机调理，乃医之道，如当外解而反下之，当下而反表之固之，皆医之咎。此条既下而脉尚浮，是邪不从下趋，而仍欲从外出，故仍用桂枝汤以导之，此真用药法窍，学者宜留心记之。

【阐释】脉浮是邪在表的主要依据，不论汗后、下后，只要脉浮（应结合头痛、发热、汗出、恶风）等表证依然存在的，那就应当再汗、三汗。本条论发汗后表未解，疑其邪已入里，而复下之，下之而不愈，脉浮等表证依然存在的，则仍当以桂枝汤解外。

三十二、太阳病，下之〔后〕，其气上冲者①，可与桂枝汤，方用前法。若不上冲者，不（可）〔得〕与（也）〔之〕。

①其气上冲：是病人自觉胸中有逆气上干。

郑论：按应外解之病，而误下之，脉浮，邪仍在表者，俱可以桂枝汤。若因下而病现上冲，此间须宜详察。盖以为上冲者，病邪欲外，故仍以桂枝汤，不冲者，邪不外出，故不可与。谓上冲而脉浮，可与桂枝汤，上冲而脉不浮，不可与。然上冲之候，多因误下伤及胸中之阳，不能镇纳下焦浊阴之气，以致上冲者极多，法宜收纳温固，又非桂枝所能也。学者务于病情、脉息、声音、动静、有神、无神处求之，

则得其要矣。

【阐释】太阳病，头项强痛而恶寒、脉浮，本应从表解，如误用下法，病若不因下而变证，其脉浮、头痛等之病证依然，病者自觉气上冲者，知正气未衰，邪犹在表，可与桂枝汤，用前之啜粥微汗法治之。若下后气不上冲，是邪已内陷，正气虚，桂枝汤已不适用。而郑氏更深一层注“上冲之候”，其谓“上冲之候，多因误下伤及胸中之阳，以致上冲者极多，法宜收纳温固，又非桂枝之所能也。”

此与过去诸名家之注不同，值得我们细心体会。

三十三、太阳病，外证未除，而数下之②，遂协〔热〕而利③，利下不止，心下痞鞭，表里不解者，桂枝人参汤主之。

②数下：指屡用攻下的意思。

③协热而利：就是在里之虚寒，挟在表之热而下利。

郑论：按下利本非正病，因子下而致之也，痞鞭亦非本有之病，因过下伤中，阴邪得以僭居高位也。以桂枝人参汤治之，方中药品，乃理中汤全方，加桂枝一味耳。不名理中，而名桂枝加人参汤者，重太阳之意，全是温中化气，补中祛邪之法也。

【阐释】太阳病外证未解，仍然存在发热恶寒、头疼身痛等表证，本应从表解，但一再误下，脾胃受损，遂导致外有表热，而内则虚寒下利不止的证候，因过下伤中，故胸院之间痞塞坚硬。主以桂枝人参汤，故以理中汤治痞鞭与下利，仅用桂枝一味以和表，而桂枝合理中同用，亦能增强温里之力，故郑氏曰：“不名理中，而名桂枝人参汤者，重太阳之意，全是温中化气，补中祛邪之法也”。

桂枝人参汤方（校补）

桂枝四两（别切）甘草四两（炙）白朮三两人参三两干姜三两上五味，以水九升，先煎四味，取五升，内桂，煮取三升，去渣，温服一升，日再，夜一服。

【方解及其应用范围】本方由理中汤加桂枝，不曰理中，而曰桂枝人参汤者，言桂枝与理中表里分头建功也。本方治下后成利，肠胃虚寒，故以人参、干姜、白朮、甘草助阳于内以止利；表证未除，故以桂枝行阳于外以解表。桂枝应迟入药。本方适用于理中汤证兼有表证者，以里证为主。凡肠胃虚寒，头痛、发热恶寒皆宜。

三十四、太阳病，桂枝证，医反下之，利遂不止。脉促者①，表未解也；喘而汗出者，葛根黄芩黄连汤主之。

①脉促：其义为脉势急促，是阳气被抑而求伸的现象

郑论：按本应表解可了之病，而反下之，引邪深入，利遂不止，此刻邪陷于下，若恶风、自汗、身疼仍在者，可与桂枝加葛根汤救之，俾邪复还于表，不治利而利自止，此以葛根黄连黄芩汤，是为脉促、喘、汗，有邪热上攻者言之，故用芩、连之苦寒以降之、止之，用葛根以升之、解之，俾表解热退而利自愈，是亦正治法也。余谓只据脉促、喘、汗，未见有热形实据，而以芩、连之品，冀其止泻，恐未必尽善。夫下利太过，中土业已大伤，此际之脉促者，正气伤也；喘者，气不归元也；汗出者，亡阳之渐也。况喘促一证，有因火而喘者，必有火邪可征；有因外寒促者，亦有寒邪可验；有因肾气痰水上逆而致者，亦有阴象痰湿可证。虚实之间，大有分别，切切不可死守陈法，为方囿也。

【阐释】郑氏对此节所解，前半段与成无己等历代往家大同小异，与葛根芩连汤散表邪，除里热，是为正治法也。而其精义则在“下利太过，中土业已大伤，此际之脉促者，正气伤也；喘者，气不归元也；汗出者，亡阳之渐也。”此属危证，回阳尚虑不及，而用葛根芩连汤散表邪，清里热耶？况喘促一症，有因火而喘者，可用白虎加人参汤治之；有因外寒束者，可用麻黄汤治之；有因肾气痰水上逆而致者，可用真武汤治之。诚如郑氏所说：虚实之间，大有分别，切切不可死守陈法，为方囿也。

葛根黄连黄芩汤方（校补）

葛根半斤甘草二两（炙）黄芩三两黄连三两上四味，以水八升，先煮葛根，减两升，内诸药，煮取二升，去滓，分温再服。

【方解及其应用范围】本方以葛根为主药，轻扬升发，芩、连苦寒清里，甘草甘缓和中，善能清热止利。至于应用：一、里热腹泻，略兼表邪，可治痢证初起而发热恶寒者。二、治不恶寒之温热病，为温病辛凉轻剂。近代推广应用治疗所有的肠道感染疾患，有良好疗效。

三十五、太阳病，下之〔后〕，脉促①，胸满者，桂枝去芍药汤主之；若微（恶）寒者〔桂枝〕去芍药加附子汤主之。

①脉促：即是脉搏很急促的形状，诊察时手指下感觉得脉搏的波动相当躁急。

郑论：按太阳果属可下，下之，俾邪从下解之法也，何致脉促胸满？必是下伤胸中之阳，以致阴气上逆而为胸满脉促，亦气机之常，理应扶中降逆，原文以桂枝去芍药者，是取姜、桂之辛散，草、枣之补中，而虑芍药阴邪之品以助邪，故去之，立法颇佳。若微恶寒，于汤中去芍加附子，亦是步步留神之意，煞费苦心。

【阐释】太阳病误下，脉促与胸满并见，此阳气被遏而欲伸，病邪仍有外出之势。郑注谓：“必是下伤胸中之阳，以致阴气上逆而为胸满脉促，亦气机之常，理应扶中降逆”。笔者认为桂枝去芍药汤不可用，扶中降逆可选用理中汤加半夏、砂仁为宜，若微恶寒者，是卫阳虚的确据，故宜前方加附子治之。

桂枝去芍药汤方（校补）

桂枝三两（去皮）甘草二两（炙）生姜三两（切）大枣十二枚（擘）上四味，以水七升，煮取三升，去滓，温服一升。本云桂枝汤，今去芍药，将息如前法。

桂枝去芍药加附子汤方（校补）

于上方内加附子一枚（炮、去皮、破八片）上五味，以水七升，煮取三升，去滓，温服一升。本云桂枝汤，今去芍药加附子，将息如前法。

【方解及其应用范围】桂枝去芍药汤由桂枝汤去芍药组成，方中桂枝、甘草温通心胸之阳，生姜宣通卫阳，甘草、大枣补中益气而滋荣阴，四味皆属辛甘温之品，组成专事辛甘化阳之方。去芍药者，为其阴药，恐益阴而减辛甘化阳之力也。胸阳得振，自能鼓邪外出，则脉促、胸满除。加附子温肾阳，合之成温补心肾之剂，正可治阳虚较重，证见脉微，恶寒甚，胸满者。上两方可推广用之治疗阳虚感冒、胸痹、痰饮咳嗽、哮喘等证；亦可治疗关节疼痛。笔者更用以治心脏病、高血压等，亦获得良好疗效。

三十六、太阳病，下之微喘者，表未解〔故〕也。桂枝加厚朴杏子汤主〔之〕。喘家作①，桂（子）〔枝〕汤加〔厚朴〕杏（仁）〔子〕佳。、

①喘家：指素患喘病的人。

郑论：按外邪蔽束肺气，法宜解表，表解已，则气顺而喘自不作。此云下之微喘，是喘因下而始见，非不下而即见，明明下伤中土，阳不胜阴，以致痰饮水湿，随气而上，干犯肺气而喘证生，又非桂枝、厚朴、杏子所宜也，学者当详辨之。余思太阳表邪，发热、恶寒、微喘，未经下者，此方实为妥切，若经下后，无发热、恶寒、与脉未浮者，此方决不可施，当以扶阳降逆为要。

【阐释】此条《伤寒论》原书作两条，前段为条：“太阳病，下之微喘者，表未解也”。是喘因下而始见，但发热、恶风、头痛等证依然，知其表证仍在未解故也。后段为条：“喘家作，桂枝汤加厚朴、杏子佳”。此为素有喘病的人患外感，即有发热、恶风、头痛等证。两者均可于解表药中加厚朴、杏仁以下气平喘。至郑氏所云：“下之微喘，明明下伤中土，阳不胜阴，以致痰饮水湿，随气而上，干犯肺气

而喘证生，又非桂枝厚朴杏子所宜也。”其说为不可从。

桂枝加厚朴杏子汤方（校补）

桂枝三两（去皮）甘草二两（炙）生姜三两（切）芍药三两大枣十二枚（擘）厚朴二两（炙、去皮）杏仁五十枚（去皮尖）上七味，以水七升，微火煮取三升，去滓，温服一升，复取微似汗。

【方解及其应用范围】本方由桂枝汤加厚朴、杏仁组成。桂枝汤以和荣卫解表邪，厚朴宽中下气消痰，杏仁宣肺降气平喘。适用于原有咳喘而又因感冒新邪者。但其见证，必具桂枝汤证如头痛、发热、恶风、脉浮等，兼有喘息者，方为适宜。

三十七、太阳病，下之，其脉促，不结胸者，此为欲解也。脉浮者，必结胸（也）；脉紧者，必咽痛；脉弦者，必两胁拘急；脉细数者，头痛未止；脉沉紧者，必欲呕；脉沉滑者，（必）协热利；脉浮滑者，必下血。

郑论：按既经下后，邪从下趋，里气既通，则表气宜畅，病亦立解。以脉促不结胸为欲解，意者不结胸为内无邪滞，脉促为邪欲外出，亦近理之论。通条又何必举某脉必现某病耶？夫脉之变化无穷，现证亦多不测，学者亦不必执脉以求病，总在临时随机应变为是。

【阐释】太阳病，用下法治疗，是属误治，但太阳病下之后，其脉促，又不结胸，此里和而不受邪，则太阳表气不因误下而陷，反欲上冲，此邪在表，为欲解也。全条又通过脉诊来断病，而不结合望、闻、问三法以论病，是不恰当的。

故郑氏曰：“夫脉之变化无穷，现证亦多不测，学者不必执脉以求病。总在临时随机应变为是。”斯为得矣。

三十八、太阳病不解，热结膀胱，其人如狂①，血自下，下者愈。其外不解者，尚未可攻，当先解〔其〕外，外解已，但少腹（结急）〔急结〕者①，乃可攻之，宜桃核承气汤。

①如狂：是狂而不甚，较发狂为轻。

①少腹：脐以下腹部称少腹，亦称小腹。一说脐以下称小腹脐两旁称少腹。

郑论：按太阳蓄血，其人如狂，理应化气从小便以逐瘀，此既已趋大肠，血自下，故断其必自愈。但外邪未解者不可攻，恐攻而邪下陷也。外邪既已解，而独见少腹急结者，是瘀尚未尽也，故可以逐瘀攻下之法施之，方不致误。鄙意以桃仁承气汤

，乃阳明下血之方，而用之于太阳，似非正法，理当分别处究，血从大便则宜，血从小便则谬，学者宜细心求之，庶不误人。

【阐释】太阳病表病不解，邪热与瘀血互结在下焦少腹部位，以致造成蓄血的证候。一是血结较浅，血被热邪所迫，其所蓄之血，方能够自下，邪热亦可随瘀血下趋而解除；一是病情较重，邪热与瘀血相结不解，血不能自下，势非用攻下药不可。但表证没有解除的，就不可先攻下，因为表里同病，里证实的当先解表，是伤寒治法的定例。解表可用桂枝汤；然后才针对里热证，处以桃核承气汤。膀胱腑之卫为气分，营为血分。热入而犯气分，气化不行，热与水结者，谓之犯卫分之里，五苓散证也。热入而犯血分，血蓄不行，热与血结者，谓之犯营分之里，桃核承气汤证也。二方皆治犯本之剂，而一从前利，一从后攻，水与血主治，各不同也。故郑氏说：“血从大便则宜，小便则谬。”可谓洞悉窍要。

桃核承气汤方（校补）

桃仁五十个（去皮尖）大黄四两桂枝二两（去皮）甘草二两（炙）芒硝二两上五味，以水七升，煮取二升半，去滓，内芒硝，更上火微沸，下火，先食温服五合，日三服，当微利。

【方解及其应用范围】本方为调胃承气汤加桃仁、桂枝，为破瘀逐血之剂。大黄之苦寒，荡实除热为君，芒硝之咸寒，入血软坚为臣；桂枝之辛温，桃仁之辛润，擅逐血散邪之长为使；甘草之甘，缓诸药之势，俾去邪而不伤正为佐也。除治少腹急结，其人如狂，小便自利的下焦蓄血证外，笔者推广以治阳虚体质的妇女月经不调，先期作痛者有良效。近代用之不仅可治瘀血，也能治出血；不仅治下部之瘀血出血，也能治上部之瘀血出血。

三十九、太阳病六七日，表证仍在，脉微而沉，反不结胸，其人发狂者，以热在下焦，少腹当鞭满，小便自利者，下血乃愈。所以然者，以太阳随经，瘀热在（表）〔里〕故也①，抵当汤主之。

①太阳随经，瘀热在里：就是太阳本经邪热，由表入里，并未传入他经，但蓄于下焦血分的意思。

郑论：按此条所现，实属瘀热在腑，理②应以行血之品，从腑分以逐之，方于经旨不错，此以抵当汤治之，较前颇重一格，取一派食血之品以治之，俾瘀血去而腑分清，其病自愈。此方可为女科干血癆对症之方也。但此方施于果系腑分有瘀血则宜，蓄血则谬；干血则宜，血枯则谬。总在医家细心求之，否则方不可轻试也。

②“理”：原书为“里”

【阐释】太阳随经瘀热在里，深入下焦，与血搏结而成蓄血之证，实属瘀热在腑，自应以行血之品，从腑分以逐之。郑氏曰：“此方可为女科干血癆对症之方也。”所谓干血癆者，多见于妇女。因五劳所伤，虚火久蒸，干血内结，瘀滞不通，久则瘀血不去，新血难生，津血不能外荣。症见经闭不行，身体羸瘦，不思饮食，骨蒸潮热，肌肤甲错，面目黯黑等。继而郑氏又言：“此方施于果系腑分有瘀血则宜，蓄血则谬，干血则宜，血枯则谬”。确属经验有得之言，殊堪宝贵。

抵当汤方（校补）

水蛭三十条（熬）虻虫三十个（去翅足熬）桃仁二十个（去皮尖）大黄三两（酒洗）上四味，以水五升，煮取三升，去滓，温服一升，不下更服。

代抵当汤桃仁归尾生地肉桂大黄芒硝穿山甲

【方解及其应用范围】本方为行瘀逐血的峻剂，药力猛于桃核承气汤，方中除大黄桃仁外，更有水蛭、虻虫，水蛭即蚂蝗，虻虫是牛马身上之蝇也。二味食血去瘀之力，可以直入血络。惟水蛭、虻虫二药，人所罕用，王肯堂《证治准绳》中，订代抵当汤（丸）：桃仁、生地、归尾，润以通之；肉桂热以动之；大黄、芒硝以推荡之；穿山甲引之以达瘀所也。代抵当汤常用于热与瘀血结于下焦有症瘕积聚者，以及妇人经水闭滞者，对肝脾肿大等有一定疗效。

四十、太阳病身黄，脉沉结，少腹鞭，小便不利者，为无血也。小便自利，其人如狂者，血证谛也①，抵当汤主之。

①谛（dì 帝）：审也，证据确实的意思。

郑论：按此条只以小便之利与不利，判血之有无也。其人少腹满而小便不利者，是蓄尿而非蓄血也；若少腹满而小便利，其人如狂者，蓄血之验也。苟其人不狂，小便利而腹满，别无所苦，则又当以寒结热结下焦处之，分别施治，庶可言活人也。

【阐释】本条承上条辨蓄血与蓄水证。若其人少腹满而小便不利，是太阳腑证中之蓄水证，治以五苓倍桂。若少腹满而小便利，其人如狂，此非膀胱蓄水，是蓄血也，所以仍用抵当汤破瘀逐血。郑氏曰：“苟其人不狂，小便利而腹满，别无所苦，则下焦又有寒结热结之分。”笔者认为寒结治以苓桂朮甘汤加附片、白蔻、砂仁；热结可用黄连解毒汤加滑石、木通。

四十一、太阳病，小便利者，以饮水多，必心下悸②；小便少者，必苦里急也③。

②心下悸：指心下胃脘部筑筑而动。

③苦里急：小便欲下不能，小腹部有急迫的感觉。

郑论：按饮水多而小便亦多，此理之常。但既称小便多，水以下行，又何致上逆凌心而为悸乎？必是小便少而水道不畅，上逆以凌心而为悸，与理方恰。小便不畅，里必苦急，势所必然。以饮水多，致心下悸，理亦不差，仍不若小便之多少处求之，更为恰切。或曰：太阳行身之背，水气何得凌心？余以为凌心者，诚以太阳之气，由下而至胸腹也。

【阐释】本条从小便之利与不利，以辨别水停的部位。饮水多，小便利者，心下胃脘部筑筑而动，此水停中焦所致，可用茯苓甘草汤治疗。饮水多，小便不利者，少腹急急迫，是水停下焦之故，可用猪苓汤治之。

四十二、大下之后，复发汗，小便不利〔者〕，亡津液故也，勿治之；〔得〕小便利，必自愈。凡病若④发汗、若吐、若下、若亡血⑤、亡津液，阴阳自和者，必自愈。

④若：应作“或”字解。

⑤亡：应作“丧失”解。

郑论：据所言汗、吐、下，以致亡血，亡津液，只要其人无甚大苦，可以勿药，俟正气来复，必自愈。明明教人不可妄用药，误用药，恐生他变也。

【阐释】此条在《伤寒论》中为两条。“大下之后，……必自愈。”按此节乃下后复汗，俟其自愈之证也。“勿治之”三字，诸家皆谓不可用利药。惟大下之“大”字，均未注明，所谓大下者，即用大承气法是也。盖大承气直泻君相二火，既伤津液中之阳，复发汗又伤津液中之阴，此小便所以不利也，亦必待其阴阳自和，斯小便得利，而自愈矣，“凡病若发汗，……必自愈”。按此节乃诸治后自愈之总纲也。阴阳自和者，即不能再用汗、吐、下之法，但当调其阴阳，则未尽之邪，从外解者，必自汗而解；从上解者，必自吐而解；从下解者，必自利而解。此即阴阳和，必自愈之真谛也。诚如郑氏所言；“教人不可妄用药、误用药、恐生他变也。”

四十三、太阳病，〔先〕下之而不愈，因复发汗，〔以此〕表里俱虚，其〔人〕因致冒，冒家汗出自愈①，所以然者，汗出表和故也，（待）里未和，然后〔复〕下之。

①冒家：指头昏目眩的病人。

郑论：据下后复发汗，以致表里俱虚，其伤正也太甚，虚则易于感冒，此理之常，

此刻应于补正药中，加解表之品，必自愈。推其故，汗出表和，待里未和，然后下之，待字不可忽略，实有斟酌可否之意，学者宜细求之。

【阐释】太阳病本不应下，先行误下，里气先虚；又复发汗，表气再虚。

则病者发生头目昏冒，若正气旺，必大汗出，汗出表和则自愈。否则应如郑氏所说，于补正药中加解表之品，如理中汤加苏叶、防风等，则自愈。若里未和，可酌用调胃承气汤以下之，方为正治。

四十四、太阳病未解，脉阴阳俱停②，必先振栗汗出而解。但阳脉微者③，先汗出而解；但阴脉微者④，下之而解。（而解）若欲下之，宜调胃承气汤。

②脉阴阳俱停。阴阳作尺寸解，停是停止，脉阴阳俱停是尺寸的脉搏均隐伏而诊之得。

③阳脉微：是指寸部脉，微见搏动。

④阴脉微：是指尺部脉，微见搏动。

郑论：按太阳病，当未解之先，而有此阴阳俱停之脉，便见振栗汗出者，是邪由战汗而解也。条中提出阳脉微者，汗之而解，阴脉微者，下之而解。余谓阳脉微者，表分之阳不足也，法宜辅正以祛之；阴脉微者，里分之阴不足也，只当温里以祛之。何得云汗之而解？下之而解？如果宜汗宜下，务要有汗下实据方可，若只凭一脉而定为可汗可下，况脉已云微，亦非可汗可下之例，学者亦〔不〕必执原文为不可易之法也。

【阐释】太阳病未解，其脉一定呈现浮缓或浮紧，此则谓脉阴阳俱停为不通，停应是微字之误，观下文阳脉微、阴脉微可知。应是营卫之气，被邪遏阻，正邪互争战汗前的暂时现象，与正气将绝的停脉，应该作出严格的区别。郑氏云：“阳脉微者，表分之阳不足也，法宜辅正以祛之；阴脉微者，里分之阴不足也，只当温里以祛之”。是有见地的。况此病在太阳，不在阳明，总不宜下，其理甚明，何得云阴脉微者下之而愈。则原文所云若欲下之，宜调胃承气汤为不可通。故郑氏又云；“学者亦不必执原文为不可易之法也”。调胃承气汤方解，见后阳明上篇。

四十五、太阳中风，下利呕逆，表解者，乃可攻之。其人𦛳𦛳汗出，发作有时，头痛，心下痞鞭满，引胁下痛，干呕短气，汗出不恶寒者，此表〔解〕里未和也，十枣汤主之。

郑论：按中风而见下利呕逆，（夫下利呕逆）其病似不在太阳，而在太阴也。太阴

受伤，转输失职，不能分运水湿之气，以致水气泛滥，上行于皮肤，故见漦漦汗出，水停心下，故见痞鞭，水流于胁，故见胁痛，至于头痛、干呕、短气，种种病形，皆是一水气之所致也，主以十枣汤，取大枣以培土去湿，湿去而诸症自释。直指太阳，盖太阳为一身之纲领，主皮肤，统营卫、脏腑，百脉、经络，主寒水，司冬令，行水气，外从皮肤毛窍而出，内自小便而出，气化不乖，水行无滞，往来灌溉，何病之有？今为风邪所中，阻滞气机，气化不宣，水逆于上而为呕，水逆于下而为利，水流于左而胁痛生，水逆于心而鞭痞作，水发于上而现头痛，水阻于中，上下往来之气不畅，而短气立至，此刻水气弥漫，表里焉得自和，主以十枣汤，直决其水，恐水去而正不支，故取枣之甘以补正，庶不致害。前所论主在太阴者，以吐利乃太阴之提纲说法也；后所论为太阳者，本篇之大旨也。所论虽未尽当，亦可开后学之心思也，高明正之。

【阐释】发热、恶风、有汗、脉浮缓者为中风，今见下利、呕逆证状，则为并病证可知矣。并病而挟水饮，似宜以逐水之剂攻之，然必待表解而后可攻。饮为有形之邪，停结于胸胁之间，所以心下痞，鞭满，牵引胁部疼痛，饮邪上迫于肺，气机受阻，所以呼吸短促，饮邪外走皮肤，所以微微出汗，由于正与邪争，所以发作有时，水邪犯胃则干呕，上攻则头痛，下趋则下利。这些都是水饮内结，水气攻窜而上下充斥，内外泛滥所致。它是属于水饮内结的实证，故用十枣汤峻逐其水邪。中指出表解者乃可攻之，如表未解而攻之，则表邪内陷更增他变。

郑氏谓：“论在太阴者，以吐利乃太阴之提纲说法也；论在太阳者，本篇之大旨也。”所论虽未尽当，亦可开后学之心思也。”此示人辨证应从各个方面来诊断，不可以偏概全。

十枣汤方（校补）

芫花（熬）甘遂大戟上三味，等分，各别捣为散，以水一升半，先煮大枣肥者十枚，取八合，去滓，内药末，强人服一钱匕，羸人服半钱，温服之，平旦服。若下少，病不除者，明日更服，加半钱，得快下利后，糜粥自养。

【方解及其应用范围】关于十枣汤，乃决堤行水之第一方也。大戟、甘遂、芫花，性味辛苦而寒，三味都是峻泻水饮的猛药，用之适当，其效极捷。但峻泻之后，影响脾胃正气，所以选用大枣为君，一以顾其脾胃，一以缓其峻毒，得快利后，糜粥自养，一以使谷气内充，一以使邪不复作，此仲景用毒攻病之法，尽美又尽善也。

《金匮痰饮篇》饮后水流胁下，咳唾引痛的悬饮证，虽然与本条不尽相同，但病的性质是一致的，二者皆是水饮结聚于胁下，都采用攻逐水饮的十枣汤治疗。笔者曾治一冯姓农民病人，腹大如鼓，能听见水响，用峻剂十枣汤一服而解大、小便半桶，腹鼓胀顿失，继服参附汤善其后。现今推广用之以治水肿病、单腹胀之腹满肠鸣、肝硬化腹水等都有疗效。

四十六、太阳病二三日，不能卧，但欲起，心下必结，脉微弱者，此本有寒分也①，反下之，若利止，必作结胸，未止者，四日复下之，此作协（势）〔热〕利也②。

①寒分：指痰饮也。以痰饮本寒，故曰寒分。

②协热利：指表热而下利。

郑论：按二三日，系阳明少阳主气之候，或经或腑，总有一定病情，此并未有二阳经腑证形足征，但云不能卧，但欲起者，是阴阳不交，而神不安也。心下必结者，胸中之阳不宣也。所称脉微弱，而曰本有寒分，明是正气之不足，无热邪之内扰，亦可概见。医反下之，大失其旨，若利止必结胸，是由下伤中宫之阳，不能镇下焦浊阴之气，以致上僭而为逆，未止者复下之，是果何所见而必当下耶？又未见有里热足征，而断为协热利耶？总之，原文所论，可见医家之咎。

【阐释】郑氏之按，与历代注家不同，其诸种证状，总由阴阳不交，胸中之阳不宣，正气之不足，下伤中宫之阳，是有见地的。法当温中逐饮，而不应攻下。但医者诊断不明，见到心下痞结，以为里有结实，妄用攻下，势必引起下利，如正气尚盛，则利当自止。但表热因下而内陷，与痰水互结，则为结胸；如正气较虚，误下后挟表热而下利水止，则为协热下利。故郑氏归结为“原文所论，可见医家之咎。”此证虽未出方治，但当温中逐饮，兼解表邪，小青龙汤为对症之方，则可免结胸与协热利之患矣。

四十七、病发于阳，而反下之，热入（必）〔因〕作结胸；病发于阴，而反下之，因作痞〔也〕①。所以（然者）〔成结胸者〕，〔以〕下之太早故也。前段

郑论：按病发于阳，指太阳表分受病也。病发于阴，指少阴里分受病也。二者皆非可下之证，结胸与痞，皆由误下之过，亦非下早之过。总之，医之过也。

①痞：证候名，主要症状是心下痞塞，按之柔软不痛，亦有痞鞭者，但并无痛感。

【阐释】历代注家对“病发于阳”、“病发于阴”的见解不一。郑氏指出“病发于阳”是指太阳表分受病；“病发于阴”是指少阴里分受病。无论太阳、少阴都不可下，结胸证是有形而邪实，故心下满而痛；而痞证是无形而邪虚，所以但觉痞闷而不痛。结胸与痞，皆由误下之过，并非早下之过。总由医者诊断不明之过也。

四十八、太阳病，脉浮而动数，浮则为风，数则为热，动则为痛，（散）〔数〕则为虚，头痛发热，微盗汗出，而反恶寒者，表未解也。医反下之，动数变迟，（胸）〔膈〕内拒痛，胃中空虚，客气②动膈，（气短燥）〔短气躁〕烦，心中懊憹③

，阳气内陷，心下因鞭，则为结胸，大陷胸汤主之。若不结胸，但头汗出，余〔处〕无汗，剂颈而还①，小便不利，身必发黄。

②客气：就是邪气，因从外来，故叫客气。

③懔：音náo（挠）。阳气：这里指表邪而言，不是指正气。

①剂颈而还：剂同齐，谓汗出到颈部而止。

郑论：按太阳既称脉浮数动，以及恶寒表未解句，明言风热之邪尚在，其病究竟未当下时，而医即下之，动数浮大之脉，忽变为迟，是阳邪（便）〔变〕为阴邪也明甚。阴邪盘据中宫，故见膈内拒痛，胃中既因下而空虚，故短气懊懔，心烦、鞭满之症作。此刻满腔全是纯阴用事，阴气闭塞，理应温中化气，则所理诸证自能潜消，兹以大陷胸汤主之。夫陷胸汤，乃硝、黄、甘遂苦寒已极之品，是为热结于心下者宜之，若浮数变迟，中虚之候用之，实为大不恰切。又曰若不结胸，但头汗出剂颈而还，小便不利，身必发黄。夫发黄之候，原是阳明热邪遏郁所致，此但以小便不利，头汗出，而断为必发黄，亦未必尽如斯言，学者当以病形、脉息、声音、有神无神各处求之，便得其要也。

【阐释】太阳病表邪未解，误用下法，有两种转归，一为结胸，一为发黄。郑氏所释，有特别见解：“此结胸非热结，乃阴邪盘据中宫，满腔全是纯阴用事，阴邪闭塞，则大陷胸汤治之为不当”。而曰：“应温中化气，则所现诸证自能潜消。”笔者认为可选用附子理中汤加砂仁、半夏、安桂，温中补气，祛阴散结。若误下未成结胸，……身必发黄，未必尽是如此，应如郑氏所说：“当以病形、脉息、声音、有神无神各处求之，便得其要也”。

大陷胸汤方（校补）

大黄六两（去皮）芒硝一升甘遂一钱匕上三味，以水六升，先煮大黄，取二升，内芒硝，煮一两沸，内甘遂末，温服一升，得快利，止后服。

【方解及其应用范围】本方以甘遂为君，味苦寒，既能泄热，又能逐水破结；芒硝咸寒软坚，咸味下泄为阴，热胜者以寒消之；大黄味苦寒，荡涤邪热，推陈致新。本方与大承气汤同用硝、黄，所不同者，一用甘遂，一用枳、朴，大承气专主肠中燥粪，大陷胸并主心下水湿。燥屎在肠，必借推逐之力，故须枳、朴；水湿在胃，必兼破饮之长，故用甘遂。本方较大承气为猛峻，非脉证俱实者不可轻用。现今推广应用于肠梗阻亦有效。

四十九、太阳病，重发汗而复下之，不大便五六日，舌上燥而渴，日晡（时）所小

有潮热①，从心（上）〔下〕至少腹鞭满而痛，不可近者，大陷胸汤主之。

①日晡所：晡，午后三时至五时。所：不定之词，表约数。

郑论：按重发汗，亦是表而再表之义，再表而邪不去，故复下之，又不大便五六日，邪既不由表解，又不由里解，固结于中，竟有负隅之势，所现一派病情，非陷胸汤决不能拔，原文主之，深得其旨。

【阐释】太阳病误汗误下后，如内无水饮，仅是燥粪内结，此为阳明腑证，可用大承气汤下之；如内有水饮，热与水结，则为结胸，从心下至少腹鞭满而痛，则非大陷胸汤不能治之。徐灵胎说：“大承气所下者燥粪，大陷胸所下者蓄水，小陷胸所下者黄涎。”乃其经验之言。故郑氏说：“原文主之，深得其旨”。

五十、结胸者，项亦强，如柔痉状②，下之则和，宜大陷胸丸。后段

②柔痉：痉一作痊，是项背强直，角弓反张的证候名称，有汗的叫“柔痉”，无汗的叫作“刚痉”。

郑论：按（胸结）〔结胸〕而项亦强，有如柔痉状者，此是邪结于胸，阻其任脉流行之气机而言也。下之以大陷胸丸者，逐其胸中积聚，积聚亦去，任脉通而气机复畅，故有自和之说也。但痉症则周身手足俱牵强，此独项强，故称为如柔痉状，学者须知。

【阐释】结胸的主证，本是心下鞭满而痛，此证项强如柔痉状，是病邪偏结于上，胸部鞭满而不能俯，所以如同柔痉。这种项强是受胸部水热结聚的影响，和筋脉失养的项强不同，水热结聚一散，胸部胀满自消，项强也就可以自愈，所以说下之则和。用大陷胸丸缓攻上部之邪，确为对证。郑氏嫚与诸家不同：“此是邪结于胸，阻其任脉流行之气机而言”。治之以大陷胸丸者，使药力缓缓而行，驱邪而正不伤，乃峻药缓攻之法也。胸中积聚去，任脉通而气机复畅，故自和也。

大陷胸丸方（校补）

大黄半斤葶苈子半斤（熬）芒硝半升杏仁半升（去皮尖、熬黑）上四味，捣筛二味，内杏仁芒硝，合研如脂，和散，取如弹丸一枚，别捣甘遂末一钱匕，白蜜二合，水二升，煮取一升，温顿服之，一宿乃下，如不下，更服，取下为效，禁如药法。

【方解及其应用范围】本方的药物组成，为大陷胸汤更加入葶苈子杏仁白蜜而成。因其邪结在胸，胸为肺位，故加杏仁色白入肺，以利肺气，用葶苈子佐甘遂破饮而泻下，恐硝黄等药下行甚速，故缓以白蜜之甘，使药力缓行，留于胸中，热结之水

，得芒硝而解，葶苈甘遂逐水饮，随大黄以下行，又为丸煮服，使药力缓缓而行，驱邪而正不伤，乃峻药缓攻之法。《医宗金鉴》用以治水肿肠潴初起，形气俱实者。

五十一、结胸证，其脉浮大者，不可下，下之则死。

郑论：按结胸而称脉浮大者，明是阳邪结胸，理应清凉以解之、开之，方为合法，若攻下之，则引邪深入，结胸愈结而不解者，焉得不死。

【阐释】此节乃结胸之虚证也。邪结于里，脉当寸浮关沉，今脉通见浮大，是邪虽内结而未实，气机仍有外达之象，若误下之，则犯本论，脉浮大，而医反下之，此为大逆之戒。亦即郑氏所云：“若攻下之，则引邪深入，结胸愈结而不解者，焉得不死”之谓也。

五十二、结胸证〔悉〕具，烦（燥）〔躁〕者〔亦〕死。

郑论：按证具结胸，阻其上下交通之机，故烦（燥）〔躁〕作。

盖烦出于心，（燥）〔躁〕出于肾，病机正在坎离交会之处，不交则烦（燥）〔躁〕立作，故决之必死也。

【阐释】结胸证悉具，邪结已深也，若更见烦躁，是正不胜邪，真气散乱，病者必死。郑氏以坎离立论谓：“烦出于心，躁出于肾，病机正在坎离交会之处，不交则烦躁立作，故决之必死也”。诚属不刊之论。

五十三、太阳病，医发汗，遂发热恶寒，因复下之，心下痞，表里俱虚，阴阳〔气〕并竭①，无阳则阴独②，复加烧针，因胸烦，面色青黄，肤瞤者，难治；今色微黄，手足温者易愈。

①阴阳气并竭：就是表里俱虚。发汗使表虚而阳气竭，攻下使里虚而阴气竭。

②无阳则阴独：谓表邪内陷成痞，表证罢而里证独具。

郑论：按太阳证总要外邪未解，方可发汗，岂有无发热恶寒，而反即汗之理？此言因发汗，遂见发热恶寒，焉知非误汗而逼阳外越乎？此症总缘汗下失宜，以致表里俱虚，阴阳并竭，无阳则阴独，此刻系纯阴用事，痞塞之症所由生，后加烧针，因而胸烦，面色青黄，则土木相刑之机，全神毕露，故曰难治。若色微黄，而无青色，手足尚温，是后天之根犹存，故纯可治。

【阐释】郑氏所按：“岂有无发热恶寒，而反即汗之理？此言因发汗，遂见发热恶寒，焉知非误汗而逼阳外越乎？”值得深思。总由汗下失宜，所以成痞，虽曰阴阳气并竭，实由心下无阳，故阴独痞塞也。复加烧针，以逼劫其阴阳，乃成此危候，自当扶阳散逆，温中祛邪之法，可用附子理中加砂、半、吴茱萸等药治之为当。

伤寒恒论卷二

太阳中篇

凡寒伤营之证，列于此篇，计五十八法（据舒本校增）

一、太阳病，或已发热，或未发热，〔必恶寒〕，体（重）〔痛〕，呕逆，脉阴阳俱紧〔者〕①，名（曰）〔为〕伤寒②。

①脉阴阳俱紧：指脉的浮沉，浮取为阳，沉取为阴。“紧脉”如切绳状，是紧张的现象，与弦脉相似而转索有力。这里所说的紧脉，是浮紧的脉象，浮紧为表寒，常与发热恶寒并见。

②名为伤寒：这里的伤寒，不是指伤寒论之广义伤寒，而是指麻黄汤证的狭义伤寒而言。

郑论：按已发热者，邪已拂郁于内也，未发热者，邪入而未遏郁也。据脉象，阴阳俱紧曰伤寒，论体（重）〔痛〕，则属少阴，呕逆则属寒饮，似于此条内不切。以余细维，现有发热、恶寒、身痛、脉浮紧者，乃为太阳伤寒之候。若无头痛、身痛、发热、恶寒，而独见身（重）〔痛〕，呕逆，脉象见紧，乃为寒入少阴之征。盖太阳底面，即是少阴，以此判其或已发热，或未发热二语，庶几恰切。

【阐释】本条乃太阳伤寒证之主证主脉。与太阳上篇中风条参之自别，主要不同点是脉紧无汗，此外体痛、呕逆也是中风证所没有的。中风因见风而恶寒，伤寒则无风而亦恶寒矣。郑氏释或已发热，或未发热，则不同于历代注家之说，而曰“太阳底面，即是少阴，以此判其或已发热，或未发热，庶几恰切”。必恶寒者，伤于寒则恶寒也。

二、太阳病，头痛发热，身（痛）〔疼〕腰痛，〔骨节疼痛〕，恶风，无汗而喘者，麻黄汤主之。

郑论：按此条乃寒伤太（过）〔阳〕之里，里寒太甚，闭束气机，上逆而喘，此理之常，主以麻黄汤开其腠里，俾邪外出，表里通畅，一切证形，立即化为乌有，学者切勿以喘而即认为肺病也，须知。

【阐释】本条为太阳伤寒的主要证状，也是应用麻黄汤证的标准。郑氏谓：“学者切勿以喘而即认为肺病。”盖人身大气，积于心中，上焦如雾也，而胸中为太阳所主，寒邪外束，荣卫闭固，气不得泄，壅阏而为喘，于肺何有也。杏仁取其利气，非治肺也，故麻黄汤实是治太阳伤寒之药，而非治肺经之方也。

麻黄汤方（校补）

麻黄三两（去节）桂枝二两（去皮）甘草一两（炙）杏仁七十个（去皮尖）上四味，以水九升，先煮麻黄，减二升，去上沫，内诸药，煮取二升半，去滓，温服八合，复取微似汗，不须啜粥，余如桂枝法将息。

【方解及其应用范围】麻黄辛温，开腠理而发汗；杏仁苦温，疏利肺气而治喘；桂枝辛甘温，协同麻黄，增强其发汗作用；甘草甘平，协和诸药，药虽四味，方义周匝。本方为开表逐邪发汗之峻剂，为太阳病表实证之主方。汪昂曰：“麻黄中空，辛温气薄，肺家专药，而走太阳，能开腠散寒；桂枝辛温，能引营分之邪达于肌表；杏仁苦甘，能散寒而降气；甘草甘平，发散而和中。”麻黄与杏仁相配，可以解表散邪，降逆平喘。曹颖甫谓：“麻黄汤为伤寒之圣药。独怪近人畏忌麻黄，徒以荆芥、防风、豆豉、牛蒡等味，敷衍病家，病家亦以其平易而乐用之，卒之愈疾之功不见”。此为经验有得之言。近代医家恽铁樵对用此方之标准谓：“除恶寒、发热、头痛、身痛等，更须注意两点：第一是无汗，第二是口中和。如其有汗，麻黄是禁药；如其口渴、舌干、唇绛，桂枝也是禁药。只要是真确无汗，口中和，此方是唯一无二的妙法，可以药到病除。”（见恽着《伤寒论辑义按》）郑氏在《医法圆通》中说：“此太阳营分主方也。仲景原文治太阳病头痛发热，身疼腰痛，骨节疼痛，无汗恶寒而喘者。”随即举出其圆通应用法三条：（一）治痘初出而急隐，壮热无汗者；（二）治肩背沉重、觉内冷者；（三）治两脚弯发起红块，痛甚。

近代药物之分析，麻黄有发汗、平咳、定喘诸作用，为辛温发汗药中效力最强大者。故凡一切感寒、伤寒诸疾病之无汗者，如头痛、腰痛、身痛、关节痛等，无不可以用之。笔者多年来常用麻黄汤以治伤寒咳嗽，无不应手取效，而从未见发生副作用。近人推广应用此方治疗肺炎、上呼吸道感染属表寒实证者，均获良效。亦有用本方治疗肾脏病的水肿，并不一定出汗，大都表现为小便增多而肿胀消。

三、伤寒一日①，太阳受之，脉若静者为不（动）〔传〕②，颇欲吐，若（烦燥）〔躁烦〕，脉数急者③，为传也。伤寒二三日，阳明少阳证不见者，为不传也。

①伤寒：指广义伤寒，包括中风在内，与上条名为伤寒有广狭义之分。

②脉若静：指脉与证符（伤寒脉紧，中风脉缓），无数急现象。传：谓以此之所受，转授之于彼也。

③脉数急：与脉静相对而言。

郑论：按伤寒本旨，以一日太阳，二日阳明，三日少阳，四日太阴，五日少阴，六日厥阴，此就六经流行之气机而言也。至于邪入太阳，虽七八日，十馀日，只要脉

静而不动，别无他经证形足征，便不传经。若脉见动，心烦欲吐，此为传也。学者临证，务要有别经证形可验，脉象之动静足征，则得传与不传之实也。

【阐释】郑氏将辨太阳病脉证并治上第四条、五条合并为一条。临床上的病变，并不是一日太阳、二日阳明……这样机械刻板，它既可以传入阳明，又可以传入少阳，甚至也有转属太阴、少阴的。但也可以在太阳七八日、十徐日不发生传变。可以从脉证的变化来诊断其传与不传，更应以证候为主。如伤寒二日，并未见到不恶寒，但恶热，口渴欲饮等阳明证，三日并未见到口苦、咽干、目眩等少阳证，则可知病邪仍在太阳，而没有传变。于此充分说明了病情已否传变，应以证候为主，决不可以日数来决定传与不传。亦即郑氏说：“务要有别经证形可验，则得传与不传之实也”。

四、伤寒二三日，心中悸而烦者①，小建中汤主之（呕家不可用建中汤②，以甜故也）。

①心中悸而烦：心中筑筑然跳动和烦扰不宁的证状。

②呕家：指素有呕吐症状的人。

郑论：按太阳司寒水之令，今二三日未见别经病情，只见心悸而烦，必是太阳失气化之令，以致水停心下，为悸而烦，今主建中汤以化太阳之气，气化而行，则升降不乖，而心悸与烦，则立化为乌有。但呕家不可用建中，以甘能上涌也，须知。

【阐释】伤寒二三日，心中悸烦是属里虚，虽有表证，亦不可汗之，总以救里为急，中气得到扶助，正气能发挥祛邪作用，表邪亦往往能随之而解。其所以里虚，如郑氏所说：“是太阳失气化之令，以致水停心下，为悸而烦”。建中汤足以化太阳之气，气化而行，则升降不乖，而心悸与烦可愈矣。小建中汤方后有“呕家不可用桂枝汤，以甜故也”。郑氏移在原文后，未知何故。

小建中汤方（校补）

桂枝三两（去皮）甘草二两（炙）大枣十二枚（擘）芍药六两生姜三两（切）胶饴一升上六味，以水七升，煮取三升，去滓，内胶饴，更上微火消解，温服一升，日三服。呕家不可用建中汤，以甜故也。

【方解及其应用范围】桂枝汤以桂枝为君，辛甘发散，以祛邪为主；本方以胶饴为君，配芍药酸甘相合，以补中为主。桂枝、生姜，温中通阳；芍药敛阴和营，桂、姜之辛，与枣、草、胶饴之甘合，则辛甘化阳；芍之苦，与甘相合，则苦甘化阴。胶饴甘温，大补脾胃，枣、草助之，以补脾胃之虚，使中宫建立，则阳气化而上行

，阴气化而下降，营卫调和，阴阳不偏，则心悸与烦可愈矣。又方后有“呕家不可用建中汤，以甜故也。”不知郑氏何故，将此段移在原文之后。本方在《伤寒论》、《金匱要略》中凡五见。治里虚腹痛，萎黄，心中悸烦，又治虚劳里急、手足烦热、梦遗失精等阴阳两虚，寒热错杂诸症。近代推广用之，治疗慢性胃炎、胃、十二指肠溃疡病、更年期综合证、心律失常、腹痛、自汗、盗汗等。笔者用治营卫不调，食减神衰，咳嗽久不愈者，以此方健胃滋脾，从阳生阴，而咳自愈。

五、太阳伤寒者，加温针必惊也。

郑论：按寒伤太阳，在营在卫，原有区别，此言加温针必惊，是邪在营分加温针而惊耶？是邪在卫分加温针而惊耶？以理揆之，当其时邪必在卫分，卫分属阳，断不可用温针之法，邪在营分，方可用温针之法。若邪在卫分而用之，如火上添膏，邪焉有不振惊内藏也，如此处断，学者方有趋向，万不致有用温针之害矣。

【阐释】历代注家对病伤寒之人，加以温针，一定要发生惊惕的变证。郑氏则分别在营在卫，卫分属阳，断不可用温针之法；邪在营分，可用温针之法。如此处断，便不致有用温针之害矣。

六、脉浮宜以汗解，用火灸之，邪无（出路）〔从出〕因火而盛①，病从腰以下必重而痹者，名〔水〕〔火〕逆也②。中段

①邪无从出：误治后，表邪不能从汗而出。因火而盛：因误用灸法，邪热愈加炽盛。

②火逆：凡误用火法治疗，因而形成变证的，称为火逆。

郑论：按脉浮之病，本应汗解，方为合法，医家不究脉体，而妄以火灸之，大悖经旨。况表阳也，火亦阳也，二阳相合，邪不从外出而从内攻，遂致腰以下必重而痹者，是邪伏于下，阻其太阳寒水流行之气机故也。名曰火逆者，是重在未得汗解，而水滞于下也。

【阐释】本条系条中一节，指出浮脉误灸后的变证。浮脉在表，宜以汗解之，医以火灸取汗，而不得汗，邪无从出，因火而盛，虽不一定焦骨伤筋，而火阻其邪，阴气渐竭，下焦乃营血所治，营气竭而莫运，必重着而为痹。亦即郑氏所说：“邪不从外出而从内攻，遂致腰以下必重而痹者，是邪伏于下。”则欲治其痹者，宜先治其火矣。

七、脉浮者，〔病在表〕，可发汗，宜麻黄汤。脉浮而数者，可发汗，宜麻黄汤。

、

郑论：按脉浮、脉数，虽云可发汗，然有用桂枝汤者，有用麻黄汤者。在营在卫，原有区分，不得以浮、数二字，而断为麻黄汤的证也。学者务于有汗、无汗、畏风、恶寒处追求，便得用方之实据也。

【阐释】本条在《伤寒论》为、条，郑氏合并为一条。凡表病皆见浮脉，麻黄汤证之主脉为浮紧，并有头疼发热，恶寒无汗等证状，方可用麻黄汤发汗。脉浮而数者，多是风热在表的象征，麻黄汤是不适合的，应该与本篇一条二条互参，如证与之相合，方可用麻黄汤发其汗，则诸证自愈。观原文不曰以麻黄汤为主之，而皆曰宜麻黄汤，则有商量斟酌之意也。

八、伤寒，发汗〔已〕解，半日许复烦，脉浮数者，可更发汗，宜（用）桂枝汤。

郑论：大约此证，既经汗解，而邪尚未尽解，故可更汗之，俾邪解尽无遗，庶无后患。

【阐释】本条为汗解后，表邪犹未尽，因而复烦，脉浮数者，邪气仍在表之证，故可更发汗，以祛表邪。但已汗复汗，故不宜麻黄汤之峻发，而宜桂枝汤之缓发也。

九、发汗已，脉浮数，烦渴者，五苓散主之。

郑论：按太阳伤寒，既称发汗已，想是外邪已去。又见其脉浮数，烦渴，必是外邪已去，而内热未解，故其脉浮数尚见。至于烦渴者，热伤津液也，理应清解其热，热去则烦渴自解，脉数便平，何得即以五苓散主之？凡用五苓散，必要太阳邪已入腑，口渴而小便不利，原文只据一烦渴，脉数，学者每多不识。

烦渴二字，亦有饮冷、饮热之分，不可不察（顶批）

【阐释】此条郑氏指出用五苓散之不当。凡用五苓散，必要太阳邪已入腑，口渴而小便不利，原文只据一烦渴，脉数，其不当明甚。

十、伤寒汗出而渴者①，五苓散主之；不渴者，茯苓甘草汤主之。

①此处之口渴，不是阳明里证的口渴，是水气停在下焦，津液不能上布之口渴。

郑论：按汗出而渴，是太阳寒水从毛窍而出，不能滋润肠胃，故见口渴，以五苓散主之，乃使太阳寒水之气，不从外出，而仍从内出，则汗渴便止。然有不渴者，是津液未大伤，胃中尚可支持，虽见汗出，以茯苓甘草汤主之，亦是化气行水之妙。此条据余所见，当时汗出而渴，小便不利者，以五苓散主之；汗出不渴，小便不利者，以茯苓甘草汤主之。加此四字，后学更易于明白了然。

再按汗出而渴，在阳明(一)有白虎之方；汗出而不渴，在少阴有亡阳之概，学者宜知。

(一)大渴饮冷（顶批）。

【阐释】此条为茯苓甘草汤证与五苓散证之辨证要点，只在渴与不渴之间，则其它证状，如脉浮数，小便不利，微热等情况，亦必大致相同。郑氏释为加小便不利四字，更加明白了然，是正确的。两证的主要区别是：一则水蓄于下，口渴而小便不利；一则水停于中，口不渴而小便不利。证情虽有异，但总的原因都属停饮蓄水为患，所以都治以温阳化水，不过一则重在温化膀胱，以利小便，一则重在温化胃阳而通利三焦，以蠲水饮，所以主治方剂各别。

茯苓甘草汤方（校补）

茯苓四两桂枝二两（去皮）甘草一两（炙）生姜三两（切）上四味，以水四升，煮取二升，去滓，分温三服。

【方解及其应用范围】本方治汗出不渴，其蓄水比五苓散为轻，因而去掉主要的利水药，仅用茯苓之淡渗，加重桂枝温阳，生姜温胃，甘草和中，四味配伍，温胃散水之功最佳，为治水气停中焦，不烦不渴，心下悸而四肢厥逆的有效良方。

十一、脉浮紧者，法当身疼痛，宜以汗解之。假令尺中迟者②，不可发汗，〔何以知之？然①，以营气不足，血少故也。〕原文

②尺中迟者：尺中的脉搏现迟而涩的现象，所谓“呼吸三至，来去极迟”。迟就是脉搏至数减少。但这里的迟，是对紧而言。

①然：古人然字，多有作“曰”字解。

十二、〔脉浮数者，法当汗出而愈，若下之，身重心悸者，不可发汗〕，当自汗出乃解。所以然者，尺中脉微，此里虚，须表里实②，津液自和，便自汗出愈。

②须：等待的意思。

郑论：条内指一脉浮紧，身痛之人，法本当汗，假令尺中虚者，不可发汗，是言其阴分本虚，发之深恐亡阳，明是教人留意于发汗之间耳。即有他证，亦俟其津液自和，自汗出愈。盖慎之深，防之密矣。

【阐释】按此二条，郑氏合并来加以注释，原文错落较多，其按亦不全面。

兹据《伤寒论》校补其错落文字，分列两条之释文。脉浮紧，身疼痛，此伤寒之脉证，宜麻黄汤以汗之者也，然尺中脉迟，此营气不足，而不可发汗之虚证也。

至条表证误下后，见身重、心悸、尺脉微的，不能再发汗，可俟其自汗出而愈。但亦可以酌用小建中汤一类方剂，温养里气，使表里正气早复，气血充沛，则津液自和，便能汗出而愈。

十三、咽喉干燥者，不可发汗。

郑论：凡咽喉干燥之人，津液已伤，岂可再行发汗，以重夺其液乎？余谓咽喉干燥之人，有因下元坎中真气衰微，不能启真水上升而致者，法宜扶阳；有因邪火灼其津液而致者，法宜清润；有因寒水逆于中，阻其胃中升腾之气而致者，法宜行水。学者留心察之，若此等证，皆非发汗所能了。

【阐释】本条为汗法禁例之一。咽喉干燥者，上焦无津液也。郑氏认为咽喉干燥之人，有三种不同情况，并提出扶阳、清润、行水三种治法。笔者认为扶阳可用四逆汤，清润可用人参白虎汤，行水可用茯苓甘草汤或五苓散。咽喉干燥，现今多称为慢性咽炎、喉炎，笔者常先用炮姜甘草汤加桔梗治之，继加补肾药调理而愈。

十四、淋家不可发汗③，汗出（则）〔必〕便血。

③淋家：是指小便淋沥不爽，尿时茎中疼痛的病人。

郑论：凡患淋之人，或热闭膀胱，或寒闭膀胱，或败精滞于尿窍，气化现有不宣，原无发汗之理，若强汗之，则津液外亡，中气被夺，即不能统束血液，血液流注阑门秘清别浊之处，渗入膀胱，小便下血，于是乎作矣。

【阐释】本条为汗法禁例之二。历代医家注解此条，其原因多由肾阴虚而膀胱有热，郑氏所指热闭膀胱即此，法宜扶肾阴，用四苓滑石阿胶汤治之。继指出有寒闭膀胱，或败精滞于尿窍，气化不宣者。寒闭膀胱者，由下焦阳微，阴寒阻截膀胱之路，阳微无力，不能化之，法宜扶下焦之阳，可用苓桂朮甘汤倍桂加砂仁、白蔻治之。至于败精滞于尿窍，气化不宣者，治当清热利水中，加以化精化气之品，可选用滋肾丸倍桂，或大剂回阳饮加味治之。淋家虽患外感，亦无强汗之理，若强汗之，阴液愈虚，膀胱之蓄热愈炽，必致邪热通血妄行，从小便而为尿血。

十五、疮家虽身疼痛①，不可发汗，汗出则痉②。

①疮家：患疮疡病者，流脓已久，此皆亡失其津血。

②痉(jìng净)：肌肉收缩，手足抽搐的现象。

郑论：《内经》云：诸疮痛痒，皆属于火。火盛则血亏，若（在）〔再〕发汗，血液被夺，筋脉失养，痉证必作。然又当察其病情轻重，可汗则汗，不可固执。

【阐释】本条为汗法禁例之三，疮家久失脓血，营血势必不足，若感外邪，虽有身体疼痛等证状，虚多实少，若以麻黄汤发其汗，则必犯虚虚之戒，故不能发汗。汗出其营血必更加亏耗，筋脉失去濡养，必然强急而为痉矣。

十六、衄③家不可发汗，汗出必（颡）〔额〕上陷，脉急紧，（目）直视不能眴④，不（能）〔得〕眠。

③衄(nù)家：常流鼻血的病人。

④不能眴：眴同“瞬”，目转动。不能眴，就是说目睛不能转动。

郑论：申言素患衄血之人，切切不可发汗，汗为血液，血液既伤，若更发汗，则阳从外亡，故现（颡）〔额〕上陷，脉紧急者，阳脱之象也。目直视不能眴者，肝开窍于目，血液已伤，不能灌溉，以致不眴不眠者，皆真阳欲绝，危亡之候也。

【阐释】本条为汗法禁例之五。常患鼻衄的病人，由于经常失血，则血液素亏，不可任意发汗，更伤其血液，其变证多端，而严重的如郑氏所说有真阳欲脱之危候。

十七、亡血家①不可发汗，发汗则寒栗而振。

①亡血家：平素有失血（包括吐血大便血、小便血、鼻血及妇人崩漏）疾患的病人。

郑论：亡血二字，即亡阳之征也。若更发汗，则阳从外越，而内无阳以温暖，故寒栗而振，此等危候非大剂回阳不可。

【阐释】经常失血的病者，不但阴血不足，即阳气亦不充沛，加之发汗亦能伤阳。阴血伤则无以濡养筋脉，阳气伤则无以卫外为固，所以发生寒栗而振，此阴阳两虚之危候。如郑氏所言，非大剂回阳不可，诚属经验有得之言。

十八、汗家重发汗②，必恍惚心乱③，小便已阴疼④，与禹余粮丸。

②汗家：指平常惯会出汗的人，包括盗汗自汗在内。

③恍惚心乱：神迷意惑，慌乱不安，形容精神失常的状态。

④小便已阴疼：小便后尿道作痛。

郑论：按汗为心之液，素多汗之人，血液早亏，今重发其汗，汗出过多，则心阳外亡，神无所主，而恍惚生，小便已阴疼者，血液已亏，不能泽及小便也。以禹余粮丸主之，亦是收纳元气之意也。

【阐释】本条为汗法禁例之六。平日汗多者，血液早亏，表阳即虚，若重发其汗，则阳从外亡，胸中神魂无主，故心神恍惚。而小便已阴疼者，阳气大虚，便出则气愈泄而化源伤，因虚而疼。禹余粮丸方，原文阙。

十九、发汗病不解，反恶寒者，虚故也，芍药甘草附子汤主之。

发汗后恶寒者，虚故也，不恶寒（反恶）〔但〕热者，实也，当和胃气，与调胃承气汤。

郑论：按发汗病不解，与发汗后恶寒者，皆里阳不足，因汗而阳更伤也，故见畏寒。以芍药附子甘草汤，使其收纳元气归根，而恶寒自己。若不恶寒而反恶热，以调胃承气汤，是为血亏火旺说法。

余更有说焉，当其时发汗，有素禀元阳不足，因发汗而有元阳外越者，外大热而内寒，学者务宜细察。若果血亏，阳明胃热，必有舌苔干黄，大渴饮冷，方可与调胃承气汤。若其人因发汗而元阳外越者，虽周身大热，舌必润滑，口必不渴，二便自利，又当以回阳为要，切切不可妄与调胃承气汤，切记。

【阐释】本条《伤寒论》分为两条。“发汗病不解”至“芍药附子甘草汤主之”为一条；以下又为一条。郑氏所按，颇为恰当。但其中特提出元阳外越与血亏火旺，阳阴胃热之区别，则与历代注家不同，临证时应特别注意。元阳外越者，可与大剂四逆或白通汤以回阳为要。

芍药甘草附子汤方（校补）

芍药三两甘草三两（炙）附子一枚（炮、去皮、破八片）右三味，以水五升，煮取一升五合，去滓，分温三服。

【方解及其应用范围】本方芍药以补阴敛液，附子温经回阳，佐以甘草，从中调和，使芍、附作用，共同发挥，能够兼顾气阴，实属阴阳双补、扶正之剂。故用治汗出过多之恶寒属于阴阳俱虚之证。笔者曾治患风湿疼痛，同时有汗出恶寒证状，脚

挛急，舌质淡，苔白腻，脉沉细，用大剂量芍药甘草附子汤治之，芍、甘各用克，附子克，连服五剂而痊愈。

二十、发汗后，身疼痛，脉沉迟者①，桂枝加芍药生姜各一两人参三两新加汤主之。

①脉沉迟：沉是重按才得，迟是跳动的次数缓慢。

郑论：据称发汗后，身疼脉迟，明是里分有寒也。汗则表阳被夺，而内寒卒起，闭塞经络，故见身疼。以桂枝加芍药人参新加汤，取姜桂以散阴寒，参芍以养血液，亦属妥切。

【阐释】发汗后，身疼痛，脉沉迟，此阳气虚损，阴液耗竭，亦即气阴两伤，营血不足也。郑氏所论“汗则表阳被夺，而内寒卒起，闭塞经络，故见身疼”。亦属确切之论。

桂枝加芍药生姜各一两人参三两新加汤（校补）

桂枝三两（去皮）芍药四两甘草二两（炙）人参三两大枣十二枚（劈）生姜四两上六味，以水一斗二升，煮取三升去滓，温服一升。本云桂枝汤，今加芍药、生姜、人参。

【方解及其应用范围】桂枝汤有调和营卫，滋阴和阳的作用。本方即桂枝汤倍芍药生姜加人参而成。倍生姜者，以脉沉迟营中寒也；倍芍药者，以营不足，血少故也；加人参者，补诸虚也。补营阴而益卫阳，表虚身疼自愈。故汗出太过津液受伤，不能濡养筋脉而身疼痛者；气血不足之身疼痛；正气不足，风湿在表之痹证。均可酌用本方治疗。

二十一、发汗后，不可更行①桂枝汤，（若）汗出而喘，无大热者，可与麻黄杏仁〔甘草〕石膏汤。发汗后饮水多（者）必喘，以水灌②之亦喘。、后段

①更行：行、施也、用也。更行就是再用的意思。

②灌：洗也，即以水洗浴之意思。

郑论：按此条所论，与前论不符。此言发汗后，不可更行桂枝汤，若其人桂枝证仍在者，原有再用桂枝之法，此说不可用，非不符而何？又云：发汗出而喘，无大热者，可与麻杏石膏〔甘草〕汤。据余所见，果系大热、口渴、饮冷、气喘者，则为火刑于肺，而麻杏石膏〔甘草〕汤可用。若无大热、口渴等情，只见汗出而喘，吾

恐汗出亡阳，若再以麻黄杏仁之方治之，能不速其亡乎？又云：“发汗后，饮水多者必喘，以水灌之亦喘。”此必因发汗而津液伤，故渴欲饮水；水入亦喘者，是为水逆于中，而中州气化不宣故也。

【阐释】本条分为两节，“发汗后”至“可与麻黄杏仁石膏甘草汤”为一节，即伤寒论条全文；“发汗后”至“以水灌之亦喘”为后一节，即伤寒论条后段。郑氏谓“此条所论，与前论不符”，其解麻杏石甘汤之可用与不可用，确有见地，非随文释义可及。又原文“发汗后，饮水多者必喘，以水灌之亦喘”郑氏释为津液伤，气化不宣。盖汗后表气虚，水气乘虚，客于腠理皮毛之间，则皮毛之开阖不利，皮毛内合于肺，故肺之呼吸迫促，而为喘也。

麻黄杏仁甘草石膏汤方（校补）

麻黄四两（去节）杏仁五十个（去皮尖）甘草二两（炙）石膏半斤（碎、绵裹）上四味，以水七升，煮麻黄减二升，去上沫，内诸药，煮取二升，去滓，温服一升。

【方解及其应用范围】本方是麻黄汤去桂枝加石膏而成。麻黄辛温开泄肺气；杏仁苦降，宣肺平喘；石膏辛甘寒直清里热；甘草以和诸药。四味配合，有清肺定喘之功。此方除治本条所举之证外，适用于邪热壅肺各种病证，如风热感冒，气管炎、哮喘、百日咳、肺炎等。笔者常用此方治寒包热之咳嗽、哮喘、肺炎，以及风温初起，无汗而喘者，屡用屡效，获得满意效果。

二十二、下后不可更行桂枝汤，若汗出而喘，无大热者，可与麻〔黄〕杏（仁）〔子〕〔甘草〕石膏汤。

郑论：按下后不可更行桂枝汤，此语皆非确论，其间有因下而引邪深入，其脉尚浮，病机尚欲外出，仍当以桂枝汤，因其势而导之，方为合法，何得拘泥？至“汗出而喘，无大热”句，更要仔细推求，果见脉浮紧，有热象可征，而麻杏甘膏汤，方是的对之方。若汗出，脉浮空，面舌俱青、白、黑色者，回阳犹恐不及，尚得以原文方治之乎？学者务要留心，探究阴阳消息，切勿死守陈言，为方所囿，则得矣。

【阐释】下后不可更行桂枝汤，郑氏谓此语非确论。若其人桂枝证仍在者，原有再用桂枝之法。太阳上篇第三十一条、三十二条，太阳中篇第二十九条，都是下后又用桂枝汤之例。至“汗出而喘，无大热”者，可否用麻杏甘膏汤，则应如郑氏所说：探求阴阳实据，切勿死守陈言，为方所囿。

二十三、发汗过多，其人叉手自冒心①，心下悸②，欲得按者，桂枝〔甘草〕汤主之。

①叉手自冒心：叉手即两手交叉，冒即按捺，形容病人的两手复盖在自己的心胸部位。

②悸：跳动也。心下悸，即心下部位有紧张跳动的感觉。

郑论：按汗为心之液，今发汗过多，则心阳不足，其人叉手自冒者，是欲扶心之意，外援之一助也。至心下悸欲按，皆本此。

【阐释】此乃汗出过多，损伤胸中阳气。因胸中阳虚，以致心下悸动不宁。叉手自冒心，亦是汗出多而胸阳虚的原故。

桂枝甘草汤方（校补）

桂枝四两（去皮）甘草二两（炙）上二味，以水三升，煮取一升，去滓，顿服。

【方解及其应用范围】桂枝甘草汤方，桂枝并非解表，乃取其入心而益阳，配以甘草补虚以益气。

桂枝配甘草，则桂枝温而不热，所以能益阳而不致发汗。辛甘合用，阳气乃生，心阳得复而悸动可愈。现本方广泛用于治疗心血管系统疾病，可调整血液循环功能。如心阳虚是受肾阳虚所引起，可酌加附子。

二十四、未持脉时①，病人叉手自冒心，师因教〔试〕令咳而不咳者，此必两耳聋无闻也，所以然者，以重发汗，虚，故如此也。前段

①持脉：与诊脉同义。

郑论：此条是教人探阴阳之妙谛，若其人令咳而能咳，则耳聪，令咳而不咳，则耳聋。故断之曰，重发汗，以致心阳虚，浊阴上干，闭其轻窍，故耳聋也，此与风寒闭束者，大有泾渭之别，学者宜细察焉。

【阐释】本条通过望诊与问诊来诊断病情，决其阴阳，重发汗，以致心阳虚，心寄窍于耳，心虚故耳聋，此与肝胆风木之火上升，阻滞清窍而耳聋迥然不同，以小柴胡汤加减治之必不效，必大剂参附汤加味治之。

二十五、发汗后，其人脐下悸者，欲作奔豚②，茯苓桂枝甘草大枣汤主之。

②奔豚：诸病源候论云“奔豚者，气上下游走，如豚之奔，故曰奔豚”。此两字在这里是形容悸气自小腹上冲心胸之势，与肾积为奔豚不同。

郑论：既称发汗后其人脐下悸者，是必因发汗而伤及肾阳也，肾阳既衰，不能镇纳下元水气，以致脐下悸，欲作奔豚，法宜回阳为是。所主之方，取茯苓以伐肾邪，而使水气下泄，不致上奔，真立法之妙谛也。

【阐释】历代注家认为发汗后心阳虚而肾水上逆脐下。郑氏则谓伤及肾阳，不能镇纳下元水气，以致脐下悸，欲作奔豚，法宜回阳为是。主以茯苓桂枝甘草大枣汤虽佳，但不若再加附片以扶肾阳，效果更好。

茯苓桂枝甘草大枣汤方（校补）

茯苓半斤桂枝四两（去皮）甘草二两（炙）大枣十五枚上四味，以甘澜水①一斗，先煮茯苓，减二升，内诸药，煮取三升，去滓，温服一升，日三服。作甘澜水法，取水二斗，置大盆内，以杓扬之，水上有珠子五六千颗相逐，取用之。

①甘澜水：一名劳水。程林曰：“扬之无力，取其不助肾邪也。”钱天来曰：“动则其性属阳，扬则其势下走故也。”

【方解及其应用范围】《医宗金鉴》云：“本方即苓桂朮甘汤去白朮加大枣倍茯苓也，彼治心下逆满，气冲胸，此则脐下悸欲作奔豚。盖以水停中焦，故用白朮，水停下焦，故倍茯苓，其病由汗后而起，自不外乎桂枝之法也。”本方与苓桂朮甘汤、茯苓甘草汤的作用大致相同，都能治水气疾患。苓桂朮甘汤证，心下逆满，气上冲胸；茯苓甘草汤证，厥而心下悸，其病理机转偏于中焦，所以一用白朮运脾，一用生姜温胃。本汤证脐下悸欲作奔豚，其病理机转偏于下焦，所以用大枣培土制水，倍茯苓以伐肾邪。

二十六、发汗后，腹胀满者，厚朴生姜半夏甘草人参汤主之。原

郑论：此病腹胀满由于发汗后，明是汗出伤及胸中之阳，以致浊阴上干，闭其清道，壅而为满，法宜补中宣通，原方亦可用，似不若理中加行滞药为当。

【阐释】此条为发汗后脾阳虚弱，不能运化转输，虚气壅滞腹胀满的治法。

郑氏云：“原方亦可用，似不若理中加行滞药为当”。笔者治此类脾虚胀满者，常用理中汤加丁香治之辄效。

厚朴生姜半夏甘草人参汤方（校补）

厚朴半斤（炙、去皮）生姜半斤（切）半夏半升（洗）甘草二两人参一两上五味，以水一斗，煮取三升，去滓，温服一升，日三服。

【方解及其应用范围】本方为温运脾阳，宽中除满，消补兼施之剂。厚朴味苦辛，性温，下气开滞，豁痰泄实，故能平胃气而除腹满，生姜辛开理气，半夏开结燥湿，人参、甘草健脾培土以助运用。参、草非胀满之要药，临床时分量宜轻。除用治脾虚作胀外，近人推广用于慢性胃炎、胃、肠消化不良等病症。

二十七、伤寒汗出解之后，胃中不和，心下痞鞭，干（呕）〔噫〕食臭①，胁下有水气，腹中雷鸣②下利者，宜生姜泻心汤〔主之〕。

①干噫食臭：噫同噯，即噯气带有食臭味。

②腹中雷鸣：形容腹肠间的响声。

郑论：此证既称汗解，是外邪已去，何至胃中不和，心下痞鞭？此是因发汗过多，以致浊阴上逆于心而成痞乎？是因挟有宿食滞于心下而成痞鞭乎？是因有邪热结于心下而成痞鞭乎？是因有寒水逆于心下而成痞鞭乎？不能无疑。又云：“干（呕）〔噫〕食臭，胁下有水气，至雷鸣下利”句，定是太阳气化失职，以致寒水弥漫四旁，一切病情，俱由此而生。但原文以生姜泻心汤主之，似不恰切。

【阐释】郑氏所注，与历代注家不同，首先提出心下痞鞭有四种不同情况，此条心下痞鞭，是因寒水逆于心下而成，此太阳气化失职，以致寒水弥漫，原文主以生姜泻心汤为不恰当。笔者认为可用五苓倍桂以化太阳膀胱之气，加附子以扶肾阳，较为妥切。

生姜泻心汤（校补）

生姜四两（切）甘草三两（炙）人参三两干姜一两黄芩三两半夏半升（洗）黄连一两大枣十二枚（擘）上八味，以水一斗，煮取六升，去滓，再煎取三升，温服一升，日三服。附子泻心汤，本云加附子。半夏泻心汤、甘草泻心汤，同体别名耳。生姜泻心汤，本云理中人，参黄芩汤，去桂枝、朮加黄连，并泻肝法。

【方解及其应用范围】本方生姜、半夏辛温散寒，除胁下水气以和胃，人参、大枣以补中，干姜、甘草以温里，黄芩、黄连以除痞结。因本方以胃不和有水气为主，故重用生姜以和胃散水，因以名方。本方主治皆属里证，寒多热少，升降失司、虚实错杂之证。

现应用本方以治急慢性肠炎、消化不良，胃扩张，胃酸过多，肠胃功能紊乱等症。

二十八、伤寒中风，医反下之，其人下利，日数十（次）〔行〕，（完）谷不化①，腹中雷鸣，心下痞鞭而满，干呕心烦不得安。医见心下痞，谓病不尽，复下之，

其痞益甚，此非结热，但以胃中虚，客气上逆②，故使鞭也，甘草泻心汤主之。

①谷不化：就是食谷不消化。

②客气上逆：不是人体正气，是胃中虚气上逆。

郑论：此条既已误下，而又复下，所现之症，既称虚冷，此非结热，原文以甘草泻心汤主之，方中芩连之苦寒，而复可用乎？仲景不当处此。

【阐释】两次误下，其痞益甚，此非热邪痞结，而是胃中虚冷之极也，理当急投四逆以救其阳，稍加人参以润之，即四逆加人参汤。在临床上，人参确有振奋胃机能，缓解虚性痞满的作用。故郑氏驳其不可用芩、连之苦寒，而曰仲景不当处此。

甘草泻心汤方（校补）

甘草四两（炙）黄芩三两干姜三两半夏半升（洗）大枣十二枚（擘）黄连一两上六味，以水一斗，煮取六升，去滓，再煎取三升，温服一升，日三服。

【方解及其应用范围】本方用甘、枣以补中，干姜、半夏，辛以通达，芩、连苦寒泻痞清热。甘草用至四两，为本方君药，故名甘草泻心汤。现今推广用以治疗胃及十二指肠溃疡多效，其证多为寒热错杂。

二十九、伤寒大下后，复发汗，心下痞，恶寒者，表未解也，不可攻痞③，当先解表，表解乃可攻痞，解表宜桂枝汤，攻痞宜大黄黄连泻心汤。

③攻痞（pǐ）：即治疗痞证。痞：痞块、痞积，腹中可触摸之硬块，伤寒病等会发生此症状。

郑论：既称下汗后，以致心下痞，明是下汗，亏损表里之阳，以致浊阴上干，结于心下而为痞，法宜温中扶阳，宣中散逆为是。又云：恶寒者表未解，恶寒二字，虽云太阳面目，究竟阳虚而畏外寒，亦见恶寒，况既大下发汗后，果见脉尚浮紧，周身尚在疼痛，发热，恶寒，如此可以解表，不然，祇见恶寒两字，不得即当解表。至于攻痞之说，虽有次第，以此症而论，则攻痞之大黄黄连泻心汤，亦未恰切，何也？未见有热象足征，祇有痞象一症，况此由下汗而成，并非未经汗下而见，前之大下，是大黄苦寒一派而致痞，既前之大黄不效，今又用之，又岂能必其效乎？吾想再下之，而命不永也。

【阐释】郑氏所按，层层分析，与历代注家迥异。下汗后，以致心下痞，乃亏损表里之阳，阴气结于心下而成痞，法宜温中扶阳，宣中散逆，所论极是。

至恶寒二字，亦有阳虚而畏寒者，则不在解表之例。至于攻痞之说，大黄黄连泻心汤，亦不恰切，盖只有痞象一症，而未见有热象足征，况此痞由下汗而成，并非未经汗下而见，前用大黄下之而成痞，今又用之，岂能必其效乎？故郑氏慨然曰：“吾想再下之，而命不永也”。

三十、脉浮而紧，而复下之，紧反入里，则作痞，按之自濡①，但气痞耳②。心下痞，按之濡，其脉关上浮（大）〔者〕，大黄黄连泻心汤主之。心下痞。而复恶寒汗出者，附子泻心汤主之。、、

①濡：与软同，柔软之意。

②痞：本是一种疾状名称，不是独立的病名。但也有以痞为主证，而进行治疗的，如诸泻心汤证。

郑论：按脉浮而紧，是寒伤的候，理应解表，医者不知解表，而复下之，紧反入里，明明引邪深入而成痞满之象，但按之濡，是无形之热邪结于心下。至于关上浮大，足见中州之实有热助之，而原文之大黄黄连泻心汤，是的确之法。若心下痞，而见恶寒汗出者，则又阳虚之征，因误下所致，原文以附子泻心汤主之，附子可用，而芩连必不可用，何也？恶寒者，阳衰之验，汗出者，亡阳之机，心下痞者，阴邪上逆之据，法宜大剂扶阳宣散为是，学者宜细察之。

【阐释】本条系《伤寒论》、、三条合并而成。“脉浮而紧”至“气痞耳”为一节，说明痞的成因与证状；“心下痞”至“大黄黄连泻心汤主之”为第二节，此热痞的证治；“心下痞”至“附子泻心汤主之”为第三节，此痞证而兼阳虚的证治。郑氏对第三节所按：“附子可用，芩、连必不可用。”发人深省。笔者认为可用附子理中汤扶阳抑阴，加半夏、砂仁健脾降逆为当。

大黄黄连泻心汤（校补）

大黄二两黄连一两上二味，以麻沸汤①二升渍之，须臾绞去滓，分温再服。

附子泻心汤方（校补）

大黄二两黄连一两黄芩一两附子一枚（炮，去皮，破，别煮取汁）上四味，切三味，以麻沸汤二升渍之，须臾绞去滓，内附子汁，分温再服。

①麻沸汤：即沸水。汪苓友曰：麻沸汤者，熟汤也，汤将熟时，其面沸泡如麻，以故云麻。渍之：用沸水泡药，而不用煎熬。

【方解及其应用范围】大黄黄连泻心汤为泻火泄热之剂。大黄苦寒，急泻上炎之火；黄连泻中焦邪火，清热消痞。二药仅用沸汤渍泡，取汁饮服，重在清中焦之热邪而不主泻下。

故凡不恶寒，但恶热，心下痞闷不舒，按之膨满而微有抵抗，自觉烦热，热气上冲，头痛，面赤等，都可治之。《金匱》用治“心气不足，吐血、衄血。”此气盛火旺，逼血妄行也。近人推广治疗炎性的胃肠病，和一般突发的充血性疾病，如高血压等，更广泛用于热盛之吐血，疗效可靠。附子泻心汤即上方加黄芩、附子，为寒热并用，温清兼施，正邪两顾之和剂。三黄泄热消痞，仅用沸水渍泡取汁，附子久煮，取浓汁。合和与服，取寒热异其气，生熟异其性药虽同行，而功则各奏。故凡证属实热而体属阳虚之胃病或吐血鼻衄等病，都可适用。

三十一、伤寒五六日，呕而发热者，柴胡汤证具，而以他药下之②，柴胡证仍在者，复与柴胡汤，此虽已下之，不为逆，必（兼之）〔蒸蒸而振〕③，却发热汗出而解。若心下满而鞭〔痛〕者，此为结胸也，大陷胸汤主之（可也）。但满而不（病）〔痛者〕，此为痞，柴胡汤不中与之，宜半夏泻心汤。

②他药：即承气之类，非有别药也。

③蒸蒸而振：蒸蒸，身热汗欲出之状也；振者，振振然动摇之貌，即寒战也。

郑论：按柴胡汤证具，而以他药下之，柴胡证仍在者，是下之而邪未深入，尚在少阳，故不为逆，若下之而转变别症，少阳证全无者，则是下之过，咎无可辞。若心下满而鞭，虽名结胸，究竟务要察其虚实，果系有邪热结于心下者，可与大陷胸汤。若系下之失宜，而阴寒水湿上逆而作者，犹宜温中降逆，化气行水方是。所云满而不（病）〔痛〕则为痞，原非柴胡汤所宜。以半夏泻心汤，确乎有理，至于方中芩连，似觉不当，学者察之。

【阐释】此条乃柴胡汤证具，误下后的三种病变。其一是虽误下而证未变，所以仍用原方治疗。其二是病转结胸的证治，又有两种情况，果系有邪热结于心下者，可与大陷胸汤；若阴寒水湿上逆而作者，则宜温中降逆，化气行水，可用附子理中汤加肉桂、砂仁、半夏、茯苓治之。其三是转痞满的证治，亦即是心下满而不痛的痞证，则宜用半夏泻心汤治疗。郑氏提出方中芩连，似觉不当，应用时宜详加审察，示人以慎重之意。

半夏泻心汤方（校补）

半夏半升（洗）黄芩、干姜、人参、甘草（炙）各三两、黄连一两大枣十二枚（擘）上七味，以水一斗，煮取六升，去渣，再煎取三升，温服一升，日三服。须大陷

胸汤者，方用前第二法。原注云：“一方用半夏一升”

【方解及其应用范围】柯韵伯云：“即小柴胡汤去柴胡加黄连干姜也。不往来寒热，是无半表证，故不用柴胡，痞因寒热之气互结而成，用黄连干姜之大寒大热者，为之两解也。”但下后中虚，所以用参草大枣以补正。近代推广应用治疗胃肠道疾病，如急慢性胃肠炎、消化不良、食欲不振，脏寒肠热之泄泻等，都有一定疗效。

三十二、本以下之，故心下痞，与泻心汤①，痞不解，其人渴而口（烦燥）〔燥烦〕②，小便不利者，五苓散主之。

①泻心汤：即大黄黄连泻心汤。

②燥烦：即口燥心烦。

郑论：痞由误下而致，服泻心汤而不解，又复见（烦燥）〔燥烦〕口渴，小便不利，原文以五苓散主之，可见初非下症，实太阳之症。因下而引入太阳之腑也。可见医家不可妄下，总要斟酌妥贴为妙。

【阐释】痞由误下而成，本条痞证是水饮内停，津液不行所致，故有渴而口燥心烦，小便不利等。如郑氏所说：“实太阳之症，因误下而引入太阳之腑，”故五苓散为对症之良方。

三十三、伤寒服（泻）〔汤〕药，下利不止，心下痞鞭，服泻心汤已，（后）〔复〕以他药下之，利不止，医以理中与之，利益甚，理中者，理中焦①，此利在下焦②，赤石脂禹余粮汤主之。复（利）不止者，当利其小便。

①理中者，理中焦：说明理中汤的作用是调理中焦脾胃。

②下焦：是指病在下部。

郑论：据所称伤寒，服（泻）〔汤〕药下利不止，而至心下痞，明是下伤胸中之阳，遂使浊阴僭居高位而成痞，虽服泻心汤而病未解，又复下之，一误再误，所失愈多，医（一）〔以〕理中汤治之，下利益甚。非下利甚之可怪，实由中州转运，而积阴下泄，虽泄甚一时，而收功已在旦夕，昧者不察，以为病在下焦，非理中可了，又复以赤石脂禹余粮汤治之，仍不效，而曰当利小便，不知下利，有小便尚利者，有小便不利者，不利者可利，而小便利者决不可利。以余所见，全是误下所致，理中是不易良法，理中内加桂、苓、砂、半是绝妙法，原文所论之方，皆在似是而非之例，学者详细辨之。

【阐释】本条指出，下后再次误下，有各种不同病情，应根据辩证论治的精神来处方治疗。如下后痞鞭下利，而胃脘部痞鞭偏甚的，宜用泻心汤；如中焦虚寒的，宜用理中汤。如下利不止，下虚滑脱的，可用赤石脂禹余粮汤；如属清浊不分，小便不利的，可用五苓散，小便一利，便可减少大便中水分，有利于下利不止的治疗。郑氏认为全是误下所致，理中是不易良法，理中内加桂、苓、砂、半是绝妙法，亦可遵从。

赤石脂禹余粮方（校补）

赤石脂一斤（碎）太一禹余粮一斤〔碎〕上二味、以水六升，煮取二升，去渣，分温三服。

【方解及其应用范围】柯韵伯云：“大肠之不固，仍责在胃，关门之不紧，仍责在脾，此二味皆土之精气所结，能实胃而涩肠，凡下焦虚脱者，以二物为末，参汤调服，最效”。

此方亦可用于大肠咳嗽，咳则遗矢。李东垣谓：“固涩止咳”。

三十四、伤寒发热，汗出不解，心中痞鞭，呕吐而下利者，大柴胡汤主之。

郑论：按伤寒发热，有风伤卫之发热，寒伤营之发热。出汗，有风伤卫之出汗，有阳明热甚之出汗，有少阴亡阳症之出汗。而此只云：发热汗出不解，是用桂枝解表之剂而出汗不解乎？是用麻黄解表而发热汗出不解乎？此中全无实据。言阳越于外发热也可，言汗出亡阳也可。又云：心中痞鞭，呕吐下利，全是太阴病情，则于太阳症不合，至于大柴胡汤，则更属不合也，学者盍察之。

【阐释】此条郑氏提出种种疑问，以及心中痞鞭，呕吐下利，证属太阴，皆值得学者辨证时深思，大柴胡汤为和表清里之剂，与病症不合，不可用矣。舒驰远更说：“大柴胡汤不可用，仲景必无此法”。方见“过经不解”一条。

三十五、伤寒发汗，若吐若下，解后①，心下痞〔鞭〕，噫气不除者②，旋复代赭石汤主之。

①解：谓大邪已散去。

②噫气：即饱食息也。俗曰打饱呃。

郑论：按伤寒病，至用汗、吐、下三法，外病已解，而见心下痞，噫气不除者，由或汗、或吐、或下，伤及胸中之阳，以致浊阴上干，逆于心下，阻其升降之气机而

为噫。以旋复代赭石汤主之，实属至当之法。

【阐释】本条为伤寒大邪解后，虚气作痞的治法。郑氏释“噫气不除者，伤及胸中之阳，以致浊阴上干，逆于心下，阻其升降之气机而为噫”。实属至当，主以旋复代赭石汤，为确切不易之方矣。

旋复代赭石汤方（校补）

旋复花三两人参二两生姜五两代赭一两甘草三两（炙）半夏半升（洗）大枣十二枚（擘）上七味，以水一斗，煮取六升，去渣，再煎取三升，温服一升，日三服。

【方解及其应用范围】本方以人参、甘草养正补虚，姜、枣和脾养胃，半夏以蠲饮降浊，更以代赭石之重，使之敛浮镇逆，旋复花之辛，用以宣气涤饮。浊降则痞鞭可消，清升则噫气可除。现多用于慢性胃肠病，胃气上逆，眩晕呕吐，胸痞，痰多而粘，食不下，大便秘结，噎膈反胃等。

三十六、病胁下素有痞，连在脐旁，痛引少腹，入阴筋者①，此名脏结②，死。脏结无阳症③，不往来寒热，其人反静，（则）舌上苔滑者，（而）不可攻也。、

①入阴筋：指睾丸而言，此指阴jing缩入。

②脏结：脏气结塞不通的意思。

③阳症：指发热、头痛、身疼、口渴等阳性证状。

郑论：两胁属肝地面，素有痞连在脐旁，是阴寒久聚于厥阴而未解，阴邪甚则痛直入阴筋，故决其死。而曰脏结者，肝为阴脏故也。无阳症，不往来寒热，其人安静，舌滑苔，则是阴症之实据，言不可攻，是教人不可妄用药以攻其结也。

【阐释】此条《伤寒论》原书分作两条：“病胁下素有痞，……此名脏结，死”。为第一节，此言脏结的痞属极危候。痞症之结深结久，惟阴无阳，阴气过极，阳气竭绝，故死。第二节为“脏结无阳症……不可攻也。”继续说明脏结证的属性，是纯阴无阳，虽有如结胸的鞭满证状，慎不可攻，若误攻之，则犯虚虚之戒。此条有论无方，前节言死，后节言不可攻。笔者认为可用大剂四逆汤、白通汤以回阳，或当于十百中挽救一二，亦是尽治病之道而已。

三十七、问曰：病有结胸④，有（结脏）〔脏结〕⑤，其状何如？

答曰：按（则病）〔之痛〕，寸脉浮，关脉沉，名曰结胸也。何为（结脏）〔脏结

〕？答曰：如结胸状，饮食如故，时时下利，寸脉浮，关脉小、细、沉、紧，名曰脏结，舌上白苔滑者⑥，难治。

④结胸：证候名，主要证状是心下鞭痛（胃脘部）。

⑤脏结：证候名，证状与结胸相似，而性质不同，为脏气虚寒而结。

⑥舌上白苔滑：就是舌上有白色的滑苔。

郑论：按结胸、脏结两症，答曰寸浮、关沉紧；寸浮、关细沉紧，皆非确论。若寸浮、关沉而不结胸；寸浮、关细沉紧而不脏结，则又当何说？以余鄙见，当时胸高突起，结于胸之上部者，可名结胸。如物盘状，结于少腹两侧，或在脐旁，可名脏结。然后以脉象参之，庶为近理。若仅以脉象而论，恐未必尽如是说也，学者须知。

【阐释】本条《伤寒论》原书分为两条。“问曰……名曰结胸也”为一条；“何为脏结……难治”又为一条。郑氏说：不能只凭脉辨结胸与脏结，而应结合证状参之。如胸高突起，结于胸之上部者可名结胸；如物盘状，结于少腹两侧，或在脐旁，可名脏结。必这样辨结胸与脏结，方为恰当。亦即对证候的诊断，四诊缺一不可。

三十八、伤寒六七日，结胸热实①，脉沉〔而〕紧，心下痛，按之石鞭者，大陷胸汤主之。

①结胸热实：是说结胸证属热属实，与寒实结胸相对而言。

郑论：此条明言热邪盘聚胸中，以致心下痛，按之如石鞭，故取大陷胸汤以治之，急欲逐去热邪之意也。前太阳上篇三十七条内云：脉浮者必结胸，此何不见脉浮也？脉沉紧者，必欲呕，此何不见呕也？总之，专以脉定病，决乎〔不〕可，况气机变化莫测，焉能以二十八脉象，以定亿万病象乎？学者切不可为脉所囿，则得矣。

【阐释】此节乃未经误下而成结胸之证也。伤寒六七日，寒不外解，而反化热入里，故曰结胸热实。提出热实二字，恐人以沉紧之脉而误认为寒实结胸也。

此证寒化为热，而与有形之水，搏结于心下，故按之石鞭而痛也。治以大陷胸汤，泻热逐水，得快利，则病自愈矣。郑氏曰：“专以脉定病，决乎不可。”必需四诊合参，方能探得病原，辨证处方，斯为得矣（此条舒本列为条，郑书列为条，按理应列为条，故从舒本将此条移前。郑书条移为条，以下依次顺移）。

三十九、小结胸（症）〔病〕，〔正〕在心下，（若）按之则痛，脉浮滑者，（小

者）小陷胸汤主之。

郑论：既名结胸，何分大小，要知有热结于胸者，有寒结于胸者，有痰结于胸者，有食结于胸者，总要分辨的确，庶无差错。若小陷胸汤，与热结者宜，而非寒、痰、食所宜，即以原文脉之浮滑而论，浮主风，而滑主痰，宜是内痰，若小陷胸汤，则未必妥切。

【阐释】小结胸症，有热结于胸者？小陷胸汤为正治之方。若寒结、痰结、食结于胸者，则非小陷胸汤所宜。笔者在临症中，对寒结于胸者，用大黄附子细辛汤；因痰结于胸者，则用苓桂朮甘汤加附子以温化之；若食积结胸者，选用加味平胃散。此皆屡用屡效之方也。

小陷胸汤方（校补）

黄连一两半夏半升（洗）栝蒌实大者一枚上三味，以水六升，先煮栝蒌，取三升，去渣，内诸药，煮取二升，去渣，分温三服。

【方解及其应用范围】本方用黄连苦寒以清热，半夏辛燥而祛痰，栝蒌实甘寒滑润，既可助黄连以清热，又可助半夏以化痰，药力较大陷胸汤为缓，故称为小陷胸汤。因本方有清热、开结、化痰之作用，推广应用于呼吸系统及消化系统疾病，如急性慢性胃炎、支气管炎、肺炎、胸膜炎等呈痰热结于胸脘之证者。

四十、伤寒十（条）〔余〕曰，热结在里，复往来寒热者，〔与〕大柴胡汤（主之）。但结胸（而）无大热者①，此为水结在胸胁也，但（欲）〔头〕微汗出者，大陷胸汤主之。

郑论：据所称热结在里，是见小便短赤乎？是见大便闭塞乎？

是见舌苔干黄、大渴饮冷乎？务要有一定实据，原文笼统言之，学者当于病情处探求，果见大便不利，复往来寒热者，大柴胡汤可用。又云：结胸而无大热者，此为水结在胸胁，但（欲）〔头〕微汗，原文以大陷胸主之，既以无大热，而为水结胸胁明是中宫不宣，水逆不行；法宜温中、健脾、行水为是，若大陷胸汤，断乎不可。

【阐释】热结在里，必要有里热之实据，复往来寒热，则大柴胡汤可用。若水结在胸胁，明是中宫之阳不能传运，水流入胁而结聚，应如郑氏所说：“当温中、健脾、行水，大陷胸汤断乎不可”。此证可用理中汤加砂、半、茯苓治之。

四十一、伤寒六七日，发热微恶寒，肢节烦疼②，微呕，心下支结③，外证未去者

，柴胡桂枝汤主之。

①无大热：指邪热传里，表无大热。

②肢节烦疼：四肢关节疼痛之甚。

③心下支结，心下感觉支撑闷结。

郑论：按伤寒至六七日，所现仍是太阳表证病情，但有微呕，则柴胡桂枝汤可用。至于心下支结，是太阳寒水之气上逆所致也，当于方中加茯苓、砂、半，庶为恰切。

【阐释】发热微恶寒，肢节烦疼，此是太阳表证未除的现象；同时又现轻微呕吐，并感觉心下支撑闷结，此即少阳证之轻者。两经证状都比较轻微，所以用桂枝汤、柴胡汤各取原方之半，双解两经之邪。

柴胡桂枝汤方（校补）

桂枝一两半（去皮）黄芩一两半人参一两半甘草一两（炙）半夏二合半（洗）芍药一两半大枣六枚（擘）生姜一两半（切）柴胡四两上九味，以水七升，煮取三升，去渣，温服一升。本云：人参汤作如桂枝法，加半夏柴胡黄芩，复如柴胡法，今用人参，作半剂。

【方解及其应用范围】此小柴胡与桂枝汤两方各半合剂而成。桂枝汤疏通营卫，解太阳之邪，则发热、微恶寒、支节烦疼除；以柴胡汤和少阳半表半里之邪，则微呕、心下支结自愈。现推广应用以治感冒，疟疾、在表之风湿性关节炎，凡与本方病机相符者，均可使用。

四十二、伤寒八九日，下之，胸满烦惊，小便不利，谵语，一身尽重，不可转侧者，柴胡加龙骨牡蛎汤主之。

郑论：按此条果系下证，下则病去无遗，何至有胸满烦惊，小便不利，谵语，一身尽重不能转侧者？明是下伤胸中之阳，以致浊阴上泛，而为胸满烦惊者，心肾之阳为下所伤也。小便不利者，下焦之阳衰，不能化下焦之阴也。谵语者，浊阴上闭神明昏乱也。一身尽重不能转侧者，少阴之阴寒甚，而无阳以化也。法非四逆、白通不能了。若原文之方，决不妥当

【阐释】郑氏对此条，其见解独特，与历代注家不同。果系下证，下之则病去无遗，何致有胸满烦惊，小便不利等证状，明是伤及中下焦之阳，柴胡加龙骨牡蛎汤则

非对症之方。而又当用四逆、白通以扶中下焦之阳，则诸证自愈。笔者信之而不疑。

柴胡加龙骨牡蛎汤方（校补）

柴胡四两龙骨、黄芩、生姜（切）铅丹、人参、桂枝（去皮）茯苓各一两半半夏二合半（洗）大黄二两牡蛎一两半（熬）大枣六枚（擘）上十二味，以水八升，煮取四升，内大黄切如碁子，更煮一两沸，去渣，温服一升。本云柴胡汤，今加龙骨等。

【方解及其应用范围】本方系柴胡桂枝二汤合方，去芩、芍、甘草，加龙骨、牡蛎、茯苓、大黄、铅丹。柴胡、桂枝解外而除身重，龙、牡、铅丹镇内而止烦惊，大黄和胃气止谵语，茯苓利小便，人参、姜、枣益气养营，扶正驱邪。如是则错杂之邪，庶可内外尽解。本方有和解少阳，疏肝和胃，清热镇惊之作用。多用于治疗神经系统方面的病证；或肝胆气郁、惊痰，与治癫痫多效。

四十三、伤寒脉结代①，心动悸（者）②，炙甘草汤主之。（一名复脉汤）〔脉〕按之来缓，（而）时一止复来者，名曰结。又脉来动而中止，更来小数，中有还者反动，名曰结，阴也。脉来动而中止，不能自还，因而复动〔者〕，名曰代，阴也，得此脉者，（为）〔必〕难治。、

①脉结代：是结脉和代脉的并称。景岳说：“脉来忽止，止而复起，总谓之结。”代者更代之意，于平脉中忽见软弱，或乍疏乍数，或断而复起，均名为代。

②心动悸：心脏筑然悸动。

郑论：据脉而论，结促之止，止无常数，代脉之止，止有常数。结促之脉，病尚可治者多，而代脉之见者，十难九痊，仲景以复脉汤主之，亦是尽治病之道而已。

【阐释】心血不足，心阳不振，则脉见结代。两脉的特征，都是脉的搏动间有歇止。结脉之止无常数，或三五至一止，旋又八九至一止，旋二三十至一止，前后参差，无一定之止也。代脉止有定规，如十五至处歇止，其第二候亦在十五至歇止，第三候仍在十五歇止，谓之止有定数。这两种脉都为气血虚惫，而脉之搏动正常，都是阴阳营卫调协之功。倘阴阳失调，气血因虚不能正常运行，皆属难治。笔者在临症中，脉见结者，除用炙甘草汤外，并用大剂回阳饮扶阳驱阴治之而愈。至代脉者，甚属罕见，虽用大剂四逆、炙甘草汤之类，收效甚微。诚如郑氏所说：“结促之脉，病尚可治者多，而代脉之见者，十难九痊”。非虚语矣。

炙甘草汤方（校补）

甘草四两（炙）生姜三两（切）人参二两生地黄一斤桂枝三两（去皮）阿胶二两麦门冬半升（去心）麻仁半升大枣三十枚（擘）上九味，以清酒七升，水八升，先煮八味，取三升，去渣，内胶烊消尽。温服一升，日三服。一名复脉汤。

【方解及其应用范围】本方以炙甘草为君，养胃益气，人参补气，桂枝通阳，生地、麦冬、麻仁、阿胶养阴补血，姜、枣调和营卫，又加清酒通经隧，则脉复而悸自宁矣。据现代药物之研究，甘草有强心的作用，故以为主药。其方具有滋阴生血，补气复脉之功。后世滋补方剂，多从此方化裁而出。本方气血双补，阴阳两调，为治心动悸、脉结代首选方。现推广用来治心血管疾病，如各种原因引起的心律失常，凡心肌炎、冠心病、风心病，肺心病、以及冠状动脉硬化、动脉硬化等，只须见脉结代、心动悸者，均可采用。而在应用时，当根据病证偏阳虚或偏阴虚进行加减，如偏于阳虚者，可加附片、黄芪、肉桂；偏于阴虚者，可加枸杞、山药。

四十四、伤寒，医下之，续得下利，清谷①不止，身疼痛者，急当救里；（复）〔后〕身疼痛，清便②自调者，急当救表。救里宜四逆汤，救表宜桂枝汤。

①清谷：清古与“圉”通，清谷就是腹泻而食物不化的意思。

②清便：就是解大便。

郑论：救表救里两法，颇与病符，不再赘。

【阐释】表证误下后，里气大虚，此指肠胃虚寒，竟至完谷不化，其严重程度可知，此时虽有身疼痛之表证，亦无暇顾及。因里气虚寒，如再行解表，必将造成虚脱之危候，故急当用四逆汤以救里。俟大便正常，尚有身疼痛等表证，再用桂枝汤以解表。

四逆汤方（校补）

甘草二两（炙）干姜一两半附子一枚（生用，去皮，破八片）上三味，以水三升，煮取一升二合，去渣，分温再服，强人可大附子一枚，干姜三两

【方解及其应用范围】四逆汤一方，乃回阳救逆之主方。干姜、附子为纯阳大热药，附子是一团烈火也。凡人一身，全赖一团真火，真火欲绝，故病见纯阴。仲景用之以补先天欲绝之火种，故用之以为君。干姜辛烈温散，能荡尽阴邪之阻塞，使附子能直入根蒂，火种复兴，而性命立复，故曰回阳。阳气既回，若无土覆之，光焰易熄，虽生不永，故继以甘草之甘，以缓其正气，缓者即伏之之意也。真火伏藏，命根永固，故得重生也。《伤寒论》原文治下利清谷，三阴厥逆，恶寒，脉沉而微者。

前哲谓：寒病多为阳虚，而四逆汤亦不独为少阴立法。凡太阳病脉沉与寒入三阴及一切阳虚之证，俱能治之。郑氏在《医法圆通》中说：“少阴为水火交会之地，元气之根。四逆汤不专为少阴立法，而上、中、下三部之法俱备”。随即举出其圆通应用法：（1）治头脑冷，（）治气喘痰鸣，（）治耳肿皮色如常，（）治舌黑唇焦，不渴少神，（）治喉痛、畏寒、脚冷，（）治喉痛、身大热、面赤、目瞑、舌冷，（）治吐血困倦，（）治齿缝流血，（）治朝食暮吐，完谷不化，（10）治足心夜发热如焚，不渴尿多，（）治面赤发热，汗出抽掣，（1）治大便下血，气短少神，（）治头摇，面白少神，（）治背冷目瞑，（）治舌肿鞭而青，（）治唇肿而赤，不渴，（）治鼻涕如注，面白少神，（）治尿多，（）治周身发起包块，皮色如常，（）治周身忽现红片如云，不热不渴，（）治发热、谵语、无神、不渴，（）治两目白睛青色，（）治两目赤雾缕缕，微胀不痛。最后郑氏说：“此方功用颇多，得其要者，一方可治数百种病，因病加减，其功用更为无穷。余每用此方，救好多人，人咸目余为姜、附先生。”的确，对于四逆汤能起死回生作用的重现，与善用之而活人无算，直可说是前无古人。笔者在临床中，细思此方既能回阳，则凡世之一切阳虚阴盛为病者，皆可服也，何必定要见四肢厥逆，腹痛下利，脉微欲绝等症而始用之，一见是阳虚症，而即以此方在分两轻重上斟酌，效如桴鼓，从未发生任何副作用，实由郑氏三书之教导也。

四十五、伤寒下后，心烦腹满，（起卧）〔卧起〕不安者，栀子厚朴汤主之，原文

郑论：按下后，至心烦腹满，起卧不安，总缘下伤中宫之阳，遂至浊阴上壅，而为腹满，脾胃之精气，不能上输于心，故心烦，此病理应温中扶阳，何得更行清热破滞之品，庶觉不合。若果系热邪，下后而仍旧弥漫，有热象可凭，则原文定不可少，学者须知。

【阐释】下后至心烦腹满，起卧不安，诚如郑氏所说，有两种不同情况。下伤中宫之阳者，应温中扶阳，理中汤是也。下后热邪弥漫，有热象可凭，方可用栀子厚朴汤栀子厚朴汤方（校补）

栀子十四个（擘）厚朴四两（炙，去皮）枳实四枚（水浸，炙令黄）上三味，以水三升半，煮取一升半，去渣，分二服，温进一服，得吐者，止后服。

【方解及其应用范围】张隐庵云：“栀子之苦寒，能泄心中之烦热，厚朴之苦温，能消脾家之腹满，枳实之苦寒，能解胃中之热结。”合之则清热除烦，气行则满自解。

四十六、伤寒，医以丸药大下之，身热不去，微烦者，栀子干姜汤主之。

郑论：按大下非微下可比，既称大下，岂有邪下而不去之理乎？尚见身热微烦，吾

恐阳从外脱，已在几希，若更吐之，能不速其亡乎？

【阐释】大下之后，损及脾胃之阳，形成中焦有寒。从条文中看，身热不去，微烦，此上焦有热。治以栀子清上热，即所以除烦，干姜温中散寒。笔者不知郑氏所指“若更吐之，能不速其亡乎”之意也！

栀子干姜汤方（校补）

栀子十四个（擘）干姜二两上二味，以水三升半，煮取一升半，去渣，分二服，温进一服（得吐者止后服）。

【方解及其应用范围】栀子苦寒，清热除烦；干姜辛热，温中散寒。寒热异性，功用不同，有是病即用是药，有何不可。此为寒热并用之方剂，亦即温清两行的治法。至方后所云：“得吐者止后服”。此不通之论，宜删去。

四十七、伤寒五六日，大下之后，身热不去，心中结痛者①，未欲解也，栀子豉汤主之，发汗若下之，而烦热胸中窒者②，栀子豉汤主之。发汗吐下后，虚烦不得眠，若剧者，必反复颠倒，心中懊侬③，栀子豉汤主之。若少气者④，栀子甘草豉汤主之。若呕者，栀子生姜豉汤主之。凡用栀子汤，病人旧微溏者⑤，不可与服之。、后段、

①结痛：是一种支结而痛，由胸中窒塞不通进一步发展而成。

②烦热：胸中烦闷而热的感觉。胸中窒：胸中痞塞不舒的感觉。

③懊侬：虚烦之剧，自觉心中烦乱不宁。

④少气：呼吸时若不能接续的意思。

⑤旧微溏：指病人平素大便溏薄。

郑论：按伤寒（病）四十七条内，用汗、吐、下三法，所用方，总以栀子豉汤、栀子甘草豉汤、栀子生姜豉汤。以余所见，务要果有热象足征，方可酌用。设若下后发热，而有阳从外越者，因发汗而有阳外出者，因吐后气机因而上浮者，此中大有经权，学者切勿以栀豉等汤，定为可恃也，汗下定要下细探求。

【阐释】郑氏将《伤寒论》原书条后段及条条合成条，其所述皆是汗吐下后余热留扰胸隔的证状与治法，最后一节为用栀豉汤的禁例。

以上诸方之应用，务要果有热象足征，否则不要轻投。若下后发热，有阳从外越者；因发汗而有阳外出者，因吐后气机上浮者。必须细心探求辨证，故郑氏告诫切勿以梔豉等汤，定为可恃也。

梔子豉汤方（校补）

梔子十四个（擘）香豉四合（绵裹）上二味，以水四升，先煮梔子，得二升半，内豉，煮取一升半，去渣，分为二服，温先一服（得吐者，止后服）。

梔子甘草豉汤方（校补）

梔子十四个（擘）甘草二两（炙）香豉二两（绵裹）上三味，以水四升，先煮梔子甘草，取二升半，内豉，煮取一升半，去渣，分二服，温进一服，得吐者，止后服。

梔子生姜豉汤方（校补）

梔子十四个（擘）生姜五两香豉四合（绵裹）上三味，以水四升，先煮梔子生姜，取二升半，内豉，煮取一升半，去渣，分二服，温进一服，得吐者，止后服。

【方解及其应用范围】按梔豉汤一方，乃坎离交济之方，非涌吐之方也。夫梔子色赤、味苦、性寒，能泻心中邪热，又能导火热之气下交于肾，而肾脏温。豆形象肾，制造为豉轻浮，能引水液之气上交于心，而心脏凉。一升一降，往来不乖，则心肾相交矣。仲景以此方治汗、吐、下后虚烦不得眠，心中懊侬者，是取其有既济之功。由于方后注云；“得吐者，止后服”，故许多注家据此说本方为涌吐之剂，名医家如柯韵伯、汪昂亦因袭其说，以讹传讹，越错越远。独不思仲景既列此方于汗、吐、下后虚烦之证，犹有复吐之理哉！梔子生姜豉汤即梔子豉汤加生姜一味，由于在梔子豉汤证的基础上有呕的兼证，所以加生姜以降逆止呕，如梔豉汤有催吐作用，仲景又为何选用梔子生姜豉汤来止呕耶？如果少气无力则梔子豉汤中加甘草以补中益气。上三方后皆云：“得吐者止后服”，皆已删去。

四十八、下之后，复发汗，必振寒①，脉微细，所以然者，以内外俱虚故也。。

①振寒：振栗恶寒的意思。

郑论：按汗、下两法，皆在要有可汗、可下之（列）〔例〕，当汗而不汗不可，当下而不下亦不可，汗、下均是祛邪之良法，若汗、下而不去，则正必亏，汗则伤阳，下则伤阴，阴阳两伤，岂有脉不细而不振寒者乎？原文故称内外俱虚，此刻只宜大固元气，不可疏忽。

【阐释】下之虚其里，汗之虚其表，是阴阳俱虚。振寒、脉微是阳气虚，脉细是阴血不足。汗下后见此脉证，为内外俱虚之危候，当以阳虚为主。郑氏谓此刻只宜大固元气，不可疏忽。笔者认为应以四逆加人参汤主之，四逆以回阳，人参益阴。

四十九、下之后，复发汗，昼日烦（燥）〔躁〕，不得眠，夜而安静，不（吐）〔呕〕不渴，无表证，脉沉微，身无大热者，干姜附子汤主之。

郑论：按汗下太过，足以损伤元气，至昼而烦（燥）〔躁〕，不得眠，其表阳之虚也明甚。但阴阳之道，昼宜不眠，从阳也，夜而安静，从阴也。今病昼烦（燥）〔躁〕，是伤在阳分一面，夜而安静，是未伤在阴分一面。不眠者，是烦（燥）〔躁〕已极，不能仰卧片时之意也。以附子干姜汤主之，实属妥切。

【阐释】下后又汗，内外阳气大虚，阴邪独盛，昼日烦躁不得眠，夜而安静，正是阳虚阴盛的表现。继提出不呕不渴，无表证，脉沉微，充分证明不是阳经热证的烦躁，而是阳气大虚，阴寒独盛的烦躁。用干姜附子汤大辛大热以回阳，单刀直入为不易之法也。

干姜附子汤方（校补）

干姜一两附子一枚生用（去皮切八片）上二味，以水三升，煮取一升，去渣，顿服①

①顿服：犹言一次服

【方解及其应用范围】本方是四逆汤去甘草而成，干姜、附子是辛热回阳药味，由于阴寒特盛，阳气大虚，故不用甘草，以免牵制姜、附回阳祛寒之功，方比四逆汤为峻。凡有少阴病见证、其中烦躁一证昼甚夜较安静为特出者，适用本方。

五十、伤寒若吐若下后，心下逆满，气上冲胸，起则头眩，脉（浮）〔沉〕紧，发汗则动〔经〕，身为振振摇（摇）者，茯苓桂枝白朮甘草汤主之。

郑论：按此由吐、下，伤及胸中之阳，以致浊阴上干，逆于心下，气逆上冲太甚，故头眩，发汗伤阴，筋脉失养，故见筋惕肉瞤之状，此刻只宜大剂扶阳，若原文之茯苓桂枝白朮甘草汤，恐力不足以当此任。

【阐释】伤寒吐、下后伤及胸中之阳，而水饮上逆，身为振振摇者，此说明不可汗，发汗则犯虚虚之禁。郑氏谓只宜大剂扶阳，若原文之茯苓桂枝白朮甘草汤，恐力不足以当此任。笔者认为可原方加附片，或用茯苓四逆汤亦可。

茯苓桂枝白朮甘草沕方（校补）

茯苓四两桂枝三两（去皮）白朮、甘草各二两（炙）上四味，以水六升，煮取三升，去滓，分温三服。

【方解及其应用范围】按苓桂朮甘汤一方，乃化气行水之方也。夫桂枝辛温，能化膀胱之气，茯苓、白朮健脾除湿。化者从皮肤而运行于外，除者从内行以消灭于中，甘草补土又能制水。除用以治本条阳虚水停之心下满头眩等证外，笔者用治一切脾虚水肿及痰饮咳嗽、哮喘，皆取得满意疗效○现代有人用以治高血压、脑震荡、带下、溃疡、风湿性关节炎及心力衰竭诸病，均取得较好效果。

五十一、伤寒，吐下后，发汗，虚烦，脉甚微，八九日心下痞鞭，胁下痛，气上冲咽喉，眩冒，经脉动（摇）〔惕〕者，久而成痿①。

①痿：是一种证候的名称，主要证状是两足软弱不能行动。

郑论：按汗、吐、下以致虚烦，脉微，元气之衰可知，至八九日，心下痞鞭，经脉动，原文以为久而成痿，此全是亏损太过，寒水弥漫，阴逆上冲，故见胁下痛，与咽喉眩冒，经脉动者，皆汗、下、吐伤及血液，以致筋脉失养，成痿者，言气衰而不振也。

【阐释】吐下后又复发汗，阴阳气血俱虚，不能濡养筋脉，久而成痿。郑氏曰：“此全是亏损太过。”但此处所指之痿，与杂病中的湿痿、寒痿、热痿是不完全相同的，故治法亦不相同。仲景对此条虽未出方治，但根据从证测药的法则，以及与上条之苓桂朮甘汤证颇有相同之处。笔者认为即可用上方重加附子合当归补血汤治之，庶几合拍。

五十二、伤寒有热，少腹满，应小便不利，今反利者，为有血也，当下之，不可余药②，宜抵当丸。

②不可余药：不可用其它的药。

郑论：（具）〔据〕喻嘉言先生云：伤寒蓄血，较中风蓄血，更为〔凝〕滞，故变汤为丸，而连渣服之，所以求功于必胜也。

【阐释】此节乃蓄血之轻证也。伤寒有热，少腹满是邪在下焦，应小便不利，今反利者知为有瘀血之候也，宜抵当丸缓下之。

抵当丸方（校补）

水蛭二十个（熬）虻虫二十个（去翅足熬）桃仁二十个（去皮尖）大黄三两上四味，捣分四丸，以水一升，煮一丸，取七合服之。晬时当下血③，若不下者更服。

③晬时：周时也，从今旦至明旦。

【方解及其应用范围】本方药物完全和抵当汤相同，其方解可参阅抵当汤条。但因改为丸药剂型，药物吸收缓慢，故其下血破瘀的作用，比抵当汤为和缓，但较之桃仁承气汤的药力，则仍为猛烈。

五十三、伤寒八九日，风湿相（持）〔搏〕①，身体烦疼，不能自转侧，不呕不渴，脉浮虚而涩者，桂枝附子汤主之。若其人大〔便〕鞭，小便自利者，去桂（枝）加白朮汤主之。

①风湿相搏：犹言风湿并至，风湿交作的意思。

郑论：按身体烦疼，乃风湿之的候，不能转侧，乃湿邪流入关节，阻滞之征，不呕不渴，脉虚浮者，湿邪之验，原文以桂枝附子汤，温经散寒除湿之意。若其人大便鞭，小便自利，由中宫气弱，不能输津液于大肠，故大便鞭，小便自利，加白朮者，培中土之意，实为妥贴。

【阐释】所谓风湿病，就是风邪与湿邪合并为病。风为阳邪，风淫所胜，则周身疼痛，湿为阴邪，湿淫所胜，则肢体重，难于转侧。治以桂枝附子汤，乃温经散寒除湿之意也。若小便自利，是湿邪能从下泄，所以大便变鞭，湿邪既欲下泄，即当因势利导，所以去解表之桂枝，加燥湿健脾之白朮。湿去则津液自还，而大便之鞭结者自调。

桂枝附子汤方（校补）

桂枝四两（去皮）附子三枚（炮、去皮、破）生姜三两（切）大枣十二枚（擘）甘草二两（炙）上五味，以水六升，煮取二升，去渣，分温三服。

去桂加白朮汤（校补）

附子三枚（炮、去皮、破）白朮四两生姜三两（切）甘草二两（炙）大枣十二枚（擘）上五味，以水六升，煮取二升，去渣，分温三服，初一服，其人身如痹，半日许复服之，三服都尽，其人如冒状，勿怪。此以附子、朮，并走皮内，逐水气未得除，故使之耳。法当加桂四两。此本一方二法，以大便鞭，小便自利，去桂也，以大便不鞭，小便不利，当加桂。

附子三枚恐多也，虚弱家及产妇，宜减服之。

【方解及其应用范围】桂枝辛温，驱在表之风邪，附子辛热，逐在经之湿邪，甘草、大枣、生姜，辛甘化阳，相互配合以和营卫，五味成方，具有祛风温经，助阳散湿作用，为风湿盛于肌表之主方。本方治风湿相搏的身体疼烦，桂枝与附子用量特重。附子小量，则温经回阳，大量则力能镇痛。本方用附子三枚，而桂枝去芍药加附子汤，只用附子一枚，所以主治完全不同。本方减去桂枝之走表，加上白朮之燥湿健脾，用以治风湿病，见有大便秘，小便自利者，主要作用是使湿邪从小便而出。笔者常用此二方治风湿痹证（即风湿关节炎），但剂量重，有时附子用量达克，白朮克，取得满意效果。

五十四、风湿相（持）〔搏〕，骨节疼（痛）〔烦〕掣痛（而）不得屈伸①，近之则痛剧，汗出〔短〕气，小便不利，恶风不欲去衣，或身微肿者，甘草附子汤主之。

①掣痛：痛有牵引的感觉。

郑论：按风湿相〔持〕〔搏〕，明风与湿阻滞经脉，以致疼痛不能屈伸。近之则痛剧者，风湿之邪甚也。汗出〔短〕气，小便不利者，太阳为风所扰，气机不得下降，以致汗出而小便不利，恶风者，太阳风伤卫之验也，不欲去衣者，湿气滞内之验也。或身微肿者，风邪之实据也。以甘草附子汤主之，实属恰切。余意方中再加防风、云苓，更觉功速。

【阐释】本条是风湿留注关节的证状与治法。其证状比上条更重笃，上条疼痛仅不能转侧，这条更不得屈伸，近之则剧痛；上条小便自利，这条小便不利”；上条不呕不渴，这条汗出短气。短气、身微肿、小便不利、恶风不欲去衣，都是心阳衰弱的征象，亦即真阳之气化不行，则当以甘草附子汤主之。郑氏认为方中再加防风、云苓，更觉功速。盖前者以祛风，后者以除湿矣。

甘草附子汤方（校补）

甘草二两（炙）附子二枚（炮去皮破）白朮二两桂枝四两（去皮）上四味，以水六升，煮取三升，去渣，温服一升，日三服。初服得微汗则解，能食汗止复烦者，将服五合，恐一升多者，宜服六七合为始。

【方解及其应用范围】本方附子辛热，用以温经扶阳，除湿，白朮苦温，燥脾化湿，桂枝辛温合附子白朮同用，能温表阳而固卫气，甘草甘温，甘能缓和诸药，使猛烈的药物，缓缓发挥其作用。风湿之邪，留注在关节之内，若徒恃猛力驱散，风邪易去，而湿邪不易尽除，故用甘草为君药以名方，岂能忽视甘草之作用哉！笔者常

用此方加味治疗风寒湿邪留着关节之痹证。患者大多恶风、特别怕冷，骨节抽掣疼痛，不得屈伸，短气，小便不利，舌苔白滑，脉沉细。此表里阳气皆虚，致邪凝滞关节不解，用大剂甘草附子汤治疗，甘、附用量有时各至克，如郑氏所言，有时加茯苓、防风，虽十数年之顽疾，亦获满意效果。

五十五、伤寒发汗已，身目为黄，所以然者，以寒湿在里，不解故也，以为不可下〔也〕，于寒湿中求之。

郑论：既称发汗已，而曰身目为黄，明言此为阴黄，而非阳黄也。阳黄有热形可征，此无阳象实据，故曰寒湿中求之，明言阴黄无疑。法宜温中除湿为主。

【阐释】寒湿在里而成的黄疸，是为阴黄，病属太阴，与湿热在里的发黄，是为阳黄，病属阳明，自属不同。阴黄是脾胃中阳不足，寒湿内困，其黄晦暗，并有里寒见证，至其治法，郑氏云：“法宜温中除湿”。笔者常用附子理中汤加茵陈治之，屡用屡效者。

五十六、伤寒，瘀热在里，身必发黄，麻黄连轺赤小豆汤主之。

郑论：按瘀热在里，未必尽成发黄之症，是必有湿邪相凑方成。

【阐释】本条是外有寒邪，内有湿热，郁蕴不解的发黄证治。叙证甚简，从方剂的作用来理解，必有一系列的表证存在，如头疼体痛，恶寒无汗等，因病势偏重于表，故宜兼汗解以治之，清利湿热亦不可少，此麻黄连轺赤小豆汤之所以立也。

麻黄连轺赤小豆汤方（校补）

麻黄二两（去节）连轺二两杏仁四十个（去皮尖）赤小豆一升大枣十二枚（擘）生梓白皮一升（切）生姜二两（切）甘草二两（炙）上八味，以潦水一斗①，先煮麻黄再沸，去上沫，内诸药，煮取三升，去渣，分温三服，半日服尽。

①潦水：李时珍云“潦水乃雨水所积”，取其味薄不助湿气而利热。

【方解及其应用范围】方中麻黄、杏仁、甘草、生姜、大枣以发散表邪，赤小豆、连轺、生梓白皮以清泄湿热，主要使湿热郁蒸之邪从表而散。此表邪未解，瘀热在里的阳黄治法。

五十七、伤寒七八日，身黄如（紫）〔橘子〕色，小便不利，腹微满者，茵陈蒿汤主之。

郑论：此明主湿热在里，熏蒸而成，若小便利，则必不能发黄。因小便利，湿热之气不得下趋，故成此候。而曰腹微满者，太阳蓄尿之验也。以茵陈蒿汤主之，妥切。但此为蓄尿发黄，而非阳明发黄，原方可加入五苓方中，庶无大谬。

【阐释】本条是湿热发黄，当以清热利湿为治疗准则。由于湿热郁蒸在里，不得外达，又小便利，湿热不下行，故发黄，以茵陈蒿汤主之，甚为恰切。郑氏更进一层曰：“腹微满者，太阳蓄尿之验也”。此太阳腑证中之蓄尿证发黄，而非阳明发黄，故应原方加入五苓散，其效更佳，笔者从之。

五十八、伤寒身黄发热（者），栀子柏皮汤主之。

郑论：此言身黄发热，而在太阳，并非阳明，必是太阳之气，拂郁于皮肤，而成此候，原文以栀子柏皮汤，是从小便以逐邪之意也。

【阐释】本条之身黄发热，亦湿热郁蒸所致，但没有腹微满的里证，又没有恶寒体疼的表证。栀子柏皮汤为清热泄湿之剂，俾邪从小便而去，湿去热清，黄亦自愈。

栀子柏皮汤方（校补）

肥栀子十五个（擘）甘草一两（炙）黄柏二两上三味，以水四升，煮取一升半，去渣，分温再服。

【方解及其应用范围】栀子苦寒，泻三焦火，通利小便，治心烦懊侬，郁热结气；黄柏苦寒，善于清热除湿。甘草甘温，和胃保脾，缓苦寒之性。三味成方，为清泄湿热之剂，使邪从小便而去，湿去热清，黄亦自愈。

伤寒恒论卷三

太阳下篇

凡风寒两伤营卫之证，列于此篇，计二十四法（据舒本校增）一、太阳中风，脉浮紧，发热恶寒，身疼痛，不汗出而烦躁者，大青龙汤主之。若脉微弱，汗出恶风者，不可服之，服之则厥逆①，筋惕肉瞤②，此为逆也。

①厥逆：指四肢厥冷。

②筋惕肉瞤：就是筋肉跳动，由于亡阳脱液，筋肉得不到煦濡所致。

【阐释】郑书原文无此条，据舒本太阳下篇一条，《伤寒论》原书辨太阳病脉证并治上条校补。郑书一、二、三、四条，挨次校为二、三、四、五条，而郑书原五条全文与三条同，应删去。太阳中风，脉浮紧，发热恶寒，身疼痛，无汗，此麻黄汤证也。烦躁一证，即是此节大眼目。当知此烦躁，系风邪遏闭于胸中，与少阴亡阳之烦躁，阳明热越之烦躁不同。盖太阳主皮毛，肺亦主皮毛，此风邪不得外泄于皮毛，所以内搏于肺也。治以大青龙汤，于辛温发汗之中，而加以重镇之石膏，其意在内以平风清热，外以发表助津液也。若脉微弱，汗出恶风者，虽内有烦躁之证，亦不可用大青龙汤之峻剂，若误服之，必亡阳，而使阴阳之气，不相顺接，而先现厥逆，以致筋惕肉瞤。筋惕者，筋战栗而如恐惧之象，肉瞤者，肉跳动而有不安之形，欲救其误，非真武汤不可。

大青龙汤方（校补）

麻黄六两（去节）桂枝二两（去皮）甘草二两（炙）杏仁四十枚（去皮尖）生姜三两（切）大枣十二枚（擘）石膏如鸡子大（碎）上七味，以水九升，先煮麻黄，减二升，去上沫，内诸药，煮以三升，去渣，温服一升，取微似汗，汗出多者，温粉粉之③。一服汗者，停后服，若复服，汗多亡阳，遂虚，恶风烦躁，不得眠也。

③温粉粉之：相当于用爽身粉，可以吸收汗液，《孝慈备览》扑身止汗法，麝皮糯米粉二合，龙骨牡蛎二两，共为极细末，以疏绢包裹，周身扑之，其汗自止。

【方解及其应用范围】本方由麻黄汤加味而成，此麻黄证之剧者，是发汗之峻剂，倍用麻黄，佐桂枝、生姜辛温以发散在表之风寒，加石膏辛寒以除烦热，甘草、大枣和中以资汗源，共奏解表清里之功。柯韵伯谓：“两青龙俱治有表里证，皆用两解法，大青龙是里热，小青龙是里寒，故发表之药相同，而治里之药则殊也。”《金匱》用以治溢饮，现今推广治感冒、肺炎、哮喘、胸膜炎等表里俱实之证而里热较甚者，多获满意效果。

二、伤寒脉浮缓，身不（痛）〔疼〕，但重，乍有轻时①，无少阴证者②，大青龙汤发之。

①乍：忽然也，猝也。

②无少阴证：没有少阴阴盛阳虚的证候。

郑论：按大青龙汤，乃风寒两伤营卫，烦躁发热之主方。此言脉浮缓，并无身疼发热，而曰身重乍有轻时，论身重乃少阴之征，而曰乍有轻时，却又非少阴的候，此为大青龙汤，实不恰切，学者宜细心求之。

【阐释】发热恶寒，无汗烦躁，乃大青龙汤之主证。此则不言主证，但言脉浮缓，身不疼，但重乍有轻时证状，还不足以为用大青龙汤的依据。故郑氏说：“此为大青龙汤，实不恰切”。值得学者深思。

三、太阳病，脉浮〔紧〕，〔无汗〕，发热，身疼痛，八九日不解，表证仍在（者），此当发其汗。服药已微除，其人发（热）〔烦〕目瞑③剧者必衄④，衄乃解。所以然者，阳气重故也，麻黄汤主之。

③目瞑：目不明也，就是目合懒开的意思。

④衄：鼻腔出血曰衄。

郑论：按此条既称八九日不解，表证仍在者，固当发其汗，既服药已微除，微字是发汗邪衰而未尽解之意，复见其人发热，目瞑，剧者必衄，衄则邪必外出，故仍以麻黄汤随机而导之之意。此条设若不衄，更见发热目瞑剧者，又当于阳越于外求之。求之奈何？于口之饮冷饮热判之，人之有神无神，脉之有力无力，二便之利与不利处求之，切切不可死守原文，当以不执方为要。

【阐释】“此条设若不衄，更见发热目瞑剧者，又当于阳越于外求之”，此又郑氏独特之见解。医者则当按《医理真传》辨认一切阳虚证法辨之，以回阳收纳为是，大剂四逆汤治之。

四、伤寒脉浮紧，不发汗，因致衄者，麻黄汤主之。

郑论：按此条乃（伤寒）〔寒伤〕营之的候，其人能大汗出而邪可立解，则不致衄，衄出，即汗出也，故以麻黄汤治之，是随机而导之之意，俾邪尽出无遗，真上乘法也。

【阐释】伤寒脉浮紧，用麻黄汤发汗，使外邪从汗而解。今当汗不汗，则邪无从出，壅闭阳络，迫血妄行，因而致衄。衄出即汗出而解。但表实之伤寒不因衄出而解，仍应以麻黄汤治之，此即郑氏“随机而导之之意，俾邪尽出无遗。”

五、太阳病，脉浮紧，发热，身无汗，自衄者愈。

郑论：此系与上同，毋容再论。

【阐释】本条是太阳伤寒麻黄汤证。因热盛而致衄，虽未服药，亦可能邪随衄解而病自愈。盖血之与汗，异名同类，不从汗解，则从衄解，其义相同。又本条与三条四条俱为表实证的衄血，但本条是未经服药的衄血，其病邪随衄而解，故曰“自衄者愈”。四条是因失治衄血，衄后病邪仍未解，脉证如故，仍以“麻黄汤主之”。三条是已经服药，邪热较盛的衄血，其邪亦随衄而解，故而“衄乃解”。

六、太阳病，得之八九日，如疟状①，发热恶寒，热多寒少，其人不呕，清便欲自可②，一日二三度发。（而）脉微缓者③，为欲愈也；脉微而恶寒〔者〕，此阴阳俱虚④，不可更发汗、更吐、〔更〕下也；面色反有热色者⑤，未欲解也，以其不能得小汗出，身必痒，宜桂枝麻黄各半汤。

①如疟状：寒热发作的情况，好象疟疾一样。

②清便欲自可；清同圉，清便欲自可，就是大小便尚能如常的思。

③热色：就是红色。

④阴阳俱虚：这里的阴阳，指表里言，谓表里都虚。

⑤脉身微缓：微与洪相对，缓与紧相对，微缓就是不洪不紧而柔和的意。

郑论：此条既称八九日，未有不用发散祛邪之方，据所言如疟状，如疟者，似疟而非真疟之谓也。虽现热多（一）寒少，而其人不呕，清便自可，以清便二字核之，与脉之微缓核之，则内无的确之风热，明是发解太过，必是阳虚似疟无疑，法宜扶阳温固为是。又曰脉微而恶寒者，为阴阳俱虚，不可更发汗、吐、下也。明明此非青龙汤、麻（黄）〔桂〕各半汤的候也。若其人面皮反有赤色，赤色二字，更宜着眼，恐是（带）〔戴〕阳，苟非（带）〔戴〕阳，果现脉浮紧，未得小汗，而致身痒疼者，方可与麻（黄）〔桂〕各半汤，学者虽于一症之中，前后参究，方可与论伤寒，读伤寒也。

（一）是属阳症热多，定现口渴饮冷，舌必有黄苔，热时必揭去衣被，小便必赤，若似

症则无此等病情。（顶批）

【阐释】本条为太阳病八九日不解，可以有三种不同的转变，但郑氏特别指出：“明是发解太过，必是阳虚似症无疑，法宜扶阳温固为是”。又“若其人面皮反有赤色，更宜着眼，恐是戴阳”。笔者认为前者可用黄芪建中汤治之，后者用白通汤。邪郁久未得出小汗，而身痒疼者，方可与麻桂各半汤，取其微汗而解。

桂枝麻黄各半汤（校补）

桂枝一两十六铢（去皮）芍药、生姜（切）甘草（炙）麻黄各一两（去节）大枣四枚（擘）杏仁二十四枚（汤浸，去皮尖及两仁者）上七味，以水五升，先煮麻黄一二沸，去上沫，内诸药，煮取一升八合，去滓，温服六合。本云桂枝汤三合，麻黄汤三合，并为六合，顿服，将息如上法。

【方解及其应用范围】桂枝汤为协和营卫之剂，用治太阳病伤风；麻黄汤乃开表逐邪，发汗之峻剂，用治太阳病伤寒。风寒同时并伤营卫，则合二方治之，肌表两解。因剂小量轻，如此既得小汗祛邪之功，又无过汗伤正之弊。笔者常用本方治疗风寒两感之咳嗽有很好疗效。

七、太阳病，发热恶寒，热多寒少，脉微弱者，此无阳也，不可（更）〔发〕汗，宜（用）桂枝二越婢一汤①。

①越婢：“婢”与“脾”古字通用，玉函经方后煎法，二“婢”字均作“脾”可证。成无己注：发越脾气，通行津液。

郑论：此条言发热恶寒者，邪犯太阳之表也，热多寒少者，风邪之盛而寒邪之轻也，以越婢汤治之，取桂枝以伸太阳之气，（躯）〔祛〕卫分之风，用石膏以清卫分之热，用麻黄生姜以散寒，所为的确之方。但条中言无阳不可发汗，既曰无阳，岂有热重寒轻之理？岂有再用石膏、桂、麻之理？定有错误。

【阐释】郑注文谓：“但条中言无阳不可发汗，既曰无阳，岂有热重寒轻之理？岂有再用石膏、桂、麻之理？定有错误。”历代很多注家都随文顺释，牵强附会，而郑氏认为定有错误，但未能指出错在何处？惟章虚谷注曰：“此条经文，宜作两截看，宜桂枝二越婢汤一句，是接热多寒少句，今为煞句，是汉文兜转法也。……”曹颖甫订正：“按宜桂枝二越婢一汤句，当在热多寒少下，今在节末，否则既云不可发汗，犹用此发汗之药，有是理乎？”章、曹二氏之注，即可解郑氏之惑，亦嘉惠后学也。

桂枝二越婢一汤方（校补）

桂枝（去皮）芍药、麻黄、甘草各十八铢（炙）大枣四枚〔擘〕生姜一两二铢（切）石膏二十四铢（碎、绵裹）上七味，以水五升，煮麻黄一二沸，去上沫，内诸药，煮取二升，去渣，温服一升。本云当裁为越婢桂枝汤，合之饮一升，今合为一方，桂枝二分，越婢一分。

【方解及其应用范围】本方即桂枝汤加麻黄石膏而成。桂枝二，仍以和营卫为主，辅以越婢一，取其辛凉之性，以清泄里热而发越郁阳。用于外有表证，里有郁热，还当有里热口渴等现象，亦即热多寒少。与麻桂各半汤、桂枝二麻黄一汤都是桂枝汤的变法，而其病理机转，用药主次都有不同之处，应细心揣摩体会，方不致误。

八、服桂枝汤，大汗出，脉洪大者①，与桂枝汤，如前法。若形似疟，一日再发者，汗出必解，宜桂枝二麻黄一汤。

①脉洪大：脉形盛大如洪水泛滥，但来盛去衰，是其特点。

郑论：此条既服桂枝汤，大汗出，而病岂有不解之理乎？既已大汗而脉见洪大，若再用桂枝汤，能不虑其亡阳乎？条中大字，定有错误，想是服桂枝汤而汗不出，故可以用桂枝汤，方为合理。至形如疟状，是表里之寒热尚未尽解，故仍以桂枝〔二〕麻黄一汤主之，俾邪外出无遗，故决之曰：汗出必解，方为合式。

（一）或者汗出而邪未尽解，脉见洪大，邪仍欲出表之意，理亦不错，但大字不能无疑（顶批）。

【阐释】郑注文“既以大汗而脉见洪大，若再用桂枝汤；能不虑其亡阳乎？”

条中大字，定有错误。”其顶批亦云：“或者汗出而邪未尽解，脉见洪大，邪仍欲出表之意，理亦不错，但大字不能无疑？”曹颖甫对本条订正为“脉不洪大，故仍宜桂枝，传写者脱去不字耳。”若如此订正，则可释郑书之疑。

桂枝二麻黄一汤方（校补）

桂枝一两十七铢（去皮）芍药一两六铢麻黄十六铢（去节）杏仁十六个（去皮尖）甘草一两二铢（炙）大枣五枚（擘）生姜一两六铢（切）上七味，以水五升，先煮麻黄一、二沸，去上沫，内诸药，煮取二升，去渣，温服一升，日再服，本云桂枝汤两分，麻黄汤一分，合为二升，分再服，今合为一方，将息如前法。

【方解及其应用范围】本方与桂枝麻黄各半汤药同而量异，麻、杏两味再减轻，则名桂枝二麻黄一汤，为辛温、微发汗之轻剂。其方解可参看桂枝汤、麻黄汤。现今用治风寒感冒之轻者，但风重于寒，用此方和其营卫，略佐疏表，大多汗出而愈。

九、伤寒不大便六七日，（若）头痛有热者，与承气汤。其小便清者，知不在里，仍在表也，当须发汗。若头痛一者，必衄，宜桂枝汤。

郑论：按伤寒六七日不大便，有热结寒结之分，务要察其果系热结，方可以大承气汤施之；头痛亦必审其脑后，方是太阳的候，有热而必兼见恶寒者为确，有不恶寒而独发热者为非。又曰其小便清者，知不在里而在表也，理宜解表。头痛而衄者，是邪从外解，仍以桂枝汤治之，是随机斡旋之意，真立法之妙也。

【阐释】伤寒六七日不大便，头痛有热者，此因大便不通，由浊阴之气与里热上犯，用大承气下之，热清浊降，大便通畅，头痛发热，随之而愈。如果头痛身热，而小便清利如常的，虽然不大便六七日，是邪不在里而仍在表；既然在表，就是桂枝汤证仍未罢，用桂枝汤解表，表解则头痛发热自愈。若头痛而衄者，此久不大便，其热较一般表证头痛之热为重，伤及阳络而衄血，则邪亦从外解也。至郑氏所言不大便有热结寒结之分，临证时，必须细心分辨，若系寒结，则当用四味回阳饮加安桂治之。

十、服桂枝汤，或下之，仍头痛、项强、翕翕发热，无汗，心下满，微痛，小便不利者，桂枝汤去桂加茯苓白朮汤主之。

郑论：按此条虽云服桂枝汤，或下之，而仍头痛、项强、翕翕发热、无汗，是邪尚在表而未解，仍宜发表为是。至于心下满而痛，小便不利，是太阳之气，不从小便而下趋，逆从于上而为心下满痛，何也？太阳之气，是由下而上至胸腹也，今既心下痛而小便不利，理应以五苓散方施之，化太阳之气，俾邪从下解，此方去桂枝加白朮、茯苓，亦是五苓之意。以予拙见，桂枝似不宜去。

【阐释】历代注家对于本条的注释，各有见解，去桂去芍，尤为争辨的焦点。郑氏认为邪尚在表而未解，仍宜发表为是。又云：太阳之气，是由下而上至胸腹也，今既心下痛而小便不利，理应以五苓散方施之，化太阳之气，俾邪从下解，……以予拙见，桂枝似不宜去，这是郑氏独特的见解。笔者认为去桂去芍皆非，用桂枝汤以解表，加苓、朮以利尿，岂五苓散方中，用桂枝以化气行水，桂枝岂能去耶？郑氏之说为妥。

桂枝去桂加茯苓白朮汤方（校补）

芍药三两甘草二两（炙）生姜（切）白朮、茯苓各三两大枣十二枚（擘）上六味，以水八升，煮取三升，去渣，温服一升，小便利则愈。本云桂枝汤，今去桂枝加茯苓白朮。

【方解及其应用范围】本方即桂枝汤原方去桂加苓、朮而成。此方末云，小便利则

愈，重在利水，故去桂枝。加白朮、茯苓健脾除水而利小便，使内停之水饮，尽从下去，则心下满头项强痛发热诸证，皆可随之而解。此和里而表自解之法也。

十一、伤寒脉浮，医以火迫劫之①，亡阳②，必惊狂，起卧不安者，桂枝去芍药加蜀（膝）〔漆〕牡蛎龙骨救逆汤主之。

①火迫劫之：以火法强迫其发汗。凡烧针、火熏、灸法，皆属火法。

②亡阳：此处的阳，指心阳而言。亡阳即心阳外亡，神气浮越之谓。

郑论：按伤寒脉浮，而医以火迫劫之，浮为阳，邪火亦阳，两阳相会，邪火内攻，扰乱心君，故惊狂不安之象所由来。致于亡阳二字，所论不切，当是亡阴，庶于此条方为合法，主以救逆汤，亦是敛阴、祛邪、安神之意也。

【阐释】郑氏所云“亡阳二字，所论不切，当是亡阴，庶于此条方为合法。”上篇以火劫而致变者，皆为亡阴，但头汗出颈项而还，其不得汗显然矣，观本条之去芍药，其为无汗之故，更显然矣。篇首误服大青龙汤而亡阳者，乃为汗多所致，以皆为无汗而致也，岂有无汗而亡阳之理哉？

桂枝去芍药加蜀漆龙骨牡蛎救逆汤方（校补）

桂枝三两（去皮）甘草二两（炙）生姜三两（切）大枣十二枚（擘）牡蛎五两（熬）蜀漆三两（洗去腥）龙骨四两上七味，以水一斗二升，先煮蜀漆二升，内诸药，煮取三升，去渣，温服一升。本云桂枝汤，今去芍药，加蜀漆、龙骨、牡蛎。

【方解及其应用范围】用桂枝汤去芍药之阴柔以助心阳，以治其本；蜀漆辛苦微寒，可涤痰消饮，重用牡蛎助蜀漆消痰饮，配龙骨镇纳浮阳安神而止惊狂，卧起不安。全方共奏温补心阳，涤痰镇惊之功，而收调和阴阳之效。用以治疗各种原因引起的心阳骤伤，兼痰浊阻窍，神志不宁，甚至惊狂等为主的症候。

十二、火逆下之，因烧针烦（燥）〔躁〕者，（当用）桂枝甘草龙〔骨〕牡蛎汤主之。

郑论：按火逆则伤阴，未见下症而下之，则伤阴，复又烧针而阴又伤，此烦（燥）〔躁〕之症所由生，而阴虚之象所由见，主以桂枝〔甘草〕龙骨牡蛎者，是取其调中而交心肾也。

【阐释】此先火后下，又加烧针，是经过三误。故郑氏说：“此烦躁之症所由生，而阴虚之象所由见。”亦即心阳受伤，而见烦躁不安之状。故用桂枝甘草以助心阳

，龙、牡以止烦躁。

桂枝甘草龙骨牡蛎汤方（校补）

桂枝一两（去皮）甘草二两（炙）牡蛎二两（熬）龙骨二两上四味，以水五升，煮取二升半，去渣，温服八合，日三服。

【方解及其应用范围】本方以桂枝入心助阳，甘草以补养心气，龙骨牡蛎以收敛浮越之正气，安神镇惊，全方有调和阴阳，潜镇心神之功。陈修园说；此为火逆烦躁者，立交通心肾之法也。”用以治疗某些心悸、怔忡、自汗、盗汗、遗精、滑精等证。近人推广用于治疗某些心血管系统和神经系统疾病，都有很好疗效。

十三、伤寒脉浮，自汗出，小便数，心烦，微恶寒，脚挛急①，反与桂枝（汤）欲攻其表，此误也，得之便厥②，咽中干，烦（燥）〔躁〕吐逆者，作甘草干姜汤与之，以复其阳；若厥愈足温者，更作芍药〔甘草〕汤与之，其脚即伸；（者）〔若〕胃气不和、谵语者③，少与〔调胃〕承气汤；若重发汗，复加烧针者，四逆汤主之。

①脚挛急：就是脚伸展不利之意。

②厥：手足发冷。

③谵语：神昏妄言，也就是说胡话。

郑论：据脉浮自汗至（拘）〔脚〕挛急，症中并无发热、恶寒、身疼，而独见自汗出者，卫外之阳不足也，小便数者，气化失机也，心烦、微恶寒者，阳衰之征也，拘挛急者，由血液外亡，不能滋润筋脉也。本非桂枝汤症，而曰欲攻其表，此误也，实为有理。至于得之便厥，咽中干，烦（燥）〔躁〕吐逆者，大抵此症先因吐逆太过，中宫转输之机，卒然错乱，不能输精气于心肾，故烦（燥）〔躁〕，吐则亡阳，故四肢厥也。咽中干者，肾阳衰不能升腾津液于上也。以甘草干姜汤与之，此是守中复阳之法也，何愁脚之不伸也？原文又以芍药甘草汤，此汤本为火盛灼筋者宜，而用之于此症，殊非正论。若胃气不和，谵语者，少与承气汤，此说觉得支离，又并无胃实足征，何得有谵语之说？即果谵语，务必探其虚实真伪方可。若重发汗，复加烧针者，主以四逆汤，此是何病情？而重汗，而又烧针耶？一条之中，东一若，西一若，吾甚不解。

（一）厥症原有热厥寒厥之分，原文主甘草干姜，是定非热厥也。总之（一）〔医〕家临症时，务宜下细探求阴阳实据方可。此论是就原文主方说法也（顶批）。

【阐释】本节“伤寒脉浮……脚挛急”，为未治以前的证状，类似桂枝汤证，但小便数，心烦，脚挛急则不是桂枝汤证所应有，与太阳上篇条的太阳病，发汗，遂漏不止，其人恶风，小便难，四肢微急，难以屈伸等证，基本是一致的。此为表阳虚，腠理不固所致，法当温经复阳，用桂枝加附子汤治疗。但辨证不明，反与桂枝汤攻其表，耗散真阳，得之便厥，咽中干，烦躁、吐逆者，此又重伤其阳，原文主以甘草干姜汤，以守中复阳，其脚即伸，是为正治。至原文所列之芍药甘草汤、调胃承气汤、四逆汤等，有如郑氏所说：“一条之中，东一若，西一若，吾甚不解。”可见条文有误，姑存之。

甘草干姜汤方（校补）

甘草四两（炙）干姜二两（炮）上二味，以水三升，煮取一升五合，去渣，分温再服。

【方解及其应用范围】甘草干姜汤一方，乃辛甘化阳之方，亦苦甘化阴之方也。夫干姜辛温，辛与甘合则从阳化，干姜炮黑，其味即苦，苦与甘合则从阴化。此方应用范围极广，仲景以此方治误吐逆烦躁而厥者，取大甘以化热，守中而复阳也。又治吐血，治中寒，取辛甘以化阳，阳气也，气能统血，阳能胜寒，阳能温中也。又用以治拘急，治筋挛，治肺痿，治肠燥，取苦甘以化阴，阴血也，血能胜热，血能润燥，血能养筋也。笔者对治多种肺、胃虚寒病症，常用甘草干姜汤加味而获效。对治血症，无论其为血热妄行，或阴虚火动，或阳不统血，皆先选用甘草干姜汤加血余炭，以止其血，然后才对症下药，屡屡获效。

芍药甘草汤（校补）

白芍药、甘草各四两（炙）上二味，以水三升，煮取一升五合，去渣，分温再服。

【方解及其应用范围】芍药甘草汤一方，乃苦甘化阴之方也。夫芍药苦平入肝，肝者阴也。甘草味甘入脾，脾者土也。苦与甘合，足以调周身之血，周身之血既调，则周身之筋骨得养，筋得血养而燥气平，燥气平则筋舒而自伸矣。本方不仅治两足拘挛急，治两足剧痛，治湿热脚气、脚弱无力皆有效。近人推广用于阴血不足致筋脉挛急疼痛各症，如颈项强痛、头痛、胃脘痛、胁痛、腹痛等，皆有疗效。

十四、发汗，若下之，病仍不解，烦（燥）〔躁〕者，茯苓四逆汤主之。

郑论：按病有当发汗者，有当下者，但要有发汗之实据，可下之病情，此统以发汗、下后，病仍不解，不解是何病情不解，以致烦（燥）〔躁〕，殊令人难以猜详。

【阐释】据历代注家之注释：发汗，若下，病宜解也，若病仍不解，则发汗是外虚

阳气，下之内虚阴液，阴阳俱虚，水火不济，故出现烦躁。又从治方上看，茯苓四逆汤是用四逆汤以回阳，加人参茯苓以复阴。《名医别录》上说：“茯苓能益阴气，补神气。”从这里亦可看出茯苓滋阴生津的作用，并不只是利水一端。本条在证状上的叙述比较简略，故郑氏说：“此统以发汗下后，病仍不解，不解是何病情不解，以致烦躁，殊令人难以猜详。”提出质疑，可以启发后学之多加思考。

茯苓四逆汤方（校补）

茯苓四两人参一两附子一枚（生用去皮破八片）甘草二两（炙）干姜一两半上五味，以水五升，煮取三升，去渣，温服七合，日二服。

【方解及其应用范围】本方主要以姜、附回阳救逆，人参茯苓益气生阴，并有治烦躁，止惊悸作用；炙甘草补中益气。此方效力较四逆汤、四逆加人参汤、干姜附子汤三方为缓，但应用范围较三方为广，并有利水去湿之功。凡四肢厥逆，面容晦黯无神，脉沉微欲绝，舌质淡，苔白滑或白腻，口中津液多等，表现为肾寒、脾湿、正虚、阴弱证候，均可使用。

十五、伤寒，胸中有热，胃中有邪气，腹中痛，欲呕吐者，黄连汤主之。

郑论：按太阳之气，由下而上至胸腹，今因寒邪拂郁于内而热生，以致胃中不和，腹痛欲呕吐者，此是上热下寒之征也。以黄连汤主之，是用黄连以清上焦之热，干姜、桂枝、半夏以祛中下之寒邪，用参、（附）〔枣〕以和中，是调和上下之妙剂也。

【阐释】本条是上热下寒，阴阳升降失其常度，阳在上不能下交于阴，故下寒者自寒；阴在下不能上交于阳，故上热者自热。郑氏指称：“黄连汤乃调和上下之妙剂。”信而有征。

黄连汤方（校补）

黄连三两甘草三两（炙）干姜三两桂枝三两（去皮）人参二两大枣十二枚（擘）半夏半升（洗）上七味，以水一斗，煮取六升，去渣，温服，昼三夜二。疑非仲景方。

【方解及其应用范围】本方寒热并用，以黄连清胃中之热，干姜以温胃中之寒，桂枝通调营卫，半夏降逆，佐黄连呕吐可止，人参、甘草、大枣和胃安中，但得寒热平调，呕吐腹痛自愈。笔者常用此方治胸腹胃中之寒热错杂诸证，疗效卓著。

十六、伤寒腹满谵语，寸口脉浮而紧，此肝乘脾也，名曰（横）〔纵〕①，刺期门

②。

①纵：是五行顺次反克的形式。

②期门：穴名，位在乳直下二寸处。

郑论：按腹满谵语，阳明之腑证也；脉浮而紧，太阳之表证也。此名曰（横）〔纵〕，甚不解，定有错误。

【阐释】郑氏疑原文定有错误。笔者参阅诸家之注，而为汇解，或可释郑氏之疑。伤寒腹满谵语而无潮热，手足絜絜汗出等为阳明之实证，脉浮而紧独见寸口，自与太阳、阳明之见证有别。《脉经》云：“浮而紧者名曰弦，弦为肝脉”。《内经》云：“脾主腹”“诸腹胀大，皆属于热。”又云：“肝主语”。以此推之，肝木旺则侮脾土，则腹满谵语，侮其所胜，故名曰纵。治法当刺期门，因期门为肝之募，故刺之以泄肝邪。邪去则腹满谵语自愈。

十七、伤寒发热，啬啬恶寒，大渴欲饮水，其腹必满，自汗出，小便利，其病欲解，此肝乘（脾）〔肺〕也，名曰横③，刺期门。

③横：是五行逆次反克的形式。

④表不解：即太阳表证，还没有解除。

郑论：按发热恶寒，太阳之表证也，大渴饮水，此由寒水逆中，阻其脾中升腾之机，真水不得上升，故大渴，其腹满者，水溢于中也，幸而自汗与小便利，上下分消，邪有出路，故知其必解也。设若不自汗，不小便，未可言欲解也。言肝乘（脾）〔肺〕，不知从何看出，余甚不解。

【阐释】郑氏说：“原文言肝乘肺，不知从何处看出，余甚不解。”笔者亦从上例为之汇解，以释郑氏之疑，是否有当，高明正之。肺主皮毛，肺受肝邪则毛窍闭塞，所以发热，啬啬恶寒；木火刑金，津液劫烁，故渴欲饮水；肺失通调水道之功能，所以小便不利而腹满。肝邪乘肺，侮其所不胜，故名曰“横”，刺期门，则肝邪得泄，肺不受侮，毛窍通畅，则自汗出，水道通调则小便利，故病可愈。

十八、伤寒表不解④，心下有水气，干呕，发热而咳，或渴、或利、或噎①、或小便不利，少腹满，〔或喘者〕，小青龙汤主之。

①噎（yē 椰）：食时气逆噎塞。

郑论：按伤寒既称表不解，心下有水气，以致一切病情，缘由寒水逆中，阻滞气机，理应发汗行水，水邪一去，则气机流通，诸症立失。学者切不可执病执方，执一己之见，总要窥透病机，当何下手，治之为是。若原文之青龙汤，重在发汗行水，而诸症立失，可知非见咳治咳，见呕治呕也。

【阐释】本条是伤寒表不解心下有水气的证治。郑氏说：“切不可执病执方，执一己之见，总要窥透病机，当何下手，治之为是。”此属其治病之经验，殊堪宝贵。故对治伤寒表不解，心下有水气，所以用外散寒邪，内蠲水饮之小青龙汤治之，则干呕，发热而咳等诸证自愈。教人不可见咳治咳，见呕止呕。

小青龙汤方（校补）

麻黄三两（去节）芍药三两干姜三两五味子半升甘草三两（炙）桂枝三两（去皮）细辛三两半夏半升（洗）上八味，以水一斗，先煮麻黄减二升，去上沫，内诸药，取三升，去渣，温服一升。若渴，去半夏加栝蒌根三两，若微利，去麻黄加芫花，如一鸡子大，熬令赤色，若噎者，去麻黄加附子一枚（炮），若小便不利，少腹满者，去麻黄加茯苓四两，若喘，去麻黄加杏仁半升去皮尖。且芫花不治利，麻黄主喘，今此语反之，疑非仲景意。

【方解及其应用范围】本方即麻黄汤、桂枝汤合方，减去杏仁、生姜、大枣，而加干姜、五味、细辛、半夏。考所增四药功能：干姜主温中，治胸满咳逆上气。细辛辛温，配麻黄能祛痰利水，散风寒外出而治咳逆上气。五味收纳肺气以入肾，故治咳逆合干姜同用，一开一阖，咳之来路去路，均告肃清，故仲景治咳，皆姜、辛、五味同用。半夏燥痰，降水气，和胃，止咳逆呕吐。麻黄汤辛温发表，逐邪之峻剂。桂枝汤和营卫以祛风。合用之肌表可开散，然不去水饮停蓄之邪，非特不能廓清其源，即麻桂之功力，亦必被停聚之水饮所阻挠也。笔者常用本方治疗外感寒邪，内挟水饮之咳喘，亦治水饮溢于皮肤而浮肿腹满，小便不利之咳喘，与夫痰饮咳嗽，哮喘之偏于寒性者，疗效卓著。近人则多以本方治疗呼吸系统疾病，屡见于报导。

十九、伤寒心下有水气，咳而微喘，发热不渴，服汤已渴者，此寒去欲解也，小青龙汤主之。

郑论：按心下有水气，阻其呼吸之气，上触而咳，以致微喘，发热不渴，服汤已渴者，水气去，而中宫升腾之机，仍旧转输，故知其欲解也。以小青龙汤主之，是随机而导之意也。

【阐释】本条是指服小青龙汤以后口渴的，此寒去疾病自愈的表现，非调解后仍用小青龙汤也。故曹颖甫订正此条，在“发热不渴”下，即移原文“小青龙主之”。

则其义更为明白了然。

二十、服桂枝汤，大汗出后，大烦渴不解①脉洪大者，白虎加入参汤主之。

①大烦渴不解：烦是心烦，渴是口渴，大是形容烦渴的厉害，不解是病未愈的意思。

郑论：按服桂枝汤以致大汗，其人大渴者，由汗出过多，血液被夺，伤及胃中津液故也。主以人参白虎汤，取人参以救津液，取石膏以清内热，的确之法也。

【阐释】服桂枝汤后，只要微微有汗即得，现在汗出太多，肌表之邪虽去，而胃中津液反为耗伤，胃燥化热，病已由太阳传至阳明，出现心烦、渴饮的症状，故用白虎汤以清阳明炽盛之热，加人参以救胃中耗伤之液，此为不易之法也。

白虎加入参汤方知母六两石膏一斤（碎，绵裹）甘草二两（炙）粳米六合人参三两上五味，以水一斗，煮米熟，汤成去渣，温服一升，日三服。

【方解及其应用范围】本方即白虎加入参汤，乃灭火救阴之神剂。有清热、生津、止渴的作用。石膏辛寒，清三焦火热，生津止渴；知母苦润、泄火滋燥；甘草，粳米调和中宫；人参有补虚救逆，又有生津止渴之功。此方并非专为伤寒之阳明症立法，凡属内里之燥热为病者，皆可服也。时人过畏石膏而不用，往往误事。前人少有用本方治目疾者，今人加以推广，不仅治赤、热、肿、痛，外障、瘀滞较甚之目疾用之取效，并用以治肺炎、脑炎、糖尿病，尤其对夏月小儿高热、多渴、多尿综合症疗效最好。一般认为凡属里热伤津，气阴两亏之老年及诸不足者，皆可用白虎加入参汤治疗，而本方的退热作用，主要在于适当配伍了石膏。现将近代名医张锡纯用石膏的经验，及笔者对本方的推广应用附后。张着《医学衷中参西录》谓：“石膏其性凉而能散，有透表解肌之力，为清阳明胃腑实热之圣药，无论内伤、外感用之皆效，即他脏腑之实热者用之亦效。……石膏医者多误认为大寒而煨用之，则宣散之性变为收敛，以治外感有实热，竟将其痰火敛住，凝结不散，用至一两即足伤人，是变金丹为鸩毒也。迨至误用煨石膏债事，流俗之见，不知其咎在煨不在石膏，转谓石膏煨用之其猛烈犹足伤人，而不煨者更可知矣。于是一倡百和，遂视用石膏为畏途。……余用以治外感实热，轻症亦必用至两许，若实热炽盛，又恒重用至四、五两或七、八两。……盖石膏生用以治外感实热，断无伤人之理，且放胆用之，亦断无不退热之理。惟热实脉虚者，其人必实热兼有虚热，仿白虎加入参之义，以人参佐石膏，亦必能退热。”又云：“且尝历观方书，前哲之用石膏，有一证而用十四斤者（见《笔花医镜》）；有一证而用至数十斤者（见吴鞠通医案）；有产后亦重用石膏者（见徐灵胎医案，然须用白虎加入参汤，以玄参代知母，生山药代粳米）。然所用皆生石膏也。”笔者三十年来，对治外感风热之邪，无论成人或小孩，身大热（体温以上），虽注射青、链霉素而身热不退，即用白虎加入参汤治

疗，屡用屡验。又治伤暑咳嗽，因高热、烦渴、津伤、汗多，舌质鲜红，舌上干燥，苔干黄，治以此方面获效。又曾治尿崩证，患者一日一夜饮水达五十磅，石膏用量初服克，一剂而饮水量减少五磅；二剂石膏增至克，饮水又有所减少。其后石膏用量增至克，连服五剂而痊愈。

二十一、伤寒脉浮滑，此里有（热）〔寒〕，表有（寒）〔热〕，白虎汤主之。

郑论：按《脉象篇》云：浮主风邪，滑主痰湿。此条只据二脉，即以白虎汤主之，实属不当。况又未见有白虎症形，指为里热表寒，即果属表寒里热，理应解表清里，何独重里热一面，而遗解表一面乎？疑有误。

【阐释】本条历代注家，争论极多，有认为此处表里二字错简，亦有认为未错简，亦有认为寒字当邪解，亦热也。但类皆自圆其说，不能使人信服。白虎汤证的病理，总归是表里俱热，必须是阳明经热炽盛的见证，才能用白虎汤。不能只凭脉以定病，而须结合证状来定，如发热汗出，烦渴引饮，此为阳明表里俱热之证，白虎汤乃对证之方。郑氏疑有误，值得深思考虑。

白虎汤方（校补）

知母六两石膏一斤（碎）甘草二两（炙）粳米六合上四味，以水一斗，煮米熟，汤成，去渣，温服一升，日三服。

【方解及其应用范围】白虎汤《伤寒论》原文共三条，分见于太阳、阳明及厥阴三篇。其方解可参阅前条白虎加人参汤条。其治疗目标是壮热、大汗出、大烦渴、脉洪大、无表证。

因热盛伤津灼阴，故汗渴饮冷。但邪初入阳明，热而未实，急需灭火清热以救阴，故以本方治之。郑氏在《医法圆通》中说：“此阳明腑分主方也。”随即举出其圆通应用法五条：（1）治上消证：（2）治心下一寸间发生疮疾，红肿痛甚；（3）治牙龈红肿痛甚，饮冷；（4）治两乳红肿痛甚；（5）治谵语、遗尿、口不仁而面垢。此外有白虎汤证而挟湿者，则加苍朮；挟风者，则加桂枝，亦极有效验。笔者用此方治疗伤热咳嗽、哮喘，取得满意效果。其症状为咽喉干痛，鼻孔出热气，口臭气粗。咳嗽而痰难出，色黄且稠，有时成块成沱，或带血腥臭，面赤身热，更兼烦躁不安，舌质红绛，舌苔干黄，脉洪大有力，全系热盛之象，故以白虎汤治之而愈。现在白虎汤广泛应用于各种急性热病，更有用于挟热之眼疾、痢疾亦获良效，可见其应用范围之广泛。

二十二、伤寒脉浮，发热无汗，其表不解（者），不可与白虎汤；渴欲饮水，无表证者，白虎加人参汤主之。

郑论：按发热无汗，本应解表，原非白虎所宜，至于大渴饮冷，阳明症具，则以人参白虎施之，的确不易法也。

【阐释】伤寒脉浮，发热无汗，为伤寒麻黄汤证。若渴欲饮水，无表证者，是恶寒已罢，里热已炽，热盛足以津伤，白虎人参汤以泄热救阴。诚如郑氏所言：大渴饮冷，阳明症具，则以人参白虎施之，的确是的确不易法也。

二十三、伤寒无大热，口燥渴，心烦，背微恶寒者，白虎加人参汤主之。

郑论：按寒邪本由太阳而起，至背恶寒，亦可云表未解，何得即以白虎汤主之。条中既称无大热，虽有燥渴心烦，未必即是白虎汤证。法中原有热极邪伏，背心见冷，而用此方，但学者于此症，务要留心讨论，相其舌之干燥与不燥，气之蒸（乎）〔手〕不蒸（乎）〔手〕，口渴之微盛，二便之利与不利，则得矣。

【阐释】伤寒背微恶寒，可云表未解，虽有燥渴心烦，但无大热，即不能用白虎汤治疗。郑氏曰：“法中原有热极邪伏，背心见冷，而用此方。”但必其舌干燥，气粗蒸手，口渴盛，二便不利，则可用白虎加人参汤治之。

二十四、伤寒若吐若下后，七八日不解，热结在里，表里俱热，（而）时时恶风，大渴，舌上干燥而烦，欲饮水数升者，白虎加人参汤主之。

郑论：按吐下后而表不解，盖吐则亡阳，下则亡阴，阴阳两虚，更不能俾邪外出，故不解。以致表邪趋入阳明地界，遂随阳明之气化，而转为热邪，故现一切症形，全是白虎汤对症之法。至饮水多者，是由下而津液大伤，故乞水以为援也。主以白虎加人参，以救欲亡之阴，实的确不易之法也。

【阐释】伤寒吐下后，津液被夺，以致表邪趋入阳明地界，转为热结在里之证。里热大盛，所以表里俱热，时时恶风，舌上干燥而烦，欲饮水以自救。此为阳明经证伤津，法当清泄里热，兼生津液。如郑氏所言：主以白虎加人参，实的确不易之法也。

伤寒恒论卷四

阳明上篇

外邪初入阳明，太阳尚有未尽者，谓之太阳阳明，列于此篇计三十九法（据舒本较增）。

一、阳明病，脉迟，汗出多，微恶寒者，表未解也，可发汗，宜桂枝汤。

郑论：论阳明病，汗出多，脉应长大，今脉迟而汗出多，殊属不合。又到微恶寒，表未解，可发汗，明是太阳寒邪，初入阳明，寒邪尚未化尽，故宜以桂枝汤导之也。

【阐释】此太阳风伤卫，传至阳明，寒邪尚未化尽，故仍可用桂枝汤，以外解表邪，但必须是里热不甚者。此仲景从证不从脉而用桂枝汤解表。

二、阳明病，脉浮，无汗而喘者，发汗则愈，宜麻黄汤。

郑论：按此条，乃太阳之病，太阳之方，并未有阳明脉象病情，实属不合，理应例入太阳篇为式。

【阐释】前条是太阳中风与阳明并病，这条是太阳伤寒与阳明并病，无汗恶寒为表实，肺气郁而不宣的喘证，麻黄汤为对症之方。此条毫无阳明脉象病情，故应如郑氏所说，列入太阳篇。

三、阳明病，〔若〕能食（者），（为）〔名〕中风；不能食（者），（为）〔名〕中寒。

郑论：按能食为中风，风为阳，阳能消谷也。不能食为中寒，寒为阴，阴不能消谷也。但阳明病，果是何等病情，而见此能食不能食也。

【阐释】此节言阳明自受风寒之证也。盖阳明居中土，外之风寒干之，故俱言中。又阳明胃腑，以纳谷为务，风寒既内中，风为阳邪，阳能化谷，故能食也，寒乃阴邪，不能化谷，故不能食也。此以能食、不能食来辨别阳明所受之风、或寒也。

四、脉阳微而汗出少者①，为自和也；汗出多者，为太过。阳（邪）〔脉〕实②因发其汗，出多者，亦为太过。太过〔者〕，为阳绝于里③。亡津液，大便因鞭也。

①脉阳微：指脉浮而微软。

②阳脉实：指脉浮有力而盛。

③阳绝于里：指阴液耗损，阳气盛极于里

郑论：论阳明而见脉微，汗出少为自和者，邪衰之征也；汗出多为太过者，又虑阳之外亡也。阳脉实，因发其汗，出多者，亦为太过，太过则津液太亏，大非吉事，故原文谓阳绝于内者，明明言汗之太过也，汗出则阳必与之俱出，而津液有立亡之机，大便因鞭之所由生，而危亡之机，亦于此见也。

【阐释】本节指津液外亡，阳无阴制则燥热益甚，肠中乏液以润，大便因而鞭结。故无论是自汗或发汗，皆不可太过，而使津液耗损，肠中干燥，造成大便鞭的变证。郑氏更进一层指出“汗出则阳必与之俱出，……而危亡之机，亦于此见也”的卓识。

五、问曰：阳明病，外证④云何？答曰：身热，汗自出，（而）不恶寒，反恶热也。

④外证：就是表现在外面的证候。

郑论：太阳症，发热恶寒，惟阳明病发热不恶寒，以此别之。

【阐释】身热汗出，为太阳、阳明共有证状，在临床鉴别上，郑氏说。“太阳症发热恶寒，阳明病发热不恶寒”，仅言其大概，而应补充。太阳脉浮，阳明脉洪大；太阳无里实证，阳明有里实证；太阳证的发热是翕翕发热，而热在体表，阳明病的发热是蒸蒸发热，是热从内蒸。以此别之，更为精审。

六、问曰：何缘得阳明病？答曰：太阳病，若发汗、若下、若（到）〔利〕小便，〔此〕亡津液，胃中干燥，因转属阳明，不更衣⑤，内实⑥，大便难〔者〕，此名阳明也。

⑤不更衣：即不大便，古人入厕，雅言更衣，因此更衣又为大便秘通。

⑥内实：肠中有燥屎结滞。

郑论：此由太阳病，因汗、吐、下后津液大伤，胃中干燥，遂成内实，不更衣，大便难之症作，故称之为阳明病，的确不易。

【阐释】阳明腑证，有因本经热盛，自然化燥而成的；有因误治伤津，病邪化热化燥内传而成的。本条即由太阳病误治而转属阳明腑实证。既言内实，必然有腹满痛

，便闭燥烦等实象。

七、问曰：病有（一日得之）〔得之一日〕，不发热而恶寒者，何也？答曰：虽得之一日，恶寒将自罢，即自汗出而恶热也。

郑论：发热恶寒，太阳症也，而云阳明，是太阳之寒邪已至阳明，而寒邪尚未化尽耳。若化尽，转瞬即独发热不恶寒，而为阳明之本症也。时称瘟疫独发热不恶寒，仍是一阳明证也。时书纷纷聚讼，以为仲景只知有伤寒，而不知仲景之阳明证，即温热之柱脚也。

【阐释】郑氏指出“瘟疫独发热不恶寒，仍是一阳明证也”，是有其独特见解。温病总是一个热病，麻杏石甘汤、白虎汤、白虎加人参汤、大、小承气汤，皆治温病之方也。

八、问曰：“恶寒何故将自罢？”答曰：“阳明居中，〔主〕土也①，万物所归，无所复传，始虽恶寒，二日自止（者），此为阳明病也”。

①主土：土是五行之一，脾胃隶属于土。由于脾和胃的生理机能以及病态表现的不同，所以有脾属阴土，胃属阳土的分别，又因土的方位在中央，所以说阳明居中主土。

郑论：按恶寒将自罢者，是这太阳之寒邪，至阳明地界，阳明主燥，乃多气多血之府，邪至而从燥化，则寒变为热，遂不寒，而独发热也。

【阐释】此承上条说明阳明病恶寒自罢的原因，亦即揭出胃家邪实之所由成也。在未答恶寒何故自罢之前，先叙阳明的部位、功能、性质、病理并隐寓治法，言脾胃同属中土，胃居体之中部，有纳水谷的功能，其性主燥，胃燥太过，则三焦之邪，皆聚于胃，邪入之必成燥化，因燥成实，邪即留中不去，必待下之而后愈。恶寒一证，虽初病时见之，至二日邪从燥化后，必然自罢，此即阳明病恶寒自罢之理。

九、本太阳（病）初得〔病〕时，发其汗，汗先出不彻，因转属阳明也。前段

郑论：太阳病，本应汗解，汗发不透，是寒邪阻滞气机，逆而不出，遂传至阳明，而成阳明症也○

【阐释】此节说明太阳病转属阳明的另一原因为发汗而汗出不彻，以致表邪不得外解，反而内传化燥，因而转属阳明。与前条太阳病转属阳明是发汗而汗出过多，津伤化燥而邪内传，显然不同。故证候的传变与治疗的得当与否，实有密切关系。

十、若汗多，微发热恶寒者，（则）外未解也，其热不潮，（又）未可与承气汤（主之）；若腹大满不通者，可与小承气汤，微和胃气，勿令〔至〕大泄下。后段

郑论：按汗多微发热、恶寒，在久病阳虚之人见此，则为亡阳之征。若新病太阳症之人，而见此者，则为邪将去之兆，并未见潮热，是邪未入阳明，未可与承气汤。若阳明症见，而又有腹满不通，可与小承气汤，是斟酌元气、邪气之盛衰，而令其勿大泄，慎重之意也。

【阐释】本条可分两节。第一节“若汗多微发热恶寒者”……未可与承气汤，此表证未尽解，不可使用下法。第二节“若腹大满不通者，……勿令至大泄下。”说明里实证固应攻下，但燥结未甚，只宜小承气汤微和胃气，不宜大承气汤峻攻。

小承气汤方（校补）

大黄四两（酒洗）厚朴二两（炙去皮）枳实三枚大者（炙）上三味，以水四升，煮取一升二合，去渣，分温二服。初服汤当更衣，不尔者尽饮之，若更衣者，勿服之。

【方解及其应用范围】此大承气汤去芒硝，积、朴用量亦少，药力自比大承气为轻，则势缓矣。治痞满实而不燥的症候。大黄可泻下实热；枳实、厚朴消腹胀痞满。其临床证候与大承气汤类似，但较轻。各种急性热病，治之皆有效。

十一、太阳病，若吐、若下、若发汗〔后〕，微烦，小便数，大便因鞭者，与小承气汤（主之），〔和之愈〕。

郑论：按汗、吐、下三法，无论何法，皆是损元气，亡津液之道，津液伤，则燥气立作，故有微烦，二便数、鞭之症，与以小承气，和其胃气，除其烦热，其病自己。

【阐释】太阳病治之不当，津液受伤，热邪入里，致见心烦，小便数，大便鞭等，此津伤气滞，以小承气汤和之则诸症自愈。

十二、伤寒吐后，腹胀满者，与调胃承气汤。

郑论：按腹胀满，胃家未大实者，可与小承气汤，俾和其胃气，以泄其邪热，乃为合法。若因吐后而中州大伤，以致胀满者，此是胸中胃阳，因吐而伤，宣布失职，浊阴僭乱，堵塞中宫，宜温中健脾，俾胃气宣畅，而胀满自消，此又非调胃承气所宜也，学者临证，宜细求之。

【阐释】若因吐后，见到腹部胀满，有两种情况。其一在上之邪，虽得到排除，而在下之病邪，却化燥成实，此时应用下法，但究因吐后，中气必然受伤，虽有实邪内聚，又不宜峻下，调胃承气汤是为最适当的方剂。其后有如郑氏所云：“若因吐后，而中州大伤，以致胀满者，…宜温中健脾，俾胃气宣畅，而胀满自消。”岂可复用下法，以重伤其正，调胃承气决不可用。笔者认为当用理中汤加砂仁、公丁香治之。

谓胃承气汤方（校补）

大黄四两（去皮，清酒洗）甘草二两（炙）芒硝半升上三味，以水三升，煮取一升，去渣，内芒硝，更上火微煮令沸，少少温服之。

【方解及其应用范围】本方系大承气汤去厚朴、枳实，加甘草而成。大黄泻下实热，芒硝润燥软坚，佐甘草以和胃气，用以治疗腹中有实热，大便燥结的症候。其药力比小承气还轻，对各种急性热病之轻者为宜。治消渴证之中消，即渴而饮食多者，亦有效。

十三、阳明病，心下鞭满者，不可攻之；攻之利遂不止者，死；利止者愈。

郑论：按心下鞭满，有可攻者，有不可攻者，有热结者，有寒结者，总之详（虎）〔辨〕的确，可攻则攻，可攻则勿妄攻，攻之利不止者，死，以其利甚则亡阴，阴亡而阳与之俱亡，故断其必死。若下利而能自止者，是中气犹存，阳不即亡，故知其必生。

【阐释】心下是胃脘部位，心下鞭满，不同于腹部鞭满，可知病邪偏于上。此心下鞭满而不痛，是胃气不实，客气上逆所致。里实腹满可攻，今心下鞭满而非腹鞭满，乃未成实，故不可攻。腹部鞭满是肠中有燥屎内结，可以用承气汤攻下，一下而愈。若此证有虚、实、寒、热之不同，实证、热证可以攻下，可用承气汤；虚证、寒证则不可妄攻，若攻之则脾胃受损，邪气内陷，形成下利不止，甚至胃气败绝而亡。笔者认为可用附子理中汤温补脾肾之阳以救之。若利能自止，是胃气渐复，为病有自愈之机。

十四、伤寒呕多，虽有阳明证，不可攻之①。

①攻之：此处是指泻下而言。

郑论：呕多二字，有热呕寒呕之别，虽有阳明证，不可妄加指责攻，务要审慎的确为是。

【阐释】恶寒发热之呕属太阳，寒热往来之呕属少阳，但恶热不恶寒之呕属阳明，此三阳呕吐之辨证也。郑氏云：“呕多二字，有热呕、寒呕之别”。呕多是病机向上，若用攻法，是逆其所治，最易造成变证。笔者于寒呕者，可用理中汤加吴茱萸以温降之；热呕者，可用黄连吴茱萸汤以清之降之。至三阳症之呕证，必结合三阳病之其它证状，选用三阳之方治之，斯为得矣。

十五、食谷欲（吐者）〔呕〕②，属阳明也③，吴茱萸汤主之。得汤反剧者，属上焦（热）也。

②食谷欲呕：当进餐时气逆作呕。

③属阳明：指胃家虚寒。

郑论：按吴茱萸汤，乃治少阴吐利之方，非阳明之正方也。此刻食谷欲呕，乃属阳明，必是胃中邪热弥漫，隔拒上焦，故得吴茱萸辛燥之品而反剧，可知非虚寒也明甚。如此模糊，何不先判明阴阳，而曰食谷欲呕，喜饮热汤者，可与吴茱萸汤。呕而欲饮冷者，此属上焦有热，以此推去、方不负立法之意。

【阐释】食谷欲呕，这是胃家虚寒的特征，虚则不能纳谷，寒则胃气上逆，所以决诊为阳明确寒，温中降逆之吴茱萸汤，自为对症之方。若上焦有热，服吴茱萸汤相反使病情增剧。郑氏以饮热、饮冷判寒热，以定吴茱萸汤之可用不可用，乃简明扼要之法矣。吴茱萸汤方，载少阴前篇。

十六、阳明中风，口苦咽干，腹满微喘，发热恶寒，脉浮而紧，若下之，则腹满，小便难也。

郑论：此阳明而兼太、少证，何也？口苦咽干，所现者少阳之经证；微喘，发热恶寒，所现者太阳之表邪；脉现浮紧，风寒之征。此证虽云阳明，而阳明胃实之证未见，故曰：若下之，则腹满、小便难，此是教人不可下。若下则引邪入太阴，故见腹满，中枢失职，转输必乖，故见小便难，此刻总宜照三阳并病法治之可也。

【阐释】本条是三阳合病，但以太阳和阳明证最重，所以称做阳明中风。

重点在于阳明，邪热在经，禁用下法，否则引邪深入。仲景未出方治，郑氏说：总宜照三阳并病法治之可也。笔者认为三阳经症同见，即以三阳之方治之，一举祛邪外出，桂麻各半汤加柴、葛、苓、夏主之。

十七、阳明病，脉浮而紧，咽燥口苦，腹满而喘，发热汗出，不恶寒，（而）反恶热，身重。若发汗则（燥）〔躁〕，心愤愤①，反谵语；若加温针，必休惕②，烦

〔躁〕不得眠；若下之，则胃中空虚，客气动隔，心中懊憹③，舌上苔者④，（宜）栀子豉汤主之。若渴欲饮水，口干舌燥者，白虎加人参汤主之。若脉浮发热，渴欲饮水，小便不利者，猪苓汤主之。、、

①懊憹：烦乱貌。

②休惕：恐惧貌。

③懊憹：烦闷不舒。

④舌上苔者：是舌上有黄白薄腻的苔垢。

郑论：论阳明证，而揭出数端，学者当细体求，探其病情，相机施治。但身重二字有误，必是身轻，与阳明证方符，若是身重，则又属少阴也，与此不合，原文变换太冗，俱宜按病治去，不可固执。

【阐释】此条亦三阳并病也。然冠以阳明病者，以其中阳明病居多也。脉浮而紧，表邪未罢，太阳也；咽燥口苦者，少阳也；发热汗出，不恶寒，反恶热，腹满而喘者，阳明也。若汗、下、烧针，俱不可用。如误用之，就发生原文所说病变。这些病变都是由于里热加剧，则当用栀子豉汤治之。若前证外，更加渴欲饮水，口干舌燥者为阳明经气之燥热，则用白虎加人参汤以解热生津。若渴欲饮水，小便不利者，是阳明饮热并盛，津液不得下通，猪苓汤利小便，以泻下焦之热也。故郑氏曰：“原文变换太冗，俱宜按病治去。”是教人细心体求，不可粗心大意。

猪苓汤方（校补）

猪苓（去皮）、茯苓、泽泻、阿胶、滑石（碎）各一两上五味，以水四升，先煮四味，取二升，去渣，纳阿胶烊消，温服七合，日三服。

【方解及其应用范围】本方滋燥利水，猪苓、泽泻都能利小便以泻肾与膀胱之湿；茯苓利小便以渗脾肺之湿；滑石利窍泄热；阿胶育阴润燥去烦渴。治疗阴液不足，发热水气不利的疾患，有很好疗效。近代推广本方以治膀胱炎、尿道炎、血尿、淋病等，以其利尿作用来治疗上述诸病有显效。

十八、太阳病，寸缓关浮尺弱，其人发热汗出，复恶寒，不呕，但心下痞者，此以医下之也。（若）〔如〕其不病人不恶寒（但）〔而〕渴者，此转属阳明也。小便数者，大便必鞭，不更衣十日，无所苦也。

渴欲饮水，少少与之，但以法救之。渴者，宜五苓散。

郑论：据脉象病情，乃太阳经证，本桂枝汤法，非可下之法，若未下而见不恶寒，独发热而渴，此阳明的候，乃白虎汤法。至小便数，大便鞭，不更衣，十余日无所苦，虽在胃腑，其邪未实，故不言下。所云渴欲饮水，亦非五苓的候，当是小便短数而渴，方是五苓的候，学者须知。

【阐释】本条整个内容都是辨证，可分为四节，自“太阳病”至“此以医下之也”为第一节，此表证与里证之辨；自“如其不下者”至“此转属阳明也”为第二节，此误下成痞与未误下邪传阳明之辨；自“小便数者”至“无所苦也”为第三节，此承气证与脾约证之辨；自“渴欲饮水”至“五苓散”为第四节，此胃燥口渴与停水口渴之辨。总之治病必求其本，必须审证精确，才能施治无误。

十九、阳明病，脉浮而紧者，（自）必潮热①，发作有时；但浮者，必盗汗出②。

①潮热：有定时的发热，有如潮汛一样。

②盗汗：睡眠中出汗，犹盗贼之出没于夜间，故名盗汗。

郑论：按脉浮紧，乃风寒之征，阳明之脉，应见长、大、洪、实，乃为的候。此言浮紧，自必潮热，但浮者，必盗汗出，是亦凭脉而定病，未必尽当。潮热，亦必审其虚实，盗汗，亦必究其源委，若执脉而言，恐非正法。

【阐释】脉浮紧、发热、恶寒，是太阳病。若阳明病脉浮紧而见潮热，是热蒸于外，邪实于里，故潮热发作有时；脉但浮而不紧，此为热越在外，盗汗乃出。故郑氏说：“凭脉而定病，未必尽当。”故临床诊断上，必须脉证合参，不能轻率。

二十、阳明中风，脉弦浮大而短气，腹都满①，胁下及心痛，久按之气不通②，鼻干，不得汗，嗜卧，一身及（面）目悉黄，小便难，有潮热，时时哕③，耳前后肿，刺之小差，外不解，病过十日，脉续浮者，与小柴胡汤。脉但浮，无余证者，与麻黄汤；若不尿，腹满加哕者，不治。

郑论：称阳明中风，是邪已确在阳明，至所现病情脉象，实阳明而兼少阳、太阳两经之证，三阳病势弥漫已极，理应照三阳并病法治之。至所主柴胡、麻黄二方，皆是相机而行之法。

①腹都满：作腹部满解。

②久按之气不通：言不按气已短，若久按之气愈不通，盖言其邪气充斥也。

③哕（yu ě 月，上三声）：呕吐。

【阐释】此节称阳明中风，而兼及太阳少阳之证也。而曰阳明者，以阳明症居多。本节证情比较复杂，不论是辨证或治疗，都存在着一定的困难，必须针对着病情的趋势而因势利导，故先刺足阳明三里穴，宣泄经络闭郁之热。“刺之小差，外不解”，是知针刺后里热已解。至所主小柴胡汤、麻黄汤，诚如郑氏所说：“皆是向机而行之法也”。又原文中有“耳前后肿”即《内经》所谓发颐。

俗所谓痄腮也，乡间称寸耳寒，西医称流行性腮腺炎。此病小儿患者很多，笔者常用麻桂各半汤治之，一、二剂即愈。

二十一、阳明病，脉迟④，食难用饱，饱则微烦头眩，必小便难，此欲作谷瘴⑤。虽下之，腹满如故，所以然者，脉迟故也。

④脉迟：即脉搏跳动得慢。

⑤谷瘴（dàn 淡）：指食不消化症。

郑论：此论而推其所以然之故，曰脉迟。迟则为寒，寒甚即不消谷，理之常也。本非热结可下之证，即下之，而胀仍如故，是下之更失宜，欲作谷瘴，亦阴黄之属也。小便难者，亦中宫转输失职之所致，学者当于迟字处理会可也。

【阐释】下之腹满如故，此不当下也。脉迟则寒，阳明确寒，其满不过虚热内壅，非结热当下之候。法当先行温中，如理中汤、甘草干姜汤，然后少与调胃承气，微和胃气可也。谷瘴，水谷之湿，蒸发而身黄也，亦即阴黄证，可用附子理中汤加茵陈治之。此条亦见于《金匱》黄疸病篇。

二十二、阳明病，若中寒（而）〔者〕，不能食，小便不利，手足濇然汗出①，此欲作固瘕②，必大便初鞭后溏；所以然者，以胃中冷③，水谷不别故也④。

①濇（jǐ 及）然：汗出貌，濇，本义为水外流。

②固瘕（jiǎ 甲）：是一种寒气结积的病证，其特征为大便先鞭后溏。腹中结块谓之瘕。

③胃中冷：指胃阳不足，消化机能失职的意思。

④水谷不别：水湿停滞，不能从小便而去，而与谷物相混。

郑论：按中寒故不能食，不食则中宫气衰，转输失职，故小便不利○手足自汗者，脾主四肢，不能收束脾中血液也，（具）〔其〕所以然之故，曰胃冷，其所现一切

，俱胃冷所致，毋庸别议○至于固瘕者，盖溏泄久而不止之谓也。

【阐释】本条是胃阳不足，复感寒邪的阳明中寒证。不能食、手足汗出、大便初鞭后溏等，俱胃冷所致。法当扶脾胃之阳，阳旺则诸症自愈。笔者认为可选用理中汤加砂仁治之。

二十三、阳明病，初欲食，小便反不利，大便自调，其人骨节疼，翕翕如有热状，奄然发狂⑤，濇然汗出而解者，此水不胜谷气⑥，与汗共并，脉紧则愈。

⑤奄然：忽然。

⑥谷气：即水谷的精气，在这里可作正气解。

郑论：其所称阳明病，初欲食者，是胃中尚有权也。胃中有权，转输自不失职，何以小便反不利？不利者，是病在膀胱，而不在胃也。观胃与大肠相为表里，胃气尚健，故见大便自调，骨节疼，翕翕如有热状者，是气机鼓动，邪从骨节而出，翕翕如狂，濇然汗出，是邪从汗出而解也。书云：“战汗而解，狂汗而解”，即此。其中全赖水谷之气胜，而邪并水谷之气而出。脉紧者，言气机盛。非指邪盛也。

【阐释】此承前条，而论阳明中风证也。骨节疼，翕翕如有热状，皆是表证，而里热未成，所以始终病从表解，一汗而愈。郑氏所论极是，笔者从之。

二十四、阳明病，不能食，攻其热必哕，所以然者，胃中虚冷故也。以其人本虚，故攻其热必哕，原文

郑论：经云：胃热则能消谷。此云不能食，明是胃寒不能消谷也。即或有挟热情形，当于温中药内，稍加一二苦寒，则得调燮之妙。若专于攻热，而不温中，岂非雪地加霜，能不致哕乎？

【阐释】阳明病不能食，既有属于实热的，也有属于虚寒的。此条之不能食，实由阳明胃腑虚冷，若误攻其热，则病哕逆，必犯虚虚之祸。这时的救逆，原文中未出方法，可用附子理中汤加吴茱萸，以祛寒降逆而止哕逆。

二十五、脉浮而迟，表热里寒，下利清谷〔者〕，四逆汤主之。

若胃中虚冷，〔不能食者〕，饮水必哕。、

郑论：按外热内寒不利，法主四逆，颇为合宜。又曰胃冷，饮水必哕，胃冷已极，而又以水滋之，阴气更为上僭，乌得不哕？

【阐释】脉浮为表热，迟为里寒，寒者胃中虚也。胃中虚寒，下利清谷，此时手足厥逆，冷汗出，胃中阳气垂绝，必用大剂四逆汤以回阳，乃得转危为安。

若胃中虚冷，不能食者，则中阳自败，较前证更重，饮水则呃逆，非重剂附子理中汤加吴茱萸以救之不可。若投以寻常治嘔之橘皮生姜汤、橘皮竹茹汤，决不能奏功也。

二十六、阳明病，法多汗，反无汗，其身如虫行皮中状者①，此以久虚故也。

①于“其身……”句：形容身痒之状。

郑论：阳明法多汗者，以其内有热也。热蒸于内则汗出。其无汗，身如虫行状者，内无大热，而气机拂郁于皮肤，由表阳太弱，不能运化而出也。

【阐释】阳明病因是热熏蒸，津液被迫，本应多汗，今反无汗，此不但阴亏，津液不足，更兼阳虚失其温化之力，不能使汗达表，致津液欲出不得，故有身痒如虫行皮肤的感觉。此证宜用《金匱》防己黄芪汤略加麻黄，使汗从皮中外泄则愈。

二十七、阳明病，但头眩，不恶寒，故能食而咳，其人咽必痛，若不咳者，咽不痛。

郑论：按头眩，能食而咳，咽痛，皆缘邪火上攻，若不咳、不咽痛、是邪火虽盛，而未上攻也，更宜察之。

【阐释】本条不恶寒而能食，其为阳明证中风无疑。由于风热之邪上干，所以头眩，犯肺所以咳嗽，咽喉为呼吸之门户，肺受热侵，自必影响及咽，故咽痛。若不咳，说明肺未受热侵，故咽亦不痛。

二十八、阳明病，反无汗，而小便利，二三日呕而咳，手足厥者，必苦头痛；若不咳不呕，手足不厥者，头不痛。

郑论：阳明病固属多汗，今无汗而小便利，虽云阳明病，其实内无热也。二三日呕而咳，至手足厥，苦头痛者，必是阴邪上干清道，闭其运行之机耳。果系阳厥，则脉息声音，大有定凭。又曰：不呕不咳不厥者，头不痛，可知全系阴邪上干清道无疑。学者切不可执定一阳明而即断为热证一边看去，则得矣。

【阐释】本条是阳明中寒，阳虚阴盛，挟有饮邪。有如郑氏所云：“必是阴邪上干清道，闭其运行之机耳”。由于胃阳衰弱，水饮内聚，胃失降下，上逆则呕，射肺则咳，胃主四肢，不能温于四末，则手足厥冷；水寒上逆，必患头痛；小便自利，

正反映本病阳虚阴盛的真相。笔者认为可用温中化饮降逆之理中汤加吴茱萸、半夏治之，则咳呕、手足厥冷、头痛等证自愈。

二十九、阳明病，下之，其外有热，手足温，不结胸，心中懊憹饥不能食，但头汗出者，栀子豉汤主之。

郑论：既云下之，其邪热必由下而解，自然脉静身凉。，方可全瘳。兹称其外有热，手足尚温，必然肌肉之间，而邪未尽解，虽未结胸，是邪热未伏于隔间耳。其人心中懊憹，是里气虽因下而稍舒，但表分之邪气拂郁未畅，畅则旷怡，不畅则心烦不安，此懊憹之所由来也。饥不欲食者，是脾气已虚，而胃气不运。兼之头汗出者，阳气发泄于上，有从上解之机也。但栀子豉汤，虽曰交通水火，似觉未恰。

余意当于脉息处探其盛衰，热之微盛，审其真假，心之懊憹，究其虚实，汗之解病与不解病，详其底蕴，又于口之饮热饮冷，二便之利与不利处搜求，自然得其要也。此以栀子豉汤，是为有热者言之，而非为虚寒者言之也。学者不可专凭原文一二语，以论药论方，则得一贯之旨矣。

【阐释】郑氏对此条之论释，与历代注家不同，着重阳虚一面，故说：“此以栀子豉汤，是为有热者言之，而非为虚寒者言之也。”若脉息不足，目瞑倦卧，声低息短，少气懒言，喜饮热汤，二便自利等情，此下伤脾胃，心中懊憹，饥不能食，头汗出者，乃阳虚也，栀子豉汤不可用也。法当扶阳，交通水火，白通汤为适当之方剂；或理脾开胃，兼以扶阳，附子理中汤可用。

三十、阳明病，口燥，但欲漱水，不欲咽者，此必衄。

郑论：据口燥而漱水，乃火炎之征，漱水而不咽，又非实火之验，断为必衄者，邪实之候说法也。漱水而不咽者，断无有必衄之证也。此证似非阳明，乃少阴之证也。姑言之，以待高明。

【阐释】口中干燥与口渴不同，漱水不欲咽，知不渴也，可知非实火。而又曰“此必衄，邪实之候也。”其说两相矛盾。历代注家，牵强注释，殊不可从。

郑氏说：“此证似非阳明，乃少阴之证也。”舒驰远《伤寒集注》云：“漱水不欲咽，当是里阳衰乏，不能熏腾津液之故，此属少阴。奈何指为阳明病乎？”可与郑说互参。

三十一、脉浮发热，口干鼻燥，能食〔者〕，则衄。

郑论：按脉浮发热，风热在表也，口燥鼻干，热入阳明也。能食则衄，胃气健而鼓

动，便可以从衄解也。

【阐释】鼻衄，有解病佳兆者。口干鼻燥，能食，虽阳明里证未全成，阳明内热已太盛，热甚则上逆，上逆则引血，血上则衄，热邪亦随之而泄。近世医家以衄为红汗者，正以其泄郁热故也。郁热泄则自愈。

三十二、阳明病，发热汗出者，此为热越①不能发黄也；但头汗出，身无汗，剂颈而还，小便不利，渴饮水浆者，此为瘀热在里②身必发黄，茵陈蒿汤主之。

①热越：里热发越于外之意。

②瘀热：即邪热郁滞的意思。

郑论：条中所言热外越者，不发黄，是因汗出，知其表气通，而热得外泄故也。若头汗出，身无汗，小便不利，渴欲饮水者，此是热伏于内，抑郁太甚，而邪无由路出，故成阳黄之候，茵陈蒿汤主之，实为的证之方，妥切之甚者也。

【阐释】此节乃阳明湿热郁蒸发黄的证状。若但头汗出，周身没有汗，则热不得越；小便不利，由湿无出路，邪热既不能外达，水湿又无从下泄，水湿与热邪相蒸不解，郁而不达，身心发黄，治以茵陈蒿汤，苦寒通泄，使湿热之邪从小便而出，湿去热清，则发黄自愈。

茵陈蒿汤方（校补）

茵陈蒿六两 栀子十四枚（擘） 大黄二两（去皮） 上三味，以水一斗二升，先煮茵陈，减六升，内二味，煮取三升，去渣，分三服。小便当利，尿如皂荚汁状，色正赤，一宿腹减，黄从小便去也。

【方解及其应用范围】湿热瘀里，蒸发而外见黄色，用茵陈苦寒清湿而解郁热，佐栀子清利三焦，以通水道，以大黄除胃热，导火下行兼清血分中之热。三味合用，使瘀热湿浊，从小便而出，湿热一泄、则发黄自愈。《伤寒》《金匱》二书中，分黄疸为阴阳两纲，叙述简略，仅根据皮肤黄染情况来辨阴阳。凡身目俱黄，黄如橘子色泽鲜明，小便不利，色黄赤而短少，腹胀食少，厌油食，舌苔黄腻，脉滑数者，为阳黄。

无论其为现代医学所称之急性黄疸型传染肝炎，湿热偏盛的慢性肝炎，肝胆道感染，胆道结石等病见阳黄证者，都可用本方加减治疗。

三十三、阳明病，面合色赤①，不可攻之。（攻之则）必发热，色黄〔者〕，小便

不利也。

①面合色赤：即面色通赤。

郑论：据阳明而面赤色，又当察其可攻与不可攻，如气粗面赤，唇焦，饮冷甚者，宜攻之；若虽面赤而无热象足征，又不可攻，攻之则必发热者，是真阳因攻而浮于上，浮于上，即不能化下焦之阴，小便亦见不利。学者切勿执一阳明病，而定为热证，妄施攻下也。此条所谓不可攻，攻之则必发热，焉知非（带）〔戴〕阳而何？

【阐释】邪热怫郁在经，禁用攻下，误攻下，必然发热，肌肤发黄而且小便不利。因误攻而见此证，欲救其失，茵陈五苓散可用。郑氏更论及“虽面赤而无热象足征，又不可攻，攻之则必发热者，是真阳因攻而浮于上，……焉知非戴阳而何？”戴阳乃危证，救逆之法，非大剂回阳不可。

三十四、阳明病，无汗，小便不利，心中懊憹者，身必发黄。

郑论：邪至阳明而从热化，无汗者，邪不得外泄，小便不利者，邪不得下泄，抑郁于中而懊憹，懊憹者，心不安之谓，所以断其必发黄也。

【阐释】阳明病没有汗出，是湿热不能外散；小便不利，几水湿不能下行。

湿与热蒸于内，则身体发黄。未出方剂，似宜麻黄连翘赤小豆汤外发内利；或栀子豉汤以清里而达表，则身黄自退。

三十五、阳明病，被火，额上微汗出，而小便不利者，必发黄。

郑论：阳明本属（躁）〔燥〕地，又得阳邪，又复被火，火势内攻，小便不通，热邪无从下泄，遏热太甚，是以决其必发黄也。

【阐释】阳明病，无汗，本应以葛根汤发其汗，今竟以火劫取汗，则热邪愈炽，津液被束，无复外布与下渗矣，其身必发黄。未出方治，根据辨证，必须清热利湿，栀子柏皮汤主之。

三十六、阳明病，下血谵语者，此为热入血室。①但头汗出者，刺期门，随其实而泻之，濇然汗出则愈。

①血室：各家见解不一，有的认为是冲脉，有的认为是肝脏，有的认为是子宫，所说都均有一定理由，顾名思义，要不外血液储留之处，三者均有连带关系，不需强分。又少阳篇条所指“血室”即子宫。

郑论：据阳明而称下血，必是胃中有热，逼血下行耳。谵语者，热气乘心，神无所主也。兹云热入血室，夫膀胱之外，乃为血海，又称血室，此病系在阳明大肠，何得直指之为血室乎？何得刺期门穴乎？但下血一（等）〔证〕，有果系热逼血下行者，必有热象可征。谵语一证，有阳虚、阴虚、脾虚之异。更有下血、谵语而将脱者，不得总统言之，学者务宜细心探求则得矣。

【阐释】本证由于邪热炽盛，血为热扰，故便血；内热蒸腾，故头汗出；热气乘心，神无所主，故谵语。郑氏按称：“此病系在阳明大肠，何得直指之为血室乎？何得刺期门穴乎？……务宜细心探求则得矣，”笔者信而从之。

三十七、阳明证，其人（善）〔喜〕忘者①，必有畜血②，所以然者，本有久瘀血，故令（善）〔喜〕忘，粪虽（难）〔鞭〕，（而）大便反易，其色必黑〔者〕，宜抵当汤（主）〔下〕之。

①喜忘：喜作善字解，言语动静随过随忘，即健忘之意。

②畜血：畜与蓄字同，瘀血停留叫蓄血。

郑论：据善忘缘因瘀血所致，瘀滞不行，气血不得流通，神明寓于气血之中，为气血之主。今为瘀血所阻，气血不得流通，神明每多昏愤，所以善忘而断之瘀血，确乎不爽。但蓄血在太阳，验之于小便，其人如狂；蓄血在阳明，验之于大肠，其色必黑，大便色黑者，蓄血之验也。

【阐释】太阳蓄血证是太阳之邪热随经入腑与血相结，以致出现少腹急结，或鞭满，小便利，如狂、发狂等证候。阳明蓄血证是阳明邪热与宿有的瘀血相结，故令善忘。二者证状不同，因蓄血扰乱神志则一。辨太阳蓄血证在小便之利与不利，辨阳明蓄血证在大便之黑与不黑、难与不难。两者的病理机转都是属于邪热与血相结，所以都可用抵当汤下之。

三十八、病人无表里证，发热七八日，虽脉浮数者，可下之。假令已下，脉数不解，合热则消谷善饥，至六七日，不大便者，有瘀血（也），宜抵当汤。若脉数不解，而下（利）不止，必协热（而）便脓血也。、

郑论：既称无表里证，即不在发表之例，即不在攻下之例，虽脉浮数，总要有风热病情足征，庶可相机施治。所云发热七八日，然发热有由外入之发热，有由内而出之发热，大有泾渭之分，若只凭脉之浮数而攻之，则由外入者，有内陷之变，由内而出者，有亡阳之逆，假令下之脉数不解，合热则消谷善饥，此是为果有外邪致发热者言之，而非为内出之发热者言之也。迨至六七日，不大便者有瘀血，何以知其必有瘀血也？况热结而不大便者亦多，此以抵当汤治之，似不恰切，仲师未必果有

是说也。

【阐释】郑注此条与历代注家不同，发热有外入与内出之分，若只凭发热而攻之，则有邪热内陷与亡阳之虞。假令已下脉数不解，合热消谷善饥，不大便者，何以辨之，并无征验，况热结而不大便亦多，提出质疑。最后归结为“此以抵当汤治之，似不恰切，仲师未必果有是说也。”

三十九、病人烦热，汗出则解，又如疟状，日晡所发热者，属阳明也。脉实者，宜下之；脉浮虚者，宜发汗。下之与大承气汤；发汗宜桂枝汤。

郑论：此条以脉实、脉虚，而定为可汗、可下，似未必尽善。

论脉实而要有胃实病形足征，方可言下，脉浮虚而要有风邪足征，始可言发汗，若专以日晡发热，而定为阳明证，即下之，决不妥切。

【阐释】本条系太阳阳明并病，即表里俱病，必先解表而后攻里。但不能仅根据脉象虚实来决定汗、下，而应结合证状来辨别太阳之表邪是否已解，或阳明之里实是否已成，然后先表后里，解表用桂枝汤，下之与大承气汤，方为合法。

伤寒恒论卷五

阳明中篇

凡外邪尽入胃腑，谓之正阳阳明，列于此篇，计三十一法（据舒本校增）

一、阳明之为病，胃家实〔是也〕。

郑论：阳明乃多气多血之府，邪至阳明（躁）〔燥〕地，与胃合成一家，其邪易实，故病见邪盛者极多，故曰胃家实。

【阐释】“胃家实”三字是阳明病的提纲。胃家包括肠、胃而言，“实”字有广义和狭义的区别，广义包括经腑两证，狭义就是单指阳明腑证而言。《内经》所说“邪气盛则实”并不仅指有形结滞而言。食物积滞而实者，承气证；热邪积滞而实者，白虎证。

二、伤寒三日，阳明脉大。

郑论：一日太阳，二日阳明，三日少阳，乃传经之次第。今三日而见脉大，可知其邪未传少阳，而仍在阳明也，何以知之，浮为太阳，大为阳明，弦为少阳故也。

【阐释】阳明病的脉大，必然大而有力，假使大而无力，或浮大无根，那就不一定全属于阳明病。此云三日阳明脉大者，谓不兼太阳阳明之浮大，亦不兼少阳阳明之弦大，而正见正阳阳明之大脉也。

三、伤寒发热无汗，呕不能食，而反汗出濇濇然者，是转属阳明也。后段

郑论：按发热无汗，寒伤营也，呕不能食，太阳有寒也，汗出濇濇然者，寒邪外出也。此曰转属阳明，果何所见而然乎？余甚不解。

【阐释】郑氏将《伤寒论》条分作两条，前段列入阳明上篇条，本条即后段。伤寒发热无汗，呕不能食，是少阳小柴胡证，不因发汗而反汗出濇濇然者，此由少阳转属阳明也，如此注释，郑氏之不解可解矣。

四、伤寒转（属）〔系〕阳明者，〔其人〕濇然微汗出也。

郑论：按转属阳明，必有阳明证足征，或见肌肉之间大热，而又见口渴饮冷，气粗口热，蒸蒸汗出，如此言之，则曰转属阳明，方可无疑。而此只凭一濇濇然汗出，而即谓之转属阳明，实不恰切。

【阐释】凡伤寒转属阳明，不论由太阳、少阳、少阴等转系阳明，其人必见濇濇然连绵不已之微汗出也。此其里热亢盛，将水分外熏而为汗，肠中始得结实，而成鞭满便难之阳明证。郑氏曰：“而此只凭一濇濇然汗出，而即谓之转属阳明，实不恰切。”舒驰远曰：“此条但据汗出濇濇一端，便是转属阳明，恐不能无疑。若热退身凉，饮食有味，岂非病自解之汗耶？必其人恶热、不恶寒，腹满、按痛、谵语诸证错见，方为有据，否则不足凭也。”故临床不能凭一证以定寒热虚实，须四诊合参乃可。

五、太阳病三日，发汗不解①，蒸蒸发热②者，属胃也，调胃承气汤主之。

①发汗不解：指发汗后热病不愈，不是太阳病不解。

②蒸蒸发热：有如蒸笼中热气，从内向外蒸腾一样，热面潮润。

郑论：按三日，乃少阳主气之期。今太阳发汗而不解，是邪入阳明，而未传经也。观其蒸蒸发热者，阳明内热之征，可以无疑矣。故以调胃承气汤治之，其病自愈。

【阐释】发汗以后，太阳表证虽解，而邪气反化热传里，转为阳明腑实。当时证状，除了蒸蒸发热以外，一定还有腹满、便秘、或心下鞭，郁郁微烦等腑实见证，才能使用调胃承气汤。设若没有上述证状，仅凭蒸蒸发热，就使用下法，是不恰当的。

六、阳明病，本自汗出，医更重发汗，病已差，尚微烦不了了者，此〔必〕大便（已）鞭故也。以亡津液，胃中干燥，故令大便鞭。当问其小便日几行，若本小便日三四行，今日再行，故知大便不久出，今为小便数少，以津液当还入胃中，故知不久必大便也。

郑论：此由过汗伤及津液，已致胃燥失润，问其小便尚利，津液未竭，故知其不久必便也。

【阐释】阳明病大便鞭而难出，有热结与津液不足两端。热结者可以攻下，承气汤之类。津液不足者，必肠中津液增加，大便鞭得濡润，无需攻下，亦必然不久自出。至于小便多的，大便必鞭；大便溏泄的，小便必少，是诊断大便鞭与溏泄的关键。今小便少，则津液还停胃中，胃中津液足，则大便润，润则软滑，此其所以必出也。

七、阳明病，自汗出（者），若发汗，小便自利者，此为津液内竭，虽鞭不可攻之。当须自欲大便，宜蜜煎导而通之，若土瓜根及（与）大猪胆汁，皆可为导。

郑论：按汗自出，与小便自利，二者皆是大伤津液，故大便虽鞭者，不可攻之，俟其津液自回，亦可自便。此以蜜导法治之，亦切要之法，此又与热结者，不可同法也。

【阐释】本条大便鞭，是因自汗出，小便自利而大伤津液，肠中津液枯竭，与阳明中篇条津液不行的脾约证，燥热结实的承气证，即郑氏所说热结皆不同，须详辨之，必俟其津液自回，用蜜煎因势利导之。

蜜煎方附：猪胆汁导法（校补）

食蜜七合上一味，于铜器内，微火煎，当须凝如饴状，搅之勿令焦着，欲可丸，并手捻作挺，令头锐，大如指，长二寸许。当热时急作，冷则鞭。以内谷道中，以手急抱，欲大便时，乃去之（疑非仲景意，已试甚良）。

又大猪胆汁一枚，泻汁，和少许法醋，以灌谷道内，如一食顷，当大便出宿食恶物，甚效。

【方解及其应用范围】这是两种通导大便的法，适用于多汗伤津，尺脉迟弱，元气素虚，想大便而便不出的病人。一般津液枯的用蜜导，邪热盛的用胆汁导。现西医用灌肠法，此法遂废而不用。

八、阳明病脉迟，虽汗出不恶寒者，其身必重，短气、腹满而喘，有潮热者，此外欲解，可攻里也。手足濇然（而）汗出者，此大便已鞭也，大承气汤主之，若汗多，微发热恶寒者，外未解也，其热不潮，未可与承气汤，若腹大满不通者，可与小承气汤，微和胃气，勿令至大泄下。

郑论：阳明主脉大，脉迟者，里有寒也。虽汗出不恶寒，因属内热之征，而汗出与身重、短气、腹满而喘观之，证属少阴，而非阳明，即汗出不恶寒一端，务要果有舌黄、干渴、饮冷、大热，方可称阳明的证，再加以日晡潮热，与手足濇然汗出，大便已鞭，则大承气乃为的候。若汗多、微发热、恶寒，则又属太阳之邪未解，又当表之，故曰其热不潮，未可与承气，足以见用药之大有分寸，即腹满大便不通，又当审其轻重而斟酌于大小之间，勿令大泄，可见用药之非易易也

【阐释】郑氏论此条着重在辨析太阳、阳明、少阴的疑似证。若汗多，微发热恶寒者，太阳证也，若汗出与身重，短气，腹满而喘者，少阴证也，汗出不恶寒一端，需参以舌黄、干渴、饮冷、大热，乃阳明的证，再加以日晡潮热，手足濇然汗出，大便燥实，则为大承气证。即腹满大便不通，郑氏亦告诫“当审其轻重而斟酌于大小之间，勿令大泄。”示人辨证用药时宜慎之。

大承气汤方（校补）

大黄四两（酒洗）厚朴半斤（炙去皮）枳实五枚（炙）芒硝三合上四味，以水一斗，先煮二物，取五升，去渣，内大黄，更煮取二升，去渣，内芒硝，更上微火一二沸，分温再服，得下，余勿服。

【方解及其应用范围】按《伤寒论》有大、小、调胃承气汤之别。大承气汤治正阳阳明，小承气汤治少阳阳明，调胃承气汤治太阳阳明。盖阳明病者，胃肠热病也。大承气为攻下重剂，治伤寒阳明腑证，阳邪入里，胃实不大便，发热谵语，自汗出。不恶寒，痞满燥实坚全见。《内经》谓：“热淫于内，治以咸寒，火淫于内，治以苦寒。”

芒硝之咸寒，以润燥软坚，配合大黄之苦寒，泻实滞，清结热。再加枳实苦寒，厚朴苦温，下气破结而除痞满，实满。唐容川谓：“三承气不但药力有轻重之分，而其主治亦各有部位之差别。大承气汤，仲景提出大便已鞭四字，是专指大肠而言，大肠居下，欲其药力直达，不欲其留于中宫，故不用甘草；大肠与胃同禀燥气，故同用硝、黄，以润降其燥；用枳、朴者，取木气疏泄，助其速降也。”本方煎煮时，大黄必须后下，后下则气锐行速，能充分发挥药之效力。本方在《伤寒论》中用于阳明病者有十一条，用于少阴病者有三条，大都有热结里实，宜急下存阴的病症。郑氏专就阳明里症立说，故特别提出“胃家实”三字提纲，必须审察的确，如大、小便不通，大便鞭、腹满、狂乱奔走叫骂，不避亲疏，潮热、谵语种种病象，务宜斟酌不可猛浪误用。又指出吴又可《温疫论》中用此方者有三十余症，教人宜明圆通应用之妙。郑氏在《医法圆通》中，推广应用以治咳嗽声如洪钟、食入即吐及头晕神昏无主三症。此三症俱非应下之症，但审其俱由邪火炽甚而致，故用本方治之而愈，实属善用成方。笔者曾用此方治伤热咳嗽，所投辄效；又用治臌胀病，患者腹胀如鼓，胸胁满闷，皮肤苍黄，肌肉变硬。大便秘结，所下如羊矢，舌质深红，苔黄燥，脉沉实有力，精神不衰，口渴饮冷。此属阳明腑症，痞满燥实俱备，大承气汤下之而愈。现加减化裁，能治多种肠梗阻及阑尾炎，亦治流行性乙型脑炎，于通下后即能热退神清，抽搐停止。

九、病人不大便五六日，绕脐痛，烦躁，发作有时者，此有（躁）〔燥〕屎，故使不大便也。

郑论：按大便五六日不便，绕脐而痛，非有热结，必系（躁）〔燥〕屎阻滞气机，不得流通畅，故有此等病形也。

【阐释】此条系肠中燥屎内结的主要证状，绕脐痛，烦躁，发作有时，其原因在于肠中燥屎不得出，矢气攻冲，时而发作，时而停止，可用大承气汤攻下之。

十、大下后，六七日不大便，烦不解，腹满〔痛〕者，此有（躁）〔燥〕屎也，所以然者，本有宿食故也，宜大承气汤。

郑论：按既经下后，应当通畅，复见六七日不大便，反烦不解，腹满，定是下时，而邪未泄尽，复又闭塞耳。果系泄尽，又云有复闭塞之理乎？此条称有屎宿积，亦是正论。

【阐释】患阳明腑证，大下之后，六七日又不大便，烦不解，则热未退可知，腹胀痛，此肠中有燥屎宿食积聚。下之未尽，仍当下之。

十一、病人小便不利，大便乍难乍易，时有微热，喘冒不能卧者①，有（躁）〔燥〕屎也，宜大承气汤。

郑论：此条总缘（躁）〔燥〕矢不行，隔塞于中，而各经气机不得舒畅，气阻于前阴，则小便不利，气阻于胆，则夜不能眠，气逆于肺，则喘证生，气阻于卫，则微热作，大便之乍难乍易者，皆气机之时开时阖所致也。急以大承气汤治之，去其（躁）〔燥〕矢，（躁）〔燥〕矢一去，气机立通，则诸证自释矣。

①喘冒：喘，因腹满壅甚，故短气如喘。冒，是热甚昏眩的现象。

【阐释】小便不利，喘冒不能卧，微热，大便乍难乍易，如郑氏所说总缘燥矢不行，隔塞于中，各经气机不得舒畅所致。用大承气汤内攻燥屎，燥屎除则诸证自愈。

十二、阳明病，潮热，大便微鞣者，可与大承气汤，不鞣者，不可与之。若不大便六七日，恐有（躁）〔燥〕屎，欲（和）〔知〕之法，少与小承气汤，汤入腹中，转失气者①，此有（躁）〔燥〕矢，乃可攻之。若不转失气〔者〕，此但初头鞣，后必溏，不可攻之，攻之必胀满不能食也。欲饮水者，与水则哕。其后发热者，必大便复鞣而少也，以小承气汤和之。不转失气者，慎不可攻也。

①转失气：肠中屎气下趋，俗言放屁。

郑论：按鞣与不鞣，指邪热之轻重，而定可攻与不可攻之意也。转失气与不转失气，乃决有（躁）〔燥〕屎无（躁）〔燥〕屎之真伪也。若攻之胀满不食，法宜温中，又非承气可了也。

【阐释】本条是反复说明运用承气汤的辨证。具体说可分为三段看，从开首至不可与之为第一段，辨识大承气汤的应用；若不大便至与水则哕为第二段，从失气不失气来辨识小承气汤的应用；其后发热至文末为第三段，从发热和失气的机转来决定是否应用小承气汤。若郑氏所论“攻之胀满不食，法宜温中。”则当用理中汤加半

夏、砂仁主之。

十三、阳明病，下之，心中懊憹而烦，胃中有燥屎者，可攻。腹微满，初头鞭，后必溏，不可攻之。若有燥屎者，宜大承气汤。

郑论：按阳明下后，而懊憹心烦者，热邪未去，而扰攘太甚也。胃中尚有燥矢者，下之而结热未净也。燥者可攻，里实也；先鞭后溏者，不可攻，里虚也。此处就是认证眼目，用药法窍，学者宜细求之。

【阐释】攻下是阳明腑实证的正治方法，现攻下后，病者心中有懊憹而烦的见证，可见邪气还没有尽除。但是下后心烦懊憹，有热邪不除留于胸隔的栀子汤证；有燥屎未去积滞内阴的大承气汤证。指出胃中有燥屎者，即辨证的要点，可用大承气汤再下之。

十四、得病二三日，脉弱，无（少）〔太〕阳柴胡证，烦〔燥〕，心下鞭，至四五日，虽能食，以小承气汤，少少与微和之，令小安。至六、七日，与承气汤一升。若不大便六七日，小便少者，虽不（能）〔受〕食，但初头鞭，后必溏，未定成鞭，攻之必溏，须小便利，屎定鞭，乃可攻之，宜大承气汤（主之）。

郑论：按此条既称脉弱，无（少）〔太〕阳柴胡证，即见烦躁，心下鞭，焉知非寒结，而成心下鞭乎？况条中并无阳明热证实据，只凭屎定鞭一语，而断为大承气汤证，于理法诚有未当，尚祈高明证之。

【阐释】郑氏对此条之按，与历代注家不同，持否定之意见。先提出“焉知非寒结而成心下鞭”质疑。继又说：“条文中并无阳明热证实据，只凭屎定鞭一语，而断为大承气汤证，于理法诚有未当”。笔者遍阅成无己、柯韵伯、陈修园等十余家之注，都牵强附会，反不若从郑氏存疑之说为当。

十五、阳明病，不吐不下，心烦者，可与调胃承气汤。

郑论：按邪至阳明，未经吐下，但心烦者，此以承气汤主之，是以为热伏于内也。余谓心烦故似热象，有胃液被夺，不能输津液于心肾者，不得一例论之，统以承气为是。

【阐释】阳明病必至腹满、便秘、潮热、谵语，乃可大攻下。此条邪热在胃，未经吐下而心烦，为邪热郁蒸也，可与调胃承气汤微溏之，以解其热，则心烦自愈。郑氏更进一层曰：“心烦故似热象，有胃液被夺，不能输津液于心肾者”，则调胃承气汤不可用，法当养阴益胃，以竹叶石膏汤加沙参、玉竹、生地治之。

十六、阳明病，谵语发潮热，脉滑而疾者①，小承气汤主之。因与承气汤一升，腹中转（矢）气者②，更服一升；若不转（矢）气〔者〕，勿更与之。明日又不大便，脉反微涩者③，里虚也，为难治，不可更与承气汤也。

①脉滑而疾：脉象圆滑流利，应指快速。

②转气：即前条转矢气之意。

③微涩：脉象微而无力，蹇涩而不流利。

郑论：按谵语发热，本可下之证，仲师斟酌，转矢气与不转矢气，以定可攻与不可攻之分。但转矢气而下之，复见脉微涩，此又正气之虚，此刻欲攻之，则恐正气不胜，不攻之，又虑邪气复炽，故曰难治，不可更与承气汤也。

【阐释】原文云：“明日又不大便，脉反微涩者，里虚也，为难治”。微为阳虚，涩为液竭，是阴阳两虚的表现，攻邪则伤正，扶正则碍邪，所以断为难治。所谓难治，并不等于不治，而邪实需攻，正虚宜扶，自以攻补兼施为宜。笔者认为可用四逆汤以补阳，加参、归、地以助阴，合承气汤而治之，则难治者不难矣。

十七、夫实则谵语①，虚则郑声②，郑声者重语也。前段

①谵语：是神志昏乱，语言没有伦次，声音粗壮。

②郑声：是说过又说，语言重复，细语呢喃，声低息短。

郑论：此条举虚实，以明阴阳现证之异。异者何？声厉、声低是也；有神、无神是也；张目、瞑目是也；安静、不宁是也。学者不可粗心，务要将谵语、郑声情形实据，熟习于胸，临证分辨，庶不误人。

【阐释】谵语属阳，郑声属阴，有如郑氏所言，“以明阴阳现证之异”。

是实是虚，当从全面证状来确定。然谵语中亦有虚证，不可不知。实证多见于阳明热实之证，由于燥实内结，浊气上干，神明受热熏灼，以致发生神志昏乱的状态。虚证是心神将脱，谵语时而昏乱，时而清澈者，或独自谵语，呼问则清楚等是也。实证治以承气汤，虚证仍当用温法治疗。郑声者，精神衰乏，不能自主，语言重复，其声微短，正气虚也，法当回阳以治之，如四逆加人参汤是也。

十八、直视谵语，喘满者死，下利者亦死。后段

郑论：按直视、谵语、喘满者，明是胃火灼尽阴精，此条专举胃火旺极者言也。更有少阴真阳衰极，真精不能上荣于目亦直视，危亡已在瞬息之间。直视而见喘满者，阴精将尽，而又下利，更竭其液，不死何待？

【阐释】直视谵语，是阳热亢极，阴精告竭的现象，火热上亢，神明受扰故作谵语。热甚伤阴，五脏之精气，被邪热所劫，不能上荣于目，故直视不动，如果再见喘满，则阴精竭绝，阳失依附，而气从上脱；若见到下利的证状，是中气亦败，邪实正虚，且利复伤阴。两者皆是死候。郑氏更论及少阴真阳衰极，真精不能上荣于目之直视，危亡已在瞬息之间，法当大剂回阳以救之。

十九、发（热）〔汗〕多，若重发汗者，亡其阳①，谵语脉短者死②，脉自和者不死③原文

①亡其阳：汗液出得太多，致有虚脱的现象。

②脉短：是上不至寸，下不至尺，只有关脉搏动。

③脉自和：与脉短相对而说，也就是脉无败象的意思。

郑论：按阳明发（热）〔汗〕，多属有余，阳旺阴必亏，若重发汗，阴必亡，阴亡阳亦与之俱亡，谵语、脉短，阴阳两不相顾之候，不死何待？若脉尚自和者，阴血未尽灭也，故断其不死。

【阐释】本条指出虚证谵语的成因是汗多重发汗，不但津液更伤，而阳气随汗外泄，有亡阳之虑，属大虚之候，脉短，这是气血津液消耗殆尽，行将阴阳离绝，故为死候。脉自和，则知阴阳尚未脱离地步，用药治疗得当，可以不死。

二十、阳明病，其人多汗，以津液外（亡）〔出〕，胃中（躁）〔燥〕，大便必鞭，鞭则谵语，小承气汤主之；若一服谵语止〔者〕，更莫〔复〕服。

郑论：按因汗出以致谵语，大便鞭者，胃（躁）〔燥〕也，血液外亡也，今既下之，而大便不鞭，不谵语者，胃得润而和，故令其勿更服，恐再下之，而别生他病也。

【阐释】谵语由于便鞭，便鞭由胃燥，胃燥由于津液少，津液少为热实于里而汗液外泄。因为大便鞭结。腑气不通，则秽浊之气上攻，心神不扰，所以发生谵语。小承气汤以去实热而和胃，则谵语自止。

二十一、伤寒四五日，脉沉而喘满，沉为在里，而反发其汗，津液越出，大便〔为

〕难，表虚里实，久则谵语。

郑论：按邪原在里，而反汗之，其误已甚，汗出则津液外越，津液外行，自然胃（躁）〔燥〕而大便亦与之俱（躁）〔燥〕，（更）〔便〕所以难也，里分邪实，无怪乎谵语也。

【阐释】表证之喘满，其满在胸部，其脉必浮；里证之喘满，其满在腹部，其脉必沉。前者可用麻黄汤之类发其汗则愈；后者发汗则误，以致津液外越，燥实结于内，久则谵语。此以过汗伤津，而不致大实满痛，宜少与小承气治之。

二十二、伤寒若吐若下后不解，不大便五六日，上至十余日，日晡所发潮热，不恶寒，独语如见鬼状。若剧者，发则不识人，循衣摸床，惕而不安，微喘直视。脉弦者生，涩者死。微者，但发热，谵语者，大承气汤主之；若一服利，〔则〕止后服。

郑论：按既经吐下后不解，延至如见鬼状，循衣摸床，微喘直视者，乃将死之征。但脉弦者，弦为阴象，是阴尚未尽也，故曰生。

若脉见涩，涩为血枯，枯则阴竭，不死何待？病形若但发热谵语，而无直视可据，故以大承气汤主之。

【阐释】伤寒表证，应汗之使邪从外解，反治以吐下，以致津伤化燥，邪陷成实，不恶寒，发潮热，便秘，都是胃肠燥实之征，延至独语如见鬼状，循衣摸床，惕而不安，微喘直视，此不仅阳明腑实自病，且已波及厥少二阴，危之甚矣。脉弦为正气尚存，阴精未竭，故曰脉弦者生；脉涩是营血衰竭，阳亢阴绝，故曰脉涩者死。若但见发热谵语之腑实证，可用大承气汤荡涤其燥结，然此峻下之剂，必须中病即止，以免过剂伤正。

二十三、汗出谵语者，以有（躁）〔燥〕屎在胃中，此为风也。须下（之）〔者〕，过经乃可下之①。下之若早，语言必乱，以表虚里实故也。下之（则）愈，宜大承气汤。

①过经：这里是太阳表证解除之意思。成无己注：须过太阳经无表证。

郑论：按既称汗出谵语，明是内热胃（躁）〔燥〕而有（躁）〔燥〕屎也。何得以风名之乎？又曰下之早，而语言必乱，乱亦谵语之属也，何必强名之乎？总之此病乃为里实证，故下之可愈。

【阐释】此条郑氏不随文注释，亦不牵强附会，而提出质疑，最后归结为：此病乃

为里实证，故下之可愈。可启迪后学深思之。

二十四、阳胆病，谵语有潮热，反不能食者，胃中必有（躁）〔燥〕屎五六枚也，若能食者，但鞭尔，宜大承气汤（主）〔下〕之。

郑论：按（躁）〔燥〕屎与但鞭，二者有轻重之分，其间谵语、潮热、不能食，皆胃中热结阻滞也。

【阐释】以能食不能食，来辨别腑实内结的微甚。重则燥屎阻结，轻则仅仅便鞭。已结者开其结，未结者涤其热，不令更结。谵语潮热虽相同，但腑实的程度有轻有重，原文俱主以大承气汤。笔者认为能食者，只用小承气微和胃气即可。若不能食，是燥屎已成之确据，则可用大承气汤下之。

二十五、阳明病，发热汗多者，急下之，宜大承气汤。

郑论：按阳明发热汗多，而急下之者，何也？恐血液外越过盛，而胃中反生（躁）〔燥〕结等证，下之正所〔以〕存津液以安胃也。但此证，只凭一发热汗多而定为急下，况人参白虎证，亦大热汗出，尚未急下。当时大约为阳亢已极者而言之也，若但发热汗出，而定为急下，不能无疑。

【阐释】郑氏谓：“若但发热无汗，而定为急下，不能无疑”。盖阳明病发热汗多，不论阳明经证、腑证都有，如属经证热炽，则白虎人参汤即可清热救阴。故此条当有其它腑实证状，如腹满痛，不大便、潮热、谵语等证，方能急下存阴。

二十六、发汗不解，腹满痛者，急下之，宜大承气汤。

郑论：按此条为阳明胃实者言之，而非为胃虚者言之，学者宜详辨虚实。

【阐释】汗为阴液，发汗则伤津而热邪更炽，与糟粕相结而成燥屎，阴梗于中，气机窒塞，不通则痛，故宜大承气汤急下之。

二十七、腹满不减(一)，减不足言，当下之，宜大承气汤。(一)腹满岂无虚实（顶批）。

郑论：按此条未指出当下实据，不能无疑，姑录之。

【阐释】按此节承上条，盖谓下后腹痛虽减腹满未减，或减十分之一二，言不甚减也。所以然者，悍热太甚，非一下可尽除也。此下之未尽，故仍以大承气汤再次攻之。前条曰急下之，本条曰当下之，用法自亦有微剧之分矣。又腹满有虚实之别，

太阴虚寒的腹满，里无实邪，其腹满，常有缓解之时；本证腹满，乃是里有燥屎，有形的实邪，腹满无减轻之时。《金匱》“腹满时减，复如故，此为寒，当与温药”。虚、实之间，最宜详辨，治法亦迥异。

二十八、伤寒六七日，目中不了了①，睛不和②，无表里证③，大便难，身微热〔者〕，此为实也，急下之，宜大承气汤。

①目中不了了：即视物不明。

②睛不和：是眼珠转动不灵活。

③无表里证：指既无头痛恶寒表证，也无腹满谵语等里证。也有认为是无少阳的半表半里证。

郑论：按目睛不了了者，皆缘内有伏热伤及津液，津液暗耗，不能上荣于目，故不了了，观其大便难，身微热，其内之伏热，亦可慨见矣。故宜急下之，正以救津液，恐迟缓则熬干阴精也。

【阐释】《内经》云：“五脏六腑之精，皆上注于目，热邪内灼，津液枯燥，则精神不得上注于目，故目中不了了，睛不和也”。燥屎内阻，则大便不通，此为里实证，谓无表证则可，无里证则不可，无里证安能下之耶？正如郑氏所说：“故宜急下之，正以救津液，恐迟缓则熬干阴精也”。

二十九、阳明病欲解时，从申至戌上。

④虬(kōu 抠)：脉之一，脉轻按浮大，重按中空，有如葱管，是阴血不足，阳气浮盛之征。

郑论：按申、酉、戌，乃阳明之旺时，邪衰者于旺时可以潜消，邪盛者于此时更盛，观日晡潮热之人，则得解与不解之道也。

【阐释】此条所论涉及时间医学，按照祖国医学理论，申、酉、戌时，（即现在的下午三时至八时）日晡时也。阳明潮热，发于日晡，阳明病解，亦于日晡，为阳明经气当旺的时候，欲解说法也。

三十、脉浮而虬④，浮为阳，虬为阴，浮虬相搏，胃气生热，其阳则绝。

【阐释】此节但言脉而不言证者。盖指平素阳旺阴虚之人，故感邪即从阳热而化也。浮则气分之阳热盛，虬则血分之津液虚，浮虬相搏，则胃中合相搏之势，而愈生

火热矣。曰其阳则绝，并不是说阳气的败绝，与阳明上篇条一样，为津液不足，里热亢盛的意思。亦即太阳膀胱之津液，不能还入胃中，有断绝不续之现象也（郑书原无三十、三十一条，据舒本校补）。

三十一、趺阳脉浮而涩⑤，浮则胃气强，涩则小便数，浮涩相搏，大便则鞭，其脾为约，麻子仁丸主之。

⑤趺（fū 肤）阳：即冲阳穴，在足背第二第三跖（zhí）骨间，属足阳明胃经，古人常用趺阳脉诊察脾胃疾病。

【阐释】此节乃太阳阳明之脾约证也。独诊之足者，盖邪热从足而上，太阳膀胱之津液先虚，故脾被热灼，而津液涩约，胃被热蒸，而火气强盛，故不用承气之速下，而用麻仁丸之缓攻，以和之也。

又上二条，舒驰远《再重订伤寒集注》具载，郑氏《伤寒恒论》缺之。但舒氏亦疑此两条非仲景原文，而为叔和录入，有矛盾。或为郑氏不录此二条之原因。

麻子仁丸方（校补）

麻子仁二升芍药半斤枳实半斤（炙）大黄一斤（去皮）厚朴一尺（炙去皮）杏仁一升（去皮尖熬，别作脂）上六味，蜜和丸，如梧桐子大，饮服十丸，日三服，渐加，以知为度。

【方解及其应用范围】本方有滋肠润燥缓泻作用，方中麻仁杏仁润肠肃肺，因肺与大肠相表里，肺气降有助于通便作用。枳实、厚朴破气行滞，芍药养阴，大黄攻下清热。所以成其润肠缓下剂，但仍兼攻下破气。现有中成药出售，为有效的润下剂，用于虚弱体质便秘者多效。

伤寒恒论卷六

阳明下篇

外邪已趋少阳，未离阳明，谓之少阳阳明，列于此篇，计八法（据舒本校补）。

一、阳明病，发潮热，大便溏，小便自可，胸胁满不去者，〔与〕小柴胡汤（主之）。

郑论：按大便溏，胃虚而不实也；小便自可，内无热也；胸胁满者，浊阴闭塞也；发潮热者，阳气浮也。此际正当温中，又非柴胡汤所宜也。此条意着重在两胁上，究其端倪，故以小柴胡汤主之。

【阐释】此节乃少阳阳明二阳合病。邪热陷于大肠，故发潮热；如胃家实，当大便鞭而小便数，今大便溏，小便自可，知非实热之证。郑氏谓：“大便溏、发潮热等诸证，正当温中，又非柴胡汤所宜”。当用理中汤加砂仁半夏治之。然就胸胁满不去一证，仍宜从胸胁而达之外，可从转枢而出。因阳明经病轻，少阳经病重，用小柴胡汤治少阳，解其主症。

二、阳明病，（而）胁下鞭满，不大便而呕，舌上白苔者，可与小柴胡汤（主之）。上焦得通，津液得下，胃气因和①，身濈然汗出而解（也）。

①胃气因和：指胃的正常机能得到恢复。

郑论：按此证，乃阳明而兼少阳也。夫两胁者，少阳之地界也。今两胁鞭满，是少阳气机不舒之候，不大便者，胃实之征，舌上白苔色者，寒也，呕时而作，少阳喜呕也。余意此证，可小柴胡内重加大黄，俾土木之气舒则内畅，而津液通，胃气自和，只用小柴胡汤而不用大黄，似不恰切。

【阐释】本条与前条亦少阳阳明二阳合病，较上节为重。前节系邪陷于大肠，此节系陷于胸胃之间。曰胁下鞭满，不大便而呕，舌上白苔者，正气不得上升下降，故使不大便也。用小柴胡汤以转其枢，则诸证自愈。但郑氏则主“小柴胡汤重加大黄，俾土木之气舒则内畅，而津液通，胃气自和”，似较仅用小柴胡汤原方为对证。

三、问曰：病有太阳阳明，有正阳〔阳〕明，有少阳阳明，何谓也？答曰：太阳阳明者，脾约是也①正阳〔阳〕明者，胃家实是也②；少阳阳明者，发汗利小便〔已〕，胃中（躁）〔燥〕烦实，大便难是也。

①脾约：脾约以胃中之津液言。胃无津液，脾气无以转输，故如穷约而不能舒展也

。即是由于津液亏少而引起便秘。

②胃家实：指肠胃中有热邪积滞。

郑论：按太阳之邪未尽，而传至阳明，如桂枝汤加葛根之属，与脾约汤之属是也。正阳〔阳〕明者，太阳之邪传至阳明，随（躁）〔燥〕而化为热邪，绝无一毫太阳寒气，而胃独受其邪，则为之正阳〔阳〕明，所云胃家实是也。少阳阳明者，是阳明之邪半入少阳地界，两经之提纲病情互见，故为少阳阳明，如两胁满而不大便是也。

【阐释】此条采取问答形式，郑氏所注分别说明三类阳明府证的成因和来路，较为全面。太阳阳明由于津亏，其证状较轻；正阳阳明由于阳旺，不大便，内实满痛，名胃家实，其证状最重。少阳阳明由于误治，其证状较太阳阳明为重。三者病因虽有别，而皆热盛于里致肠胃成实，则理无二致。

附：少阳转阳明二证（据舒本校补）

四、少阳阳明〔者〕，发汗利小便〔已〕，胃中（躁）〔燥〕烦实，大便难是也。
后段

③此条与上条第三小节重复，不识何故，为保存原书面貌，姑存之。

郑论：按此证，前已申明，兹不复叙③

五、服柴胡汤已，渴者属阳明，以法治之。后段

郑论：接此条，本有少阳证，故服柴胡汤已而口渴者，胃有热而伤及津液也，仍以阳明口渴法治之。余细思口渴一证，有胃热太甚，口臭气粗，身热汗出，渴饮冷者，仲师以人参白虎汤治之。有阳衰不能熏腾津液于上而亦口渴，但饮滚饮冷不同，仲师以回阳治之，如此用药，方不误人。

【阐释】本条明言“渴者属阳明也，以法治之”。郑氏主以人参白虎汤治之，于理于法皆合。至有阳衰不能熏腾津液于上，而亦口渴，其非阳明证明甚，当属少阴证之口渴，自当以回阳法治之。

附：太阴转阳明一证（据舒本校补）

六、伤寒脉浮而缓，手足自温者，是为系在太阴。太阴者，身当发黄。若小便自利者，不能发黄，至七八日，大便鞭者，为阳明〔病〕也。

郑论：按缓脉，乃太阴之本象，此以为当发黄，吾甚不解。夫缓为胃气，不主于病，取其兼见，方可论病。又曰：小便利者不发黄，全未见有胃家遏郁病情，而独曰小便利者不发黄，皆非正论。即谓太阴转属阳明，其脉必不得以缓论，即见大便鞭，当下之证，定有一翻先数日脉缓，后忽见实、大、洪、数之脉，乃为合法。

【阐释】自此以下三节，皆言阳明假实之证，亦即邪从三阴传入阳明之证也。太阴病湿盛阳微，不能温运，若寒湿瘀滞，身当发黄；如小便通利，湿从下泄，便不能发黄。但小便自利过多，则肠中水分渐干，积至七八日而大便鞭者，则太阴转成阳明证矣。如此解释，则郑氏之疑可以不疑矣。

附：少阴转阳明一证（据舒本校补）

七、少阴病，六七日，腹胀（满）〔不大便〕者急下之，宜大承气汤。

郑论：按此病必是少阴协火而动之候，前数日所现定是满盘少阴证形，迨延至六七日，积阴生内热，邪遂从热化矣。热甚以致腹胀不大便，则邪已转入阳明，若不急下之，则真阴有立亡之势，故下之宜急也。

【阐释】郑氏曰：“积阴生内热，邪遂从热化矣。热甚以致腹胀，不大便，则邪已转入阳明”。腹胀不大便者，必兼见舌苔干燥，恶热饮冷，方为实证。实则此乃少阴化热太过，火伤中土之证也。急下以救中土，土坏则生机立竭矣。非用大承气急下，安能救其危哉！

附：厥阴转阳明一证（据舒本校补）

八、下利谵语者，有（躁）〔燥〕屎〔也〕，宜小承气汤。

郑论：按谵语多缘内有（躁）〔燥〕屎，兹何又称下利谵语？若下利而谵语，必非实证，必非下证。然谵语亦有似是而非处，学者务当细求，苟下利而谵语，其人有神，脉大而实，口渴、舌干、饮冷，此为协热而下利，皆在可下之例；若其人下利谵语，身重无神，舌润不渴，脉微，又当温肾扶阳，不得以谵语而尽为热证，亦不得尽为可下之证也。

又按此条，大约为里虚夹（躁）〔燥〕，而有（躁）〔燥〕屎结于中者言之也。余意当于温补剂中，加大黄逐之，庶为妥切。

【阐释】下利而谵语，有阳虚、阴虚之别，阳证者为协热而下利，治以小承气汤。若阴证下利谵语，无神不渴，脉微，法当温肾扶阳，治以附子理中汤加补肾药味。故郑氏曰：“不得以谵语而尽为热证，亦不得尽为可下之证也”，自当辨证施治，

方为恰当。又按此条，大约为里虚夹燥，郑氏于温补剂中，加大黄逐之，法可遵从。

伤寒恒论卷七

少阳篇计二十一法（据舒本校补）

一、伤寒五六日，中风，往来寒热①，胸胁苦满②，默默不欲饮食③，心烦喜呕④，或胸中烦而不呕、或渴、或腹中痛、或胁下痞鞭、或心下悸、小便不利、或不渴、身有微热，或咳者，小柴胡汤主之。

①往来寒热：恶寒时不知热，当热时不知寒，寒和热间代出现，即所谓间歇型热。

②胸胁苦满：谓胸胁部有苦闷的感觉。因少阳脉循胸胁，邪入其经，所以胸满。

③默默：静默不言也。

④喜呕：即是时常作呕。

郑论：按少阳当阴阳交会之中，出与阳争则热生，入与阴争则寒作，故有寒热往来也。胸胁满，默默不欲食者，肝邪实而上克其土，土畏木克，故不欲食。心烦喜呕者，肝喜发泄也。甚至或烦、或咳、或渴、或腹痛、或心下悸、或小便不利，种种病情，皆系肝木不舒所致也。故以小柴胡主之，专舒木气，木气一舒，枢机复运，而诸证自释矣。

【阐释】往来寒热，胸胁苦满，默默不欲饮食，心烦喜呕，这是小柴胡汤的主要证候，以下的或然证，并不是用小柴胡汤的主要目标。郑氏所按已详尽矣，无庸赘述。

小柴胡汤方（校补）

柴胡半斤黄芩三两人参三两半夏半升（洗）甘草（炙）生姜各三两（切）大枣十二枚（擘）上七味，以水一斗二升，煮取六升，去渣，再煎取三升，温服一升，日三服。若胸中烦而不呕者，去半夏人参，加枳实一枚。若渴，去半夏，加人参合前成四两半，枳实根四两。

若腹中痛者去黄芩，加芍药三两。若胁下痞鞭，去大枣，加牡蛎四两。若心下悸，小便不利者，去黄芩，加茯苓四两。若不渴，外有微热者，去人参，加桂枝三两，温复微汗愈。若咳者，去人参、大枣、生姜，加五味子半升，干姜二两。

【方解及其应用范围】小柴胡汤乃表里两解法，亦转输调和之方。柴胡乃少阳主药，可升阳达表，力能输肝木之滞机，宣畅气血，使半表半里之邪得从外宣。黄芩苦

寒，能清胸腹之热，使半表半里之邪得从内彻。《本经》称柴胡推陈致新，黄芩主治诸热，柴、芩合用，能解半表半里之邪，半夏、生姜调理胃气以止呕，人参、枣、草益气和中以养正。本方寒热并用，攻补兼施，有疏利三焦气机，调达上下升降，宣通内外，运行气血之功，八法中列入和剂。关于此方除用治少阳经症外，郑氏在《医法圆通》中说：“治发热、口苦、耳聋，其脉弦者，又治太阳、阳明二经发热不退，寒热往来。随即举出其圆通应用六条：（）治两胁胀痛；（）治头响，两侧胀；（）治两耳红肿痛甚；（）治疟疾；（）治吐酸不食；（）治妇女热入血室，谵语。笔者用以治肝咳，其由于肝阳不足者，用小柴胡汤去参、枣、生姜，加干姜、五味、桂枝以温肝利肺而咳愈；如因肝阴不足，肝火上逆，治当滋肝、降火、润肺，用小柴胡汤去参、姜、枣、加贝母、知母、石膏治之。又曾治胃脘胀痛，其症状为口苦、目眩、胸胁满闷，脘腹时作胀痛，稍多食则大便溏，日四五次，舌质淡红，苔腻，脉弦细，治以小柴胡汤加公丁香，吴茱萸，二剂而痊愈。现代用以治疗具有本方主症的多种疾病，如感冒、扁桃腺炎、流行性腮腺炎、各型肝炎、胆囊炎、胸膜炎、肾炎及产后发热、长期潮热等，只要加减适宜，均能收到良效。更有用本方以通小便、止泄泻的，可能与原文所谓“上焦得通，津液得下，胃气因和”的作用有关，足见其制方之精当与应用之广泛了”。

二、少阳之为病，口苦、咽干、目眩也。

郑论：按少阳禀风火之脏，口苦咽干者，胆有热也，胆液乃目之精，今为热扰，精气不荣，故见眩也。

【阐释】诸家注伤寒者，大多以口苦、咽干、目眩为少阳病之提纲。郑氏仅释三者之成因而不说是少阳病之提纲。舒驰远亦仅谓此少阳之腑证也。口苦、咽干、目眩，少阳病自然可以见到，但就不得为提纲。如阳明上篇条的：“阳明中风，口苦咽干”。同篇条云：“阳明病，脉浮而紧，咽燥口苦”。太阳中篇条云：“气上冲胸，起则头眩”。太阳上篇条亦云：“心下悸，头眩身瞤动”。这说明口苦、咽干、目眩等证，太阳病、阳明病都有，把它作为提纲看，在临床没有多大价值。相反把本篇第一条：“寒热往来，胸胁苦满，默默不欲饮食，心烦喜呕”的小柴胡证作为少阳病提纲，还全面得多。在临证时，应把两条结合起来，这样就全面了。

三、伤寒脉弦细，头痛发热者，属少阳。少阳不可发汗，发汗则谵语，此属胃，胃和则愈，胃不和，（则躁）〔烦〕而悸。

郑论：按少阳证，本宜和解，原不在发汗之例，强发其汗，血液被夺，则胃必（躁）〔燥〕，胃（躁）〔燥〕而谵语生，此条可谓少阳转阳明，立论方可。

又按燥与悸，本系两证，燥为热邪，悸为水邪，此以笼统言之，大非少阳立法。

【阐释】三阳证均有头痛发热，但在部位上有区别，太阳痛在脑后，阳明痛在前额，少阳痛在两侧。今头痛发热而脉弦细，正是少阳的主脉，与太阳头痛发热脉必浮，阳明头痛发热脉必大，亦有明显的不同。少阳病邪不在表，是以禁汗。郑氏曰：“强发其汗，血液被夺，则胃必燥，胃燥而谵语生”。所论甚是。

胃和则愈可有两种情况，一是胃气自和而愈，一是治疗得当而愈，可用调胃承气汤治之。

四、少阳中风①，两耳无所闻，目赤，胸中满而烦（躁）者，不可吐、下，吐、下则悸而惊。

①中风：此处当解作外邪的总称，包括伤寒在内。

郑论：按少阳属相火，今得中风，风火相煽，壅于上窍则耳聋目赤，壅于胸中则满而烦躁，当此时也，正当小柴胡加开郁清火去风之品，切切不可吐下。前条原有当下、当吐、与不当下、不当吐之禁，若妄施之，则惊悸立作矣，可不慎欤？

【阐释】此条合前条是治疗少阳病的三禁，不问其为伤寒或中风，只要病在少阳，均当禁用汗、吐、下三法。因少阳病邪不在表，所以禁用发汗；病不在里，肠胃没有燥屎结实，所以禁用攻下；虽有胸满而烦，却非胸中邪实，所以禁用吐法。郑氏释耳聋、目赤、胸中满而烦为风火相煽，亦是正确的。若误吐下，则诛伐无过，反致损气耗液，而引起心悸、惊惕等变证。

五、伤寒三日，三阳为尽，三阴当受邪，其人反能食〔而〕不呕，此为三阴不受邪也。

郑论：按三阴、三阳，各有界限，当三日后，应归三阴，而其人反能食不呕，可知太阴气旺，旺不受邪，理势然也。

【阐释】诊断病邪传变，应当以现有证状为依据，方可决定其传与不传。郑氏说：“能食不呕，可知太阴气旺，旺不受邪，理势然也”。正足以说明不能为传经规律所拘。

六、伤寒三日，少阳脉小者，欲已也。

郑论：按少阳当三日而脉小者，邪已衰也，故断其欲已。

【阐释】根据传经规律，伤寒三日，应为少阳受病，脉当弦紧，今脉小者，邪气微而病退，为欲愈的征象。亦即郑氏所说“邪已衰也，故断其欲已”，笔者认为不能

单凭脉以定证，必须证状见减的，庶为欲愈。如脉小而证状加剧，则为正衰邪盛，非欲愈之征。

七、少阳病欲解时，从寅至辰上。

郑论：按六经各有旺时，邪气衰者，每于旺时自解，正所谓正旺而邪自退也。

【阐释】本条指出少阳病欲解的时间，其精神与太阳病，阳明病欲解时同一意义。寅至辰上即每日上午三点至九点之间。

八、伤寒六七日，无大热，其人（烦躁）〔躁烦〕者，此〔为〕阳去入阴故也①。

①阳去入阴：就是去表入里的意思。

郑论：按身无大热者，表邪将尽也，其人烦躁者，邪入阳明之验也，又并无三阴证据，何言阳去入阴，于理法不合，姑录之，以俟高明。

【阐释】郑氏云：“无三阴证据，何言阳去入阴，于理法不合”。此应解“阳去入阴”为由表证“阳”入里证“阴”之谓也。阴者指里而言，非指三阴也。

九、伤寒四五日，身热恶风，（头）〔颈〕项强，胁下满，手足温而渴者，小柴胡汤主之。

郑论：按项强、身热恶风者，太阳之表证也。口渴而手足温者，胃中有热也。胁下满者，少阳气机为寒束也。法宜桂枝汤加粉葛、柴胡、花粉之类，于此病庶为合法，若专主小柴胡汤，似未尽善。

【阐释】本条有太阳表证，复有阳明里证，更有少阳证，即胁下满者，少阳气机为寒束也。据“伤寒中风，有柴胡证，但见一证便是，不必悉具”之义，则可用小柴胡治之。郑氏则认为专主小柴胡汤未尽善，而主桂枝汤加粉葛、柴胡、花粉之类，是三阳症状兼顾，更为全面，理法可从。

十、伤寒阳脉涩，阴脉弦，法当（温）〔腹〕中急痛（者），先与小建中汤，不差者，（与）小柴胡汤主之。

郑论：按阳脉涩者，阳虚也，阴脉弦者，阴盛也，法宜扶阳祛阴。若腹中急痛，则为阴寒阻滞，小建中汤力弱，恐不能胜其任。余意当以吴茱萸四逆汤，小柴胡汤更不能也。

【阐释】腹中急痛，多属虚寒证，所以金匱有虚劳里急，腹中痛的记载，都用小建中汤建立中气。但郑氏认为小建中汤力弱，主用吴茱萸四逆汤，一举祛邪外出。其实本条为少阳病兼里虚寒证，脾胃之阳气不能流畅，故腹中急痛，与小建中汤调和气血，建中止痛，自属正治。服后腹痛止，而少阳证不差者，再用小柴胡汤以和解少阳。

十一、伤寒五六日，已发汗而复下之，胸（腹）〔胁〕满微结，小便不利，渴而不呕，但头汗出，往来寒热，心烦者，此为未解也，柴胡桂枝干姜汤〔主之〕。

郑论：按少阳证，法当和解，汗、下皆在所禁之例，今既汗、下之，而胸（腹）〔胁〕满微结者，是下之伤中，浊阴得以上僭也。汗之而太阳伤，以致气化失运，小便所以不利也。又见寒热往来，少阳证仍在，主小柴胡汤加桂枝、干姜，三阳并治，实为妥切。

【阐释】太阳病汗、下后，则邪当解。今不解而见胸胁满微结，小便不利，又见寒热往来等证，是邪陷少阳，复有太阳之表，阳明之里，此三阳并病。故郑氏曰：“主小柴胡汤加桂枝、干姜，三阳并治，实为妥切”。

柴胡桂枝干姜汤方（校补）

柴胡半斤桂枝三两（去皮）干姜二两黄芩三两栝蒌根四两牡蛎二两（熬）甘草二两（炙）上七味，以水一斗二升，煮取六升，去渣，再煎取三升，温服一升，日三服，初服微烦，复服汗出便愈。

【方解及其应用范围】本方柴胡、黄芩、栝蒌根合用，和解少阳，清热、生津、止渴之效显著；桂枝、干姜、甘草合用，当有健心阳、温脾之作用；牡蛎与栝蒌根配伍，能治水饮内停之口渴。用以治少阳兼水饮病为有效。对治寒多热少，或但寒不热之疟疾，疗效亦佳。亦用于较小柴胡汤证为虚、贫血、呈郁热挟水饮上冲之证。

十二、服柴胡汤已，渴者属阳明（也），〔以法治之〕。后段

郑论：按既服柴胡汤，而病已去。但渴者，属阳明。试问渴饮冷乎？饮热乎？舌干乎？舌润乎？大便利乎？小便利乎？饮冷、舌干、便塞，方可指为阳明。若饮热、舌润、便溏，不可谓之阳明。虽指为阳明，学者不可执为定，当各处搜求，庶不误人。

【阐释】此节与阳明下篇五条相同，郑氏更为之进一步详细注释，示人应灵活辨证，不可执定阳明也。

十三、凡（服）柴胡汤病证而（反）下之，若柴胡证不罢者，复与柴胡汤，必蒸蒸而振①，却发热汗出而解。后段

①蒸蒸而振：蒸蒸，内热貌。气从内达，邪从外出，则发生振栗之状，是形容战汗的现象。

郑论：按柴胡证既误下，而少阳证仍在，是邪不从下而解。复以柴胡汤，枢机转，而蒸蒸发热汗出，是邪仍由汗而解也。总之，凡病邪有吐、下后而变逆者；有吐、下而本病尚在，无他苦者，用药不可不知。

【阐释】柴胡证是邪在半表半里之间，汗、吐、下都在禁例。若误下之，邪不从下解，而柴胡证仍在者，可复与柴胡汤，如郑氏所说：“枢机转，而蒸蒸发热汗出，是邪由汗而解也”。

十四、伤寒五六日，呕而发热者，柴胡汤证具，而以他药下之，柴胡证仍在者，复与柴胡汤，此虽已下之，不为逆，必蒸蒸而振，〔却〕发热汗出而解。若心下满而鞭痛者，此为结胸也，（法宜）大陷胸汤主之。但满而不痛者，此（则）为痞，柴胡不中与之，宜半夏泻心〔汤〕。

郑论：按此条（以）〔理〕应在少阳篇，不知因何列入太阳中篇，兹不再赘。

【阐释】柴胡证误下后的转归及治法，应如郑氏所说理应列在少阳篇，不知因何列入太阳中篇条，前已言之，郑氏为保留原书面貌，仍照录，但不赘论。

十五、〔本〕发汗，而复下之，此为逆也；若先发汗，治不为逆。（未）〔本〕先下之，而反汗之（此）为逆；若先下之，治不为逆。

郑论：按少阳虽云汗、下当禁，然亦当视其可与汗者汗之，可与下者下之，总在用之得宜，庶不为逆。

【阐释】此条示人在临床的时候，必须根据证情的先后缓急来处理，治有先后，先后误施，病必不愈。亦即郑氏所说：“总在用之得宜，庶不为逆”。

十六、伤寒五六日，头汗出，微恶寒，手足冷，心下满，口不欲食，大便鞭，脉细者，此为阳微结①，必有表复有里也。脉沉，亦在里也。汗出为阳微，假令纯阴结②，不得复有外证，悉入在里，此为半在里半在外也。脉虽沉紧，不得为少（阳）〔阴〕病，所以然者，阴不得有汗，今头汗出，故知非少阴也，可与小柴胡汤，（若）〔设〕不了了者，得屎而解。

①阳微结：热在里而大便鞭，叫做阳结。外带表邪，热结犹浅，所以叫做阳微结。

②阴结：没有一定表证。其症状是身体重，不能食。大便反鞭，脉象多现沉迟。

郑论：按头汗出，至脉细微，阳微结等语，满盘俱是纯阴之候，何得云必有表也？表像从何征之？又曰复有里，以为脉沉者里也，汗出为阳微，既称阳微，不得以柴胡汤加之。又曰：假令纯阴结，不得复有外证，此是正论。少阴、少阳，原有区分，脉沉紧而头汗出，头属三阳，故知非少阴也。其为阴结者，是指外之寒邪闭束，而非谓少阴之阴寒闭结也，可与小柴胡汤，是从头汗而得之，若不了了，得屎而解者，里气通，则表气畅也。

【阐释】本条主要在辨明少阴与少阳的疑似证。自头汗出至脉细等症状，都很象少阴证，但少阴病不应有表证，病人头汗出，微恶寒，是表证尚在，所以说不是少阴证，而是“阳微结”，这种症候一定有表证也有里证，邪在半表半里之间，小柴胡自是对症之方。郑氏所按，自相矛盾之处甚多，不可从。

十七、凡病若发汗、若吐、若下、若〔亡血〕①、亡津液②，阴阳自和者③，必自愈。

①亡血：指一切原因的失血。

②亡津液：又叫做“伤津液”，如过汗过下都足以损伤津液。

③阴阳自和：犹言气血自和。

郑论：按汗、吐、下三法，与亡津液，审其别无他苦，但见阴阳自和者，必能自愈。若现有别证，相机治之，便得也。

【阐释】夫汗、吐、下都是治病的大法，如用之不当或用之太过，都能伤及正气，皆可亡血亡津液，血与津液都是属于阴，亡血实质上与亡津液是一个意思。如其阴阳能处于协调状态，就可以自然痊愈。正常人的身体机能，全在阴阳平衡，亦即《内经》所说“阴平阳秘，精神乃治”的意义。

十八、妇人中风，发热恶寒，经水适来④，得之七八日，热除而脉迟身凉，胸胁（不）〔下〕满，如结胸状，谵语者，此为热入血室也⑤，当刺期门，随其实而（泻）〔取〕之。

④经水：即月经。

⑤血室：即子宫。张景岳云：“子户，即子宫也，俗名子肠，医家以冲任之脉盛于此，则月事以时下，故名之曰血室。”

郑论：按发热至热除，表已解也，脉迟身凉，如结胸、谵语，是热不发于外，而伏于内，因其经水适来后，随气机收藏而入于内，故曰热入血室，病已重也，刺期门，实以泄其邪热也。

【阐释】合下三节，皆言热入血室之证也。血室在人身体上究在何处，历代医家注释不一。如成无己谓：“血室者，营血停止之所，经脉留会之处，即冲脉也”。柯韵伯说：“血室者，肝也，肝为藏血之脏，故称曰血室”。但张景岳则谓：“血室即子宫”，笔者认为张氏之说为是，详见注释⑤。此条乃邪伤厥阴血分之证也。曰妇人中风，发热恶寒，经水适来者，借妇人以明血室之所在也。

诚如郑氏所说：“表已解也，热伏于内，因其经水适来，随气机收藏而入于内，故曰热入于血室”。邪热入而居之，里热已重也，刺期门穴以泻里热，则诸证尽失也。

十九、妇人中风，七八日续得寒热，发作有时，经水适断者，此为热入血室，其血必结，故使如疟状，发作有时，小柴胡汤主之。

郑论：按此条血虽结，而表证尚在，但和解之，邪去而结自化为乌有矣，故主小柴胡汤，随机加减，则得矣。

【阐释】此节为经水已来，因病而适断者，则寒热发于外，虽与经水适来者不同，而此亦为热入血室。如郑氏所云：“血虽结而表证尚在，但和解之”。小柴胡汤达经脉之结，仍借少阳之枢以转之，俾气行而血亦不结矣。

二十、妇人伤寒，发热，经水适来，昼日明了，暮则谵语，如见鬼状者，此为热入血室，无犯胃气，及上二焦，必自愈。

郑论：按昼明了，夜昏愦，是邪在里而不在表，故曰热入血室。但清其血分之热即可了，故曰无犯胃气，及上二焦，必自愈，是明教人不可妄用攻下之意也。

【阐释】此节与上二节之差异处，彼是中风，此是伤寒；彼之谵语，不分昼夜，此则昼日明了，暮则谵语，乃邪正交争也。此证乃经水尚行，血未曾结，为邪干血分之轻病，原不同蓄血之如狂发狂，不分昼夜之重病也。如郑氏所说：“但清其血分之热即可了……不可妄用攻下之意也。”即不得用桃仁承气、刺期门及小柴胡诸法也。盖血海既虚，当调和膀胱之气化，俟其正气回复，而病自愈也。

二十一、血弱气尽①，腠里开，邪气因入，与正气相搏，结于胁下。正邪分争，往来寒热，休作有时，默默不欲饮食，脏腑相连，其痛必下，邪高痛下，故使呕也，小柴胡汤主之。前段

①血弱气尽：气血不足，正气衰弱的意思。

郑论：按此条指气血虚弱而言，正虚则外邪得以乘虚而入，邪正相攻，结于胁下，往来寒热，默默不欲食者，少阳之属证也。脏腑相连者，指肝与胆也，肝胆气机不舒故痛，厥阴气上逆则呕，主以小柴胡汤，专舒木气，木气一舒，枢机复运，而痛自愈矣。

【阐释】“血弱气尽，腠里开，邪气因入”，言正气衰弱时，阳气不能卫外为固，腠理不密，外邪因入。邪入与正气相搏，结于胁下，……至默默不欲食等，此小柴胡汤证。又脏腑相连，邪高痛下者，少阳表热为邪高，厥阴里寒为痛下，厥气上逆则作呕。如此用小柴胡汤主之，似未尽善。既气血不足，正气衰弱，其身体素质之虚，可以想见。且能专用小柴胡汤舒少阳之气以治之，而当加附子、吴茱萸、炮姜、肉桂以破厥阴之寒而散逆止呕，于此病庶为合法。

伤寒合病

计九法（据舒本校补）

一、太阳病，项背强几几①，反汗出（而）恶风者，桂枝加葛根汤主之。

①项背强几几：形容项背拘急，俯仰不能自如之状。几几，俯仰不自如貌。

郑论：按此条乃太阳风伤卫证。

【阐释】太阳风伤卫证，应用桂枝汤解肌。今增项背强几几一证，是风邪入于经输之故。太阳经输在背，邪入其间，致使经气不舒，阴滞津液不能敷布，经脉失去濡养，则项背强几几。故用桂枝汤解肌，加葛根以散经输之邪。

桂枝加葛根汤方（校补）

葛根四两桂枝三两（去皮）芍药三两甘草二两（炙）大枣十二枚（擘）生姜三两（切）上六味，以水一斗，先煮葛根减二升，内诸药，煮取三升，去渣，温服一升。覆取微似汗，不须啜粥，余如桂枝法将息及禁忌。

【方解及其应用范围】本方即桂枝汤加葛根，治桂枝汤证而项背强几几者，用桂枝

汤治汗出恶风以解表；葛根味甘平，有生津液作用，则滋养筋脉，故能解除项背强直，亦即治项背强几几。近人推广应用此方于营卫不和，太阳经脉不舒之证，如感冒、头痛、抽搐等；亦有用治高血压脑动脉供血不足之头痛而兼项背紧痛者，效果良好。

二、太阳病，项背强几几，无汗恶风（者），葛根汤主之。

郑论：按此条乃寒伤营证，两证皆未见阳明（并）〔病〕形，又从何分为合病也？总之风主太阳卫分，寒主太阳营分，以有汗无汗判之，用药自无错乱之。况阳明有阳明证表形，不得混而言之。

【阐释】合病者，或合两经，或合三经之证而为病。若两经合病，自必并见两经之证，此一定之法也。郑氏谓：“两证皆未见阳明病形，又从何分为合病也？……况阳明有阳明证表形，不得混而言之”。疑有阙文，实则本条为寒伤营病，在太阳经背部治法。

葛根汤方（校补）

葛根四两麻黄三两桂枝二两（去皮）芍药二两甘草二两（炙）生姜三两（切）大枣十二枚（擘）上七味，以水一斗，先煮麻黄、葛根，减二升，去上沫，内诸药，煮取三升，去渣，温服一升，复取微似汗，不须啜粥，余如桂枝法将息及禁忌。

【方解及其应用范围】按葛根汤一方，乃肌、表两解之方，亦太阳、阳明合解之方也。夫风寒之邪，一从肌腠而入，则为桂枝汤症，一从肤表而入，则为麻黄汤症，今以桂枝汤加麻黄、葛根，是从肌腠以达肤表，俾邪直出。太阳与阳明接壤，太阳之邪已在经输，逼近阳明，此刻阳明不病亦病也。去太阳之邪，即所以救阳明也。葛根为阳明之主药，用之以截阳明之路，而邪不敢入，又能鼓舞胃气上腾，足以助桂、麻祛邪之力。葛根味甘气凉，能生津液，滋养筋脉，故能解除项背强几几。郑氏在《医理真传》中，用治太阳病，兼见项背强几几。自汗恶寒，以致吐血者。其在《医法圆通》中谓系治邪在太阳之经输，发热、恶寒、项背强，及邪初入阳明而成的必自下利的二阳合病。更用以治发斑、呕吐，眼皮肿痛，两乳红肿、发热，小儿痘初现点四症，皆邪甚、热郁、津亏的阳明地界疾病，故能治之而愈。现代推广应用于治太阳阳明合病之流行性感、支气管炎、肺炎、扁桃体炎、荨麻疹等，均可用本方施治而获效。

三、太阳与阳明合病，（则）不下利（而）〔但〕呕者，（用）葛根加半夏汤主之。

郑论：按此条方合，不再赘。

【阐释】太阳与阳明合病，表邪不得外泄，不下迫于肠，故不下利，但上犯于胃，所以呕逆，故治疗应以解表为主，仍用葛根汤，但加半夏一味，降逆止呕。

葛根加半夏汤方（校补）

葛根四两麻黄三两（去节）甘草二两（炙）芍药二两桂枝二两（去皮）生姜二两（切）半夏半升（洗）大枣十二枚（擘）上八味，以水一斗，先煮葛根、麻黄，减二升，去白沫，内诸药，煮取三升，去渣，温服一升，复取微似汗。

【方解及其应用范围】太阳与阳明合病下利，用葛根汤治疗，今不下利而呕，故加辛温之半夏，和胃健脾，镇逆止呕。此亦因势利导，宣通逆气之方也。

四、太阳与阳明合病者，必自下利，葛根汤主之。

郑论：按二条下利与不下利，以见风寒主证之不同，风为阳而上逆，寒为阴而下行，此势时自然之理，足以见用半夏之降，葛根之升，皆有妙处也。

【阐释】太阳与阳明合病下利，郑氏以“风寒主证之不同，风为阳而上逆，寒为阴而下行”之论。则上逆而呕，下注而为利，自是正确的，方与证合拍。

五、太阳与阳明合病，喘而胸满者，不可下，〔宜〕麻黄汤（主之）。

郑论：按喘而胸满，胸中之阳为寒所束，上攻于肺，呼吸错乱，而喘证作，此条举太阳阳明而言。若火刑于肺而喘者，下之不宜。若少阴肾气上冲于肺而喘，不（谓）〔仅〕麻黄不可用，用之是速其亡也。之言不可下，是谓寒束于肺，下之恐引邪深入，必生别病，故曰不可下，下之为患不小。首用麻黄汤大开腠理，表气一通，里气则畅，邪自表分出，而内境安守也。

【阐释】阳明可下，合病则表证未解，故不可下。喘而胸满者，因汗不得出，热毒壅迫于肺脏故也，与麻黄汤发汗，则喘满自除。表里证同时出现，先解表，后攻里，为治疗原则之一，本条就是在说明这个道理。故郑氏说：“用麻黄汤大开腠理，表气一通，里气则畅，邪自表分出”，则病解也。

六、太阳与少阳合病，自下利者，与黄芩汤，若呕者，黄芩加半夏生姜汤主之。

郑论：按太少合病，总要两法病情相孚，照两经法治之，此但举太少合病，而曰自下利者，与黄芩汤，呕者加半夏生姜汤，其中不能无疑，疑者何？夫自下利而呕，是属太阴证乎？是属太阳协热下利乎？少阳本气喜呕乎？若果属太阳协热下利，黄芩汤乃为正治法。若呕果系少阳本气者，黄芩加半（下）〔夏〕生姜汤，本为对证

法。如属太阴，又当以理中汤加柴、桂，庶为合法。

【阐释】本条虽提太阳与少阳合病，并无发热恶寒，头痛项强之太阳表证，亦无胸胁苦满之少阳半表半里证。仅提太少合病而至下利，故郑氏对此条提出质疑“是属太阳协热下利乎？少阳本气喜呕乎？是属太阴证乎”？实则太少合病，其在表之寒邪悉入而为里热，里热不实，故与黄芩汤以清里热，使里热清而在表之邪自和矣。若呕者，乃是胃气上逆所致，则应再加半夏生姜，以降逆止呕。如此解释，则明白了然，可以释疑矣。

黄芩汤方（校补）

黄芩三两芍药二两甘草二两（炙）大枣十二枚（擘）上四味，以水一斗，煮取三升，去渣，温服一升，日再，夜一服。

黄芩加半夏生姜汤方（校补）

即上方加半夏半升（洗）生姜一两半，一方三两（切）

【方解及其应用范围】黄芩、芍药之苦以撤热和阴，甘草、大枣之甘以调中，而缓其津液之下奔也，有苦甘合化清热存阴之义。呕为气逆，加半夏辛降，生姜辛散，则气逆得降，呕亦自止。后世推广用之以治热痢。治痢之方剂，大都由此方化裁而来。

七、阳明少阳合病，必下利，其脉不负者，〔为〕顺也。负者，失也①，互相克贼，名为负也。脉滑而数者，有宿食也，当下之，宜大承气汤。

①其脉……失也：这是根据五行生克的学说，从脉象上来解释疾病的顺逆。阳明属土，少阳属木，二经合病而下利，如纯见少阳弦脉，则木必克土，病情较逆，是即所谓“负也”，“失也”；如果脉见滑数，则木不克土，是即所谓“顺也”。证状与脉象不符为“负”。脉象与证状相合为“顺”。

郑论：按阳明少阳合病，察系两经表邪，当从两经解表法治之。但下利，里未实也，何得下之？此以脉滑而断为宿食者当下之。然亦当辨其果有宿食，与未有宿食，有食可下，无食断乎不可。

【阐释】伤寒合病章条太阳与阳明合病自下利，是病偏重于太阳之表者，故用葛根汤；条太阳与少阳合病自下利，是邪偏重于少阳之半表半里者，故用黄芩汤。此节为阳明少阳合病，从脉象上来判断顺逆。脉证相符的为顺，容易获愈；脉证不符的为逆，不易治疗。必下利者，脾虚里有寒也，当用理中汤温其里。郑氏曰：“有食

可下，无食断乎不可”。纵有宿食，亦宜温下之，用附子理中汤加砂仁、鸡内金、大黄，中病即止，岂有下利而反用大承气汤下之之理？

八、三阳合病①，脉浮大，〔上〕关上②，但欲眠睡，目合则汗。

①三阳合病：即太阳、少阳、阳明三经同时发病。

②上关上：脉搏长大，从关部上至寸口的意思。

郑论：按三阳同病，阳邪盛已。关上浮大，胃邪炽也，欲眠睡者，热甚神昏也；闭目汗出，内热之验也。虽然，不可不详辨之，其中实实虚虚，千变万化，实难窥测。有名为三阳，却非三阳，此则专为三阳说法，若系由内出外之热，有似此三阳者，余亦详而验之，但其人舌无苔而润，口不渴者，余即不按三阳法治之，专主回阳，屡试屡效。

【阐释】三阳病均属热证，三阳合病则邪热尤盛，因高热而神昏欲眠睡，不恶寒而恶热也，与寒中少阴，但欲寐者，其人恶寒，脉必沉而微细者显然不同；目合则汗，是由于阳热太甚，则阴不内守。郑氏说：“若系由内出外之热，有似此三阳者，余亦详而验之，但其人舌无苔而润，口不渴者，余即不按三阳法治之，专主回阳”。此郑氏示人辨证宜细心求之，虽未列出治疗方剂，总不出四逆、白通之类大剂回阳。

九、三阳合病，腹满身重，难以转侧，口不仁③，面垢④，谵语遗尿。发汗则谵语，下之则（颡）〔额〕上生汗，手足逆冷，若自汗〔出〕者，白虎汤主之。

③口不仁：言语不利，不知食味。

④面垢：面部油垢污浊。

郑论：按三阳合病，必有三阳实据可凭，此则所现，纯阴居十八，仅有腹满谵语似阳明，余故细辨之者，何也？阳主身轻，阴主沉重，阳主开而阴主阖；口之不仁，阴也；身重难以转侧，阴也；面垢、遗尿，肾气不纳，阴也。果系三阳表邪，汗之则解，何至腹满谵语；果系三阳里实，下之则解，何至（颡）〔额〕汗出，而手足逆冷？学者务于未汗下时，详其舌之润与不润，舌之燥与不燥，口气之粗与不粗，口之渴与不渴，饮之喜冷喜热，二便之利与不利，而三阳合病之真假自得矣。所论之病象，大有可疑，故详辨之。

【阐释】郑氏之详辨阴证、阳证，可为后学准绳，笔者从之，无赘言也。

伤寒并病

计四法（据舒本校补）

一、二阳并病①，太阳初得病时，发其汗，汗先出不彻，因转属阳明，续自微汗出，不恶寒。若太阳病证未罢者，不可下，下之为逆，如此可小发汗。设面色缘缘正赤者②，阳气（拂）〔拂〕郁在表③，当解之熏之。若〔发〕汗（出）不彻，不足言阳气（拂）〔拂〕郁不得越④，当汗不汗，其人（烦躁）〔躁烦〕，不知痛处，乍在腹中，乍在四肢，按之不可得，其人短气但坐，以汗出（而）不彻（之）故也，更发汗则愈。何以知汗出不彻，以脉涩故知也。

①并病：一经之证未罢，又见到另一经证状的，叫做并病。

②缘缘：不断之意。

③拂郁：此处是遏郁之意。

④越：发、散之意。

郑论：按太阳初病，渐至不恶寒独有热象，方为转属阳明，若已得汗而解，无发热，不得为转属阳明。即转属阳明，而太阳证未罢，胃未实，即不得妄下，下之则逆，可以小发汗者，是指太阳证未罢，里邪未实时也。若面色赤者，是内热拂郁之征，亦在可表可熏之例。若汗出不彻，虽面赤即不得谓之拂郁不得越。至于当汗不汗，烦（燥）〔躁〕者，热攻于内，而内不安也，乍腹乍四肢，总以汗未出透，里气不畅也。然则何以知其汗出不彻乎？以脉涩知之。余常谓涩为血少，以此涩脉而定为汗出不彻，未免牵强，夫汗之彻与不彻，实系乎正气之旺与不旺，正气旺则邪必尽出无遗，何致有不彻之患哉？

【阐释】发汗不彻，为太阳与阳明并病的主要原因。虽为并病，但表证仍然存在的时候，仍当用发汗的方法，而不能使用下法。所举诸种证状，皆汗出不彻之故。何以知其汗出不彻，原文云：以脉涩知之。郑氏谓：“涩为血少，此以涩脉而定为汗出不彻，未免牵强。夫汗之彻与不彻，实系乎正气之旺与不旺，正气旺则邪必尽出无遗”。涩脉，《内经》谓参伍不调为涩，指下触觉脉搏的波动涩滞不流利，为血行障碍的脉象，汗闭或汗出不彻，虽可能见到这种脉象，究不常见，更不可能根据脉搏的涩滞，而预知其汗不彻的情况。郑氏之论，亦有足取。

二、二阳并病，太阳证罢，但发潮热，手足絜絜汗出，大便艰而谵语者，下之则愈，宜大承气汤。

郑论：按此条指太阳传至阳明，而寒邪已化为热，所见潮热、谵语、大便艰、汗出，全是阳明，故称太阳证罢，下之可愈，便是用药的法窍处也。

【阐释】本太阳病并于阳明，名曰并病。前条太阳证未罢，故不可下，今则表邪已解，所现全为里实证，可用大承气汤下之以清里热，此郑氏谓“下之可愈”也。

三、太阳与少阳并病，头顶强痛或眩冒，时如结胸，心下痞鞭者，当刺大椎第一间①、肺俞②、肝俞③，慎不可发汗，发汗则谵语，脉弦，五日谵语不止，当刺期门（穴）④。

①大椎第一间：在第七颈椎和第一胸椎棘突之间（督脉经）。

②肺俞：当第三第四胸椎横突起间，在脊外方一寸五分（膀胱经）。

③肝俞：当第九第十胸椎横突起间，在脊椎外方一寸五分（膀胱经）。

④期门：乳直下二肋间（肝经）。

郑论：按太少合病，如何只有太阳经证，而无少阳经证，似不可以言并病。若谓眩冒本属少阳，加结胸，心下鞭，仍属太阳，何也？太阳之气，由下而上至胸腹，今结胸心下痞，多系寒水上逆而成，理应按法施治，又何必以针刺，而伤无病之经哉？

【阐释】太阳与少阳并病，就是太阳之邪传并少阳，而太阳之邪未罢，既有头痛项强的太阳证，又见到头眩昏冒胸胁痞满的少阳证，由于邪已渐入，所以又有时如结胸的现象。汗、下治法皆非所宜，原文采取针法治之。郑氏曰：“理应按法施治，又何必以针刺，而伤无病之经哉？”然则如何按法施治？邪入少阳而太阳证未罢，可用柴胡桂枝汤治之。桂枝汤以解太阳之邪，柴胡汤以和解少阳，则眩冒可除。若误汗则热邪入于肝经而谵语，当如太阳下篇、条例，刺期门以泄肝邪，肝之邪热去，谵语自止。

四、太阳少阳并病，而反下之，成结胸，心下鞭，下利不止，水浆不下，其人心烦。

郑论：按此条大约当解表而不解表，误下之，则邪正相搏，结下心下而成痞鞭，以致上之水浆不入，下之利不止，其人心烦，实危亡之首，可不（谨）〔慎〕软？

【阐释】此为太阳少阳并病，本不当下而反下之，三焦气阻，水道不行，与水相结而成结胸，因而心下鞭。正虚于下则下利不止，邪逆于上则水浆不下，气结于中则

心烦，此乃误下而成结胸之危候。郑氏曰：“实危亡之道”。然则坐以待毙耶？笔者认为应大剂回阳收纳，待正气充实，继用陷胸汤攻之，俟邪去而以温补调之，斯为得矣。

伤寒坏病

计二法（据舒本校补）

一、太阳病三日，已发汗，若吐、若下、若温针①，仍不解者，此为坏病②。桂枝不中与〔之〕也③。（现）〔观〕其脉证，知犯何逆，随证治之。前段

①温针：针灸的一种方法，用针针于一定穴位，以艾裹针体而蒸烧之，以冀发汗。

②坏病：因治疗错误致病情发生恶化，证候变乱，而不能称其名者。

③不中与：就是不中用的意思。

郑论：按太阳证，既经汗、吐、下、温针，治皆不愈，总其未得病之源委而误用之也，仍究察其何逆，而随机治之，然亦不得为之真坏证也。

【阐释】太阳证，既经汗、吐、下、温针的治疗，病仍未解，原因是治法不当，使病情变化，成了坏病。郑氏曰：“仍究察何逆，而随机治之”。假如发汗、温针亡阳，则有脉微身寒之变，宜桂枝加附子汤。吐伤中气，气逆脉促者，宜生姜半夏汤。下之而寒水下陷，利遂不止，脉濡滑者，宜四逆理中辈。此即原文随证治之之义矣。

二、〔本〕太阳病不解，转入少阳者，胁下鞭满，干呕不能食，往来寒热，尚未吐、下，脉沉紧者，与小柴胡汤。若已吐、下、发汗、温针，谵语，柴胡证罢，此为坏病，知犯何逆，以法治之。、

郑论：按太阳之邪不解，应当传入阳明，何得越位而转入少阳也？然太阳寒水之气，亦许结于胁下鞭满，如此而言。亦可谓转属少阳也。迨至干呕不欲食，往来寒热，少阳之本证具也，未经吐、下，可与小柴胡汤以和解之，若已经汗、吐、下，温针而见谵语，未见柴胡证，似从谵语法治之，亦不得尽目之为坏病也。学者又当于临证时，细细求之可也。

【阐释】本条前段提出太阳病不解，转入少阳，既具少阳主证，脉虽沉紧与证不符，当舍脉从证，可与小柴胡汤治疗。后段则述及少阳病误治的变证及救误的原则，郑氏曰：“亦不得尽目之为坏病也，当于临证时，细细求之可也”。

总之误用汗、吐、下、温针，非病胃燥，即为血热。胃燥之证，轻则小承气，重则调胃承气，最重则为大承气。血热之证。轻则刺期门，重则桃核承气，尤重者抵当汤，随证施治可也。

伤寒痰病

计三法（据舒本校补）

一、病如桂枝证，头不痛，项不强，寸脉微浮，胸中痞鞭，气上冲咽喉，不得息者，此为胸有寒也①，当吐之，宜瓜蒂散。（诸亡血家不可与瓜蒂散）原文

①胸有寒：这里的“寒”字作“邪”字解，即胸中邪气阻滞的意思。凡痰涎宿食等都属于邪的范围。

郑论：按此条头项既不强痛，又无恶寒、恶风情状，何得如桂枝证，此皆不经之论。应当云寸脉微浮，胸中痞鞭，气上冲咽喉，不得息者，胸有寒也，后人即按胸有寒结治之，何等直切，此病亦不在可吐之例，至亡血家更不在吐之例也

【阐释】本条郑氏持否定意见。笔者认为病如桂枝证，即有发热汗出，但头不痛、项不强，则非表证。寸脉微浮，主病在上，胸中痞鞭，是痰涎壅塞于膈上，阻碍气机，痰随气逆，所以上冲咽喉不得息。这是正气驱邪外出所反应的证状，所以治疗采取因势利导的方法，用瓜蒂散涌吐，此即《经》所谓“在上者因而越之”的治则。汗、吐、下是攻病的三个大法，病在膈上就当使用吐法，吐法取效简捷，能直接将病邪倾吐而出。但在《伤寒论》中，吐法的方证俱备者只此一条。方治后又垂戒云：“诸亡血虚家，不可与瓜蒂散”。教人慎重之意耳。

瓜蒂散方（校补）

瓜蒂一分（熬黄）赤小豆一分上二味，各别捣筛，为散已，合治之，取一钱匕，以香豉一合，用热汤七合，煮作稀糜，去渣，取汁和散，温顿服之，不吐者，少少加，得快吐乃止。诸亡血虚家，不可与瓜蒂散。

【方解及其应用范围】瓜蒂味极苦，性升而催吐；赤小豆味苦酸，功能利水消肿。两药配合，有酸苦涌泄之功。香豉轻清宣泄，更能加强涌吐之力。本方力猛，过吐恐伤胃气，所以体虚或失血的人应该慎用。后世推广用于膈上痰积、食积、以及卒中痰迷，涎痰雍盛。吐之即愈。

二、病人有寒，复发汗①，胃中冷，必吐蛔。

①复：更也，言误也。

郑论：按病人既有寒饮而发其汗，汗则亡阳，胃阳既亡，胃中之冷更甚，必吐蛔者，蛔不安于内也。

【阐释】里寒之人，虽有表证，仍当先温其里，否则表证虽除，里寒转甚，胃中冷而吐蛔矣。本条未出方治。《金鉴》说：“宜理中汤送服乌梅丸可也”。与病情颇为切合。

三、病人手足厥冷，脉乍紧者，邪结在胸中②。心（中）〔下〕满而烦，饥〔而不〕能食者，病在胸中，当须吐之，宜瓜蒂散。

②邪：这里是指停痰食积等致病因素。胸中：概指胸胃而言。

郑论：按手足逆冷，胃阳不达于四末也。但逆冷务必究其阴阳，苟阳邪甚而伏者，必有火形足征，阴邪甚而逆者，亦必有阴邪可验；胸满饥能食，属阳甚者，为热壅，胸满而不能食，属阴者，为寒结。或清、或温、或吐，自有一定之法也，岂得专一吐言哉！

【阐释】本条为痰饮食积，壅塞胸中而厥逆的治法。病人手足厥冷，阳气不达于四末，然阳气何以不达，则不可不辨。阳邪甚而伏者宜清，阴邪甚而逆者宜温。胸满饥能食为热壅，则可吐之；胸满饥不能食属阴为寒结，则当温也。故郑氏说：“或温、或清、或吐，自有一定之法也，岂得专一吐言哉”。

伤寒恒论卷八

太阴〔全〕篇计九法（据舒本校补）

一、太阴之为病，腹满而吐，食不下，自利益甚，时腹自痛，若下之，必胸下结鞕①。

①胸下结鞕：指胃脘部痞结胀鞕的意思。

郑论：按腹满而吐，有因饮食停滞而吐者，有因邪热结聚上壅而吐者，有因寒邪闭结上逆而吐者，不可不辨。但邪之所聚，上逆则为吐，下迫则为泻，故有腹痛之征。理应相机施治，若误下之则正气大伤，必有结鞕之患，不可不慎也。

【阐释】此条为太阴病的提纲。太阴与阳明同主肠胃疾患，但两者的性质不同，阳明为里实热证，而太阴为里虚寒证。前者腹满为肠胃中有宿食燥屎，按之鞕满而痛，故大便利而满亦去。后者腹满为肠胃外郁寒湿，按之柔软不痛，故下利而满仍不除。郑氏谓：“腹满而吐，有因饮食停滞而吐者，有因邪热结聚上壅而吐者，有因寒邪闭结上逆而吐者”。笔者对上述三种腹满而吐，分别以温中行气降逆之理中汤加半夏治之；苦寒降逆之大、小承气汤治之；扶阳散寒降逆之吴茱萸四逆汤治之，均获得满意效果。

二、太阴中风，四肢烦疼②，阳微阴涩而长者③，为欲愈。

②“烦疼”：指疼之甚，反侧安置极不舒适、难于形容之状也。

③阳微阴涩：阳微阴涩的阴阳二字，应作浮沉解，言轻取之而微，重取之而涩。

郑论：按太阴为脾脏，既称中风，夫中者，如矢之中人，既中脾脏，系属绝证，何竟四肢烦疼，应是太阴受风，庶与病合。而曰四肢烦疼是风邪不胜之意。阳微、言风邪之轻，阴涩而长，言脾气之旺，故称曰欲愈，如此处论，庶合经旨。

【阐释】郑氏驳“中”字为不当。“中”字应作感受风邪解。太阴属脾，脾主四肢，太阴经受风邪，所以四肢烦疼。风脉本浮，今而微，知风邪当去；涩是阴脉，长是阳脉，阴脉中而有阳脉，为正气复来之征，正气复就有力驱邪外出，故为欲愈。

三、太阴病，脉浮者，可发汗，宜桂枝汤。

郑论：按既称太阴病，应是理中汤法也。虽见脉浮，并未见太阳恶风畏寒，不得以桂枝汤发汗，即太阴兼太阳合病，亦无非理中汤内加桂枝耳。今每见脉浮，属饮食

停滞者多，亦不可不察，学者宜知。

【阐释】自此以下凡六节，言太阴病有表、里、寒、热、虚、实之不同也。郑氏谓：“既称太阴病，应是理中汤法也。……即太阴兼太阳合病，亦无非理中汤内加桂枝耳”。示人不能以脉定病，而必须脉证合参。若果系太阴病，当是“太阴病中风”，四肢烦疼而脉浮者，并有头疼发热等表证，无腹满而呕，食不下、自利诸症，然后可用桂枝汤。

四、自利不渴者，属太阴，以〔其〕脏有寒故也①，当温之，宜〔服〕四逆（汤）〔辈〕②。

①脏有寒：指胃肠虚寒而言。

②四逆辈：指四逆汤一类的方剂，如四逆汤、白通汤、通脉四逆汤之类。

郑论：按自利之人，每多口渴，以其气机下降，津液不得上潮。此则不渴，乙太阴主湿，湿甚故自利，故不渴，称为脏寒，法固当温里，应大剂温中，而原文所主四逆（汤）〔辈〕。但四逆乃少阴之主方，而非太阴之主方，此中固属大有关键，而圆通之机，即四逆亦大可用也。学者亦不可泥于法，而为法所囿也。

【阐释】自利而渴者属少阴，自利不渴者属太阴。此节乃太阴自受之里寒证也，曰自利者，非误治后之下利也，不渴者，乃寒湿盛而无燥热之化也。曰属太阴，又曰以其脏有寒，盖恐人但知太阴之湿，而不知自利不渴者，必有寒在脏也。宜服四逆辈者，当包括理中汤在内，以温脾肾为要，斟酌用之。

五、伤寒脉浮而缓，手足自温者，系在太阴；太阴当发身黄，若小便自利者，不能发黄；至七八日，虽暴烦下利，日十余行，必自止，以（胃）〔脾〕家实③，腐秽当去故也④。

③脾家实：指胃肠机能恢复而言。

④腐秽：指肠中宿积腐败的物质。

郑论：论发黄与不发黄，专视乎小便之利与不利，利者气机不能遏郁，故不发黄，不利者气机遏郁，故见发黄。此条专在小便之利与不利上分，大有卓见。至暴烦下利，日十余行，而曰（胃）〔脾〕家实，腐秽当去，是气机下降，非若阳明之便鞭便难，故知其属太阴无疑也。

【阐释】此节乃太阴表邪入里之实证也。浮缓之脉虽类太阳中风，但无发热汗出恶

风之证，而手足自温，所以属于太阴。太阴为湿土之脏，寒湿滞郁亦能发黄，但此种身黄，色黄而黯晦，为阴黄，与湿热郁蒸之阳黄，色鲜明如橘子色者很易区别，前者治以附子理中汤加茵陈，后者用茵陈五苓散治之。若小便自利，则湿邪从下而去，湿不内郁，故不发黄。至暴烦下利，乃脾阳回复，自动祛邪外出，可不药而愈。

六、本太阳病，医反下之，因（而）〔尔〕腹满时痛者，属太阴也，桂枝加芍药汤主之。前段

郑论：此条原系太阳因误下，而邪陷于脾，故见腹满时痛，理应温中醒脾，似非桂枝汤(一)所宜，学者细酌之。

(一)邪陷下而用桂枝汤，使邪复从于表而解，所加芍药者，和脾络之意也，亦妙（顶批）。

【阐释】本条与下条，伤寒论原文合为一条，成无己则分为两条，舒驰远与郑氏从之。太阳误下，邪陷太阴之实证也。“腹满时痛”是因误下而致脾气受伤所致，不是太阴里虚本寒，无吐利等证，但以太阳表证未除，故于桂枝汤内加芍药，以解表而和脾，脾气和则满痛自除。郑氏谓；“理应温中醒脾，似非桂枝汤所宜，学者细酌之”。示人不可执一，应以辨证为是。

桂枝加芍药汤方（校补）

桂枝三两（去皮）芍药六两甘草二两（炙）大枣十二枚（擘）生姜三两（切）上五味，以水七升，煮取三升，去渣，温分三分。本云桂枝汤，今加芍药。

【方解及其应用范围】本方即桂枝汤内倍芍药。《本草经》谓芍药主邪气腹痛，除血痹，破坚积，寒热，疝瘕、止痛、利小便、益气。本证因太阳误下邪陷太阴，太阳表邪未解，故仍用桂枝汤解表，腹满时痛，故加芍药以和脾止痛。现推广以治拘挛性疼痛、产后乳房红肿胀痛，慢性痢疾等，主要是重用芍药之故耳。

七、大实痛者，桂枝加大黄汤主之。后段

郑论：按大实痛而在太阴，理应大承气汤以逐其邪，于桂枝何取乎(一)？

(一)此亦太阳之邪，陷于脾而邪实，故表里两解之，亦妙法也（顶批）。

【阐释】此条紧接上条，如郑氏所言，理应大承气汤以逐其邪，于桂枝何取乎？但此是太阳病误下而致，于证似可急下，此阴实而非阳实，故应从桂枝例，升举阳邪

，但加大黄以破结滞，使表里两解，各有去路，则寒随湿去，不温而自温矣。

桂枝加大黄汤方（校补）

桂枝三两（去皮）大黄二两芍药六两生姜三两（切）甘草二两（炙）大枣十二枚（擘）。

上六味，以水七升，煮取三升，去渣，温服一升，日三服。

【方解及其应用范围】本方乃表里两解之剂，用桂枝汤领出陷入的阳邪，加大黄以导其滞，以治实痛，使表里之邪，各有出路。燥尿去而阳明之内道通，则大实痛减矣。现推广用以治腹中寒热不调而大痛，痢疾腹痛，荨麻疹等。

八、太阴为病，脉弱，其人续自便利，设当行大黄芍药者①，宜减之，以其人胃气弱易动故也②。

①行：此处作用字解。

②易动：指胃阳受伤，伺泄不止。

郑论：按脉弱而又见自利，其不足甚已，焉有再行大黄之理，似近画蛇添足，殊非确论。

【阐释】此条紧承上条，指出临床用药，必须注意患者体质，体质弱的，攻伐药应慎用，或减轻用药量，以免正气受损，下利不止。郑氏所论正确，当从之。

九、太阴病，欲解时，从亥至丑上。

郑论：各经皆有旺时，病之轻者，可以当旺时而潜消，宜知。

【阐释】郑氏所论各经皆有旺时，涉及时间医学，从亥至丑上，即下午九时至次日上午三时，此太阴经气旺时也。如郑氏所说：病之轻者，当旺时而潜消。

伤寒恒论卷九

少阴〔前〕篇

凡外邪挟水而动之证，列于此篇，计二十七法。（据舒本校增）

一、少阴之为病，脉微细①，但欲寐〔也〕②。

①脉微细；微是脉的搏动轻微无力，属于阳气衰弱，细是脉的形态细小，属于营血不足。

②但欲寐：是指迷迷糊糊似睡非睡的状态。

郑论：按此乃少阴提纲也。脉微细者，阳不足而阴有余也。阳主开故寤，阴主阖故寐。寤则从阳，寐则从阴，故知邪入少阴也。

【阐释】本条是少阴病的脉证提纲。少阴病，可分为直中与传经两种：寒邪直接侵袭少阴，一开始就是少阴证状，为直中；由他经发病而邪传到少阴的，为传经。传经则以从太阳传来的为多，此因太阳与少阴相为表里，二者关系密切，太阳受病时，正气旺者，邪就在太阳而解，正气不足者，邪即乘虚而陷入少阴；其次亦可从太阴传入。少阴病是全身性虚寒证，较太阴病的脾胃阳虚更深一层，而为心肾阳虚，一派阴霾之气，弥漫内外，故有四肢厥逆，恶寒蜷卧，下利清谷，精神困倦等严重的阴盛阳微现象。但少阴之本属阴而标属阳，既可从阴化寒，又可从阳化热，所以少阴是有寒化热化的区别，也是有热证的，后面将叙述。

二、少阴病，始得之，反发热，脉沉者，麻黄附子细辛汤主之。

郑论：按既云少阴病，而脉（尚浮）〔当沉〕，虽有发热，焉知非真阳外越乎？然麻黄附子细辛，固属少阴之法，学者总要审其发热之原委，或有头痛、身疼，或无头痛、身疼，畏寒甚否，又审其色之青白，舌之黑干润黄，口渴之饮冷饮热，小便之青长短赤，便得用药之道，庶不致误，原文反发热三字，不可忽略，此脏系根蒂之所，不得草草读去，务宜细心。

【阐释】少阴病，当无热恶寒，郑氏曰：“反发热三字，不可忽略”。反发热者，邪在表也，脉沉为少阴里证，此即太阳与少阴同病，故其治疗方法，既不同于太阳，也不同于少阴，但又不离乎太阳和少阴。三阴必以温经之药为表，麻黄以解太阳少阴之寒，细辛、附子以温少阴之经，俾外邪之深入者可出，而内阳亦不因之外越也。

麻黄附子细辛汤（校补）

麻黄二两（去节）附子一枚（炮、去皮、破八片）细辛二两上三味，以水一斗，先煮麻黄，减去二升，去上沫，内诸药，煮取三升，去渣，温服一升，日三服

【方解及其应用范围】恶寒发热，无汗而脉沉，是表里同病，故用麻黄以发汗解表，附子以温经扶阳，麻附配伍，可使体力增强而表邪易解，并使汗出表解而无损于心阳；更益以细辛配麻黄，专走少阴，而助麻黄辛温发散。三者合用，补散兼施，虽发微汗，无损于阳气矣，故为温经散寒之神剂。本方伤寒论治少阴病反发热脉沉者。郑氏用此方治忿嚏不已，治腰痛难于转侧，及周身皮肤浮肿、内冷身重三症，亦系取其温经散寒的作用。笔者经验认为本方治疗慢性咽炎、喉炎有很好疗效。因少阴经脉循于咽喉，挟舌本，故咽喉疼痛痹阻，属少阴病者甚多，辨证无误，皆药到病除。又本方加干姜、桂枝、甘草，可治寒邪入里，表里同病，恶寒发热，口不渴，全身倦怠无力，但欲寐。时时背部恶寒，小便清长，咳甚痰多，全身骨节疼痛，项强，心累，手足酸软无力之咳嗽、哮喘，伤寒虚弱之咳、喘，以及因伤寒引起之各种疾病数十种，屡获显效。

三、少阴病，得之一二日，口中和①，其背恶寒者，当灸之②，附子汤主之。

①口中和：就是舌面润，口不苦，舌质不绛，唇不干绛，不渴。

②灸之：即将艾火放在姜片上来烧。当灸膈俞、关元穴。郑论：按背恶寒，口中和，证似太阳，而非少阴，何也？太阳行身之背，恶寒乃太阳提纲，此以为少阴者，太阳底面即是少阴，少阴寒甚，溢于太阳地面，故恶寒而见于背，是亦里病及表之验也，故灸之，主以附子汤，皆是助阳祛阴之意也。

【阐释】此节乃少阴阳虚寒盛的证状和治法，采用艾灸之法与汤药配合施用。灸法用于回阳救急，应灸膈俞、关元等穴，方剂用附子汤，亦取其温经散寒，补益阳气。

附子汤（校补）

附子二枚（炮去皮破八片）茯苓三两人参二两白朮四两芍药三两上五味，以水八升，煮取三升，去渣，温服一升，日三服。

【方解及其应用范围】本方以附子名汤，目的在于温补元阳以散寒邪，人参回生气之源，再加茯苓、白朮健脾利湿，芍药和血，同奏温经逐寒，益气健脾之功，为少阴固本御邪之方也。本方推广以治虚寒性之神经痛、肌肉痛、风寒或风湿性关节炎，或类风湿性关节炎，少腹寒凉隐痛等病证，都有疗效。

四、少阴病，得之二三日，麻黄附子甘草汤微发汗，以二三日无里证，故微发汗也。

郑论：按少阴病，虽云二三日，并未现出病情，统以麻黄附子甘草〔汤〕微发汗。又云无里证，是邪在表分，而非少阴证也，明甚。含含糊糊，未知所从，不敢强解。

【阐释】本条和前二条相互联系，相互发明，皆为少阴初病，未见吐利逆冷诸里证，先行发汗，预防里证之治法。后者病势较轻较缓，故以甘草易细辛，去细辛之辛散，益以甘草之甘缓，相机施治耳。郑氏谓：“原文含含糊糊，未知所从，不敢强解”。似非确切之论。

麻黄附子甘草汤方（校补）

麻黄二两（去节）附子一枚（炮去皮破八片）甘草二两（炙）上三味，以水七升，先煮麻黄一两沸，去上沫，内诸药，煮取三升，去渣，温服一升，日三服。

【方解及其应用范围】本方即前麻黄附子细辛汤去细辛之辛散，加甘草之甘缓，此少阴感寒之微发汗法，也是温经发表的方剂，用以微微发汗以治疗病势较轻的少阴兼太阳表症。

近人推广以治阳虚体质之感冒，寒邪侵入少阴之咳嗽、咽喉痛等证。

五、少阴病，欲吐不吐^①，心烦，但欲寐，五六日自利而渴者，属少阴也。虚、故引水自救；若小便色白者，少阴〔病〕形悉具。小便白者，以下焦虚^①，有寒，不能制水，故令色白也。

①欲吐不吐：是指要吐而又不得吐出之状态。

①下焦：这里指肾脏。

郑论：按阴邪上干，故欲吐而不吐，以致心烦，但欲寐者，少阴之征，五六日，自利而渴者，气机下泄，肾气不充于上也。虚、故引水自救，学者于此，当以饮冷、饮热判之，舌苔之干、润判之。因邪热自利之渴者，当以救肾水为急，因虚自利之渴者，当以救肾阳为先。至小便白，下焦火化不足，虚寒之候，可以无疑也。

【阐释】久病之人，小便黄者，阳气未绝于内也。至下焦虚寒，不能制阴寒之水，不受阳热蒸化而小便反白，故知久病而小便白者，皆危候也。少阴病形悉具者，指脉微细而沉，利不止，厥逆，干呕而烦。上有虚热，下有实寒，法当用白通汤治之。

。然遽投热药，上有虚热相拒，则水药必将倾吐而出，故需用苦寒之猪胆汁，及咸寒之童便，引之下行，乃能尽白通汤之力而收其效。但令肾水得从温化，蒸气上行，则心烦燥渴可愈，下行之小便，亦将色变矣。

六、病人脉阴阳俱紧，反（出汗）〔汗出〕者，亡阳也，此属少阴，法当咽痛，而复吐利。

郑论：按少阴乃封藏之所，脉现细微，乃是本象，今所现者紧，而反汗出，是阳亡于外，上逆而为吐，为咽痛，阳既上逆，而下部即寒，故见自利。

【阐释】太阳伤寒，脉阴阳俱紧，是浮而紧；少阴病，则阴阳俱紧，是沉而紧，此为寒邪已直侵少阴。阴证本不当有汗，现在反见汗出，此阴寒太甚，阳虚不能固外而从外脱，则上为吐，下为利。由于阴寒极盛，虚阳上浮，故咽痛，此类咽痛，大多不红不肿，和实证咽痛完全不同，此为假热真寒证。治以白通加童便、猪胆汁以回阳固脱，则诸证自愈。

七、少阴病，脉微，不可发汗，亡阳故也；阳已虚，尺脉弱涩者，复不可下〔之〕。

郑论：按脉既微，本非可汗之证，汗之必亡阳，故曰不可发汗；阳已虚，而尺脉又见涩，涩为血少，更不可以言下，此系根本之地，明示人汗、下之非法，当慎之也。

【阐释】此节指出少阴病不可汗、下。然仅以脉来定少阴病，似不妥当，必须结合少阴证其它证状来判定。少阴病，其脉微，为阳虚，当温之；尺脉弱涩者，尺主下焦，弱主气不足，涩主阴不足，亦当温。此条本为少阴禁汗禁下而设，故不言治。然温经补阳之附子汤之类，即可治也。

八、少阴病，下利（者），若利自止（者），恶寒而蜷卧①，手足温者，可治。

①蜷卧：就是四肢敛缩而卧。

郑论：按利止而手足温，阳未尽也。若利止，手足逆冷不回，阳已绝矣，生死即在此处攸分。

【阐释】下利、恶寒、蜷卧是阴寒极盛，下利停止而手足转温，则中阳未绝，此乃阳气回复阴寒去而里和，所以说其病可治，但可治并不等于勿药可愈，投以大剂四逆汤类，可以克日奏功。

九、少阴病，恶寒而蜷，时自烦，欲去衣被者，可治。

郑论：按少阴恶寒而自烦，欲去衣被者，真阳扰乱，阳欲外亡、而尚未出躯壳，故为可治。若去衣被，而汗出昏晕者，阳已外亡，法在不治。

【阐释】郑氏谓：“欲去衣被者，真阳扰乱，阳欲外亡，而尚未出躯壳”。

实则此为阳气来复与阴邪相争，阳气获胜的现象，故曰可治。若再投以麻黄附子细辛汤，则诸证可早日告愈。

十、少阴病，脉紧，至七八日，自下利，脉暴微，手足反温，脉紧反去者，为欲解也，虽烦下利，必自（止）〔愈〕。

郑论：按脉紧，是病进之征，至渐自利，脉暴微，手足反温，是阳回之验，阳回虽见下利，必自愈，所患者手足不温，脉紧不退耳，既已退矣，又何患乎？

【阐释】郑氏谓：“手足反温，是阳回之验，阳回虽见下利，必自愈。”盖少阴病脉紧为里寒盛，自下利，脉暴微者，阴寒内泻也，是邪气从下而解；手足转温，是阳气复。正复邪退，乃病有向愈之机矣。

十一、少阴病，身体痛，手足寒，骨节痛，脉沉者，附子汤主之。

郑论：按脉沉者，邪在里也，其人身体骨节寒痛，是脉与病合也，主以附子汤，亦温经祛寒之意也。

【阐释】本条主要是阳气虚弱，故脉沉，邪在里也。阳气虚衰，不能充达于四肢，所以手足寒；正由于阳气虚弱，阴凝之气，滞而不行，留着于经脉骨节之间，故身体痛、骨节痛。郑氏曰：“脉与病合，主以附子汤，亦温经祛寒之意也”，是正确的。

十二、少阴病，吐利，〔手足逆冷〕，烦（燥）〔躁〕欲死者，吴茱萸汤主之。

郑论：按吐利而致烦（燥）〔躁〕欲死，此中宫阴阳两亡，不交之甚者也。夫吐则亡阳，利则亡阴，阴阳两亡，故有此候，主以吴茱萸汤，降逆安中，是的确不易之法也。

【阐释】阳明证的食谷欲呕，厥阴病的干呕吐涎沫，和本条的吐利，都是属于虚寒证，皆可用吴茱萸汤治之。吐利，手足逆冷，而烦躁欲死，诚如郑氏所说：“阴阳两亡，主以吴茱萸汤，降逆安中，是的确不易之法。”手足逆冷与烦躁，乃因呕吐

繁剧所致，与真阳欲绝之四逆烦躁，根本不同。呕吐由于寒邪犯胃，胃中虚冷，故用吴茱萸汤以驱寒温胃，降逆止呕。

吴茱萸汤方（校补）

吴茱萸一升（洗）人参（三两）生姜六两（切）大枣十二枚（擘）上四味，以水七升，煮取二升，去渣，温服七合，日三服。

【方解及其应用范围】按吴茱萸汤一方，乃温中、降逆、补肝之剂也。吴茱萸辛温，乃降逆补肝之品，逆气降而吐自不作，即能补中，肝得补而木气畅达，即不侮土；生姜为治呕之要药，其辛温与吴茱萸同声相应，合大枣之甘，能调胃阳，复得人参甘寒，功专滋养脾阴，二土得补，皆具生机，转运复行，烦躁自然立止。笔者曾用本方治厥阴干呕吐涎头痛之症，屡用屡效。近人推广用以治疗胃肠炎、慢性胃炎和胃酸过多，都能使症状缓解或痊愈。

十三、少阴病，下利，白通汤主之。

郑论：按少阴下利，下元火衰也。主以白通汤，亦温肾助阳，阳回利止之意也。

【阐释】郑氏云：“主以白通汤，亦温肾助阳，阳回利止”。是正确的，但语焉不详，特为之补出。此条属少阴虚寒下利，从方治推测，用干姜、附子，则知本证亦属脾肾阳虚。肾中有真阳，为一身阳气之本，脾胃为中阳之本，脾肾之阳俱虚，则阳气不能达于四肢，所以必有脉微细、恶寒、四肢厥冷等候。加葱白取其急通上下之阳气，本证较四逆汤证严重，去甘草者，恐甘草缓姜、附之性，反掣急救回阳之肘，所以弃而不用。

白通汤方（校补）

葱白四茎干姜一两附子一枚（生，去皮，破八片）上三味，以水三升，煮取一升，去渣，分温再服。

【方解及其应用范围】附子大辛大热，火性迅发，无所不到，为回阳救逆第一药品，能大补肾阳。

干姜辛烈温散，能荡尽阴邪之阻滞，迎阳归舍。用葱白而曰白通汤者，能通阳气以破阴，此扶阳散寒止利之剂也。本方能通调周身上下之阳气，为治阳隔于上之要方。笔者曾用此方治疗高烧不退，以及慢性咽喉炎，取得满意疗效。患者虽注射针药而烧不退，盖此乃真寒假热，阳隔于上也。

十四、少阴病，下利，脉微者，与白通汤；利不止，厥逆无脉，干呕烦者，白通加猪胆汁汤主之。服（后）〔汤〕脉暴（脱）〔出〕者死，微续者生。

郑论：按下利而用白通，直救其阳也。其脉暴〔出〕者，脱之机也；其脉微续，生之兆也。

【阐释】少阴病，下利脉微者，宜附子汤回阳以消阴。而用白通者，郑氏说：“直救其阳也”。但服后利不止，厥逆无脉，干呕烦者，此阴盛阳虚的程度相当严重，阴盛隔阳，汤药被阴邪所格拒，并非药不对证，所以仍主白通汤，加入咸寒苦降之猪胆汁、人尿，取其反佐作用，使热药不致被阴寒所格拒，以达到回阳救逆目的。服药后其脉暴出者，正气因发泄而脱也，故死；脉微续者，阳气渐复也，故生。

白通加猪胆汁方（校补）

葱白四茎干姜一两附子一枚（生、破八片）人尿五合猪胆汁一合上五味，以水三升，煮取一升，去渣，内胆汁，人尿，和令相得，分温再服。若无胆，亦可用。

【方解及其应用范围】本方即白通汤加人尿、猪胆汁。白通汤之解见前。加人尿、猪胆汁，引阳药达于至阴，而调二气之格拒，通上下之阴阳，此方即《内经》反佐之法也。故证见寒极格热，干呕而烦不受热药，下咽即吐者，则为白通加猪胆汁汤证。推广以治霍乱吐泻之症、中风卒倒，其它暴卒及脱阳之症，皆建奇效。

十五、少阴病，二三日不已，至四五日，腹痛，小便不利，四肢沉重疼痛，自下利者，此为有水气，其人或咳、或小便利，或下利，或呕者，真武汤主之。

郑论：按少阴腹痛，小便不利者，寒结于下，不能化下焦之阴也。四肢沉重，自下利者，阳气下趋，不能达于四末也。其中或咳、或下利、或小便利，当从未议，不可混为一证也。主真武汤，是重寒水阻滞而设，学者不可固执，总在扶阳驱阴为要。

【阐释】少阴病，腹痛是寒盛于内，小便不利是水不下行，四肢沉重疼痛是湿侵于外，自下利是水溢于内。此皆由阳虚不能化气所致。真武汤主要作用在温经扶阳，而不在利水，阳旺则寒水自然潜消。

真武汤方（校补）

茯苓三两芍药三两白朮二两生姜三两（切）附子一枚（炮去皮，破八片）上五味，以水八升，煮取三升，去渣，温服七合，日三服。若咳者，加五味子半升，细辛一两，干姜一两；若小便利者，去茯苓；若下利者，去芍药，加干姜二两；若呕者，

去附子，加生姜足前为半斤。

【方解及其应用范围】本方有温有行，阴阳两调，为温阳行水之首选方。附子辛热以壮肾阳，使水有所主；白朮之燥以健脾，使水有所制；生姜辛散，佐附子以补阳，于主水中有散水之意；茯苓淡渗，佐白朮健脾，于制水中有利水作用；本病肾阳既虚，肾阴也亏，附子、芍药同用，兼能回阳保阴，但又以回阳行水为主。本方应用范围较广，凡是肾阳虚，因寒水而致的腹痛，小便不利，大便下利，肾炎、水肿、心力衰竭以及由于辛温发汗太过而致汗多亡阳的头眩心下悸，肉腠筋惕等证，效果显著。笔者用之以治肾阳虚水泛为痰之咳嗽、哮喘，获得满意疗效。

十六、少阴病，下利清谷，里寒外热，手足厥逆，脉微欲绝，〔身〕反不恶寒，其人面（赤色）〔色赤〕，或腹痛，或干呕，或咽痛，或利止脉不出者，通脉四逆汤主之（若脉即出者，愈）。

郑论：按下利清谷，其人面色赤，里寒外热，厥逆，脉微欲绝，种种病形，皆是危亡之候，但其人身反不恶寒，其阳犹在，尚未离根；若恶寒身重甚，阳已离根，招之不易，服（白）通〔脉四逆〕汤，其脉即出而缓者生，其脉暴出者死。

【阐释】本条之少阴病，实阴盛格阳于外之真寒假热证。所载各证，皆是危亡之候。至脉微欲绝，较之四逆汤证的脉象不过沉或微细为严重。整个证状或病情上都较四逆汤为重，故于四逆汤内倍用干姜，并加重附子用量，以急驱内寒，挽行将越脱之阳气。郑氏说：“服通脉四逆汤，其脉即出而缓者生，其脉暴出者死。”其意与前十四条同。

通脉四逆汤方（校补）

甘草二两（炙）附子大者一枚（生用、去皮、破八片）干姜三两，强人可用四两上三味，以水三升，煮取一升二合，去渣，分温再服，其脉即出者愈。面赤色者，加葱九茎。腹中痛者，去葱加芍药二两。呕者，加生姜二两。咽痛者，去芍药加桔梗一两。利止脉不出者，去桔梗加入参二两。病皆与方相应者，乃服之。

【方解及其应用范围】本方即四逆汤倍干姜加重附子用量，作用与四逆汤相同，但因其整个证状都较四逆汤为严重，故加重其剂量。陈修园谓：“阳气不能运行，宜四逆汤；元阳虚甚，宜附子汤；阴盛于下，格阳于上，宜白通汤；阴盛于内，格阳于外，宜通脉四逆汤。盖以生气既离，亡在顷刻，若以柔缓之甘草为君，岂能急呼散阳而使返耶！故倍用干姜，而仍不减甘草者，恐散涣之余，不能当姜附之猛，还借甘草以收全功也”，允称恰当之释。其主要作用是治疗少阴格阳证。笔者治一初起恶寒发热之患者，误以为表实证，服麻黄汤而病不愈。体温在℃左右，虽热而不思饮，腹中痛，下肢冷，脉轻按浮大，重按则无，舌质淡，苔白，故断为阴盛隔阳

之证，以大剂通脉四逆汤治之，连服四剂，体温降至℃，腹中痛及下肢冷告愈。继以附子理中汤加味调理，巩固疗效，连服十剂而停药。

十七、少阴病，脉沉者，急温之，〔宜〕四逆（辈）〔汤〕。

郑论：按少阴而见脉沉，里寒甚已，法宜急温以扶阳，庶可免危亡之祸。

【阐释】少阴病脉本微细，今者轻取之微脉不见，重取之细脉几亡，伏匿而至于沉，此寒邪深中于里，殆将入脏；则身重欲寐，下利、厥逆等证俱包括在内，实即危亡之候，“急温之”之意，为不可缓矣。如郑氏所说：“法宜急温以扶阳，庶可免危亡之祸。”

十八、少阴病，饮食入口（即）〔则〕吐，心中温温欲吐①，复不能吐，始得之，手足寒，脉弦迟者，此胸中实，不可下〔也〕，当吐之。若膈上有寒饮，干呕者，不可吐也，（急）〔当〕温之，宜四逆（辈）〔汤〕。

①温温：同愠愠，即欲吐不吐，心中自觉泛泛不适的形容辞。

郑论：按饮食入口即吐，有寒逆热逆之别，此则手足寒，而脉见弦迟，是寒饮上逆之候。而非热逆之候。既属寒逆，法当温中降逆，故云不可吐，不可下，主以四逆辈，实千古不易之确论也。

【阐释】此节乃少阴病胸中有痰实与膈上有寒饮的辨证和治疗。郑氏所论不够全面，兹特辨而明之。因胸中有痰涎等实邪阻滞，饮食入口则吐；而心中愠愠欲吐，复不能吐，此宿痰胶滞；手足寒是胸阳为痰浊所阻，不能通于四肢也；弦脉主痰饮，弦而兼迟，是痰浊阻遏，阳气不布之象；胸中邪实，非攻下之剂所能驱除。《内经》谓：“其高者因而越之”，故当吐也，瓜蒂散证是也。但笔者用白矾溶于水内，饮者即吐痰涎，较瓜蒂散简便易行，屡用屡效者。若膈上有寒饮，证见干呕，此属阳气不化之寒饮。病痰饮者，当以温药和之，宜四逆汤以温之，则寒去胃和，故不可吐也。

十九、少阴病，下利，脉微涩，呕而汗出，必数更衣，反少者②，当温其上，灸之。

②必数更衣，反少者：大便次数多而量反少。

郑论：按少阴下利脉微者，阳气虚也。脉涩者，阴血弱也。呕者，阴气上逆也。汗出，阳亡于外也。必数更衣，阳从下陷也。灸其上者，下病上取，以升其阳，不使下陷也。

【阐释】此节为阴虚血少而汗出亡阳者，用灸法以急救回阳也。郑氏之按是正确的。灸其上者，百会穴是也。灸百会穴确有升阳作用，疗效可靠。举凡一切阳虚下陷的疾患，都可灸百会穴，不但起下陷之阳，并且有交通阴阳之妙。要知本证虽为阴阳两虚，仍以阳虚为急，若以汤剂治疗，即可选阴阳兼顾的方剂，四逆加人参汤可治之。

二十、少阴病，吐利，手足不逆冷，反发热者，不死；脉不至者，灸少阴七壮①。

①灸少阴：就是灸少阴经脉所循行的穴位。七壮：每艾灸一炷为一壮，七壮，灸七个艾炷。

郑论：按吐利而手足不逆冷者，阳尚未亡也，反发热者，虽在不死之例，而阳已发于外也，急宜招之。倘发热兼见汗出，则殆矣，所幸者无汗，故曰灸之，实以助阳也。

【阐释】此节论少阴病阳复可治，脉不至者可灸。手足不逆冷，反发热者，此阳气来复也。脉不至者，由于吐利交作，正气暴虚，致脉一时不能接续，灸少阴太溪穴、涌泉穴；如欲其回阳驱阴，更可灸关元、气海穴，以通阳复脉。正如郑氏所说：“灸之实以助阳也。”凡此等证，内服与艾灸，可以并行不悖，汤剂可选用四逆辈。

二十一、少阴病，恶寒，身蜷而利，手足逆冷者，不治。

郑论：按恶寒、身蜷而利，阳气下趋已甚，又见手足逆冷，阳将尽也，法在不治之例，能急温之，手足能温者，尚可不死。虽云不治，医者亦不得束手旁观，能无侥幸之一愈也。

【阐释】少阴病，纯阴无阳者为不治。郑氏说：“虽云不治，医者亦不得束手旁观，能无侥幸之一愈也。”笔者认为急投大剂四逆、白通一类方剂，或可挽救十之一二。舒驰远说：“此证尚未至汗出息高，急投四逆加人参汤，或者不死”。

二十二、少阴病，吐利（烦燥）〔躁烦〕，四逆者，死。

郑论：按此条系吴茱萸汤证，何以前不言死，而此言死也，又见其四逆故也。

【阐释】此条与前条吴茱萸汤证相同，何以前不言死，而此言死也，何故？必是已用理中、四逆、白通诸汤治之不愈，转加躁烦，四肢厥逆，不死何待？亦即郑氏所说：“又见其四逆故也”。非死不可。

二十三、少阴病，下利止而头眩，时时自冒者①，死。

①自冒：冒者，如以物蔽目的意思，这里是指眼发昏黑，目无所见的昏晕而言。

郑论：按下利既止，应乎不死，此以死论者，以其时时头眩自冒，冒者何？是阳欲从上脱也。诸书云：“阳回利止则生，阴尽利止则死”。余观此条，时时眩冒，阳将脱而未脱，急急回阳，或者可救。总之阳回利止，精神健旺，阴尽利止，精神惫极，大有攸分。

【阐释】下利虽止，而头眩，时时自冒，是阴竭于下，阳欲脱于上之极危候，急投大剂回阳之品，如郑氏所说：“阳将脱而未脱，急急回阳，或者可救”之谓矣。

二十四、少阴病，四逆，恶寒而身蜷，脉不至，（而）〔不〕烦而（燥）〔躁〕者，死。

郑论：按恶寒、身蜷四逆，阳衰已极之候，况脉既不至，阳已不能达于外也，兼见烦（燥）〔躁〕，烦出于心，（燥）〔躁〕出于肾，心肾不交，方有此候，今竟如是，其人安得不死？

【阐释】郑氏据原文以释，是正确的，最后曰：“其人安得不死”。笔者认为少阴一证，但令有一线微阳，即有再生之机，医者志在救危，可用重剂通脉四逆汤救危亡于万一，以尽医者天职。

二十五、少阴病，六七日，息高者②，死。

②息高：指呼吸浅表，不能作深长的呼吸，甚至呼气多而吸气少的意

郑论：按息高而在阳明，未犯少阴，尚可不死。若在少阴，少阴乃根本之地，先天之真阳寄焉，真阳喜藏而不喜露，今见息高，是肾气上奔，阴阳离绝，危亡转瞬，故知其必死。又曰：阳明少阴从何分别乎？阳明者，胃脉鼓指，而尺脉沉细，口热气粗，多系有余；若少阴者，尺大而空，或弦劲鼓指，爪、甲、唇、舌青黑，遗尿等形，多系纯阴无阳，故知之也。更有新久之不同，病形之迥异为别。

【阐释】息高有阳明少阴之别，阳明多系有余之证，少阴则为纯阴无阳。少阴病而见息高，此肾气下绝，肺气上脱，为上下离绝之象，故知其必死。若能于六七日之前，见微知机，用大剂通脉四逆汤加收固肾气药品治之，或可免于死亡。至郑氏所释阳明、少阴息高之分，则可指导临证。

二十六、少阴病、脉微、细、沉，但欲卧，汗出不烦，自欲吐，至五六日，自利，

复烦躁不得卧寐者，死。

郑论：按欲卧而转至不得卧，阴阳不交甚已，又加以烦躁自利，安得不死？

【阐释】脉微、细、沉，但欲卧，是少阴本证。汗出不烦是阳气外亡，自欲吐为阴邪上逆。盖至此未为死证，当急用四逆、白通回阳以救之。若失此不治，至五六日，如郑氏所释：“阴阳不交甚已，又加以烦躁自利，安得不死？”此即阳虚已脱，阴盛转加，阴阳离绝而死矣。

二十七、少阴负趺阳者①，为顺也。后段

①少阴负趺阳：脉小于趺阳脉。少阴即太溪脉，趺阳即冲阳脉。少阴负趺阳，谓太溪脉小于趺阳脉

郑论：按少阴为水脏，趺阳为土脏，今少阴负趺阳者，土足以制水，水即汜溢，得土以拌之，水有所归，不至横流为灾，故为顺也。

【阐释】少阴为肾经，属水，其脉在太溪穴；趺阳为胃经，属土，其脉在冲阳穴；少阴负趺阳，则脾胃的谷气犹盛，其病虽危，而正气仍可奋起抗邪，所以为顺，亦即其病可以转危为安。

少阴〔后〕篇

凡外邪挟火而动之证，列于此篇，计十七法（据舒本校补）

一、少阴病，欲解时，从子至寅上。

郑论：按子丑寅，系少阴之旺时，凡病气之衰，亦于旺时即解，此亦邪不胜正之说也。

【阐释】六经都有欲解时一条，一般都在该经主气之时，得旺气而解。本条不解于阴盛的时候，而独解于阳生之时，即子丑寅时，（晨三至上午十时）是因阳长而阴消，阳进则阴退，正所谓阴得阳则解也。由是推之，少阴所重者在真阳，明矣。

二、少阴病，脉细沉数，病为在里，不可发汗。

郑论：按少阴为蛰藏之府，原不在发汗之例，当审其协火而动，与协水而动，二者之间，便得用药之妙也。若协火而动，汗之则亡阴，协水而动，汗之则亡阳，不可不知。

【阐释】本条指出脉细、沉、数，是少阴里证的脉象。细为血虚，沉为在里，数脉与沉细并见，且不发热，不能认数为热而误以汗解。郑氏所论，明确可从。

三、少阴中风，脉阳微阴浮者，为欲愈。

郑论：按少阴中风，果现何等病形，而只曰阳微阴浮者为欲愈，令人不解。况中风有闭、脱之不同，在少阴则为中藏之候，生死即在转瞬之间，不得含糊立论也，恐有遗误。

【阐释】本条少阴中风，仅言脉阳微阴浮者为欲愈，而忽略证状叙述。应脉证互参，则诊断才能正确。故郑氏说：“中风有闭、脱之不同，在少阴则为中脏之候，生死即在转瞬之间，不得含糊立论，恐有遗误”。舒驰远亦云：“外证云何？若不掣明外证，奚从辨之”，亦对此持怀疑态度。

四、少阴病，咳而下利，谵语者，被火〔气〕劫故也，小便必难，以强责少阴汗也

①原文

①强责：强责少阴汗是不当发汗而强用发汗的方法。

郑论：按下利、谵语而咳，在阳明为胃火攻劫所致，在少阴为强责其汗，血液被夺，以致阴亏而火旺，亦有此候。

【阐释】下利为少阴之本病，惟咳而谵语，则为少阴证所本无，所以致此变证者，如郑氏所说：“在少阴为强责其汗，血液被夺，以致阴亏而火旺。”可用调胃承气汤使腑滞下行，则燥热之气除，而咳与谵语可愈。

五、少阴病，八九日，一身手足尽热者，以热在膀胱，必便血也。

①强责：强责少阴汗是不当发汗而强用发汗的方法。

郑论：按膀胱有热，必口渴饮冷，小便不利，或短赤等情，此以少阴病而延至八九日，一身手足尽热，是邪在表，而并未在里，又焉知非阳越于外乎？况又未见膀胱腑证情形，而曰热在膀胱，必便血，不能无疑。

【阐释】郑氏曰：“未见膀胱腑证情形，而曰热在膀胱，必便血，不能无疑。”夫病在少阴，一般是不发热的，今少阴病至八九日，不见少阴虚寒证，而见一身手足尽热，寒邪已化为热，是为病由阴转阳，肾移热于膀胱，气病及血，引起迫血妄行而见便血，此乃阳回太过之象，如此注释，可解郑氏之疑。以便血证治法，柯韵伯指出轻则猪苓汤，重则黄连阿胶汤，可供临证参考。

六、少阴病，但厥无汗，而强发之，必动其血，未知从何道出，或从口鼻，或从目出〔者〕，是名（厥上竭下）〔下厥上竭〕①为难治。

①下厥上竭：厥逆因于下焦阳虚，故称下厥，阴血因上出而耗竭，故称上竭。

郑论：按少阴病，厥亦已重矣，无汗则幸矣，而强汗之，是逼阳于外，血即不动亦动矣。血或从上从下，原不可定，此名曰（厥上竭下），〔下厥上竭〕为难治，确乎不爽。

【阐释】少阴病，若因其无汗而强发之，则既伤其阳，复竭其阴，势必厥逆不除，更动其血，逼血上出，致阳亡于下而厥，阴涸于上而竭，下厥上竭，属误治危候，故曰难治。唯景岳六味回阳饮，滋阴回阳并用，或可治此危候。

七、少阴病，得之二三日以上，心中烦，不得（眠）〔卧〕，黄连阿胶汤主之。

郑论：按此条即少阴挟火而动之候，余于六经定法已言之，兹不赘。

【阐释】此条郑氏于《医理真传》六经定法已言之，可参阅。按此乃寒邪化热，血液受伤之候。本证的心烦，与心、肾有密切关系，肾属水，心属火，肾水不足，心火有余，水不升，火不降，心肾不交，故不得卧；又肾水不足，不能制其心火，故心烦，必得滋其肾阴，制其心火，斯为正治，黄连阿胶汤主之是也。

黄连阿胶汤方（校补）

黄连四两黄芩二两芍药二两鸡子黄二枚阿胶三两上五味，以水六升，先煮三物，取二升，去渣，内胶烊尽，小冷，内鸡子黄，搅令相得，温服七合，日三服。

【方解及其应用范围】按黄连阿胶汤一方，乃交阴阳之方，实养阴清热之方也。夫此方本为少阴热化症而为心烦不得卧者立法。盖心烦者，坎中之精不能上交于心；不得卧者，离中之阴不能下降于肾。方中芩、连、芍药之苦，直清其热；又得鸡子黄以补离中之气，阿胶以补坎中之精，坎、离得补，阴、阳之气自调，升、降不乖，而水、火互为其根矣。因本方能育阴制阳，使心肾相交，升降协调，故能治多种失眠症。

笔者治阳虚阴盛之患者，用大剂扶阳药品，病者服此等热药，服至周身发热难安时，然后与以一剂滋阴之药，以敛其所复之阳，阳得阴敛，而阳有所依，自然互根相济，而病愈矣。所选用之方剂，即此黄连阿胶汤，屡用而效者。又治高血压及卒中之后阴虚火旺，手足心烦热、面热赤、或谵妄者。

八、少阴病，二三日至四五者，腹痛，小便不利，下利不止，便脓血者，桃花汤主之。

郑论：按腹痛、小便不利者，寒结于下也。下利不止者，是阴寒阻截膀胱运行之机也。便脓血者，下利过甚，而肠中之脂膏，亦与之俱下也。主以桃花汤者，温中化气，镇塞海底之意，诚良法也。

【阐释】本条叙述桃花汤的证状较为详细，当与下条合看，也是属于虚寒性的下利。郑氏谓：“主以桃花汤者，温中化气，镇塞海底之意”。方与证合，不再赘述。

九、少阴病，下利，便脓血者，桃花汤主之。少阴病，〔下利〕，便脓血者，可刺①。

①可刺：是可以用针刺的方法。

郑论：按桃花汤，乃治少阴虚寒下利的方，若湿热下利者，断乎不可。

【阐释】此属少阴病虚寒性的下利便脓血证。脾肾阳气不足，肠胃虚寒，下焦不能固摄所致。故本证下利，必定滑脱不禁，并有脉沉细或腹痛喜按等虚寒性的脉证，没有里急后重和肛门灼热的感觉，色泽暗晦，或血色浅淡，其气不臭等；而热性下利便脓血，血色鲜明，气味很臭，有里急后重，肛门灼热的感觉，两者根本是不同的。故郑氏说：“桃花汤乃治少阴虚寒下利的方，若湿热下利者，断乎不可”。此证也可采用针刺法治疗，原文未言穴位。常器之云：可刺足少阴幽门、交信二穴。刺以泄其邪，通行其经络，则其病可愈。

桃花汤方（校补）

赤石脂一斤（一半全用，一半筛末）干姜一两粳米一升上三味，以水七升，煮米令熟，去渣，温服七合，内赤石脂末方寸匕，日三服，若一服愈，余勿服。

【方解及其应用范围】李时珍曰：取赤石脂之重涩，入下焦血分而固脱；干姜之辛温，暖下焦气分而补虚，粳米之甘温，佐石脂、干姜而润肠胃也。”为温中、涩肠、固脱之方。故广泛用于虚寒滑脱之久痢、久泄有显著疗效。

十、少阴病，下利、咽痛，胸满、心烦（者）猪肤汤主之。

郑论：按少阴证，而用猪肤汤者，协火而动之的候也。若协水而动，断不用此，学者务宜于六经定法上探求，协火协水病情，便得其要也。

【阐释】郑氏说：“少阴证，而用猪肤汤者，协火而动之的候也。”少阴协火而动者何？病人真阳素旺，客邪入而附之，即从阳化而为热，邪热下注则下利，利则阴气更伤，因而虚火上炎，产生咽痛、胸满心烦等证。且利久必伤脾，脾虚津亦难复，故用猪肤汤滋阴润燥和中以治下利止咽痛。

猪肤汤方（校补）

猪肤一斤上一味，以水一斗，煮取五升，去渣，加白蜜一升，白粉五合，熬香，和令相得，温分六服。

【方解及其应用范围】本方乃滋润平补之剂，猪肤咸寒入肾，滋肾水而清热润燥，白蜜甘寒润肺，清上炎之虚火而利咽，白粉即白米粉甘缓和中，扶脾止利，使下利止，津液来复，虚火降敛，则咽痛、胸满、心烦诸证均可消除，为治疗少阴热化，津液下泄，虚火上炎之良方。

十一、少阴病，二三日，咽痛者，可与甘草汤；不差（者）①，（宜）与（吉更）〔桔梗〕汤。

①不差（ch ā i 𠂔）：病势减轻的意思。

郑论：按甘草汤与（吉更）〔桔梗〕汤，二方皆苦甘化阴之方，实治少阴协火而动，上攻于咽之方也，不可概作此论。

【阐释】咽痛一证，阴证阳证都有。此言咽痛者，盖少阴客热之咽痛，不兼及其它证状，而岂病情较轻，所以只用一味甘草汤以清火解热；如果服后不愈者，当为咽喉有痰热交阻之故，桔梗汤开肺驱痰治之。若为阴症之咽痛，投以此方则无效。故郑氏曰：“不可概作此论”矣。

甘草汤（校补）

甘草二两上一味，以水三升，煮取一升半，去渣，温服七合，日二服。

【方解及其应用范围】本方仅生甘草一味，乃从长桑君以后相传之神方。具清热、润燥、和偏、缓急、化毒、补中之力，应该重用才能发挥疗效。《肘后方》以治“肺痿咳嗽吐涎沫，心中温温，烦躁而不渴者。”笔者常用此方治久病患者之中药毒者，（包括西药中毒，即产生抗药性）必先解其药毒，然后才有疗效。但必需重其剂量，服后肚泻，屙风泡沫涎，带乌黑色，药毒解矣。

桔梗汤方（校补）

桔梗一两甘草二两上二味，以水三升，煮取一升，去渣，温分再服。

【方解及其应用范围】本方即甘草汤内加桔梗，桔梗有宣肺豁痰，排脓消炎的作用，合之以治咽喉痛，为治咽喉痛之祖方。《金匱》用以治肺痈虚证。笔者常用本方治风热为患之咽喉肿痛病者，屡用屡效，但剂量必重，否则无效。

十二、少阴病，咽中痛，半夏散及汤主之。少阴病，咽中伤，生疮①，不能语言，声不出者，苦酒汤主之②。、

①生疮：是指喉部的疮疡，如喉蛾、喉痹等。

②苦酒：就是酸醋。

郑论：按此条皆少阴协火而动，上攻咽喉所致，观所主之方，纯是苦甘之剂，则得此病之实据也。

【阐释】本条前段咽中痛，乃阴寒外束，阳邪郁聚不得伸达，郁而化火，除咽痛之外，应伴有恶寒、气逆、欲呕等证状。后段先言咽中伤，而后言生疮，则因伤而成疮可知，至于不能言语，风痰互结，咽部糜烂而有所阻滞，声乃不出，此证较咽中痛为重。郑氏说：“观所主二方，纯是苦甘之剂，则知此病是少阴协火而动，上攻咽喉所致”。所论极是。

总的来说，咽痛一证，阴证阳证都有，最难辨认。到于少阴咽痛，虽识之而用温里之剂，又多畏而不敢轻投，而温法又各有别，不容概施。如少阴前篇条之咽痛，此为假热真寒证，白通汤加童便之证也。

条之咽痛，此为阴盛于内，隔阳于外，通脉四逆汤证也。至于本篇条之咽痛，为下利伤阴，虚火上亢，与条之咽痛，皆少阴证协火而动之的候，前者治以猪肤汤，后者治以甘草汤，不差者，治以桔梗汤，此皆苦甘化阴之方。条之咽中痛，治以半夏散及汤；咽中伤，生疮，不能语言，声不出者，又当以苦酒汤治之。此亦属少阴协火而动，上攻咽喉所致。以上所述虽同为少阴病之咽痛，而证有轻重，方亦有缓急，其不取寒凉直折一也。笔者师郑氏之意，凡遇此类患者，先以炮姜甘草汤合桔梗汤治之，然后视证之轻重，或用附子理中汤，或用白通汤、通脉四逆汤治之。但少阴肾经之脉，循喉咙，挟舌本，故加补肾药物，疗效更佳。

半夏散及汤方（校补）

半夏（洗）桂枝（去皮）甘草（炙）上三味，等分，各别捣筛已，合治之。白饮和，服方寸匕，日三服。若不能服散者，以水一升，煎七沸，内散两方寸匕，更煮三

沸，下火令小冷，少少咽之。半夏有毒，不当散服。

【方解及其应用范围】本方以半夏开结降痰，桂枝疏风散寒，甘草止痛和中。凡咽痛由于风寒外束而痰多者，宜用本方。其取舍在于是否有表证，否则，纵然阴虚火动，亦不适合。

苦酒汤方（校补）

半夏（洗破如枣核）十四枚鸡子一枚（去黄，内上苦酒，着鸡子壳中）上二味，内半夏苦酒中，以鸡子壳置刀环中，安火上，令三沸，去渣，少少含咽之。不差，更作三剂。

【方解及其应用范围】半夏辛温滑利，以开上焦痰热之结邪；但半夏辛燥，故佐以鸡子清之甘寒，润燥止痛；更以苦酒消肿敛疮。三者相合，可达散结祛痰，消肿止痛的作用。本方应注意“少少含咽之”服法，使药效能持续作用于咽部。今人少有用此方者。

十三、少阴病，四逆，其人或咳、或悸、或小便不利，或腹中痛，或（上轻）〔泄利〕下重者，四逆散主之。

郑论：按少阴病，而至四逆，阳微阴盛也。其中或咳或悸者，水气上干也；小便不利者，阳不化阴也；腹痛下重，阴寒之极也。法宜大剂回阳为是，而此以四逆散主之，吾甚不解。

【阐释】历代诸家注解本条，皆谓本证四逆是由于肝气郁结，阳郁于里，不能通达四肢，所以逆冷。对治以四逆散，亦为之曲解，使其符合条文。郑氏则认为此条乃少阴虚寒证，法宜大剂回阳。根据原文之义，当以郑说为是，笔者从之。

四逆散方（校补）

甘草（炙）枳实（破、水渍、炙干）柴胡芍药上四味，各十分，捣筛，白饮和服方寸匕，日三服。咳者，加五味子、干姜各五分，并主下利。悸者，加桂枝五分。小便不利者，加茯苓五分。腹中痛者，加附子一枚，炮令坼①。泄利下重者，先以水五升，煮薤白三升，煮取三升，去渣，以散三方寸匕，内汤中，煮取一升半，分温再服。

①坼（chè 四声撤）：分裂也。

【方解及其应用范围】本方为宣达郁滞之剂，亦和解之方。用柴胡宣阳解郁使阳气

外达，枳实破滞气，芍药和血，甘草缓中调胃以解郁热。柴胡甘草同用，和中疏郁；枳实芍药同用，通经散结。所治四逆，不属于阴盛阳虚的少阴病范围，而方中并无一味辛热回阳之品可以概见。本方适用于肝郁气滞，肝胃失调所引起之多种疾病。后世乎肝诸方，如局方逍遥散，皆此方化裁。

十四、少阴病，下利六七日，咳而呕渴，心烦不得眠者，猪苓汤主之。

郑论：按此条乃少阴协热下利之的候也。咳而呕者，热上壅也；渴而心烦不得眠者，内热扰攘不安之象也，法宜清润为要。

【阐释】本条为阴虚兼水热互结之证。由于水热互结在里，水渗大肠则利，犯肺则咳，犯胃则呕，津不化则渴，阴虚阳亢则心烦不得眠。亦即郑氏所说：“乃少阴协热下利之的候也。”用猪苓汤育阴清热利水，乃对症之良方。

十五、少阴病，得之二三日，（而）口燥咽干者，急下之，宜大承气汤。

郑论：按少阴病，而用至大承气汤者，以少阴为水脏，宜乎口咽润泽，今见口燥咽干，是少阴协火而旺之的候。火盛则阴亏，恐真阴为火灼尽，而命不永，故宜急下之以存阴。但此证只凭口燥咽干而定为急下，余每常见口燥咽干而不渴，舌尚润滑，小便清长，治之不外扶阳，阳气上升，则口燥咽干自愈。若此证，断为急下，务要察其口咽干而喜饮冷，气粗而蒸手，小便短赤痛，脉健有力，方可以主急下法，否则，断乎不可。

【阐释】自此以下三节，皆言急下。少阴协火之证，口燥咽干外，必有阳明胃实诸证兼见，如喜冷恶热，气粗蒸手，小便短赤而痛，脉健有力，方可主以急下。若口燥咽干而不渴，舌尚润滑，小便清长，不能急下，治之不外扶阳。急下与扶阳两法，不可混淆，若见证是少阴挟火之证，复转阳明，方可用大承气汤急下之。口燥咽干而不见阳明胃实诸证兼见，笔者治此证，先用甘草干姜汤加桔梗治之，如服后无不良反映，则继用附子理中汤以扶阳，阳气上升，则口燥咽干自愈。

十六、少阴病，自利清水，色纯青，心下必痛，口干燥者，急下之，宜大承气汤。

郑论：按少阴下利清水，青色，似乎虚寒，不知邪火入于少阴，火动于中，水液不藏，不待转枢，随气机而下泄，兼见心痛，口干燥者，邪火伤阴之明验也。若不急为下之，火盛阴亏，便非佳兆。若此等证。务要细心，不可猛浪，总要求其真实火象，便不错误。

【阐释】少阴下利，多稀薄清冷，或下利清谷，治宜急温。本条自利清水，所下皆青黑色污水，且有心下痛，口干燥，郑氏指为“邪火伤阴之明验也”。失此不治，

真阴将随之消亡，故用大承气汤急下存阴，实《内经》通因通用之法。

十七、少阴病，六七日，腹胀不大便者，急下之，宜大承气汤。

郑论：按腹胀不大便，亦有寒热之别，寒结于下，闭其大便运行之机，为之寒闭，法宜大辛大温，俾寒解气通，自然胀者不胀，而不便者便矣。若热闭下焦，阻其运行之机而作者，法宜急下，此不易之法。大约此证，是为热结少阴者说法也。

【阐释】此条亦见于本书卷六阳明下篇七条，可互相参看。郑氏说：“腹胀不大便，有寒热之别。”宜急下者，为热闭下焦，阻其运行之机。若寒闭者，法宜大辛大温，俾寒解气通，则诸证自愈。临证时务须全面分析，始不有误。

伤寒恒论卷十

厥阴上篇

计二十一法①

①舒本厥阴篇不分上、中、下三篇，厥阴篇下有“计四十八法”一句，为照应前体例，厥阴上篇下加“计二十一法”一句。以下厥阴中篇加“计十七法”一句。厥阴下篇加“计十法”一句。

一、厥阴之为病，消渴②，气上撞心，心中疼热，饥而不欲食，食则吐蛔③，下之利不止。

②消渴：指饮水多而渴仍不解。

③食则吐蛔：进食后呕吐蛔虫。

郑论：按此乃厥阴寒热错杂之候也。消渴者，热伤津液也；撞心者，热邪上干也；饥不欲食，食则吐蛔者，里有寒也，吐蛔者，寒甚，则虫不安而外出也；下之利不止者，既属虚寒，何得以降之、利之乎？明是教人不可妄下也。

【阐释】过去很多注解伤寒论者，认为此条是厥阴病的提纲，其实非也。

仅是厥阴病上热下寒之证，亦即郑氏所说：“寒热错杂之候也”。如消渴、气上撞心，心中疼热，就是上热证状；饥而不欲食，食则吐蛔，下之利不止，就是下寒证状。并不包括本篇厥热胜复，寒厥热厥等全部疾病，所以不能称为厥阴病的提纲。

二、厥阴中风，脉微浮（者）为欲愈，不浮（者）为未愈。

郑论：按厥阴为阴脏，阴病而见浮脉，是阴病得阳脉者生，不得阳脉者，为未愈也。

【阐释】阴病脉不当浮，今厥阴中风脉反浮者，以厥阴与少阳为表里，若得少阳冲和之气，病势有从阴出阳之机者，脉必微浮。亦即郑氏所说：“阴病得阳脉者生，不得阳脉者为未愈也。”

三、厥阴病，欲解时，从丑至卯上。

郑论：按六经各有旺时，邪退邪进，可于旺时决之。

【阐释】六经皆有欲解时一条。据厥阴篇：“厥少热多，其病当愈；寒多热少，其病为进；热不除便脓血者不必死；下利厥不止者必死。”则本条所谓欲解，其为寒尽阳回之证。亦即郑氏所说：“邪退邪进，可于旺时决之”之意。从时间来说，当在夜间一时至早晨五时之间。

四、厥阴病，渴欲饮水者，少少与之，愈。

郑论：按此乃厥阴挟有微热也。学者于此，当细求阴阳实据为要。

【阐释】本条是厥阴病邪退阳复的渴欲饮水，因阳气乍复，津液一时不及上承，因而口渴。即郑氏所说：“乃厥阴挟有微热也”，故少少与饮，以资助其津液，则病可自愈。

五、诸四逆厥者，不可下之，虚家亦然。凡厥者，阴阳气不相顺接，便为厥。厥者，手足逆冷者是也。

郑论：按厥证原有阳厥阴厥之别，阳厥可下，阴厥不可下，此乃一定之理。

【阐释】本条前段指出虚寒性厥逆不可下，即凡属虚家而不厥逆者亦不可下，法当扶阳治之。后段并赅寒热二厥在内，致厥的原因，皆因阴阳气不相顺接所形成，证见手足逆冷。寒厥者，寒盛至极，则阴气独胜，而阳气相对衰微，不能通达于四肢，故手足发生厥冷，因成寒厥。相反的热盛至极，则阳气被遏，亦不能通达于四肢，因成热厥。寒厥热厥，同样是四肢厥冷，病因病理却截然不同，故治法亦异。郑氏曰：“阳厥可下，阴厥不可下，此乃一定之理”。指出治疗法则，可为准绳。

六、伤寒脉迟，六七日，而反与黄芩汤彻其热①，脉迟为寒，今与黄芩汤，复除其热，〔腹中应冷〕，当不能食，今反能食，此名除中②，必死，原文

①彻：除也，此处含有治疗意思。

②除中：病名，指胃气将绝时的一种反常见证。

郑论：按迟则为寒，其理明甚，而反与黄芩汤，是失其治也。失其治，病人应不能食，乃其常，今反能食，是反其常，反其常者死，此名为除中。除中者，胃阳暴露，如灯光之火，欲灭而骤明，转瞬即灭也。

【阐释】伤寒脉迟，脉迟属阴主寒，胃必虚冷也。设遇此虚冷之脉证，当用理中汤以温之，今反用黄芩汤以消其胃中仅存之阳气，病人应不能食，反能食者，此名除中。郑氏释除中谓：“胃阳暴露，如灯火之光，欲灭而复明，转瞬即灭也”，形象

生动。俗称之回光反照，必死无疑。

七、伤寒〔始〕发热六日，厥反九日而利，凡厥利者①，当不能食，今反能食者，恐为除中，食以（素）〔索〕饼②，不发热者，知胃气尚在，必愈。恐暴热来〔出〕而复去也，后（三）日脉之③，其热续在者，期（以）〔之〕旦日夜半愈④，所以然者，（未）〔本〕发热六日，厥反九日，复发热三日，并前六日，亦为九日，与厥相应，故期之旦日夜半愈。后三日脉之，〔而脉〕数，其热不（减）〔罢〕者，此为热气有余，必发痈脓也。

①厥利：是指手足厥冷而又患腹泻。

②食（sì 饲）以索饼：即拿东西给人吃。索饼，是以面粉做成的条状食物。

③脉之：即诊察的意思。

④旦日夜半：是第二天的半夜。

郑论：按厥与利，皆在不能食之例，今反能食，近似除中，当在发热与不发热两字判之。若尚能发热，则知胃气尚存，但不可暴〔出〕也。暴是脱机，微是生机，苟无发热，则除中决矣。期之半夜愈者，就在这一点微热决之耳。至必发痈脓，胃阳有余，遏郁太甚也。又云：以（素）〔索〕饼不发热，既不发热，胃气已去，尚得云知胃气尚存乎？不字定是微字，方与论合。

【阐释】本条文长义繁，总的来说，言厥与热日数相较是相当的，其病能自愈。若厥多于热则病利；热多于厥则发痈脓；厥利并见，当不能食，反能食者恐为除中。是否除中，可与索饼食之。郑氏曰：“若尚能发热，则知胃气尚存；不发热则胃气已去，尚得云知胃气尚存乎？不字定是微字，方与论合”。此郑氏订正原文之功矣。

八、伤寒先厥后发热，（而）〔下〕利（者）必自止，而反汗出，咽中痛者，其喉为痹⑤。发热无汗，而利必自止；若不止，必便脓血（者），〔便脓血者〕，其喉不痹。

⑤其喉为痹：是指喉部痛而红肿的疾患。

郑论：按厥后发热而利，发热乃阳回之征，故可决其必自止。但利止而反汗出，咽疼为喉痹，是厥阴挟风邪而上攻，若利不止，必便脓血，是热邪下攻故也。利止与不止间，上攻下攻之病，不问自明也。

【阐释】本条先厥后热，是阳进阴退之征，利必自止。如阳复太过，在上则为喉痹，在下则便脓血。治喉痹可用桔梗汤，便脓血可用白头翁汤。至便脓血，为热邪下利，而不复上病咽痛也。

九、伤寒（二三）〔一二〕日至四五者，（而）厥者必发热，前热者后必厥，（热）〔厥〕深者（厥）〔热〕亦深，（热）〔厥〕微者（厥）〔热〕亦微。〔厥〕应下之，而反发汗者，必口伤烂赤①。

①口伤烂赤：口舌生疮，红肿糜烂。

郑论：按热深厥深，是为阳亢热伏者说法，本宜破阳扶阴为主，其中有反发汗，以致口糜烂赤者。凡发药皆上升之品，邪火得升而上浮，焉得不有此口糜赤烂之患耶？

【阐释】热厥形成的机转，主要是热邪深伏，阳气内郁不能外达，即是郑氏所说：“是为阳亢热伏者说法”，法当破阳扶阴，选用承气汤下热存阴，自不可发汗，如误汗之，劫夺其津，热邪更炽，邪热上干，就可产生口舌生疮，红肿糜烂。

十、伤寒病，厥五日，热亦五日，设六日，当复厥，不厥者，自愈。厥终不过五日，以热五日，故知自愈。

郑论：按热与厥，俱属五日，乃阴阳平应之候，故断之曰必自愈。

【阐释】阴阳偏盛则病作，阴阳和平则病愈，一切疾病之由来皆如此。厥阴病的病势进退生死之机，亦不外此理。故热与厥日数相等，亦即郑氏所说：“乃阴阳平应之候”，故知自愈也。

十一、伤寒脉微而厥，至七八日（胃）〔肤〕冷，其人烦（燥）〔躁〕无暂安时者，此为藏厥②，非蛔厥也③。蛔厥者，其人当吐蛔，（今）〔令〕病者静，而复时烦〔者〕，此为藏寒

①，蛔上入〔其〕膈，故烦，须臾复止，得食而呕，又烦者（虫）〔蛔〕闻食臭（而）出，其人当自吐蛔，蛔厥者，乌梅丸主之，又主久痢。

②藏厥：是指内藏真阳极虚而引起的四肢厥冷。

③蛔厥：是因蛔虫而引起的四肢厥冷。

①藏寒：是指内脏虚寒而言。这里所说的藏寒，可以作胃气虚寒来解释。

郑论：按既称脉微而厥，（胃）〔肤〕冷为之脏寒，即按脏寒法治之，何必另为咨议？又曰蛔厥，蛔乃厥阴风〔木〕所化，胃冷虫必不安，胃热虫亦不安，胃不得食，虫亦不安，如此推求，便得治虫之法也。条内并未有热象足征，不得为之寒热错杂。其主久痢，是亦寒泄之谓，乌梅丸，皆非正论。

【阐释】本条前段自“伤寒脉微而厥”至“此为藏厥，非蛔厥也”，为藏寒发厥，病情已属危候，急用四逆、白通救之。蛔厥有吐蛔证，其烦是时作时止，不是烦躁无暂安时，其厥是肢厥而非肤冷，原文乌梅丸主之，又主久痢。郑氏认为治以乌梅丸，皆非正论。笔者对治蛔证，常用乌梅丸改作汤剂而获效。夫久痢多属虚寒滑脱，法当温补收涩，常用附子理中汤加栗壳治之。

乌梅丸方（校补）

乌梅三百枚细辛六两干姜十两黄连十六两当归四两附子六两（炮去皮）蜀椒四两（出汗）桂枝六两（去皮）人参六两黄柏六两上十味，异捣筛，合治之，以苦酒渍乌梅一宿，去核，蒸之五斗米下，饭熟，捣成泥，和药令相得，内臼中，与蜜杵二千下，丸如梧桐子大，先食，饮服十丸，日三服，稍加至二十丸，禁生冷、滑物、臭食等。

【方解及其应用范围】本方寒热并用，攻补兼施之剂，能益胃安蛔。方中乌梅为主药，有酸涩的作用，配川椒以杀虫；虫得苦则安，所以用黄连、黄柏；而附子、干姜、细辛、桂枝，温中散寒；人参补脾；当归补肝；合成一个温中祛寒，杀虫平厥的方剂，治蛔厥有良好效果。郑氏谓：“厥阴为阴经，阴极则生阳，故多寒热错杂。……仲景立乌梅丸，寒热并投，并非专为虫立法，凡厥阴一切症候，莫不备具。”向为治蛔厥及久痢之首选方，应用确较广泛。郑氏在《医法圆通》中，用以治巅顶痛、腹痛饮冷、睾丸肿痛。笔者以此方治病，无分新久，改丸为汤剂，功效显著。今人以乌梅丸加减治胆道蛔虫及多种肠道病，屡获良效。更有人认为凡寒热错杂之症，本方均可施治，足见其应用之广泛了。

十二、伤寒热少微厥^①，指头寒，默默不欲食，烦躁，数日小便利，色白者，此热除也。欲得食，其病为愈。若厥而呕，胸胁烦满者，其后必便血。

①微厥：谓厥逆很轻微。

郑论：按热少厥微，是阳厥之最轻者也。至于默默不欲食，烦躁，至小便白色，此时内无热邪可征，故曰热除。欲得食，是胃气渐复之机，故为欲愈。倘呕而胸胁烦满，此中宫不宣，胃气滞塞，断为便血者，是因其气机之滞而决之也。

【阐释】伤寒热少厥微为热厥轻证，故仅见指头寒；阳热内郁不甚，故默默不欲食

；郁极求伸，故见烦躁。数日后小便通畅色白者，此热邪已除，欲进食者乃胃气已和，此病为欲愈。若厥复见，其热不解，上逆而呕，且有胸胁烦满之证，是热又深入，伤及阴络，必便血矣。仲景对此未提治法，柯韵伯谓：“微热者可用小柴胡汤，热深者用大柴胡汤”。笔者认为此二方可供临证选用。

十三、伤寒发热四日，厥反三日，复热四日，厥少热多〔者〕，其病当愈；四日至七日，热不除者，（其后）必便脓血。

郑论：按热多厥少，是阳有余，特患者热不除耳，热除自愈。热不除者，阳胜血亏，即有逼血下行之事，故断之曰便脓血。至寒多热少者，阴有余，阳必亏，其病为进者，即小人道长，君子道消之意也，知此可与论药论方也。

【阐释】此条从厥和热的多少来观察病变，这和前面十条是一致的。厥少热多是身体抗病力战胜病变的象征，所以当主病愈。若热仍不止，则热郁于阴，即郑氏所说：“阳胜于阴，即有逼血下行之势”，其后必便脓血。至寒多热少，则为阴盛阳衰，衰极则有亡阳之虞。至于治法，阳胜宜下，阴盛宜温。

十四、伤寒六七日，脉微，手足厥冷，烦（燥）〔躁〕，灸厥阴②，厥不还者，死。

②灸厥阴：灸厥阴经的孔穴。据张令韶的意思，可灸厥阴经的行间和章门穴。

郑论：按脉微而厥，乃阳衰阴盛之征，迨至烦躁，上下有不交之势，灸厥阴，原正所以扶阳御阴也。阳回即是生机，不还即是死机，不易之理也。

【阐释】自此以下三节，皆言阴中亡阳之死证也。本节是厥阴脏厥之重证，内外皆寒，一派阴霾之象，故急用灸法以回其阳。灸宜关元、气海即丹田穴；并可内服大剂四逆汤等一类方剂，以救欲脱的阳气，当能增加疗效。如手足逆冷，过时不还，是阳已亡，故死。

十五、伤寒发热，下利厥逆，躁不得卧者，死。

郑论：按发热下利，乃阴阳欲脱之征，何也？发热者，阳竭于上也；下利者，阴竭于下也。其人苟未见厥逆、躁，尚未得以脱论，此以断为脱者，正于厥、躁论之也。

【阐释】此条内真寒而外假热的危候。伤寒发热，若属阳回，下利当自止，手足当温。今虽见发热，下利厥逆依然，可知此非阳回之热，乃阴盛于内，格阳于外，更加躁不得卧，亦即郑氏所说：“阴阳欲脱之征”。急与大剂通脉四逆汤，或可救危。

亡于万一。

十六、伤寒发热，下利至甚，厥不止者，死。

郑论：按发热下利至甚，将脱之兆，况加以厥而不回，乌得不死。

【阐释】此条乃阴阳离绝之危候，与上条同一病理。虽无躁不得卧之证状，但不利言至甚，厥逆言不止，其厥利程度，较上条严重，发热亦属虚阳外浮。遇此危候，当用大剂四逆、白通温经止泄以回其厥。若厥回可生，不回则死。

十七、发热而厥，（不）〔七日〕下利者，为难治。

郑论：按发热而厥，乃阳厥之征，务要察其人果现有热象可凭，即照阳厥法治之。至七日内下利，是邪盘据不欲下趋，热与厥不退，故曰难治。若下之而利，热退厥回，即是生机；下之而不利，厥不回，方为难治。

【阐释】本条与上十五、十六两条同为阴寒内盛，阳气外浮而呈现的厥利。

本条虽同是真寒假热证，但无上述两条严重，所以不言主死，而云难治。然难治非不治之谓，更非代表死候，可选用大剂白通，四逆等汤治之，可救危亡。

十八、伤寒六七日不利，便发热而利①，其人汗出不止者，死，有阴无阳故也②。

①便：作忽然解。

②有阴无阳：下利是阴证，汗出不止是亡阳，故称有阴无阳。

郑论：按六七日不利，至发热而利，里已通矣，里通表畅，发热亦是病解之机。但其人汗出不止为可虑，可虑者，汗出亡阳，不止，是阳无所附，脱离即在转瞬，不死何待？

【阐释】郑氏谓“汗出亡阳”，此即辨证大眼目。汗出不止，是阴盛于内，阳浮于外，是谓有阴无阳，故死。

十九、病（人）〔者〕手足厥冷，言我不结胸，小腹满，按之痛者，此冷结在膀胱关元也③。

③膀胱关元：关元为任脉经穴，在脐下三寸。治脐下痛，灸之良。膀胱关元，是指病的部位在脐下。

郑论：按四肢厥，而无热形可征，则为阴盛无疑，寒结于下，未在中上，故不结胸，而独在小腹，故痛亦在小腹也。

【阐释】此种证状，经常见之。笔者常用大剂回阳之方，如四逆、白通之类，加肉桂、小茴以治之；外则用肉桂、小茴、花椒、橘叶以熨痛处。屡用屡效者。

二十、伤寒五六日，不结胸，腹濡④，脉虚复厥者(一)，不可下，此亡血⑤，下之死。

④腹濡：腹部按之柔软。

⑤亡血：指血分不足。

(一)腹濡脉虚复厥，，明明阴盛阳微，下之则微阳立消，乌得不死？（顶批）

郑论：按脉微而厥，明明阴盛，而非阳盛也。阳盛始能伤血，血伤故不可下，今所见者，阳虚的候，非阴虚的候，何所见而为亡血乎？余甚不解。

【阐释】阳盛始能伤血，血伤始见亡血之证，今所见者为阳虚的候，非阴虚的候，故郑氏曰：“何所见而为亡血乎？余甚不解。”此血虚致厥，下之安得不死！

二十一、手足厥寒，脉细欲绝者①，当归四逆汤主之。若其人内有久寒者，宜当归四逆加吴茱萸生姜汤主之。

①脉细：指其脉体细如丝状。

郑论：按四肢厥，而脉细微欲绝，阴盛阳虚之明验也。此际正宜大剂回阳，兹以当归四逆汤主之，决非确论，余不敢从。

【阐释】本条郑氏认为系“阴盛阳虚之明验，正宜大剂回阳，以当归四逆汤主之，决非确论。”但历代注家谓手足厥冷，既不同于阳微阴盛的四逆汤证；亦不同于热深厥深的白虎汤证；更不是阳气郁遏于里，不能透达的四逆散证。而是血虚寒郁，不能荣于脉中，而四肢失于温养，所以手足厥寒。本方不用姜附回阳而亦以四逆名汤者，正像四逆散一样，以其能治四肢逆冷之故。故郑氏所说：“决非确论”是当深思的。

当归四逆汤（校补）

当归三两桂枝三两（去皮）芍药三两细辛三两甘草二两（炙）通草二两②大枣二十

五枚（擘），一法十二枚上七味，以水八升，煮取三升，去渣，温服一升，日三服。

当归四逆加吴茱萸生姜汤方（校补）

即前方加生姜半斤（切）吴茱萸二升上九味，以水六升，清酒六升和，煮取五升，去渣，温分五服。

②通草：本方通草即现今木通。

【方解及其应用范围】本方即桂枝汤去生姜，倍用大枣，加当归、细辛、木通而成。桂枝汤本调和营卫之方，但本证属血虚寒凝，故用当归补心血为君药，芍药收心气，大枣、甘草、木通缓肝急，生肝血，桂枝、细辛温阳散寒。合之则治血虚寒滞，阳气虚衰，脉行不利之证，是温血散寒，补血助阳之剂。若其人内有久寒者，宜当归四逆加吴茱萸生姜汤治之。吴茱萸辛温以散久寒，生姜辛温以行阳气，再以清酒和之，以助药之行，则阴阳调和，手足自温。关于本方应用范围，《伤寒论》原文所载主治“手足厥寒，脉细欲绝者”。其病机在于血虚寒滞。由于血被寒邪凝滞之程度和部位不同，则临床见证各异，一切阴寒凝结之血虚气滞，皆可用本方温而通之以取效。如一身痛、四肢关节痛、腰痛、腿痛、胸痛、巅顶头痛、虚寒下痢，妇女经期痛、行经时四肢麻木抽搐、手足厥寒、小儿麻痹症，以及脱疽（栓塞性脉管炎）等，皆可用本方治疗而获效。笔者曾治胡某二十余年之腰腿关节疼痛，其症状为痛有定处，下肢冷，遇寒痛增，似觉骨痛，麻木、拘挛，沉重，伸缩行动困难，须靠搀扶方能移步。经当地医院诊断为风湿性关节炎，但治之无效。其面容黯黑，舌质微乌，苔灰白而腻，脉微细，参之以上述证状，此为血虚气滞，寒邪内搏所致。法当养血通络，温经散寒，以当归四逆汤加味治之，连续服二十剂而痊愈。

厥阴中篇

计十七法

一、大汗出，热不去，内拘急①，四肢疼，又下利厥逆而恶寒者，四逆汤主之。

①内拘急：腹中挛急，动不自如。

郑论：按汗出热不去，非外感之热，乃元阳外出之热也。汗过甚，血液亏，不能营养筋脉，故内拘急，而四肢疼，况又下利而厥，此刻阳虚已极，大有欲脱之机，非大剂四逆，何能挽回？

【阐释】本条是真寒假热之证。大汗出是阳亡于外，四肢疼，下利厥逆是寒盛于里

。均是阴盛阳亡之证，故应以四逆汤急救回阳。诚如郑氏所说：“此刻阳虚已极，大有欲脱之机，非大剂四逆，何能挽回”？

二、大汗，若大下利，而厥冷者，四逆汤主之。

郑论：按大汗、大下利而厥冷，皆阴阳两脱之候，理应大剂四逆回阳，千古定论。

【阐释】大汗大下，均能伤阳，其亡津液，损阳气一也，而致手足逆冷，阴阳两脱之候也。郑氏所说：“理应大剂四逆回阳，千古定论”为不谬。

三、伤寒脉促，手足厥逆，可灸之。

郑论：按脉促、厥逆，系阴寒阻滞之征，灸之是祛阴散寒之意；理实可从，不易之论也。

【阐释】手足厥逆，本当用四逆汤。因脉促当属阳为阴阻，而非阳虚也，故可用灸法以运行阳气。当灸“涌泉”，引血下趋，脏复而心力强，阳可不致外越。若厥而脉微者，则非用四逆汤不可。

四、伤寒脉滑而厥者，里有热（也），白虎汤主之。

郑论：按滑脉主痰，滑而厥，诚湿痰闭束气机，不能达于四肢也。此以为里有热，而用白虎汤，果何所见也？当其时，口燥舌干欬？气粗口渴饮冷欬？不然，何所见而必用此方，学者不可执一，总要四面搜求里热实据，庶不致误。

【阐释】厥有阳厥阴厥之别，阳厥必有汗出恶热，烦渴等证，知其厥为热深厥亦深之假像。但此仅无形之热，宜清而不宜下，故用白虎汤以清里热，里热除则厥逆自解。郑氏说：“总要四面搜求里热实据，庶不致误”，乃经验之谈，可为后学之助。

五、病人手足厥冷，脉乍紧者，邪结在胸中，心下满而烦，而不能食者，病在胸中，当须吐之，宜瓜蒂散①。

①此条与卷七少阴痰证之第三条完全相同，录之以存原书全貌。但郑氏所论与前论不同，故以下照录，亦就郑论：作出相应阐释。

郑论：按手足厥冷，乃寒结于胸，阳气不能达于四末也。胸满而不能食，中宫为寒所阻滞，运力微耳。主瓜蒂散以吐之，是为邪壅于上说法也。但此证乃寒邪阻滞，吐之能不更伤其中乎？以余拙见，理应大剂温中醒脾为是。

【阐释】郑氏谓：“此证乃寒邪阻滞，吐之能不更伤其中乎”？实则本条为痰饮食积壅塞胸中而厥冷，病在上焦，而中下焦无病，用瓜蒂散涌吐其胸中之邪，就是内经所谓：“其高者因而越之”的治疗法则。笔者认为邪去正虚，然后以理中汤调养之。

六、伤寒厥而心下悸（者），宜先治水，当（用）〔服〕茯苓甘草汤，却治其厥；不尔，水渍入胃②，必作利也。

②水渍入胃：饮水渗入胃肠系水邪阻遏胸中之阳所致。茯苓甘草汤为治水饮之方，其证有心下悸，较五苓散证为轻。郑氏认为此方力薄，恐不能胜任，主用苓桂朮甘汤重加附子。笔者认为再加上肉桂以化膀胱之气，其效果更好。

郑论：按厥而心下悸者，寒水凌于心下也，此以茯苓甘草汤，与理颇是，但其力薄，恐不胜任，莫若用苓桂朮甘汤，重加附子为妥。

【阐释】水饮停蓄心下则悸，胸阳被遏而不达四末则厥。本条悸、厥之证，

七、伤寒六七日，大下后，寸脉沉而迟，手足厥（冷）〔逆〕，下部脉不至①，咽喉不利②，唾脓血，泄利不止者，为难治，麻黄升麻汤主之。

①下部脉：指尺脉而言。

②咽喉不利：咽喉疼痛，吞咽困难的意思。

郑论：按经大下脉迟，手足厥冷，下部脉不至，其阳虚之极已明甚。至咽喉不利，气化不宣也。吐脓血者，浊阴不降也。泄利不止者，下焦虚寒，不能收束也。法宜大剂回阳，阳回利止；手足温，斯为合法。所主麻黄升麻汤，系太阳阳明发散之药，并非厥阴所宜，大非其法，恐有错误。

【阐释】对于本条，历代注家如柯韵伯、舒驰远等均持否定态度。郑氏认为此证“阳虚之极已明甚，法宜大剂回阳，阳回利止，手足温，方为合法。”是有见地的。笔者认为此条方证不相符，原文后云“难治”，论中凡言难治，仲景多不出方，“麻黄升麻汤主之”一句，当系衍文。

麻黄升麻汤方（校补）

麻黄二两半（去节）升麻一两一分当归一两一分知母十八铢黄芩十八铢萎蕤十八铢（一作菖蒲）芍药六铢天门冬六铢（去心）桂枝六铢（去皮）茯苓六铢甘草六铢（炙）白朮六铢干姜六铢石膏六铢（碎绵裹）上十四味，以水一斗，先煮麻黄一两沸

，去上沫，内诸药，煮取三升，去渣，分温三服，相去如炊三斗米顷，令尽，汗出愈。

【方解及其应用范围】邪深入而阳内陷，故以麻黄升麻配伍可以升举下陷之寒湿而外散之；当归以补血；黄芩以清胆火；知母石膏以清胃热，所以止吐脓血也；萎蕤天冬以润肺，所以利咽喉不利也；白朮干姜芍药桂枝茯苓甘草，所以解水分之寒湿，增营分之热，而通利血脉也，但令水寒去而营热增，手足之厥冷自解矣。此方药味较多，方组复杂，而本条是阴阳两竭的证候，方证不符，故录之以俟高明。

八、伤寒四五日，腹中痛，若转气下趋少腹者，此欲自利也。

郑论：按少阴腹痛者，寒也。其气下趋为欲自利，此刻尚未下也，急宜温之，庶可无害。

【阐释】郑氏曰：“此刻尚未下也，宜急温之”。凡里阳虚阴寒盛，水谷之气不能正常运行，腹中痛，急欲作自利。笔者常用大剂四逆汤加延胡索治之，图功于未着也。

九、伤寒本自寒下，医复吐下之，寒（隔）〔格〕①，更逆吐下，若食入〔口〕即吐，干姜黄连黄芩人参汤主之。

①寒格：指上热为下寒所格，致饮食入口即吐，故称寒格。

郑论：按病既称寒下，又经医误下吐之，寒逆更甚，食入即吐，则中宫之气逆而又逆，寒而愈寒也明甚。此刻理应温中、降逆、回阳。主以干姜黄连黄芩人参汤，似非正论。况此证又无寒热错杂病情足征，何得以此方为主，恐有遗误。

【阐释】其人本自寒下，又误用寒药，条中又无热证，纯阴无阳，且又指之曰寒格。若食入口即吐，是阴寒格阳，拒食不纳，如此病情，应如郑氏所说：“温中、降逆、回阳，原文主以干姜黄连黄芩人参汤，似非正论”。然则如何治之，笔者认为可选用理中汤加附子、半夏，稍加黄连清胃热可也。

干姜黄连黄芩人参汤方（校补）

干姜、黄连、黄芩、人参各三两上四味，以水六升，煮取二升，去渣，分温再服。

【方解及其应用范围】黄连黄芩泄热于上，则吐逆可除；干姜温中助阳，则下利可止；人参以补胃气。则阴阳升降复常，而寒热格拒自愈。药虽四味，有温清并用，补泄兼施之功。对上热下寒、上下格拒，食入即吐之胃肠炎治之有效。

十、下利，脉沉而迟，其人面少赤，身有微热，下利清谷者，必郁冒汗出而解②，病人必微厥，所以然者，其面戴阳①，下虚故也②。

②郁冒：指眩冒昏晕，一时眼发暗黑，看不到东西。

①戴阳：面部潮红，乃寒盛于下，虚阳上浮的假热现象。

②下虚：下焦虚寒，指微厥的原因。

郑论：按下利清谷，脉现沉迟，其里寒甚矣。况面戴赤，身有微热，诚元阳外越之候也。以为郁冒汗出解，脉证不孚，大非确论。此证所幸者未出汗，阳尚在躯壳，可招而回，今既汗出，则阳露于外，诚死机也。既知面赤下虚，何得妄云〔汗出而解〕？仲景当不说此。

【阐释】郑氏说：“原文以为郁冒汗出而解，脉证不孚，大非确论”。盖肾阳发露，则面赤而为戴阳。戴阳证为里阴盛而隔阳于上也。此时微阳仅存一线，最忌汗出，汗出而阳散矣，何得谓汗出而解也。诚不若于汗未出之际，急以通脉四逆汤挽之。

十一、下利清谷，里寒外热，汗出而厥者，通脉四逆汤主之。

郑论：按下利清谷，里寒外热，汗出而厥，此阴盛逼阳于外之候，主以通脉四逆，诚不易之法也。

【阐释】下利清谷，是阴寒内盛；汗出而厥，是真阳外竭。此阴盛逼阳于外，虚阳欲脱的危症。与少阴前篇条的主要证状相同，所不同的，此为汗出，彼为面色赤，但总是虚阳欲脱的现象，所以都用通脉四逆汤。

十二、下利（而）手足厥冷，无脉者，灸之不温，若脉不还，反微喘者，死。前段

郑论：按下利厥冷无脉，阳将尽也，灸之而温，阳回也。灸之不温，反见微喘者，阳将脱也，不死何待？

【阐释】此条乃阳气衰微欲绝，阴寒邪气充斥内外，病情已十分危急，当此时机，用汤药来挽救其阳，恐怕是缓不济急，所以用灸法急救，可灸关元、气海二穴。除用灸法以外，亦可用白通加猪胆汁以回阳救急。

十三、下利后脉绝，手足厥冷，晬频率还③，手足温者生，脉不还者死。

③晬（zuì 罪）时：一昼夜时间。

郑论：按脉绝，手足厥冷，有频率还，手足温，阳尚未亡也；若脉不还，阳已尽矣，故知其必死。

【阐释】此条乃寒中厥阴的泄泻，非久利也。惟暴注下利，津液骤然大泄，阳气乍脱，故手足厥冷，脉一时隐伏不见。如此危证，非大剂四逆汤不可。并可外灸关元、气海穴，以救欲绝之阳。

十四、下利，腹胀满，身体疼痛者，先温其里，乃攻其表，温里宜四逆汤，攻表宜桂枝汤。

郑论：按下利，腹胀满，纯是阳衰，而阴气上逆聚于中耳。身体疼痛，乃阴邪阻滞筋脉所致，并非外感身疼可比。外感者，必有风寒病形足征，若此故知其为阴寒阻滞无疑，法宜温里，里寒得温，胀满与身疼，亦自灭亡。以先温其里，后攻其表，温里以四逆汤，实属合法，攻表以桂枝汤，殊非正论，学者宜细察之。

【阐释】本条乃虚寒下利兼有表证的治法。郑氏则解“身体疼痛乃阴邪阻滞筋脉所致，并非外感身疼可比，……攻表以桂枝汤，殊非正论”，是有见地的。

但服四逆汤后，如下利止，胀满除，而身体仍然疼痛，并有头痛、项强、脉浮等表证，则桂枝汤又为对证之方。

十五、下利清谷，不可攻表，汗出必胀满。

郑论：按下利清谷，里寒之极也，原文不可攻表，此是正论。

攻之必汗出胀满，是教人不可妄攻也。攻之岂仅汗出胀满可患哉？

【阐释】下利清谷是完谷不化，胃肠虚寒，里虚之征，纵有表证，不可误汗，严重者可虚脱，故郑氏说：“攻之岂仅汗出胀满可患哉？”故一切腹痛呕泄诸证，严戒不可发汗。

十六、伤寒下利，日十余行，脉反实者①，死。

①脉反实：实脉是长大而有力，多见于大热大实的证候，虚证而见脉实，所以说反。

郑论：按下利之脉，大半微细，今见脉实，是脉不合病，邪甚正虚，恐难获效，故

决其死也。

【阐释】下利日十余行，正气甚虚，脉当沉微弱，今脉反实，是邪实，脉证不符，攻之不行，温之则生燥，故决其死也。

十七、下利有，微热而渴，脉弱者，（令）〔今〕自愈。下利，脉数而渴者，（令）〔今〕自愈，设不差，必圉脓血，以有热故也。下利脉数，〔而〕有微热，汗出，（令）〔今〕自愈，设复紧为未解。、、

郑论：按下利一证，以脉象求之，脉弱而渴，里有寒也，寒邪下泄，而津液不上潮，故口渴，有微热者，是阴症而得阳也，故曰自愈。脉数而渴，里有热也，热邪下行，热伤津液，故口渴，邪脉相合，故曰自愈；设不差，而圉脓血，是余热未尽故也。至于下利脉数，有微热汗出，是气机鼓动，有上升之机，故不利可自愈；设脉紧，紧为寒邪，寒伏于内，故为未解。

【阐释】本条在伤寒论中分列为三条。第一节从“下利有微热而渴”至“今自愈”，指阴盛下利将愈的脉证；第二节从“下利”至“有热故也”，指阳复自愈与阳复太过之便脓血证；第三节从“下利脉数”至“为未解”，指阴盛下利将愈的脉证及未解的脉象。郑氏对此，详为注释，简明扼要，故不赘述。

厥阴下篇

计十法

一、下利，寸脉反浮数，尺中（有）〔自〕涩者，必清脓血。

郑论：按寸为阳，尺为阴，寸见浮数，阳邪之征，尺见（浮）〔自〕涩，血虚之验。清脓血者，邪气太盛，逼血下行耳。

【阐释】厥阴下利本属虚寒，今脉反见浮数，是阴病转阳的脉象。本条阳复太过，由于邪无出路，热不得泄，以致内伤阴络，血为热蒸，腐化为脓，故大便脓血，亦即郑氏所说：“清脓血者，邪气太盛，逼血下行耳”。

二、下利，脉沉弦者，下重也①；脉大者，为未止；脉微弱数者，为欲自止，虽发热，不死。

①下重：指肛门有重滞之感。

郑论：按下利一证，原有因寒、因热、因湿、因膀胱失职、因中虚、因饮食、种种

不一，总要认证分别阴阳实据，学者一见，自有定法，若只见一脉而论证，未免不恰。况脉只数十端，而病有千万，何得只凭脉一端立法？仲景当不若此，定有遗误。

【阐释】下利一证，应如郑氏所说：“总要认证分别阴阳实据”，对证用药，无不立应。但仅凭一脉立说，玄渺难凭，不足为法。

三、热利下重者，白头翁汤主之。

郑论：按下利而曰热，法宜清热，不独白头翁汤可治，学者总宜圆通，认理为要。

【阐释】下利而有各种热性证状的，称为热利，有别于寒利。下重则邪滞下焦，不独白头翁汤可治，应如郑氏说“总宜圆通，认理为要。”

白头翁汤（校补）

白头翁二两黄柏三两黄连三两秦皮三两上四味，以水七升，煮取二升，去渣，温服一升，不愈，更服一升。

【方解及其应用范围】白头翁清热活血止腹痛；黄连、黄柏清湿热，厚肠胃，泻下焦之火；秦皮亦属苦寒，有收涩之功。合之有清热平肝止利之功。本方用于治疗细菌性痢疾有特效；凡属热性下痢，无论肠炎痢疾疗效都很高。

四、下利欲饮水者，以有热故也，白头翁汤主之。

郑论：按下利饮水，明是热伤津液也，故以白头翁汤清热之剂主之。

【阐释】此条与上条同，凡属清热之剂，可随宜选用，不可执定白头翁汤为是。

五、下利谵语者，（以）有燥屎也，宜小承气汤（主之）。

郑论：按下利谵语一证，亦有虚实之不同，不得尽为有燥矢而用小承气汤，但利有新久之分，谵语有虚实之异，务在临时斟酌，于饮冷、饮热、舌润、舌干、小便清、黄，如此求之则得矣。

【阐释】用承气汤之目的，是泻阳明里实，而不是泻厥阴之热，本证所以列入厥阴篇中，一方面因为下利的辨证，连类而及，一方面因为病变源于厥阴，实际上病仍属阳明。今下利而见谵语，主有燥屎，则下利为热结旁流，谵语为里有实热。里有实热，用小承气汤下其实热，则下利自止。故郑氏：“利有新、久之别，谵语亦有

虚、实之异。”则治阳虚者，急当回阳止泄，以固其脱；若阴虚者，自当急下存阴”，斯为得矣。

六、下利（后）更烦，按之心下濡者，为虚烦也，宜梔子（豆）豉汤。

郑论：按下利过甚，中气骤伤，阴阳不交，故见虚烦，用药宜慎，不可执一梔豉汤，为不可易，当细辨之。

【阐释】此承上节而来，乃厥阴下利后虚烦之证也，与上节之燥屎实邪迥别。与太阳汗、吐、下后，心中懊憹，虚烦不得眠；以及阳明下早，以致虚烦的机转是一致的。故用梔豉汤以上清包络胸膈之余热，下启肾脏寒水之阴津，则正气复而烦自去也。

七、呕而发热者，小柴胡汤主之。

郑论：按呕（而发热，但呕）有寒呕、热呕之不同；发热有外入、内出之各别，不得统以小柴胡汤论，当辨明为是。

【阐释】关于呕而发热，郑氏曰：“不得统以小柴胡汤论”，是正确的。如选用柴胡汤，必兼口苦、咽干、目眩、胸胁苦满等证，方为合法。

八、呕而脉弱，小便复利，身有微热，见厥者，难治，四逆汤主之。

郑论：按呕而脉弱，虚寒上逆也；小便复利，身有微热，真阳有外亡之机也；更加以厥，阴盛阳微也。故为难治，此际非大剂四逆不可。

【阐释】本条叙述阴盛阳虚，呕逆的证治，郑氏所按甚当。笔者再为之细析，胃中虚寒，则呕而脉弱；下焦虚寒，故小便自利；阳气浮于外，故身有微热；阴寒据于里，故手足见厥。若阴盛格阳，阳气将脱，此乃危候，故云“难治”。“难治”并非不治，可用大剂四逆汤温经回阳以救之。

九、干呕，吐涎沫①，头痛者，吴茱萸汤主之。

①吐涎沫：指味出清稀涎沫。

郑论：按呕吐涎沫，而巅顶痛者，则是厥阴头痛无疑，何也？厥阴脉会顶巅故也。条内只言一头痛，夫头痛六经皆有，不将巅顶指出，则厥阴之证，尚属含糊，主以吴茱萸汤，一定不易之法。

【阐释】本论中用吴茱萸汤凡三见：一为阳明中篇条，二为少阴前篇条，三即本条。证状虽有不同，而其为肝胃虚寒，浊阴上逆所致则同。干呕，吐涎沫，是肝胃寒邪挟浊阴之气上逆，头痛多在巅顶部位，为阴寒上逆之征。治以吴茱萸汤散寒止呕，温胃降逆，则诸症自愈。笔者曾治一巅顶头痛之患者，四肢冰凉，面容苍白无神，食少，一身都痛，恶寒特甚，呕吐涎沫，经中西医治疗，经年累月无效。余综合分析，断为厥阴头痛。先服麻附细辛汤加味四剂，一身痛等有所减轻；继服四逆汤以扶阳祛阴，恶寒等又有减轻；最后治以吴茱萸汤加附片，吐涎沫、头痛诸症悉愈，复以理中汤善其后。

十、呕家，有痈脓〔者〕，不可治呕，脓尽自愈。

郑论：按呕出痈脓，大半多属热壅于内，在厥阴篇中，用药多居辛燥，故教人不治吐脓，盖慎用辛燥之意也。

【阐释】厥阴寒尽阳回之后，阳热太甚，伤及血分，下行则便脓血，上出则呕痈脓。若强止其呕，则脓不得出，反生他变。郑氏曰：“在厥阴篇中，用药多居辛燥，故教人不治吐脓，盖慎用辛燥之意也”。既禁辛燥之剂，其治当辛凉以开其结，苦泄以排其脓，甘寒以养其正，使脓尽而呕自止，可用排脓汤加味治之。

过经不解

四法，附三阴经后（据舒本校补）

一、太阳病，过经十余日②，反二三下之，后四五日，柴胡证仍在者，先与小柴胡。呕不止，心下急③，郁郁微烦者④，为未解也，与大柴胡汤下之则愈。

②过经：此处含有病传他经之意。

③心下急：胃脘部有窘迫的感觉。

④郁郁：言烦闷之状。

郑论：按太阳过经不解，延至十余日，反二三下之，此际邪仍在太阳，方可云过经不解。若是柴胡证，十余日后，邪仍在少阳，方可言过经不解。此说一呕不止，心下急，郁郁微烦病情，乃系太阴中宫不宣，阴邪上逆之象，若只据一呕，而即云柴胡证仍在，殊属不当。

总要寒热往来，口苦、耳聋、喜呕全在，用小柴胡汤，乃为恰切，不得草草了事。

【阐释】过经不解计四条，他书俱载在太阳中篇，舒驰远将此四条，附在三阴经后，郑氏从之。太阳病，过经十余日而不解，或为桂枝汤证，或为麻黄汤证，皆无可下之理，此际邪仍在太阳，故可云过经不解。郑氏辨过经不解与其它注家随文释义不同，是有见地的。至论“呕不止，心下急，郁郁微烦病情，乃系太阴中宫不宣，阴邪上逆”之征，则大柴胡汤不可用，法当温中降逆散邪，理中汤加砂仁半夏治之。

大柴胡汤方（校补）

柴胡半斤黄芩三两芍药三两半夏半升（洗）生姜五两（切）大枣十二枚（擘）枳实四两（炙）上七味，以水一斗二升，煮取六升，去渣再煎，温服一升，日三服。一方加大黄二两①，若不加，恐不为大柴胡汤。

①大黄：晋葛洪《肘后方》载大柴胡汤都有大黄二两，当从之。

【方解及其应用范围】本方有柴胡、半夏、生姜之辛以解表，黄芩、芍药、枳实、大黄之苦以涤除里热，是两解表里之剂。若无大黄，原文何云与大柴胡汤下之愈。

二、太阳病，过经十余日，心下温温欲吐②，而胸中痛，大便反溏，腹微满，（而）郁郁微烦，先此时，自极吐下者③，与调胃承气汤。若不尔者，不可与，但欲呕，胸，中痛，（而）微溏者，此非柴胡〔汤〕证，以呕，故知极吐下也。

②温温：同愠愠，言烦愤之状。

③极吐下：大吐下的意思。

郑论：按太阳过经十余日，所现病情，皆正气不足之候，何也？心下温温欲吐者，中宫不宣，而阴邪滞也；大便溏而微满者，中宫有寒湿弥漫之象也；郁郁微烦，正气不畅达也。此皆由吐、下失宜，方有此候。

【阐释】诸家注解此条，纷纷聚讼，其实难从。唯郑氏能独抒己见云：“太阳过经十余日，所现病情，皆正气不足之候”。此皆由吐、下失宜，既非柴胡证，亦非调胃承气汤所能治。所现诸证，无非内脏虚寒，或为吐下所伤，或为中气素弱，或为寒湿弥漫，法宜温中散寒祛湿，理中汤加砂仁、半夏、茯苓治之。

三、伤寒十三日〔不解〕，胸胁满而呕，日晡所发潮热，已而微利，此本柴胡证，下之（而）〔以〕不得利；今反利者，知医以丸药下之，〔此〕非其治也。潮热者实也，先宜服小柴胡〔汤〕以解外，后以柴胡（汤）加芒硝〔汤〕主之。

郑论：按胸胁，乃肝胆地界，今见病而呕，邪气拂郁也。日晡发热而微利，本有热也，此乃柴胡的候，下之本非其治。学者总宜相机施治为是。至原文所主之方，亦不可固执。

【阐释】胸胁满而呕，日晡发潮热等证，是少阳兼阳明内实之证，故郑氏曰：“下之本非其治。”上证既兼里实，大便应见秘结，今反下利，此是误用丸药所致，虽有微利而病不解，柴胡证仍在；潮热为里实。故先用小柴胡汤以解外；再用柴胡加芒硝汤兼治里实。郑氏又曰：“原文所主之方，亦不可固执”，示人以活法圆通之妙。

柴胡加芒硝汤方（校补）

柴胡二两十六铢 黄芩一两 人参一两 甘草一两（炙） 生姜一两（切） 半夏二十铢 本云二十铢五枚（洗） 大枣四枚（擘） 芒硝二两 上八味，以水四升，煮取二升，去渣，内芒硝，更煮微沸，分温再服。不解，更作。

【方解及其应用范围】此为少阳，阳明兼治的方剂，和解清里之方也，治小柴胡汤证兼胃有实热者。

虽有微利，燥结仍留。加芒硝者，泄热软坚，胃实可除，潮热微利自止。亦即本方证之少阳证及阳明证均较大柴胡汤证为轻者适用之。可以推广用于小柴胡汤证，而腹有坚块苦满难解者；或小柴胡汤证，发潮热，大便不通者。此用咸寒之芒硝以润燥软坚之效也。

四、伤寒十三日（不解），过经谵语言^①，以有热也，当以汤下之。若小便利者，大便当鞕，而反下利，脉调和者，知医以丸药下之，非其治也。若自下利者，〔脉〕当微厥；今反和者，此（谓）〔为〕内实也，调胃承气汤主之。

①过经：此处是病已离开太阳经的意思。

郑论：按谵语而称内热，下之理也；大小便利者，里气通也；脉调和者，气机顺也。此以为医以丸药下之，非其治，殊非正论。又若自下利，当微厥者，正虚之征也；而反和者，正未大虚也。何得此为内实，当下之，非正论，决非仲师所语也。

【阐释】历代注家对本条大多只是随文顺释，殊觉含糊。郑氏对原文提出疑问，不同于历代注解者。第一段“伤寒十三日”至“知医以丸药下之，非其治也”；第二段“若自下利”至“此为内实，当下之”。郑氏均斥为非正论。最后归结为“决非仲师所语也”。郑论按过经不解一语，似非确论，如太阳病有十余日，仍在太阳者；阳明病有下而再下，十余日仍未解。总之不必专拘时日，务以认证为妥，辨明虚

实为要。

【阐释】本节郑论，系概括前四节而言。虽曰过经，究竟仍在六经之内，辨其证在何经，即用何经之法以治之，无所往而不得之矣，又何必用此过经不解之法哉？

差后劳复

计五法（据舒本校补）

一、大病差后②，劳复者③，枳实栀子豉汤主之（若有宿食者，加大黄，如博棋子大五六枚）④。

②大病：诸病源候论云：“大病者，中风、伤寒、热劳、温症之类是也”。

③劳复：疾病新愈，因劳又发的，叫劳复。

④若有……五六枚三句：据成无己本增。其它诸书，此十六字皆在枳实栀子豉汤后。

郑论：按大病差后，稍有劳动，而病依然复初，此皆元气薄弱之故，不得按前法治之。但病（果按）劳复一证，果系何脏损伤，何经为病？病差后，稍有劳动，其病依然，应按脏经施治，原文所主之方，大非确论，恐有遗误。

【阐释】大病新差，真元大虚，气血未复，过劳了可能复发旧病，与前无异，自当照前用药，此一定之理也。而郑氏则说：“而病依然复初，此皆元气薄弱之故，不得按前法治之”。何其自相矛盾？过劳了既可能复发旧病，亦可能新感为病，仍应以随证施治为准。故郑氏又谓：“原文所主之方；大非确论，恐有遗误”。其质疑是正确的。

枳实栀子豉汤方（校补）

枳实三枚（炙）栀子十四个（擘）豉一升（绵裹）上三味，以清浆水七升①，空煮取四升，内枳实栀子，煮取二升，下豉，更煮五六沸，去渣，温分再服，复令微似汗。若有宿食者，内大黄如博棋子大五六枚②，服之愈。

①清浆水：徐灵胎曰：浆水即淘米泔水，久贮味酸为佳。

②博棋子大：千金方：羊脂煎方后云，棋子大小如方寸匕。

【方解及其应用范围】体虚劳复，热气浮越，所以用枳实宽中下气，梔子泄热除烦，香豉宣泄陈腐，兼解其表，更用浆水煮药，以开胃调中，所以具有泄热除烦，散表和中的作用。假如兼有宿食停滞，再加大黄以荡涤肠胃，推陈致新，所谓邪去则正自安。

二、伤寒差以后，更发热（者），小柴胡汤主之。脉浮者，以汗解之；脉沉实者，以下解之。

郑论：按病既称差已，何得更现发热乎？又并未现出柴胡证，何以小柴胡汤主之？即脉浮、沉、实，亦当审其何部何经，应表解、应下解、方可定（按）〔案〕，此以笼统言之，定非确论。

【阐释】伤寒差已，则大邪已去，后更发热者，表里之气未和也，脉当微弦，必兼有口苦、咽干、胸胁满等证，否则不能投以小柴胡汤。至以汗解、以下解，亦当审其何部何经，兼辨其证状，对证下药，始为适当。故郑氏曰：“此以笼统言之，定非确论”。

三、大病差后，从腰以下有水气者，牡蛎泽泻散主之。

郑论：按大病差后，从腰下有水气者，是病不责之太阳，而责之于肾也。太阳底面，即是少阴，太阳病已，而少阴肾气发泄于外，故现腰以下有水气，法当温肾收纳，若牡蛎泽泻散，是亦利水之一法也，似非正论。

【阐释】本条原文甚简，必须结合其它证状来辨别水气之属性，是否可用牡蛎泽泻散治疗。如下焦气化失常，湿热壅滞，膀胱不泻，水性下流，故但从腰以下，水气壅积，膝胫足跖，皆肿重也。此属有余之邪，脉必沉数有力，二便不利，方可用此排决逐水之剂。若脾胃气虚，不能升清降浊；肾气涣散，膀胱气化不行，水邪泛滥而为肿。牡蛎泽泻散决不可用，当如郑氏所说：“当温肾收纳”。兼以化气，四逆汤加肉桂、砂仁、白蔻、破故纸治之。

牡蛎泽泻散方（校补）

牡蛎（熬）泽泻蜀漆（暖水洗去腥）葶苈子（熬）商陆根（熬）海藻（洗去咸）栝蒌根各等分上七味，异捣，下筛为散，更于臼中治之，白饮和服方寸匕，日三服，小便利，止后服。

【方解及其应用范围】牡蛎软坚行水，泽泻渗湿利水，蜀漆祛痰逐水，葶苈子宣肺泄水，商陆、海藻专于润下行水，共使水邪从小便排出。栝蒌根止渴生津液，为本方之反佐，使水去而津液不伤。此方施之于形气实者，其肿可随愈也，若病后土虚

不能制水，肾虚不能行水，则又当别论，慎不可服也。

四、大病差后，喜唾①，久不了了（者）②，（胃）〔胸〕上有寒，当以丸药温之，宜理中丸。

①喜唾：实时时泛吐唾沫。

②久不了了：延绵不已的意思。

郑论：按病后喜唾不了，中宫有寒湿未尽也。寒湿上逆而不降，故唾不止，法宜温中降逆，是一定之理也。

【阐释】郑氏所论极是，法宜温中降逆。笔者将理中丸改为汤剂，再加砂仁、半夏，增强其效，轻者一二剂，重者五六剂，即竟全功。

理中丸方（校补）

人参、干姜、甘草（炙）、白朮各三两上四味，捣筛，蜜和为丸，如鸡子黄许大，以沸汤数合，和一丸，研碎，温服之，日三四，夜二服，腹中未热，益至三四丸，然不及汤。汤法：以四物依两数切，用水八升，煮取三升，去渣，温服一升，日三服。若脐上筑者，肾气动也，去朮，加桂四两；吐多者，去朮加生姜三两；下多者，还用朮；悸者，加茯苓二两；渴欲得水者，加朮，足前成四两半；腹中痛者，加人参，足前成四两半；寒者，加干姜，足前成四两半；腹满者，去朮，加附子一枚。服汤后如食顷，饮热粥一升许，微自温，勿发揭衣被。

【方解及其应用范围】本方乃温中之剂。白朮甘温，燥湿而健脾，主治风寒湿痹。干姜辛温，主胸满咳逆上气，又能暖中宫之气。徐灵胎曰：“凡味厚之药主守，气厚之药主散，姜气味俱厚，故散而能守，夫散不全散，守不全守，则旋转于经络脏腑之间，驱寒除湿，和血通气，所必然矣。”甘草与辛药同用，便可化周身之阳气，阳气化行，阴邪即灭。但恐辛热太盛，故用人参之微寒继之，有刚柔相继之意，阴阳庶几不偏。仲景在前太阳中篇条曾云：“理中者，理中焦”，中焦是脾胃所司，乃《伤寒论》太阴病温中散寒之主方，原文已有几种加减法，参看前面所述，此处不再赘叙。郑氏在《医法圆通》中说：“理中汤所治的主症是腹满而吐，食不下，时腹自痛，不利，口不渴。”是太阴病的典型证候。其基本病理是脾胃虚寒，气机阻滞，故以温中散寒补脾之理中汤为首选方，其圆通应用法，郑氏举出：（1）治吐血，（2）治四肢浮肿，（3）治心下嘈杂吐水，（4）治咳嗽吐清水，（5）治唾水不休，（6）治呃逆不休，（7）治手足微冷少神。以上七症，皆由脾胃虚寒，转输失职所引，故能治之而愈。笔者经验用此方加味治疗脾脏咳嗽。其因脾脏阳虚而咳嗽者，乃脾脏之阳不足，不能转输津液水谷而作，理中汤能温阳利湿，益气化痰，故可

治之而愈。如由于胃寒发吐而咳嗽者，则加砂、蔻、半夏，其效始着。

今人用本方加减化裁以治虚寒性的消化道疾病，如慢性胃炎、肠炎及胃痛、胃溃疡、多见良效。

五、伤寒解后，虚羸少气^①，气逆欲吐，竹叶石膏汤主之。

①虚羸：虚弱消瘦之意。

郑论：按寒邪既称解后，人既虚羸少气，本属不足，气逆欲吐，大半阴邪上逆，正气不支，法宜温中、扶阳、降逆为是。以竹叶石膏汤，是为胃热上攻者说法，若施之于虚羸少气之人，断乎不可。学者务宜于病情或寒或热上体会，庶不致误。

【阐释】伤寒解后，无论汗解、下解，其为伤胃阴则一。胃虚津伤，余热未除，方可用竹叶石膏汤。若病后虚羸少气者，元气衰乏，肾气不足也，病属少阴；气逆欲吐者，脾虚不能摄饮，饮邪上逆，病属太阴，法当扶阳补气，理脾固肾，竹叶石膏万不可用，可选用附子理中汤加砂仁、故纸等药。故郑氏曰：“学者务宜于病情或寒或热上体会，庶不致误。”

竹叶石膏汤方（校补）

竹叶二把石膏一斤半夏半升（洗）人参二两麦门冬一升（去心）甘草二两（炙）粳米半升上七味，以水一斗，煮取六升，去渣，内粳米，煮米熟，汤成去米，温服一升，日三服。

【方解及其应用范围】本方为白虎人参汤加减而成。竹叶、石膏除烦清热，人参、甘草益气生津，麦冬，粳米滋养胃液，半夏降逆。合之能生津益气，清热养阴。本方推广应用于急性热病，肺热、胃热之咳喘或呃逆，受暑之吐泻，以及热病后期津气两伤，余热未尽各症。笔者用治小儿麻疹已出透，仍继续高热，咳嗽剧烈者，则热去而津生，咳嗽自愈。

差后食复

计一法（据舒本校补）

病人脉已解^①，而日暮微烦，以病新差，人强与谷，脾胃气尚弱，不能消谷，故令微烦，损谷则愈^②。

①脉已解：病脉已除，即脉搏平和的意思。

②损谷：即节制食物的意思。

郑论：按胃气旺，则食谷易消，胃气弱，则食难化，此亦理之常也。今日暮而微烦，正阴长阳消之时也。损谷则愈，使其食不骤，而胃气宽舒，自可无虞矣。

【阐释】病人已愈，尚见日暮微烦，因病当新愈，正气未复，勉强进食，脾胃虚弱，只要减食则愈。此即揭示病愈后，应注意饮食调护，不可过食也。

阴阳易病

计一法

伤寒阴阳易之为病，其人身体重，少气，少腹里急，或引阴中拘挛①，热（气）〔上〕冲胸，头重不欲举，眼中生花，膝胫拘急者，烧裨散主之。

①引阴中拘挛：牵引阴部拘急痉挛。

郑论：按阴阳易病，皆由新病初愈，余邪尚未大尽，男与女交则女病，女与男交则男病，以致一线之余毒，势必随气鼓荡，从精窍而发泄也。治之不外扶正为主。至于烧裨散一方，男用女裨，女用男裨，近阴处布方寸，烧灰兑药服之，亦是取阴阳至近之气机，必引药深入，亦是近理之论。余于此等证，在大剂扶阳，取童便为引，服之屡屡获效。

【阐释】阴阳易病者，是男子或妇人伤寒病新差未平复，而与之交接得病者。其证状是身体重，少气、少腹里急等，这是下寒证；热上冲胸，头痛不欲举等，这是上热证。下寒是真寒，上热是假热。郑氏认为治之不外扶正为主，用大剂回阳扶阳，取童便为引，服之屡屡获效，诚不易之治法矣。笔者从之，并认为烧裨散决不可用。

烧裨散方（校补）

妇人中裨近隐处，取烧作灰。

上一味，水服方寸匕，日三服。小便即利，阴头微肿，此为愈矣。妇人病，取男子裨烧灰服。

【阐释】笔者对此证此方，体会很少，不作强解。

外附

太阳少阴总论

夫阳者，即坎中真阳也；少阴者，即坎水也。阳居二阴之中，阴含一阳之内。人身中一水一火，即在此处攸分。故太阳为人身纲领，主皮肤，统营卫者是也。太阳之气上升，则水精之阴，即从太阳而上行，从皮肤而出水气。太阳为外邪干犯，必由毛窍而入，仲景所以着《伤寒》，皆是从根底上来也。故太阳之底〔面〕是少阴，少阴之底面即是太阳，所以太阳发汗有亡阳之虞，即此是也。后学不知根底，着春温，着利证，种种不一，自以为补仲景之不逮，而不知仲景列六经，早已发明其要，惜后人之学识未到，功力未深，自诩以为独得之秘，而其中亦有好处，不得即为之无用也。总之根底未澈，源头未清，不得不直言之也。

【阐释】郑氏于书末附太阳少阴总论者，何故？《医理真传》一书，首揭乾坤大旨，而以坎、离为人生立命之根。坎水在人身虽属阴血，但中有真阳，在人身为肾，一点真阳，含于二阴之中，为人立命的真种子。离为火，属阳，气也，在人身为心。而中一爻来自坤元，真阴寄在其中。在人身则肾中真阳升发，能使水上交于心，心中真阴能使火下交于肾。气血循环，周流不息，水升火降，阴平阳秘，使人身体健康，心智焕发，都是坎离互济交融，一升一降，往来不穷，性命于是乎立。伤寒六经中之太阳，即坎中真阳也；少阴者，即坎水也。六经以太阳为首，凡病邪初入，必由太阳，以太阳为寒水之区，主皮肤，统营卫，为一身纲领。然太阳底面，即是少阴肾经，相为表里也。若太阳病过发汗，则伤少阴肾中真阳，而有亡阳之虞。太阳一经为病，有经病，有伤风症，有伤寒症，有两感症，有腑症。腑症之中，又有蓄尿症，蓄热症，蓄血症，癃闭症。在六经病证中，最为繁多，变化亦大，其治似简实难。至少阴一经之病，有由传经而来，亦有外邪直中少阴经。少阴经兼属手少阴心及足少阴肾，系上火下水，而下水中复有真阳，故本经之病，除经症外，尚有协火、协水两症。在六经中，除太阳经外，本经较其它诸经为复杂，因其为水、火交会之地，元气之根，人身立命之主也。病至此际，是元气衰极，剥至于根，故少阴病中，重症、死症较多。仲景立四逆，是专为救这一点元气说法。又云治三阴厥逆，可知这一点元气，澈上澈下，包罗天地，此方不独专为少阴立法，而上中下三部之法俱备，知得此理，便知得姜附之功用也。笔者数十年之经验，对治阳虚诸种病症，用姜、附少则克，多达克，从未发生任何副作用，真是药到病除。不敢自秘，愿与同人共享之，以救世之阳虚患者，功莫大焉。

麻脚瘟说

余自幼小时，即闻老人相传，有麻脚瘟证，终不知此证是何也？今者历医有年，始得其要。夫曰麻脚瘟者，人身卫外之阳不足，卒为阴邪所闭也。然有吐有泻，皆是阴邪已犯中宫，上下逼迫，而人身元气系在后天，顷刻将元气剥尽，能令人死。余曾救多人，一见此症，即用大剂回阳，可以移危为安。如斩关丸、四逆汤，皆神效之品。设穷乡僻壤，觅药维艰，一遇此等证候，即速捣生姜汁同红糖服之，如无红

糖，即姜汁亦可；如姜不便，而胡椒亦可，速速吞之，皆能获效。昧者不识，胡乱施治，未有不速其死者也，愿诸公熟记之，至切至切。

【阐释】郑氏释麻脚瘟病为人身卫外之阳不足，卒为阴邪所闭也，是经验有得之言。因其病来势凶猛，顷刻将元气剥尽，能令人死。即用大剂回阳，如四逆汤、斩关元服之，可以转危为安。对缺医少药之穷乡僻壤，提出简便易行之姜汁同红糖服之，或胡椒速吞之，皆能获效，足以补医药之不逮，弥足珍贵。

斩关丸方

舒驰远自制（据舒本少阴前篇五条补入）

硫磺五两，研细末，贯入猪大肠，线札煮去肠滚水淘数次晒干肉桂一两白蔻、生附子、花椒、生白朮、吴茱萸、半夏、鸡内金各五钱以上共为末，饭碾成丸。

辨认内外发热证至要约言

医家治病，务要识得内外两法，邪有由外而入者，有由内而出者，大有分别。如发热一证，无论男妇老幼一见发热，鲜不以为外感也，不知大有分别。余阅历数十年，方始识得，不敢自秘，以公诸世，亦救世之意也。千古以来，名贤迭出，惜此未剴切详明也。曰内曰外，何以辨之？证之？由外感者，无论男妇老幼，一经外感，邪从毛窍而入，闭其外出之气机，人即沉迷倒卧不起，所现头疼、身痛、恶风、畏寒等等情状。若由内而出者，无论男妇老幼，人不困倦，起居一切如无病者，但发热而已。其间有手心独发热者，有上半日发热者，有下半日发热者，有夜间发热者，种种不一。但其人面白、唇青、口不渴、满口津液，饮食无味，大小便利，不思水饮为据。即有面赤如朱，口红唇裂、皆在舌上，津液满口，小便清长，喜饮热汤上辨之，万无一失。

【阐释】发热有内、外之分，郑氏原文剴切详明，无庸赘述。但笔者认为将《医理真传》认病捷要总诀发热类与之合参，则更为全面，故不惮繁而录之，以供辨证。发热而身疼者，外感也（自汗桂枝汤，无汗麻黄汤）。发热而身不疼，饱闷吞酸者，内伤于食也（平胃散加消食行气之药）。发热身疼，不恶寒，舌黄而饮冷者，热伤于里也（白虎汤加桂枝干葛）。发热身疼，恶寒，口不渴者，邪入少阴也（麻黄附子细辛汤）。素禀不足，无故身大热，舌青欲饮极热者，元阳外越也，亦有口不渴者，皆同（吴茱萸四逆汤）。小儿发热，气粗口热者，表里俱病，内有热也（人参败毒散加芩、连、梔子）。发热出气微温，而口不热，小便清长，大便不实，素有疾者，元气不固也（理中汤、六君子汤之类）。

问答计三条

问曰：俗云服姜附烧干肾水，果有是说乎？

答曰：子不观仲景之用姜附，所以回阳也，阳回则津液自生，何以不烧干肾水而反生津液，生死人而肉白骨乎？此其中大有关键，昧者不明阴阳底蕴，畏姜附视若砒霜，不敢轻用，病家亦不敢轻服，相沿成风，牢不可破。犹其不知姜附乃少阴主药，仲景用之以扶少火而生气者也。曰：然则姜附其可恒用欤？曰：可。曰：何以知其可恒用也？曰：凡一切阳虚诸症，如少气、懒言、身重、恶寒、声低、息短、舌润、舌黑、二便清利、不思水饮、心悸、神昏、不语、五心潮热，喜饮热汤、便血、吐血、闭目妄语，口臭难禁，二便不禁，遗尿遗屎，手足厥逆，自汗，心慌不寐，危候千般，难以枚举，非姜附何以能胜其任，而转危为安也乎？曰：然则世之用大黄芒硝以治病者，其故何也？曰：大哉斯问也？曰：夫大黄芒硝乃治壮火食气之症也。曰：壮火之为病若何？曰：壮火者，是外来之邪热，入与阳明之燥热相合，盘据于中，若不急为扑灭，顷刻将真阴灼尽而性命不保，故曰壮火食气即此。仲景于此，轻则以人参白虎，重则以大承气、小承气汤，与夫六味、麦味、鸡子黄连润燥、养阴、救阴诸法，皆一辙也。至所现病情，如气粗口热、大渴饮冷、壮热、烦躁、汗多、身轻、张目不眠、声音响亮、口臭、芒刺满口，谵语神昏，二便不利，胸腹痞满，狂叫不休，便血，吐血，种种危候，难以枚举。如此之病，不惟姜附不用，即一切辛燥之品，皆当禁服也。由是观之，则医亦可学也，而用药之宜热宜凉，有一定之理也。噫！先生此论，其可为医门之一助也，实快事也。

【阐释】郑氏此条采取问答形式，说明姜附之功用，并斥服姜附烧干肾水之说。仲景伤寒论方中，用附子者有方，盖附子纯阳之性，能补坎中真阳。《医理真传》一书中，有坎卦解、离卦解、气血两字作一卦解，君相二火解等，都是说明气血周流五脏六腑，以及全身，必须相应平衡，始能健康长寿。如有偏盛，必发而为病。“气有余便是火，气不足便是寒”。“火旺者阴必亏，寒甚者阳必衰”。此阳虚阴虚之所由来也。姜附乃阴症主药，用之以扶少火而生气者，凡一切阳虚诸症，皆可服之。附子为热药之冠，能扶欲绝之火种，又必佐干姜之辛散，以荡尽阴邪，迎阳归舍，故曰回阳。凡阳虚阴盛为病，皆可放胆使用，能早用善用，即不致酿成危候。盖邪火始能伤阴，真火实能生阴，火盛则水盛，火衰则水衰，故烧干肾水之说，实属无稽。笔者临证数十年来，以善用姜桂附闻于世，用附片少则数十克，多则达二三百克，从未发生任何副作用，盖即本诸邪火始能伤阴，真火实能生阴之理论。又曰：“然则世之用大黄，芒硝以治病，其故何也”？盖硝、黄乃治壮火食气之药也，食气者，食尽元阴之气也。若不急为扑灭，顷刻将真阴灼尽而命不永。至其所现症状，如气粗口热，大渴饮冷等，非但姜附不可用，即一切辛燥之品，皆当禁服，此又白虎、承气之用矣。

或问：俗云小儿纯阳之体，不宜服姜附，是耶？非耶？

答曰：小儿者，稚阳也，如初生之萌芽，其质娇嫩，用药稍差，即祸生不测，便酿

出阳虚种种危候，非姜附何能扶少火而生气，以助先天危亡之机乎？世人动曰纯阳，岂非见之左耶。总之用姜附亦必究其虚实，相其阴阳，观其神色，当凉则凉，当热则热，何拘拘以姜附为咎哉？

【阐释】俗说“小儿纯阳之体，有热无寒”。其实此语非是。有初生小儿，生下后其身体即为阳虚者，由其母在妊娠期中，喜食生冷；或因营养不良，以致胎儿在母腹中，即未健康成长，发育不好，其面容皎白，额上显出青纹，口唇青白，哭时声不洪亮，舌质淡红，苔白腻等。亦有小儿患病，注射青链霉素，或过服寒凉之剂，有如郑氏所说：“用药稍差，即祸生不测，便酿出阳虚种种危候。”

上述两种症状，则非用姜附以扶少火而生气，以救危亡不可。总之用姜附必辨其阴阳虚实，何能拘泥于小儿纯阳之体，不宜服姜附哉！笔者曾治患儿戴某，生下后三月，即患咳嗽，病势严重，送医院治疗，经注射青霉素半月，病愈出院。在一年中，咳喘断续发作，住医院四次。最后一次诊断为肺气肿，虽注射针药及输液治疗，未见减轻，已下病危通知书。患儿面容乌黑，咳时头倾胸曲，气喘促，出冷汗，手足冰凉，舌质淡红，苔白腻。其母在妊娠期中，喜吃生冷瓜果以及冰糕汽水等饮料。根据上述诊断，胎儿在母体内即受损伤，生下后即现阳虚之象。加之三月即住医院治疗，共有五次，注射青霉素及输液，损伤阳气。现已见种种危候，非用姜附以扶阳止咳喘不可。先用四逆汤加麻黄治之；继用真武汤，最后以理中汤善其后，共服药三十剂而痊愈。今十年，小孩健康成长，已读小学矣。

或问：俗云小儿初生，先服开口药，以下胎毒，免生疮症，用药不外大黄、银花、勾藤、防风、巴豆、大枣等，果可服否？

答云：小儿下地，定要服开口药，以下胎毒，免生疮、风症，此皆不经之论。夫小儿居母腹中，母呼一呼，母吸一吸，十月功圆，破衣而出，此时一团真气养成，有何胎毒？如果有毒，小儿尚可活乎？既经下地，如初出土萌芽，此则一身真气，本是并无一毫外邪，何得即以戕伐生气之药而施之，则无疾反生有疾，不生风因而生风，故有四六风、七天风，十有九死，难以枚举。此千古之流弊，实千古小儿之大厄也。噫！何世人之不讲理法耶？

【阐释】郑氏认为小儿初生下地，不可妄施药品，力斥世俗用大黄、银花等药以下胎毒之非是，并指出其流弊，在当时是很有见地的。现今产科医院林立，妇女生育小孩多在医院，此种陋习，已随之而消失矣。

附录

《伤寒论》原文，有《伤寒恒论》中所无者，补上备考。

○太阳病，发热而渴，不恶寒者，为温病。若发汗已，身灼热者，名风温。风温为病，脉阴阳俱浮，自汗出，身重，多眠睡，鼻息必鼾，语言难出。若被下者，小便不利，直视失溲。若被火者，微发黄色，剧则如惊痫，时瘈瘲。若火熏之，一逆尚引日，再逆促命期。

○问曰：症象阳旦，按法治之而增剧，厥逆，咽中干，两胫拘急而谵语。师曰：夜半手足当温，两脚当伸。后如师言，何以知此？

答曰：寸口脉浮而大，浮为风，大为虚，风则生微热，虚则两胫挛，病形象桂枝，因加附子参其间。增桂令汗出，附子温经，亡阳故也。

厥逆，咽中干，烦躁，阳明内结，谵语烦乱，更饮甘草干姜汤。夜半阳气还，两足当热，胫尚微拘急，重与芍药甘草汤，尔乃胫伸；以承气汤微溲，则止其谵语，故知病可愈。

○太阳病，十日以去，脉浮细而嗜卧者，外已解也，设胸满胁痛者，与小柴胡汤；脉但浮者，与麻黄汤。

○病发热头痛，脉反沉，若不差，身体疼痛，当救其里，宜四逆汤。

○得病六七日，脉迟浮弱，恶风寒，手足温，医二三下之，不能食，而胁下满痛，面目及身黄，颈项强，小便难者，与柴胡汤，后必下重，本渴饮水而呕者，柴胡不中与也，食谷者哕。

○条前段。伤寒中风，有柴胡证，但见一证便是，不必悉具。

○形作伤寒，其脉不弦紧而弱，弱者必渴，被火必谵语，弱者发热脉浮，解之当汗出愈。

○脉浮热甚，而反灸之，此为实，实以虚治，因火而动，必咽燥吐血。

○病人脉数，数为热，当消谷引食，而反吐者，此以发汗，令阳气微，膈气虚，脉乃数也。数为客热，不能消谷，以胃中虚冷，故吐也。

○病在阳，应以汗解之，反以冷水濯之，若灌之，其热被劫不得去，弥更益烦，肉上粟起，意欲饮水，反不渴者，服文蛤散。若不差者，与五苓散。寒实结胸，无热证者，与三物小陷胸汤，白散亦可服。

○太阳少阳并病，心下鞭，颈项强而弦者，当刺大椎、肺俞、肝俞，慎勿下之。

○阳明病，汗出多而渴者，不可与猪苓汤，以汗多胃中燥，猪苓汤复利其小便故也。

○伤寒先厥，后发热而利者，必自止，见厥复利。

○伤寒厥四日，热反三日，复厥五日，其病为进，寒多热少，阳气退，故为进也。

○伤寒大吐大下之，极虚，复极汗者，其人外气怫郁，复与之水，以发其汗，因得哕。所以然者，胃中寒冷故也。

○伤寒，哕而腹满，视其前后，知何部不利，利之即愈。

辨霍乱病脉症并治篇○问曰：病有霍乱者何？答曰：呕吐而利，此名霍乱。

○问曰；病发热头痛，身疼恶寒，吐利者，此属何病？

答曰：此名霍乱。霍乱自吐下，又利止，复更发热也。

○伤寒，其脉微涩者，本是霍乱，今是伤寒，却四五日至阴经上，转入阴必利，本呕下利者，不可治也。欲似大便而反失气，仍不利者，此属阳明也，便必鞭，十三日愈，所以然者，经尽故也。下利后，当便鞭，鞭则能食者愈。今反不能食，到后经中，颇能食，复过一经能食，过之一日当愈，不愈者，不属阳明也。

○恶寒脉微而复利，利止，亡血也，四逆加人参汤主之。

四逆加人参汤方甘草二两（炙）附子一枚（生、去皮，破八片）干姜一两半人参一两上四味，以水三升，煮取一升二合，去渣，分温再服。

○霍乱，头痛发热，身疼痛，热多欲饮水者，五苓散主之。寒多不饮水者，理中丸主之。

○吐利止，而身痛不休者，当消息和解其外，宜桂枝汤小和之。

○吐利汗出，发热恶寒，四肢拘急，手足厥冷者，四逆汤主之。

○既吐且利，小便复利，而大汗出，下利清谷，内寒外热，脉微欲绝者，四逆汤主之。

○吐已下断，汗出而厥，四肢拘急不解，脉微欲绝者，通脉四逆加猪胆汤主之。

通脉四逆加猪胆汤方甘草二两（炙）干姜三两强人可四两附子大者一枚（生去皮，破八片）猪胆汁半合上四味，以水三升，煮取一升二合，去渣，内猪胆汁，分温再服，其脉即来。无猪胆，以羊胆代之。

○吐利发汗，脉平小烦者，以新虚不胜谷气故也。